



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PROFIL KESEHATAN INDONESIA

Tahun 2016

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2017

PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2016

351.077
Ind
p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. --
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2017

ISBN 978-602-416-253-5

1. Judul I. HEALTH STATISTICS

Buku ini diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id
Website: <http://www.kemkes.go.id>

TIM PENYUSUN

Pengarah

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor

drg. Rudy Kurniawan, M.Kes
Yudianto, SKM, M.Si
Boga Hardhana, S.Si, MM
drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes

Anggota

Cecep Slamet Budiono, SKM, MSc.PH; Nuning Kurniasih, S.Si.Apt, Msi;
Evida V. Manullang, S.Si, MKM; Wardah, SKM, MKM; dr. Fetty Ismandari, M.Epid;
Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM;
Annisa Harpini, SKM, MKM; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM;
Eka Satriani Sakti, SKM; dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Reno Mardina, SKM;
Erwin Susetyoaji, SKM, M.Kes; Hira Ahmad Habibi, S.Sn; Dian Mulya Sari, S.Ds;
B. B. Sigit; Sinin; Hellen Maslinda

Kontributor

Kementerian Dalam Negeri; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Kepegawaian; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Krisis Kesehatan; Pusat Kesehatan Haji; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Dit. Kesehatan Keluarga; Dit. Kesehatan Lingkungan; Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga; Dit. Gizi Masyarakat; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan; Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Dit. Pelayanan Kesehatan Primer; Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan; Dit. Pelayanan Kesehatan Tradisional; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Set Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan; Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI



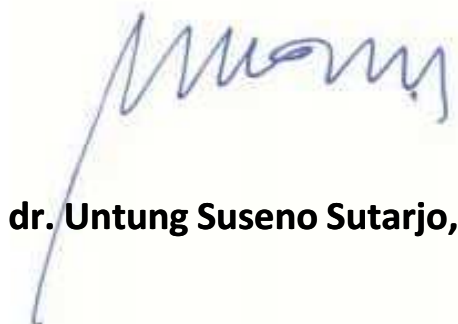
Berkat rahmat dan izin Allah SWT maka penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2016 telah selesai lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2016 ini.

Profil Kesehatan Indonesia yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup komprehensif ini disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang ada. Sumber data diperoleh dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik berupa data rutin maupun hasil dari survei atau sensus.

Profil Kesehatan Indonesia 2016 ini menyajikan data dan informasi tentang Demografi, Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, serta Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Selain dalam bentuk cetakan, Buku Profil Kesehatan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* yang dapat diunduh melalui *website* www.kemkes.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang.

Jakarta, Juli 2017
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes



KATA SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN RI



Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program prioritas Pembangunan Kesehatan pada periode 2015 – 2019 dilaksanakan melalui Program Indonesia Sehat dengan mewujudkan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Upaya mewujudkan paradigma sehat ini dilakukan melalui pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pendekatan, kebijakan, dan strategi program yang tepat serta sasaran yang jelas. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan dihidupkannya kembali “Pendekatan Keluarga”. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan menuju arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat.

Saya menyambut gembira atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2016 sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif. Publikasi seperti ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan. Profil Kesehatan ini juga merupakan pemenuhan hak terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Saya berharap upaya peningkatan kualitas Profil Kesehatan Indonesia terus dilakukan, baik ketepatan waktu, validitas, kelengkapan, dan konsistensi data, serta kecepatan penerbitan Profil Kesehatan Indonesia ini sehingga pemanfaatannya akan lebih optimal. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan yang berbasis data.

Akhir kata saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi, khususnya pengelola data di pusat, daerah, dan lintas sektor dalam penyusunan Profil Kesehatan 2016 ini.

Jakarta, Juli 2017
Menteri Kesehatan RI



Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek Sp.M (K)

DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA (DALAM JUTAAN) MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2012 – 2016	2
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012	3
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2016	3
GAMBAR 1.4	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2016	4
GAMBAR 1.5	PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ² DI DONESIA TAHUN 2016	5
GAMBAR 1.6	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2013 – 2016 (DALAM PERSEN)	7
GAMBAR 1.7	GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2016	8
GAMBAR 1.8	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	9
GAMBAR 1.9	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER-KAPITA PER-BULAN TAHUN 2016	11
GAMBAR 1.10	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN 2016	13
GAMBAR 1.11	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS (DALAM TAHUN) TAHUN 2012 - 2016	14
GAMBAR 1.12	ANGKA MELEK HURUF (DALAM PERSEN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	15
GAMBAR 1.13	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2013 - 2016	16
GAMBAR 1.14	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN TAHUN 2013 - 2016	17
GAMBAR 1.15	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2013 - 1016	18
GAMBAR 1.16	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 1996 - 2016	19
GAMBAR 1.17	KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2015 - 2016	20
GAMBAR 1.18	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	21

BAB II. SARANA KESEHATAN

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2012 – 2016	26
GAMBAR 2.2	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2016	27
GAMBAR 2.3	JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2016	28
GAMBAR 2.4	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP TAHUN 2012 – 2016	29
GAMBAR 2.5	JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 2016	31
GAMBAR 2.6	JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA DI INDONESIA TAHUN 2016	32
GAMBAR 2.7	PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TAHUN 2016	34
GAMBAR 2.8	PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONALDI INDONESIA TAHUN 2016	34
GAMBAR 2.9	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2013 - 2016	36
GAMBAR 2.10	PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2016	37
GAMBAR 2.11	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2012 - 2016	37
GAMBAR 2.12	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016	38
GAMBAR 2.13	PERSENTASE AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2016	39
GAMBAR 2.14	JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2016	41
GAMBAR 2.15	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2015	41
GAMBAR 2.16	PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2016	43
GAMBAR 2.17	JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKKES DIPLOMA III DAN IV DI INDONESIA TAHUN 2016	45
GAMBAR 2.18	JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III DAN IV POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2016	46

BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

GAMBAR 3.1	REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2016	50
GAMBAR 3.2	JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2016	51
GAMBAR 3.3	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2016	52
GAMBAR 3.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2016	53
GAMBAR 3.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2016	54
GAMBAR 3.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2016	55
GAMBAR 3.7	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2015	56
GAMBAR 3.8	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	57
GAMBAR 3.9	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2016	58
GAMBAR 3.10	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2016	59
GAMBAR 3.11	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI EMPAT DOKTER SPESIALIS DASAR DAN TIGA DOKTERSPESIALIS PENUNJANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	60
GAMBAR 3.12	KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERTULAR (3T)	61
GAMBAR 3.13	PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN (DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT, DAN BIDAN DI DAERAH 3T DENGAN JUMLAH NASIONAL TAHUN 2016	62
GAMBAR 3.14	RASIO DOKTER TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016	63
GAMBAR 3.15	RASIO DOKTER GIGI TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016	64
GAMBAR 3.16	RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016	65

GAMBAR 3.17	RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016	66
GAMBAR 3.18	JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2016	67
GAMBAR 3.19	JUMLAH PENERBITAN STR MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2016	68
GAMBAR 3.20	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2016	69
GAMBAR 3.21	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2016	70
GAMBAR 3.22	JUMLAH DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER TAHUN 2016	72
GAMBAR 3.23	JUMLAH RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2016	73
GAMBAR 3.24	JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2016	74
GAMBAR 3.25	KABUPATEN/KOTA PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT TAHUN 2016	76
GAMBAR 3.26	JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT TAHUN 2016	76
GAMBAR 3.27	TREN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGAJUAN/PERPANJANGAN RPTKA DAN IMTA BAGI SDM K WNA TAHUN 2014-2016	78

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010 – 2016	82
GAMBAR 4.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2016	82
GAMBAR 4.3	PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2016	83
GAMBAR 4.4	REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	85
GAMBAR 4.5	PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN TAHUN 2014 – 2016	87
GAMBAR 4.6	PROPORSI JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN PER 31 DESEMBER TAHUN 2016	88

GAMBAR 4.7	GAMBARAN JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN MENURUT JENIS DAN PERSENTASE PENAMBAHANNYA TAHUN 205 - 2016	89
GAMBAR 4.8	JUMLAH KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI PER 31 DESEMBER 2016 (DALAM RIBUAN)	89
GAMBAR 4.9	PERKEMBANGAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014 - 2016	90
GAMBAR 4.10	PROPORSI JENIS FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2016	91
GAMBAR 4.11	GAMBARAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DAN PERSENTASE PENAMBAHANNYA MENURUT JENIS TAHUN 2014 - TAHUN 2016	91
GAMBAR 4.12	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI PER 31 DESEMBER 2016	92
GAMBAR 4.13	SEBARAN JUMLAH FKTP YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 201	93
GAMBAR 4.14	PERKEMBANGAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014 - 2016	93
GAMBAR 4.15	PROPORSI JENIS FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2016	94
GAMBAR 4.16	GAMBARAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DAN PERSENTASE PENAMBAHANNYA MENURUT JENIS TAHUN 2014 - 2016 ...	94
GAMBAR 4.17	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL) YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2016	95
GAMBAR 4.18	SEBARAN JUMLAH FKRTL YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2016	96
GAMBAR 4.19	ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) BPJS TAHUN 2014 – 2016	96

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1	ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 1991 - 2015	102
GAMBAR 5.2	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2006 - 2016	105
GAMBAR 5.3	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	106

GAMBAR 5.4	CAKUPAN IMUNISASI TT5 PADA WANITA USIA SUBUR DI INDONESIA TAHUN 2016	108
GAMBAR 5.5	CAKUPAN IMUNISASI TT2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2016	109
GAMBAR 5.6	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	110
GAMBAR 5.7	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2016 ..	112
GAMBAR 5.8	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	113
GAMBAR 5.9	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	115
GAMBAR 5.10	PUSKESMAS MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	116
GAMBAR 5.11	CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2016	118
GAMBAR 5.12	CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2016	118
GAMBAR 5.13	PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA TAHUN 2016	119
GAMBAR 5.14	PERSENTASE PUS BUKAN PESERTA KB (<i>UNMEET NEED</i>) DI INDONESIA TAHUN 2016	120
GAMBAR 5.15	TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA TAHUN 1991 – 2015	124
GAMBAR 5.16	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	126
GAMBAR 5.17	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2016	128
GAMBAR 5.18	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	129
GAMBAR 5.19	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	130
GAMBAR 5.20	ANGKA <i>DROP OUT</i> IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI TAHUN 2007 - 2016	131
GAMBAR 5.21	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	132
GAMBAR 5.22	CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN PESERTA DIDIK KELAS I MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 ...	134

GAMBAR 5.23	CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN PESERTA DIDIK KELAS VII DAN X MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	135
GAMBAR 5.24	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	137
GAMBAR 5.25	CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI UMUR 0 – 5 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	139
GAMBAR 5.26	CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6 – 59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	140
GAMBAR 5.27	PERSENTASE GIZI BURUK DAN KURANG PADA BALITA 0 – 59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	142
GAMBAR 5.28	PERSENTASE GIZI BURUK DAN KURANG PADA BALITA 0 – 23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	143
GAMBAR 5.29	PERSENTASE PENDEK PADA BALITA 0 – 59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	144
GAMBAR 5.30	PERSENTASE BALITA PENDEK DAN SANGAT PENDEK BERUMUR 0 – 23 BULAN MENURUT PROVINSIDI INDONESIA TAHUN 2016	145
GAMBAR 5.31	PERSENTASE BALITA KURUS DAN SANGAT KURUS BERUMUR 0 – 59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	146
GAMBAR 5.32	PERSENTASE BALITA KURUS DAN SANGAT KURUS BERUMUR 0 – 23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	147

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1	PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2012 - 2016	155
GAMBAR 6.2	ANGKA NOTIFIKASI KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008 - 2016	156
GAMBAR 6.3	ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKOLUSIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	156
GAMBAR 6.4	ANGKA KEBERHASILAN PENGobatan PASIEN TUBERKULOSIS TAHUN 2008-2016	157
GAMBAR 6.5	ANGKA KEBERHASILAN PENGobatan PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	158
GAMBAR 6.6	JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2016	159
GAMBAR 6.7	PROPORSI KASUS BARU HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2016	160

GAMBAR 6.8	PERSENTASE KASUS BARU HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2016	161
GAMBAR 6.9	PERSENTASE KASUS BARU HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2016	161
GAMBAR 6.10	JUMLAH KASUS AIDS MENURUT PEKERJAAN DI INDONESIA TAHUN 2016	162
GAMBAR 6.11	ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN TAHUN 2004 - 2015	163
GAMBAR 6.12	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2016	165
GAMBAR 6.13	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2011 - 2016	166
GAMBAR 6.14	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005 DAN 2016	167
GAMBAR 6.15	ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2012-2016	168
GAMBAR 6.16	ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2016	168
GAMBAR 6.17	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2012 - 2016	169
GAMBAR 6.18	DISTRIBUSI KASUS TETANUS NEONATORIUM PER PROVINSI TAHUN 2016	171
GAMBAR 6.19	DISTRIBUSI KASUS CAMPAK RUTIN DI INDONESIA TAHUN 2016.....	172
GAMBAR 6.20	<i>INCIDENCE RATE (IR)</i> CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	173
GAMBAR 6.21	PROPORSI KASUS CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2016	174
GAMBAR 6.22	SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	175
GAMBAR 6.23	PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2016	175
GAMBAR 6.24	PENCAPAIAN <i>NON POLIO AFP RATE</i> PER 100.000 ANAK USIA < 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	176
GAMBAR 6.25	<i>NON POLIO AFP RATE</i> PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2016	177
GAMBAR 6.26	PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 ...	178

GAMBAR 6.27	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	178
GAMBAR 6.28	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2010-2016	179
GAMBAR 6.29	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	180
GAMBAR 6.30	<i>CASE FATALITY RATE</i> DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	181
GAMBAR 6.31	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2010-2016	182
GAMBAR 6.32	ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2010-2015	182
GAMBAR 6.33	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2010-2016	183
GAMBAR 6.34	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2016...	184
GAMBAR 6.35	CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2010 – 2016	186
GAMBAR 6.36	PROPORSI KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2016	186
GAMBAR 6.37	ANGKA KESAKITAN MALARIA (<i>ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API</i>) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2009-2016	187
GAMBAR 6.38	ANGKA KESAKITAN MALARIA (<i>ANNUAL PARACITE INCIDENCE/API</i>) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	188
GAMBAR 6.39	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN $API < 1$ PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	189
GAMBAR 6.40	PERSENTASE PEMBERIAN <i>ARTEMICIN-BASED COMBINATION THERAPY (ACT)</i> MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	190
GAMBAR 6.41	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2016	191
GAMBAR 6.42	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2016	193
GAMBAR 6.43	JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN ANTRAKS DI INDONESIA TAHUN 2009-2015	194
GAMBAR 6.44	JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DAN <i>CASE FATALITY RATE (CFR)</i> FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2016	195
GAMBAR 6.45	KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN VEKTOR TERPADU MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	197
GAMBAR 6.46	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016	200

GAMBAR 6.47	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016	201
GAMBAR 6.48	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMPUNYAI PERATURAN KTR MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016	202
GAMBAR 6.49	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN KTR MINIMAL PADA 50% SEKOLAH MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016 ...	203
GAMBAR 6.50	PERSENTASE PEMERIKSAAN IVA MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016	204
GAMBAR 6.51	JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT JENIS PER BULAN DI INDONESIA TAHUN 2016	205
GAMBAR 6.52	PERSENTASE KEJADIAN BENCANA MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2016	206
GAMBAR 6.53	PERSENTASE KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2016	206
GAMBAR 6.54	PERSENTASE KEJADIAN BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2016	207
GAMBAR 6.55	PERSENTASE KEJADIAN BENCANA SOSIAL DI INDONESIA TAHUN 2016	207
GAMBAR 6.56	JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI TAHUN 2016	208
GAMBAR 6.57	JUMLAH PROVINSI TERKENA BENCANA MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2016	209
GAMBAR 6.58	CAPAIAN PEMERIKSAAN PERTAMA JAMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2016	213
GAMBAR 6.59	JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2016	214
GAMBAR 6.60	PROPORSI STATUS ISTITHAAH KESEHATAN JAMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2016	215

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1	CAPAIAN DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2012 - 2016	222
GAMBAR 7.2	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2016	223
GAMBAR 7.3	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA TATANAN KAWASAN SEHAT TAHUN 2016	226
GAMBAR 7.4	PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK TAHUN 2016	228

GAMBAR 7.5 PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN
TAHUN 2016 229

GAMBAR 7.6 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP
SANITASI LAYAK TAHUN 2016 231

GAMBAR 7.7 PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT
KESEHATAN TAHUN 2016 233

GAMBAR 7.8 PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI
SYARAT KESEHATAN TAHUN 2016 235

GAMBAR 7.9 PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGOLAHAN LIMBAH
MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2016 237

GAMBAR 7.10 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 240

GAMBAR 7.11 PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH MENURUT PROVINSI TAHUN
2016 242

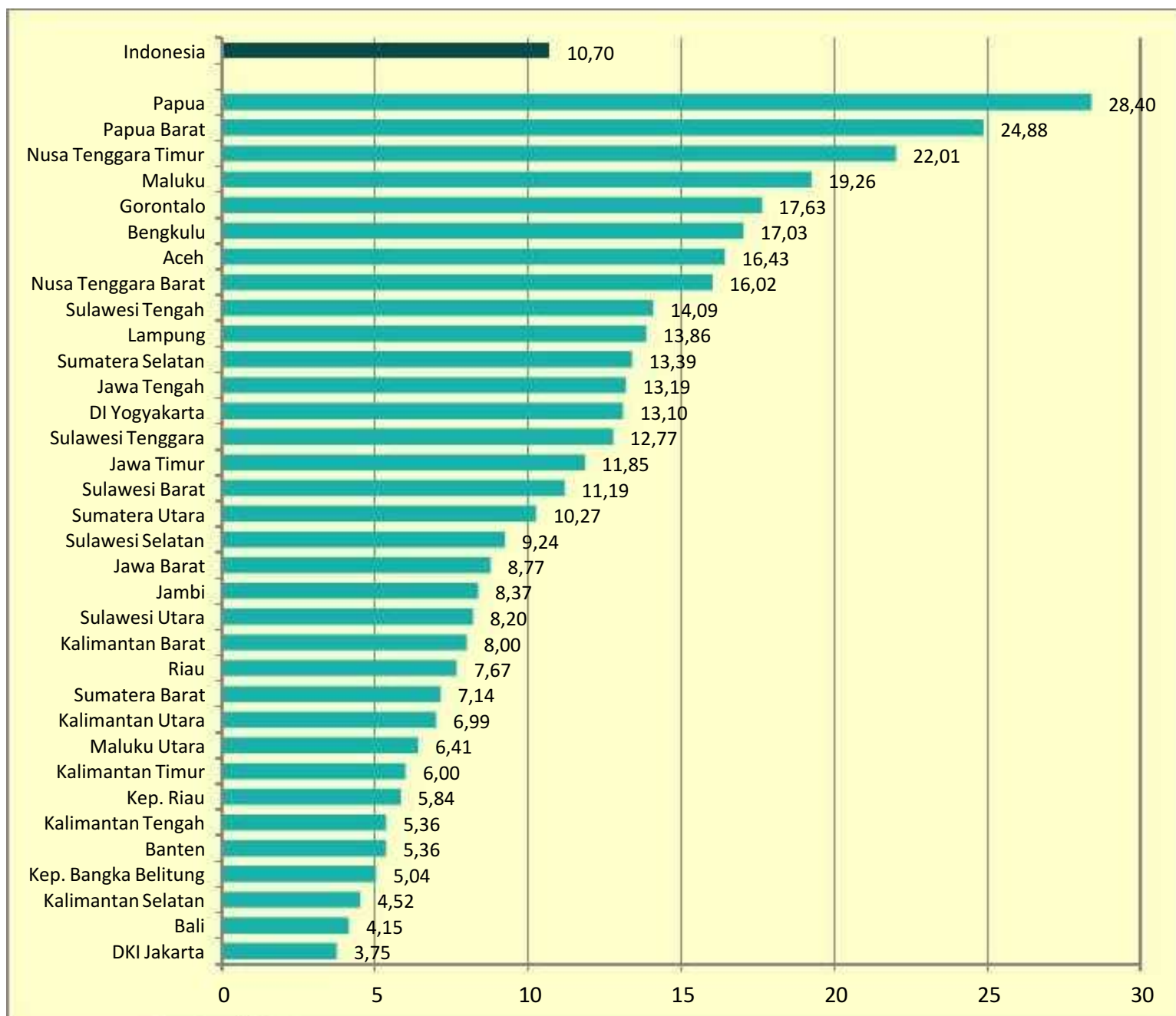
DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2016	6
TABEL 1.2	PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2013 - 2016	10
TABEL 1.3	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2013 – 2016 (JUTA ORANG)	12
TABEL 2.1	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2013 – 2016	35
TABEL 4.1	SEPULUH KODE CBG’S TERBANYAK PADA TINGKAT LAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016	97
TABEL 4.2	SEPULUH KODE CBG’S TERBANYAK PADA TINGKAT LAYANAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUT (RITL) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016	98
TABEL 6.1	PERKIRAAN PERSENTASE KASUS PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016	164
TABEL 6.2	REKAPITULASI KLB DIARE TAHUN 2016	170
TABEL 6.3	REKAPITULASI KLB DIARE DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2016	170
TABEL 6.4	DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 6 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2015	192
TABEL 6.5	JUMLAH KEJADIAN BENCANA ALAM DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2016	209
TABEL 6.6	JUMLAH KEJADIAN BENCANA NON ALAM DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2016	210
TABEL 6.7	JUMLAH KEJADIAN BENCANA SOSIAL DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2016	211
TABEL 6.8	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2016	215

Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2016, penduduk miskin yang tinggal di perdesaan sebesar 62,23 % dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2016 sebesar 63,08 %.

Berdasarkan provinsi pada tahun 2016, persentase penduduk miskin terbesar yaitu Papua (28,40%), Papua Barat (24,88%) dan Nusa Tenggara Timur (22,01%). Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah DKI Jakarta (3,75%), Bali (4,15%) dan Kalimantan Selatan (4,52%).

GAMBAR 1.8
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Persebaran jumlah dan proporsi penduduk miskin berdasarkan kelompok pulau tahun 2013-2016 pada tabel di bawah ini memperlihatkan persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multi dimensional, oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

TABEL 1.2
PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN
MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2013 – 2016

No	Kelompok Pulau	2013		2014		2015		2016	
		Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
1	Sumatera	6.190,1	21,7	6.070,4	21,9	6.309,1	22,1	6.214,9	22,4
2	Jawa	15.546,9	54,4	15.143,8	54,6	15.312,3	53,7	14.832,8	53,4
3	Kalimantan	978,7	3,4	972,9	3,5	994,0	3,5	970,2	3,5
4	Bali dan Nusa Tenggara	1.998,1	7,0	2.004,5	7,2	2.181,6	7,7	2.111,6	7,6
5	Sulawesi	2.139,6	7,5	2.054,9	7,4	2.192,8	7,7	2.088,2	7,5
6	Maluku dan Papua	1.700,5	6,0	1.481,4	5,3	1.524,2	5,3	1.546,7	5,6
Indonesia		28.553,9	100,0	27.727,8	100,0	28.513,6	100,0	27.764,3	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Masalah kemiskinan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan secara nasional tahun 2016 sebesar 1,74. Indeks Keparahannya Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan secara nasional tahun 2016 sebesar 0,44. Rincian mengenai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.11.

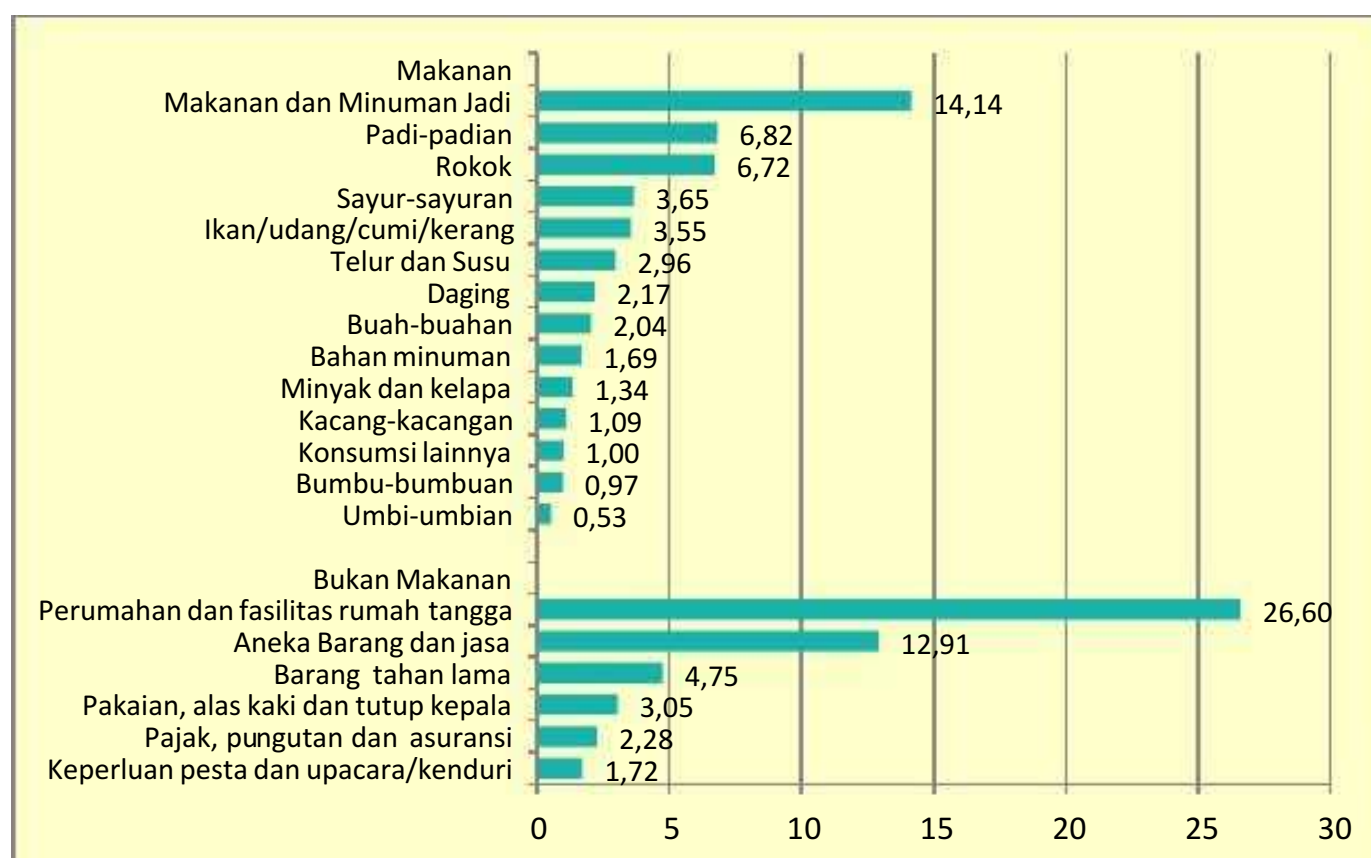
Ukuran yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini/Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai Indeks Gini 0 artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki Indeks Gini yang konstan yaitu sekitar 0,4 dari tahun 2012-2016. Rincian mengenai Indeks Gini dapat dilihat pada Lampiran 1.12.

Pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan

bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum ekonomi (Ernest Engel, 1857) bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian secara umum semakin meningkat pendapatan (kesejahteraan), semakin berkurang persentase pengeluaran untuk makanan.

Pada Gambar 1.9, berdasarkan hasil Susenas Maret 2016, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan (48,68%) masih lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan (51,32%). Tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (26,60%), makanan dan minuman jadi (14,14%) dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (12,91%).

GAMBAR 1.9
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG
TAHUN 2016



Sumber: Pengeluaran Untuk konsumsi Penduduk Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2016
Susenas Maret, 2016

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun hanya penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat

pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Pada Tabel 1.3 menunjukkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2013-2016. Pada periode Agustus 2013 hingga Agustus 2016 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka berfluktuasi yang dapat dilihat pada Tabel 1.3. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 sebesar 120,17 juta orang, meningkat menjadi 125,44 juta orang pada Agustus 2016. Namun terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 66,77% pada Agustus 2013 menjadi 66,34% pada Agustus 2016. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

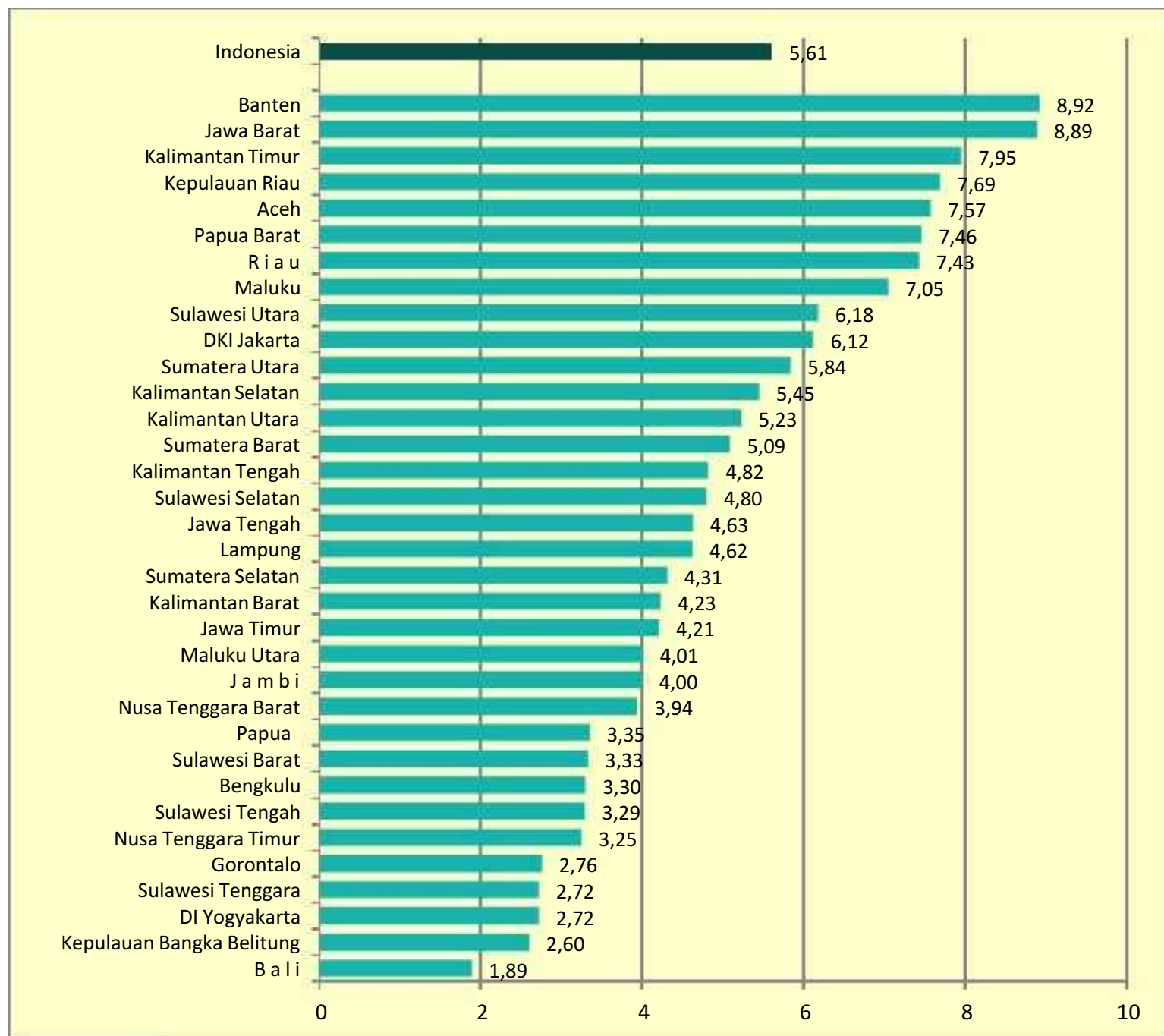
TABEL 1.3
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2013-2016
(JUTA ORANG)

Angkatan Kerja	2013		2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	123,17	120,17	125,32	121,87	128,30	122,38	127,67	125,44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,15	66,77	69,17	66,6	69,50	65,76	68,06	66,34
Jumlah penduduk yang bekerja	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82	120,65	118,41
Jumlah pengangguran terbuka	7,25	7,41	7,15	7,24	7,45	7,56	7,02	7,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,88	6,17	5,7	5,94	5,81	6,18	5,50	5,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Dalam kurun waktu setahun terakhir, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berkurang sekitar 0,53 juta dari 7,56 juta pada Agustus 2015 turun menjadi 7,03 juta pada Agustus 2016. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,61% pada Agustus 2016. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja, atau perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

GAMBAR 1.10
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

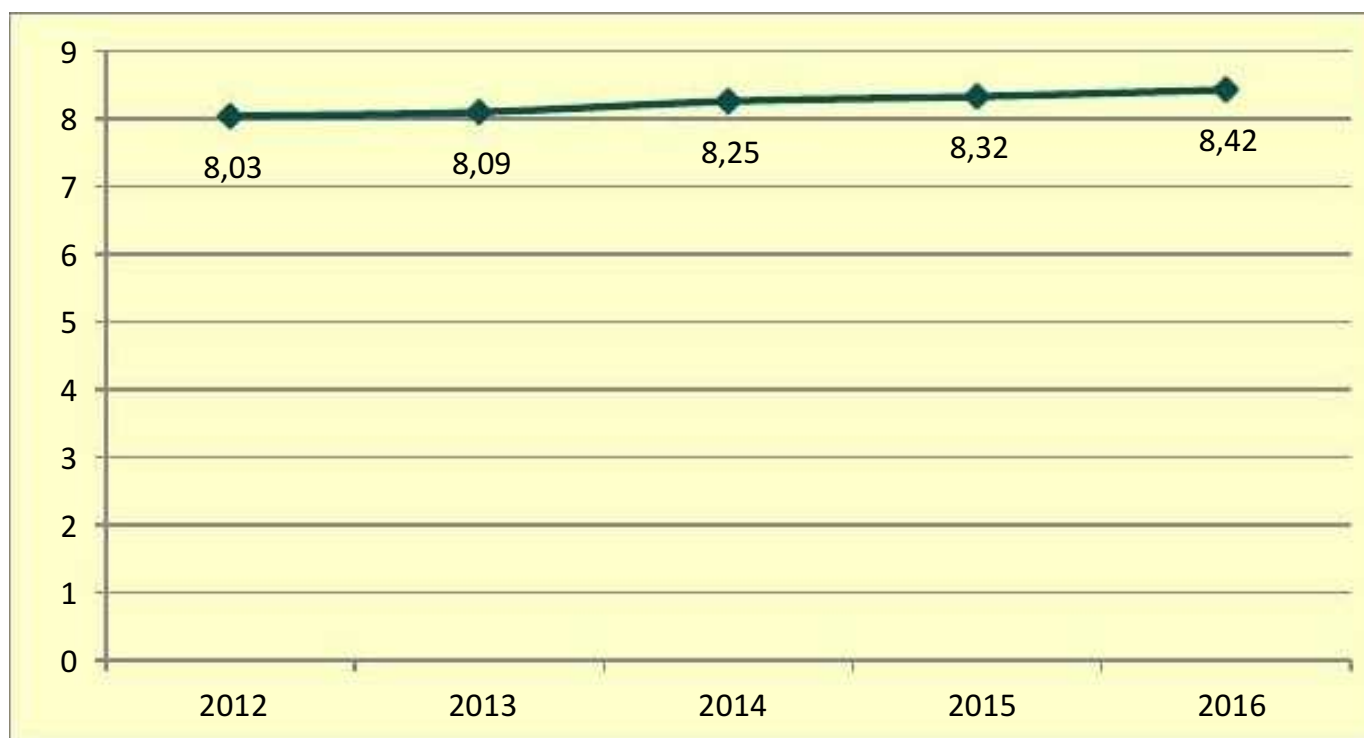
Dari gambar di atas tampak Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan provinsi tahun 2016 yang paling tinggi adalah Banten (8,92%), Jawa Barat (8,89%) dan Kalimantan Timur (7,95%). Sedangkan TPT yang paling rendah adalah Bali (1,89%), Kepulauan Bangka Belitung (2,60%) dan DI Yogyakarta (2,72%), Sulawesi Tenggara (2,72%). Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus

pada perilaku masyarakat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu rata-rata lama sekolah.

GAMBAR 1.11
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS (DALAM TAHUN)
TAHUN 2012 - 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

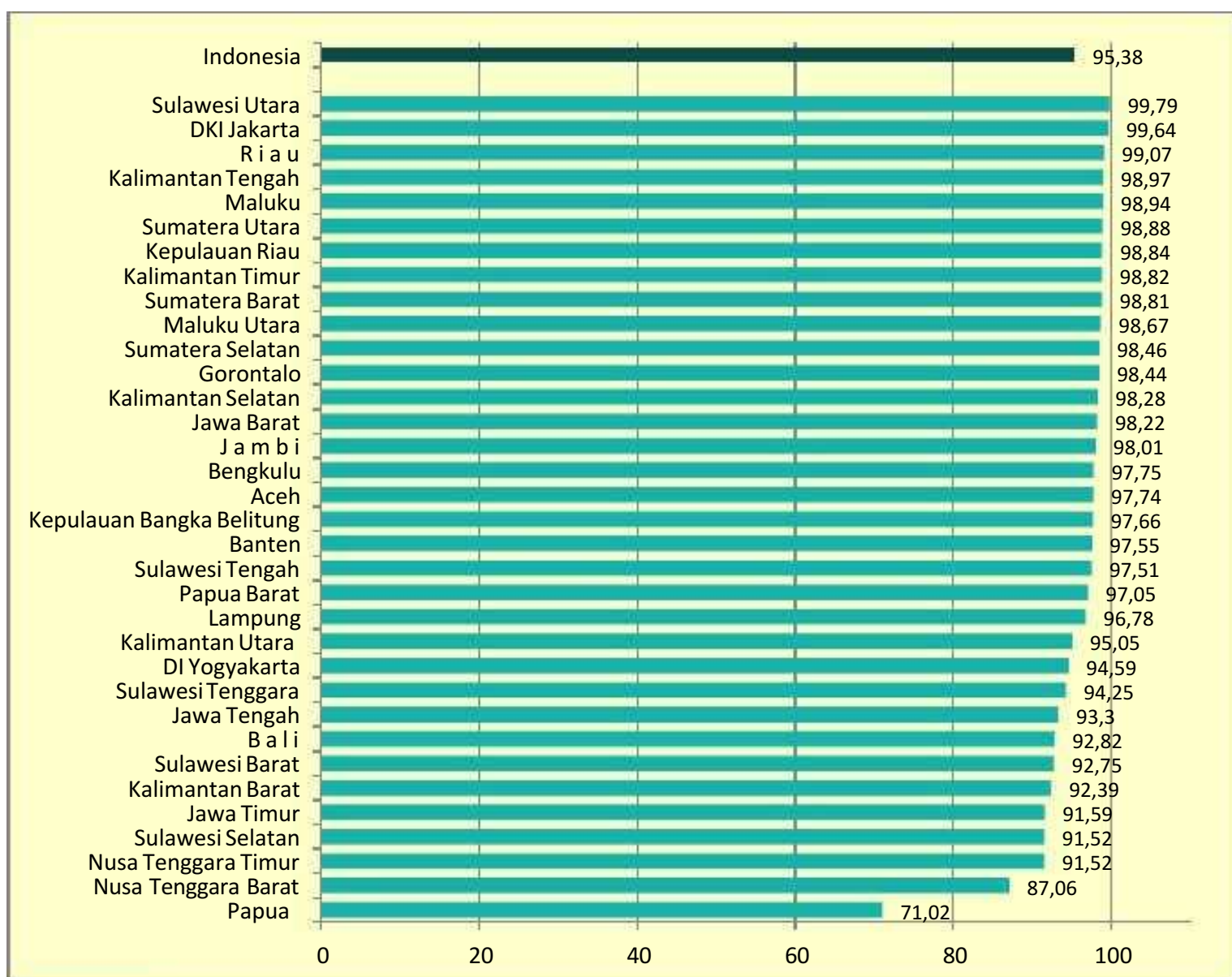
Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas cenderung meningkat, yaitu 8,03 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,42 tahun pada tahun 2016. Namun begitu angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2016, terlihat kecenderungan rata-rata lama sekolah di perkotaan (9,56 tahun) lebih besar dibandingkan di perdesaan (7,18 tahun). Hal ini terkait dengan keberadaan fasilitas sekolah yang lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Menurut jenis kelamin, laki-laki (8,75 tahun) cenderung lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan (8,09 tahun). Sebanyak 10 (sepuluh) provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Maluku, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Rata-rata lama bersekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,48 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,92 tahun. Rincian rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.16.

Hal mendasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera yaitu kemampuan membaca dan menulis. Penduduk yang bisa membaca dan menulis secara umum memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga peluang untuk hidup lebih sejahtera dimiliki oleh penduduk yang bisa membaca dan menulis. Kemampuan

membaca dan menulis tercermin dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH).

ABH menjadi dasar pelaksanaan program pemberantasan buta huruf, dan diharapkan ABH terus menurun. Tahun 2012-2016 ABH cenderung menurun dari 7,03% tahun 2012 menjadi 4,62% pada tahun 2016. Angka Melek Huruf merupakan kebalikan dari Angka Buta Huruf. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. AMH yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat.

GAMBAR 1.12
ANGKA MELEK HURUF (DALAM PERSEN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

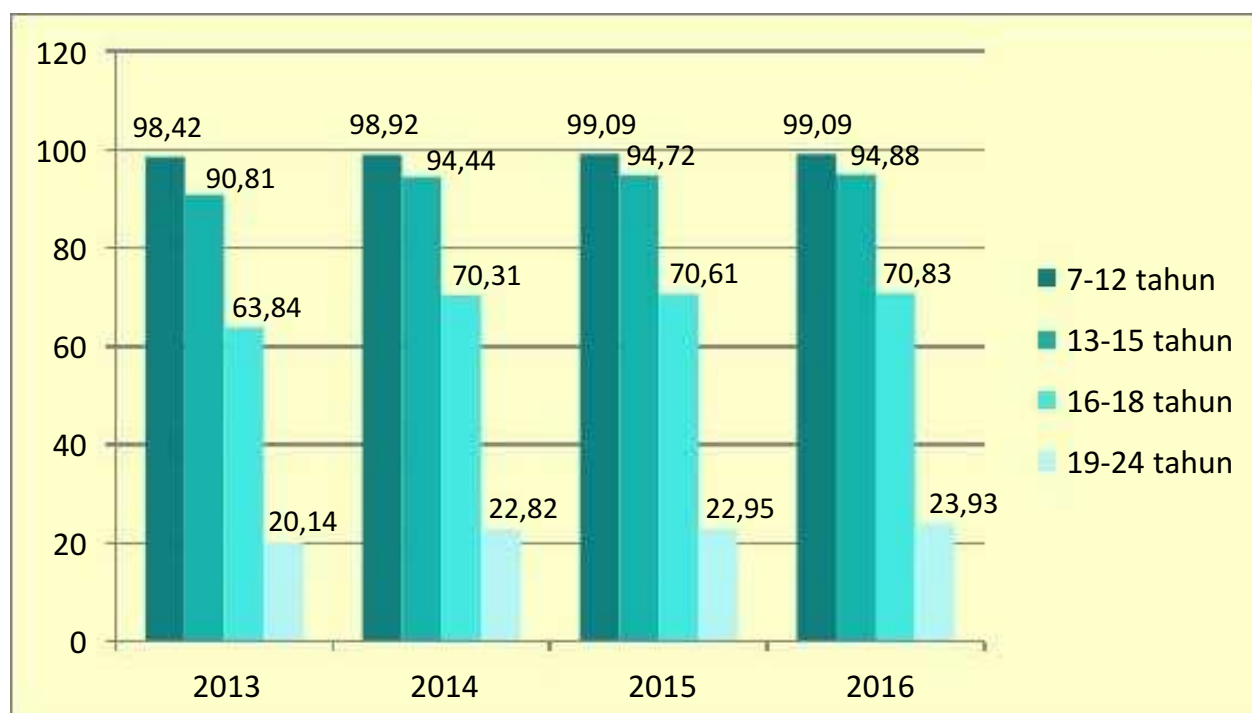
Pada Gambar 1.12, AMH secara nasional tahun 2016 sebesar 95,38%. Provinsi Sulawesi Utara memiliki AMH tertinggi (99,79%) dan terendah di Provinsi Papua (71,02%). Secara umum di 34 provinsi, AMH laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Disparitas AMH antara laki-laki dan perempuan berkisar antara 0,10% sampai dengan 12,12%, terendah di

Provinsi Gorontalo dan tertinggi di Provinsi Papua. Rincian AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.17.

Indikator angka partisipasi merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2013 – 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

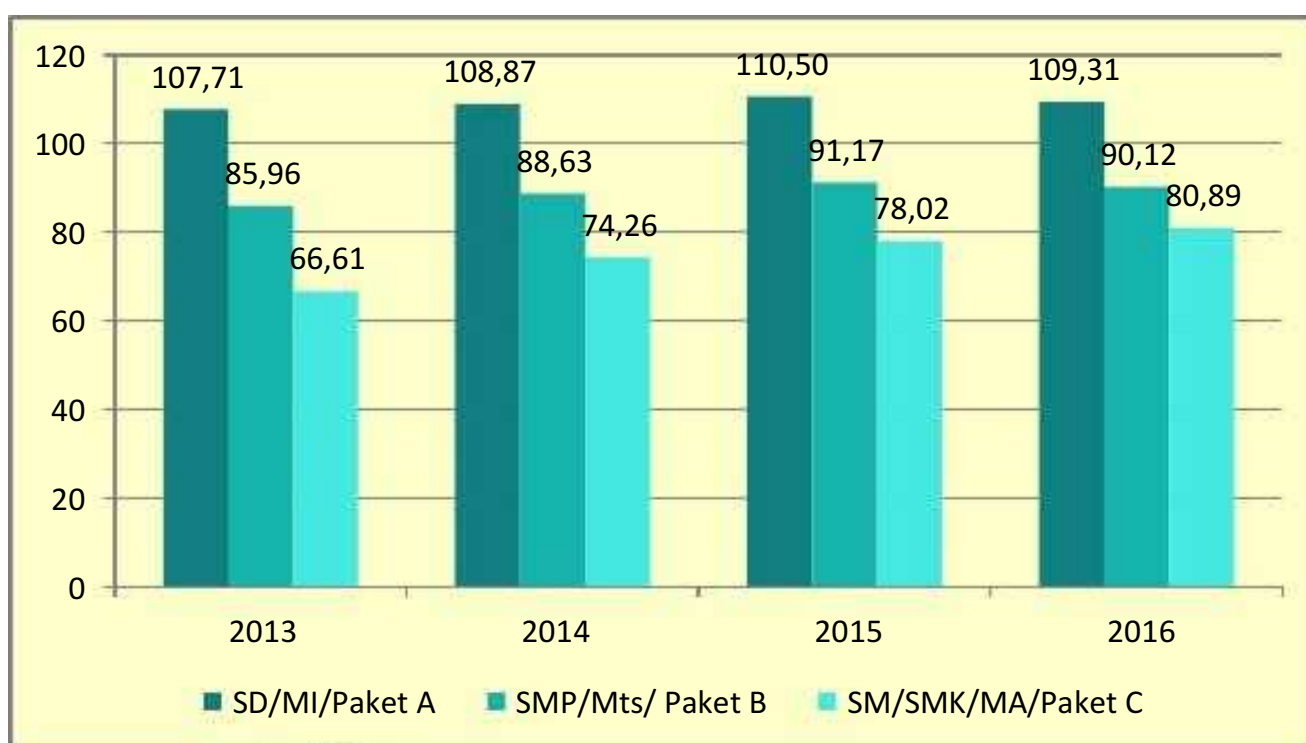
Gambar 1.13 memperlihatkan APS tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 untuk tiap kelompok umur sekolah cenderung meningkat. Semakin tinggi kelompok umur maka tingkat partisipasi sekolahnya semakin kecil, hal ini dimungkinkan pada kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan bekerja. Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun atau kelompok umur SMA/ sederajat, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun juga terjadi dan sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun yang mendahului program wajib belajar 12 tahun. Rincian APS menurut provinsi dan kelompok

umur tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.18, sedangkan rincian APS menurut provinsi, jenis kelamin, dan kelompok umur tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.19.

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Pada Gambar 1.14 diketahui nilai APK untuk SD/MI tahun 2013-2016 melebihi 100 persen yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia dibawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/ sederajat). Dari tahun 2013-2016 APK cenderung mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 nilai APK untuk SD/MI dan SMP/Mts sedikit menurun dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016 nilai APK untuk SD/ sederajat sebesar 109,31%, SMP/ sederajat 90,12%, SMA/ sederajat sebesar 80,89%. Rincian APK menurut provinsi tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.20. Secara umum APK penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki di semua jenjang pendidikan, kecuali SD/ sederajat. Hal ini menunjukan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2016 terdapat pada Lampiran 1.21.

GAMBAR 1.14
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN TAHUN 2013 – 2016

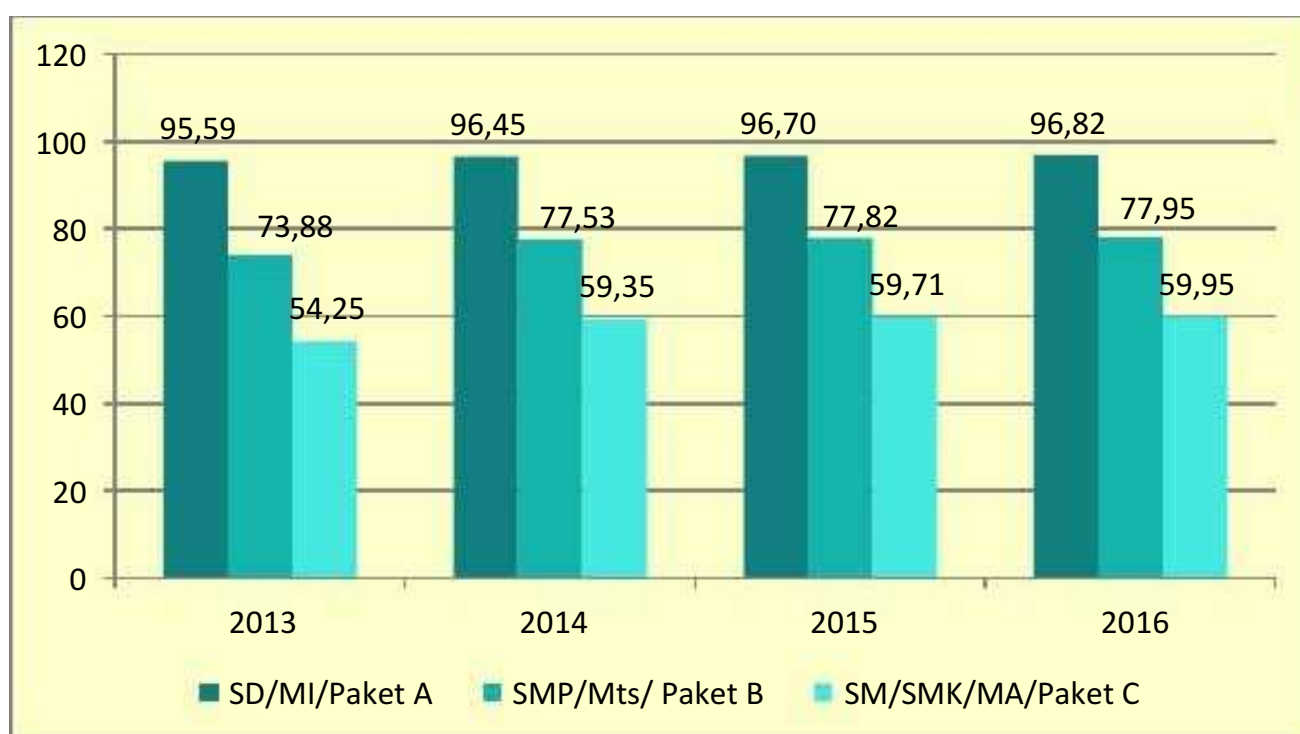


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Pada Gambar 1.15, tahun 2016 nilai APM untuk SD/ sederajat sebesar 96,82%, SMP/ sederajat sebesar 77,95% dan SMA/ sederajat sebesar 59,95%. Kondisi ini terus meningkat pada semua jenjang pendidikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nilai APM lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah dibandingkan nilai APK. Rincian APM menurut provinsi tahun 2013-2016 terdapat pada Lampiran 1.22.

GAMBAR 1.15
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2013 – 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

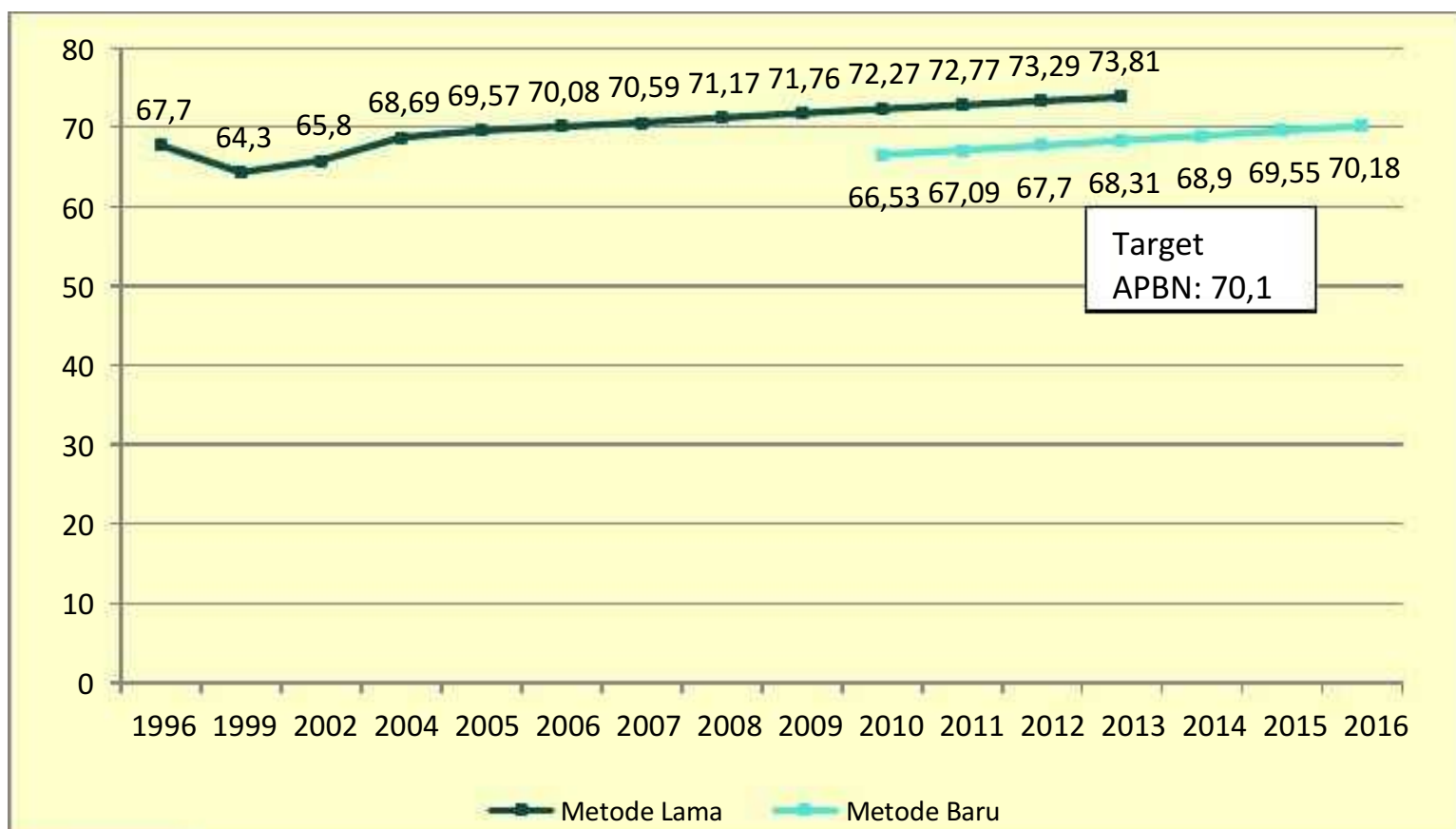
Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan) digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan

gabungan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, digunakan indikator Kemampuan Daya Beli (*purchasing power parity*) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (PDB).

Pada tahun 2014 terjadi perubahan metodologi IPM. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dengan metode lama (1996-2013) maupun dengan metode baru (2010-2016). Dengan metode baru selama periode 2010-2016, nilai IPM Indonesia telah meningkat 3,65 poin, yaitu dari 66,53 tahun 2010 menjadi 70,18 pada tahun 2016. Bila dilihat berdasarkan target APBN, yang menargetkan IPM sebesar 70,1 sudah melampaui target (IPM 2016=70,18). Akselerasi yang tinggi diduga merupakan salah satu penyebab terlampauinya target APBN tersebut. Pada tahun 2016, IPM Indonesia tumbuh 0,91% atau bertambah 0,63 poin dibandingkan IPM tahun 2015.

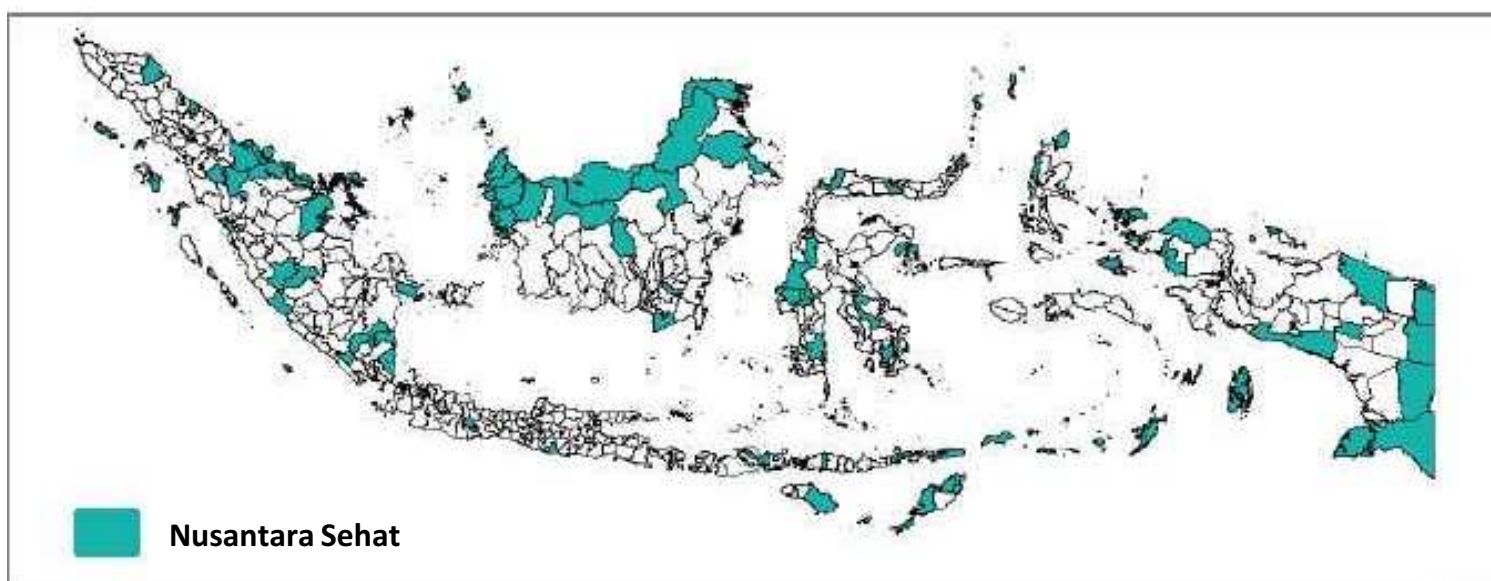
GAMBAR 1.16
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) INDONESIA TAHUN 1996 - 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Pertumbuhan IPM yang tinggi pada tahun 2016 didorong oleh peningkatan semua indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2016, indeks pendidikan mencapai 61,83 atau meningkat 0,83 poin dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan indeks standar hidup

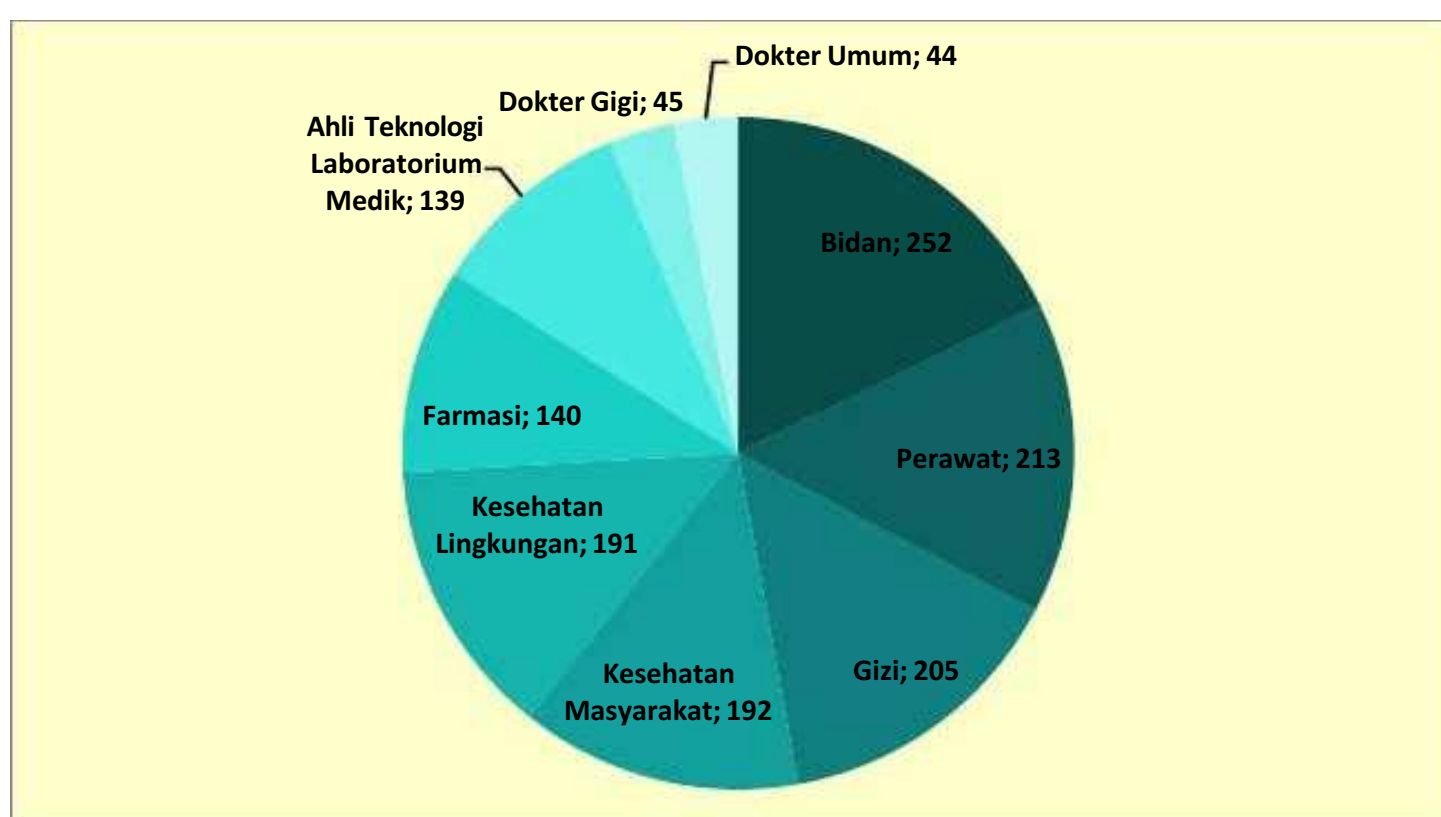
GAMBAR 3.25
KABUPATEN/KOTA PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT TAHUN 2016



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2017

Sampai dengan tahun 2016, telah dilaksanakan penugasan khusus berbasis tim dengan lima periode keberangkatan. Periode pertama dan kedua dilaksanakan pada tahun 2015 dengan penempatan di 120 puskesmas. Periode ketiga sampai dengan kelima dilaksanakan pada tahun 2016 dengan penempatan di 131 puskesmas. Total penempatan sampai dengan tahun 2016 adalah 28 provinsi, 91 kabupaten/kota, dan 251 puskesmas. Rincian lengkap mengenai penempatan Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 3.21 dan 3.22.

GAMBAR 3.26
JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT TAHUN 2016



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2017

Jenis tenaga yang paling banyak diberangkatkan yaitu bidan (17,7%) dan perawat (15%). Provinsi dengan jumlah penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim terbanyak adalah NTT yaitu 212 orang. Provinsi dengan jumlah penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim paling sedikit adalah Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat yaitu 5 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 3.23.

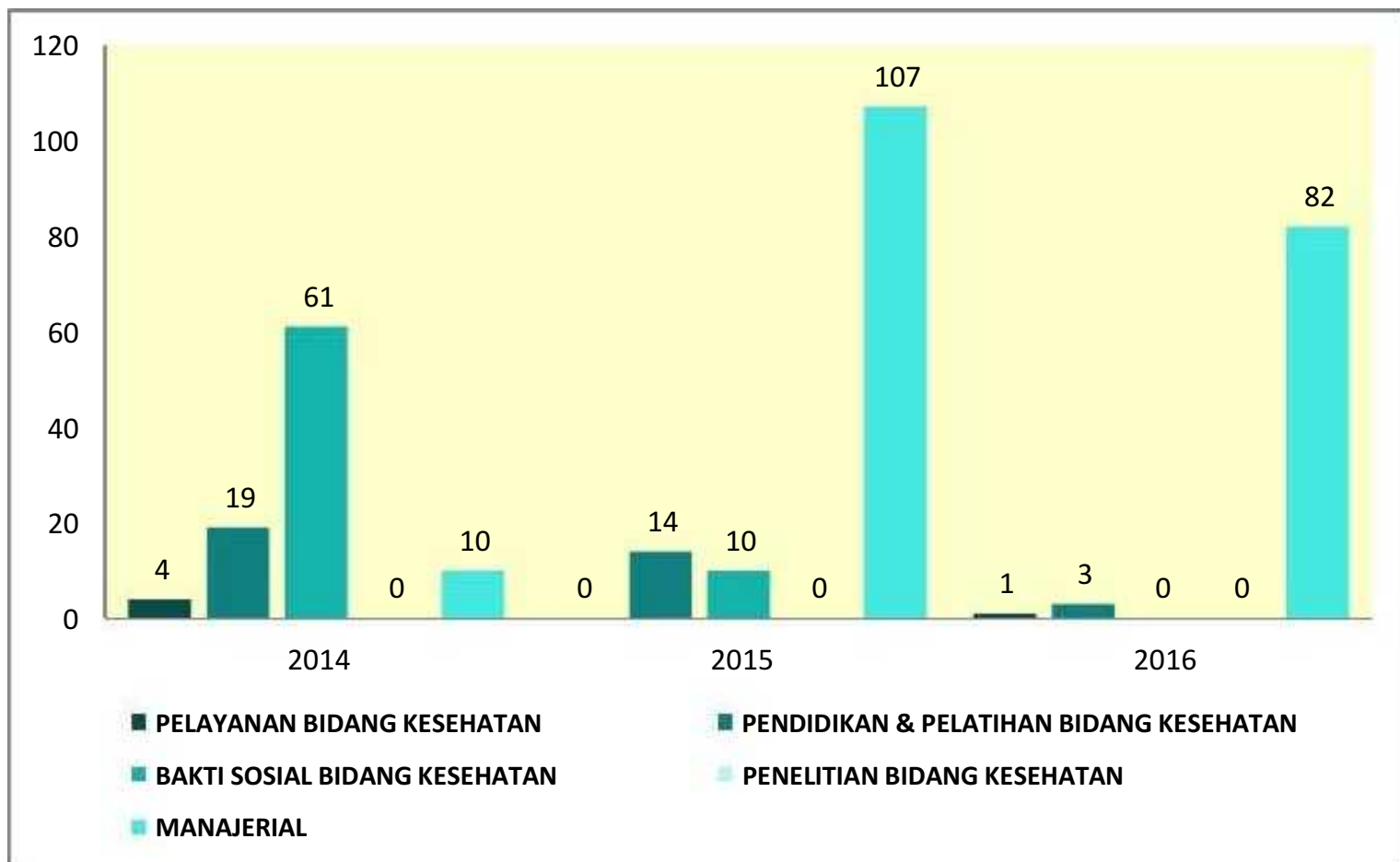
3. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA)

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Regulasi tersebut mengatur persyaratan dan tata cara mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing dalam koridor alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 4 bidang kegiatan yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, bakti sosial kesehatan dan penelitian kesehatan. Dalam hal pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK WNA) bidang manajerial di fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015, yang saat ini sedang dirancang untuk ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan.

Semua tenaga kerja asing termasuk tenaga kesehatan warga negara asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA kepada Kementerian Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Menteri melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan menugaskan Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan SDMK WNA yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan rekomendasi yang diajukan.

TKWNA yang melakukan kegiatan pendayagunaan bersentuhan dengan pasien harus mengikuti evaluasi kompetensi meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan. Setelah lulus evaluasi kompetensi maka diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara (STRS) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk satu tahun berikutnya.

GAMBAR 3.27
TREN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGAJUAN/ PERPANJANGAN
RPTKA DAN IMTA BAGI SDM WNA TAHUN 2014 – 2016



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2017

Tren permohonan rekomendasi pengajuan atau perpanjangan RPTKA dan IMTA bagi SDM WNA yang akan bekerja di Indonesia dalam lima jenis kegiatan mengalami penurunan di tahun 2016. Pada tahun 2015 sejumlah 131 orang dengan rincian kegiatan pendayagunaan meliputi bakti sosial kesehatan sebesar 10 orang dan manajerial sebesar 107 orang sedangkan di tahun 2016 sejumlah 86 orang dengan rincian kegiatan pendayagunaan meliputi pelayanan kesehatan sebesar 1 orang dan manajerial sebesar 82 orang. Jika melihat rincian kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun tren pendayagunaan SDM WNA mengalami penurunan, akan tetapi permohonan pendayagunaan SDM WNA dalam kegiatan manajerial kesehatan masih dalam jumlah yang besar.

Pendayagunaan SDM WNA dalam kegiatan manajerial kesehatan banyak yang tidak sesuai perijinannya yaitu dengan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dan penting sekali dilakukan kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendayagunaan SDM WNA serta sinergitas sektor kesehatan dan lintas sektor lainnya dalam perijinan maupun pemantauan/pengawasan SDM WNA di Indonesia. Rincian lengkap mengenai jumlah permohonan rekomendasi pengajuan atau perpanjangan RPTKA dan IMTA bagi SDM WNA dapat dilihat di Lampiran 3.24.

BAB IV

PEMBIAYAAN KESEHATAN



BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

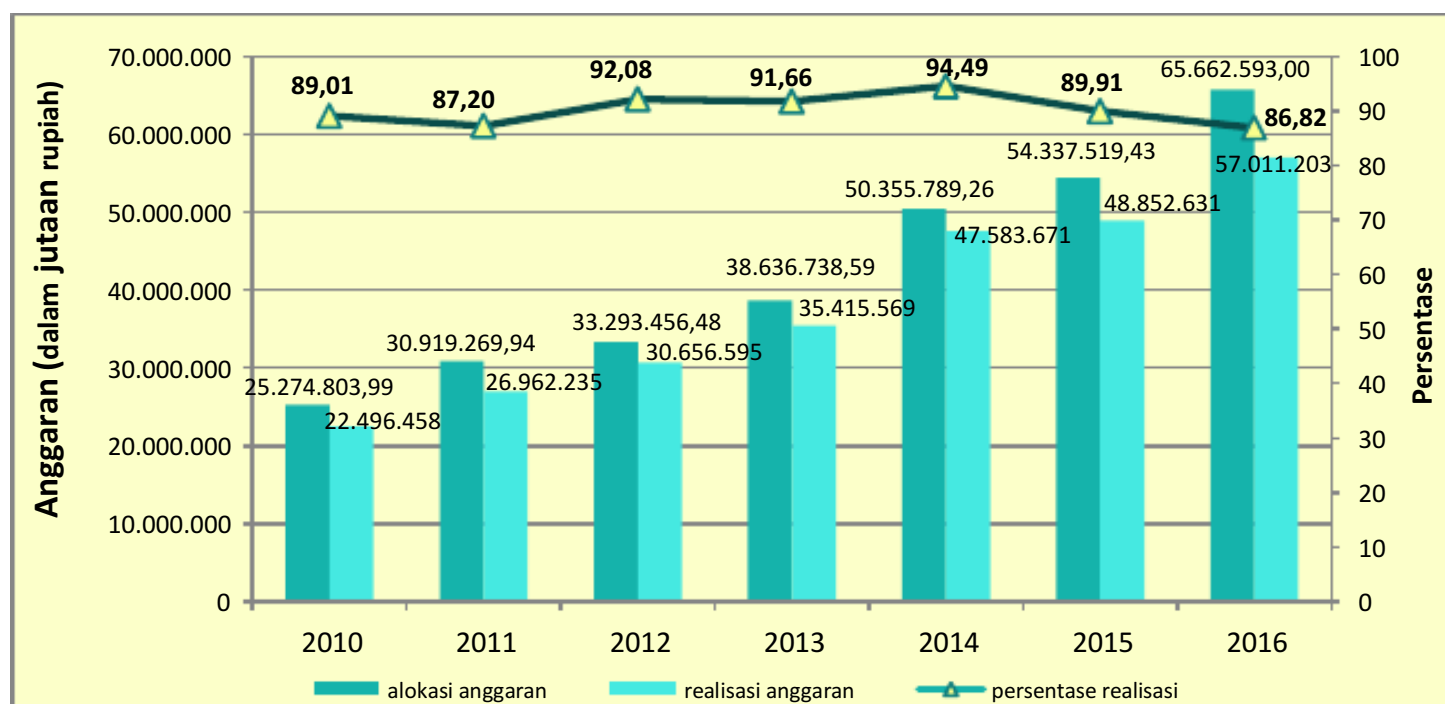
Salah satu sub sistem dalam kesehatan nasional adalah sub sistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Anggaran kesehatan adalah anggaran kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,66 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 57,01 trilyun rupiah. Besar alokasi maupun realisasi anggaran tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, yaitu alokasi sebesar 54,33 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 48,85 trilyun rupiah. Namun demikian, jika dilihat dari persentase realisasi tahun sebelumnya, angkanya mengalami penurunan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 sebesar 86,82%, turun dari tahun 2015 yang sebesar 89,91%.

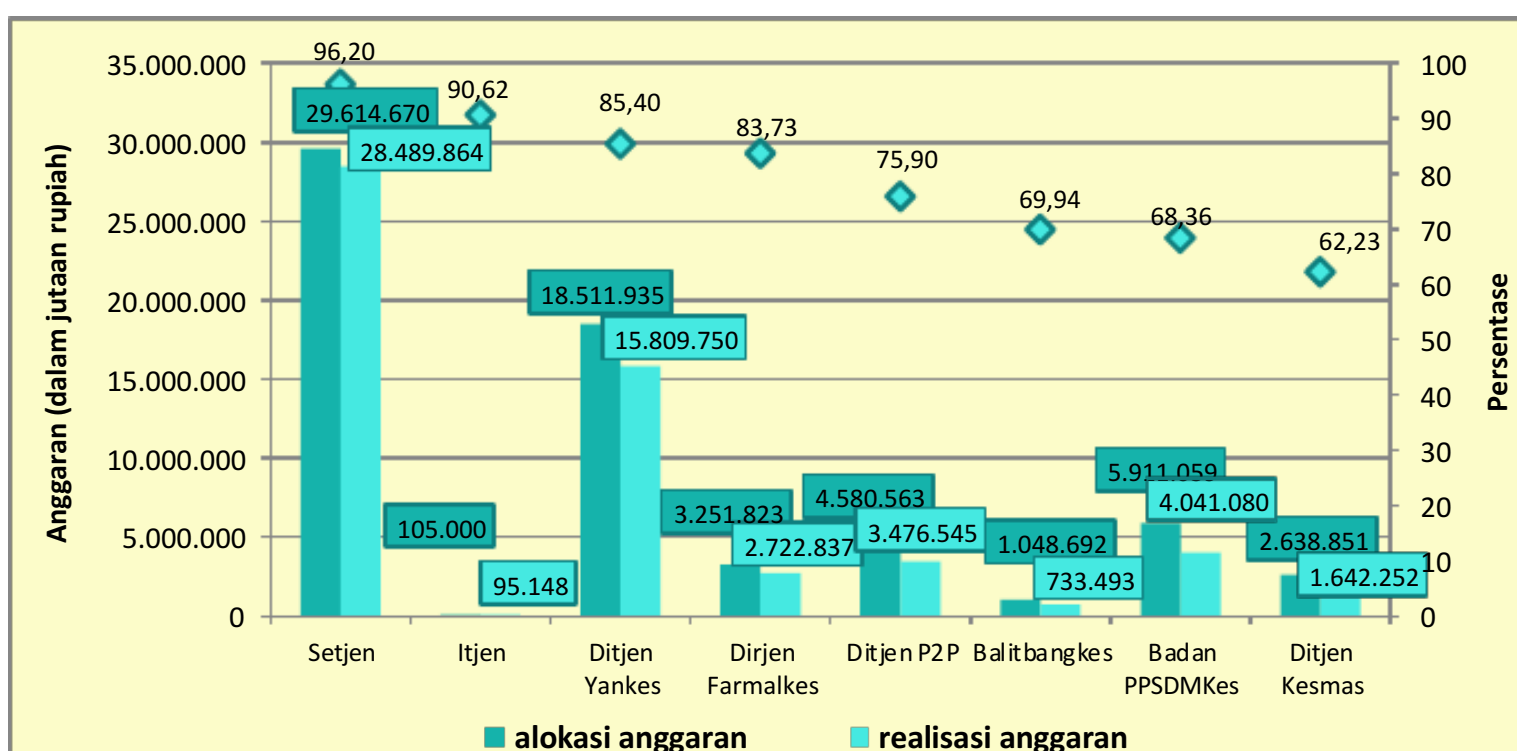
GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2016



Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2017

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2010 Kementerian Kesehatan RI memiliki alokasi anggaran sebesar 25,27 trilyun rupiah dengan realisasi 22,49 trilyun rupiah dan persentase realisasi sebesar 89,01%, jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2016 menjadi 65,66 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 57,01 trilyun rupiah dan persentase realisasi sebesar 86,82%. Akan tetapi untuk persentase realisasi terus menurun dari 94,49% pada tahun 2014 menjadi 86,62% pada tahun 2016.

GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2016

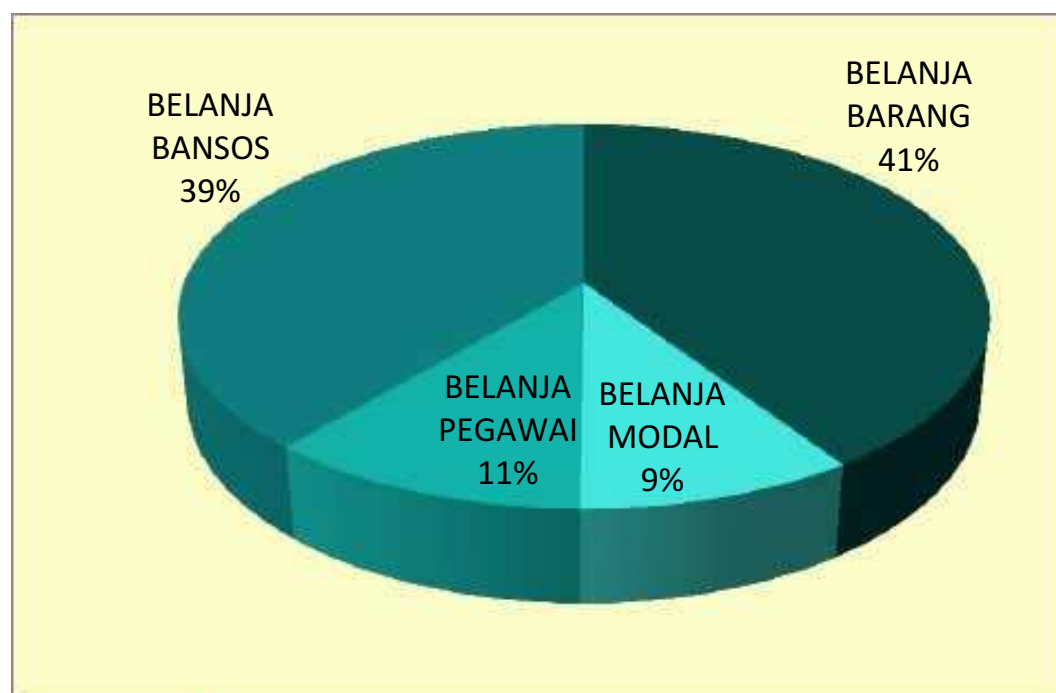


Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2017

Distribusi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit kerja eselon I menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 29,6 trilyun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 105 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 96,20%, sedangkan realisasi terendah adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) dengan persentase realisasi sebesar 62,23%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit eselon I pada tahun 2016 terdapat pada Lampiran 4.3.

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang sebesar 65,66 trilyun rupiah, sebanyak 25,50 trilyun rupiah atau sebesar 38,8% nya merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran belanja bantuan sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Selain itu, 41% anggaran Kementerian Kesehatan lainnya dialokasikan untuk belanja barang, 11% lainnya merupakan belanja pegawai, dan sisanya sebesar 9% digunakan untuk belanja modal.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN 2016



Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2017

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sesuai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK No. 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK No. 248/PMK.07 untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/ prioritas nasional, serta meningkatkan peran provinsi dalam kerangka *good*

governance dalam mengawal pelaksanaan program kementerian/lembaga (K/L) di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Prinsip pendanaan dekonsentrasi adalah untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Sifat kegiatan yang didanai ialah kegiatan non-fisik seperti sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Proses penganggaran dana dekonsentrasi ini melalui beberapa tahap/mekanisme, diantaranya adalah : penetapan pagu alokasi dana dekonsentrasi pada masing-masing pemerintah daerah (dalam hal ini dinas kesehatan provinsi) oleh satuan kerja (satker) pengampu program di tingkat pusat; pengajuan usulan kegiatan oleh dinas kesehatan provinsi dengan mengacu pada menu dekonsentrasi yang telah ditetapkan sebelumnya; dan pemeriksaan terhadap usulan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit pusat terkait. Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan hanya bisa dialokasikan kepada dinas kesehatan provinsi, yang selanjutnya dikelola untuk membiayai kegiatan non fisik yang dimungkinkan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota. Data dan informasi lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi dana dekonsentrasi pada tahun 2016 disajikan pada Lampiran 4.4.

Pagu dan realisasi dana dekonsentrasi kesehatan menurut provinsi tahun 2016 disajikan pada Gambar 4.4. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi paling rendah terdapat pada Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 39,25%, realisasi terendah ke dua yaitu Provinsi Maluku (43,56%). Sedangkan provinsi yang realisasinya paling tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 75,68%. Masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dekonsentrasi pada beberapa provinsi, termasuk di dalamnya analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi itu sendiri.

Berdasarkan Permenkes Nomor 82 Tahun 2015, Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub bidang Sarana Prasarana (Sarpras) Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2016. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

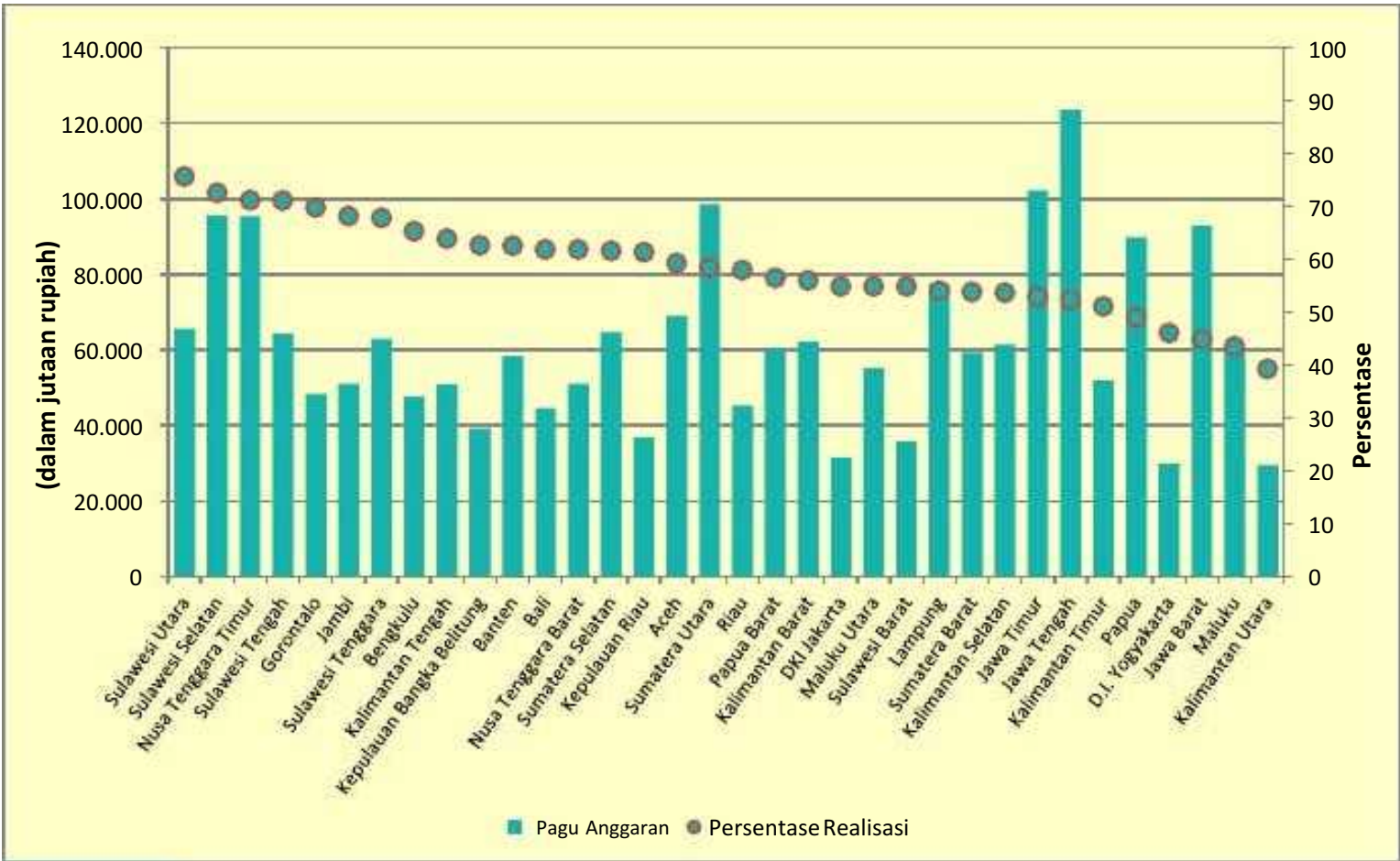
- a. dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan;
- b. dana alokasi khusus fidik reguler sarana dan prasarana penunjang sub bidang sarana dan prasarana kesehatan
- c. dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan.

Alur pelaporan DAK bidang kesehatan dilaporkan secara berjenjang mulai dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten/kota, kemudian dilaporkan ke dinas kesehatan provinsi, lalu terakhir dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Laporan dikirimkan secara berjenjang, dengan batas waktu pengiriman sebagai berikut.

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada dinas kesehatan provinsi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Kementerian Kesehatan, setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Selain itu Kepala SKPD (dinas kesehatan kabupaten/kota dan RS kabupaten/kota) menyampaikan laporan triwulan kepada dinas kesehatan provinsi lalu kemudian menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di kabupaten/kota kepada Menteri Kesehatan.

Pada tahun 2016, alokasi DAK non fisik 2016 sebesar Rp 3.344.147.265.400 dengan realisasi sebesar Rp 1.538.763.186.509. Sedangkan alokasi untuk DAK fisik bidang kesehatan tahun 2016 sebesar Rp 6.755.304.980.692.

GAMBAR 4.4
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2017

C. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, di antaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah pusat memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan pemerintah daerah dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi atau terbagi-bagi, sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program JKN.

JKN diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Manfaat JKN terdiri atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulans. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan yang meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat; imunisasi dasar yang meliputi *Bacille Calmett Guerin* (BCG), *Difteri Pertusis Tetanus* dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak; keluarga berencana yang meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi; skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit

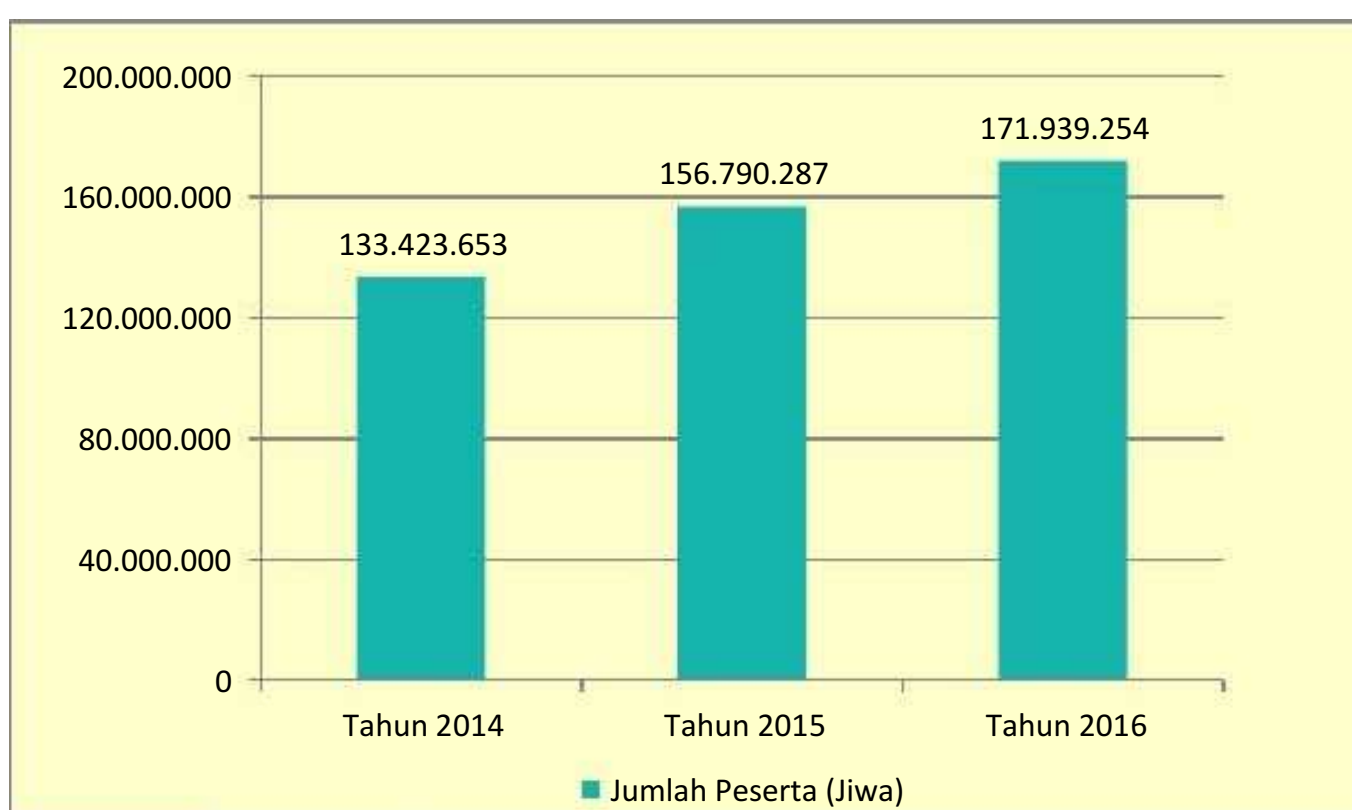
dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, peserta dalam program JKN meliputi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas dua kelompok yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan adalah pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Kepersertaan program JKN yang dimulai pada 1 Januari 2014 terdiri dari peserta PBI JKN (pengalihan dari program Jamkesmas), anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, anggota POLRI dan PNS di lingkungan POLRI dan anggota keluarganya, peserta asuransi kesehatan sosial dari PT. Askes (Persero) beserta anggota keluarganya, peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek dan anggota keluarganya, peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang telah berintegrasi, dan peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah).

Sampai dengan Desember 2016, cakupan kepesertaan program JKN berjumlah 171.939.254 peserta. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan meningkat sebesar 22,40% yaitu dari 133.423.653 jiwa pada tahun 2014 menjadi 171.939.254 jiwa pada tahun 2016.

GAMBAR 4.5
PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN
TAHUN 2014 -2016



Sumber : BPJS Kesehatan, 2017

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

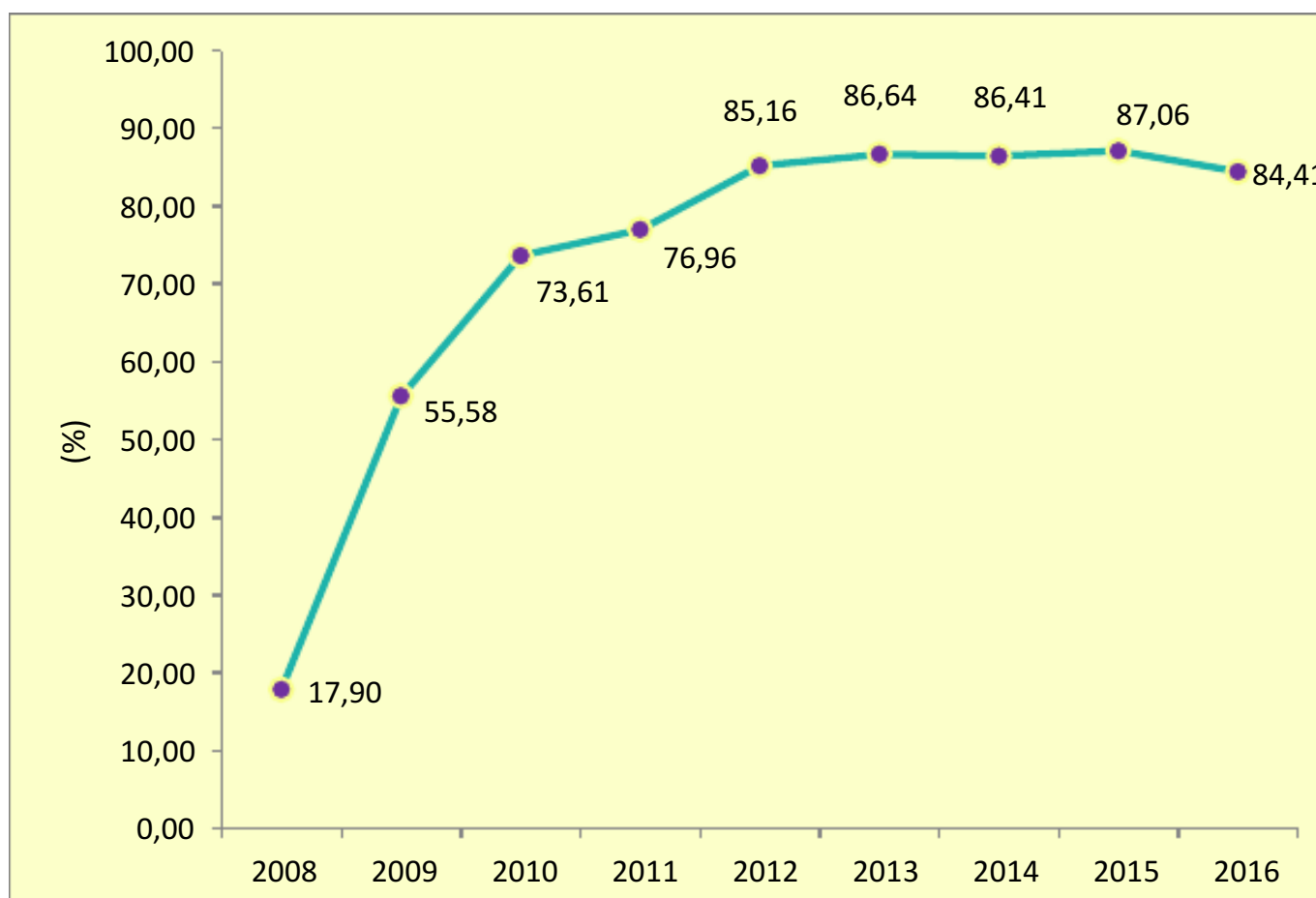
Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.

Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari :

- a) pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
- b) pemeriksaan tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
- c) pemeriksaan lochia dan cairan *per vaginam* lain;
- d) pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
- e) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;
- f) pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Gambar berikut menyajikan cakupan kunjungan nifas di Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

GAMBAR 5.7
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2016

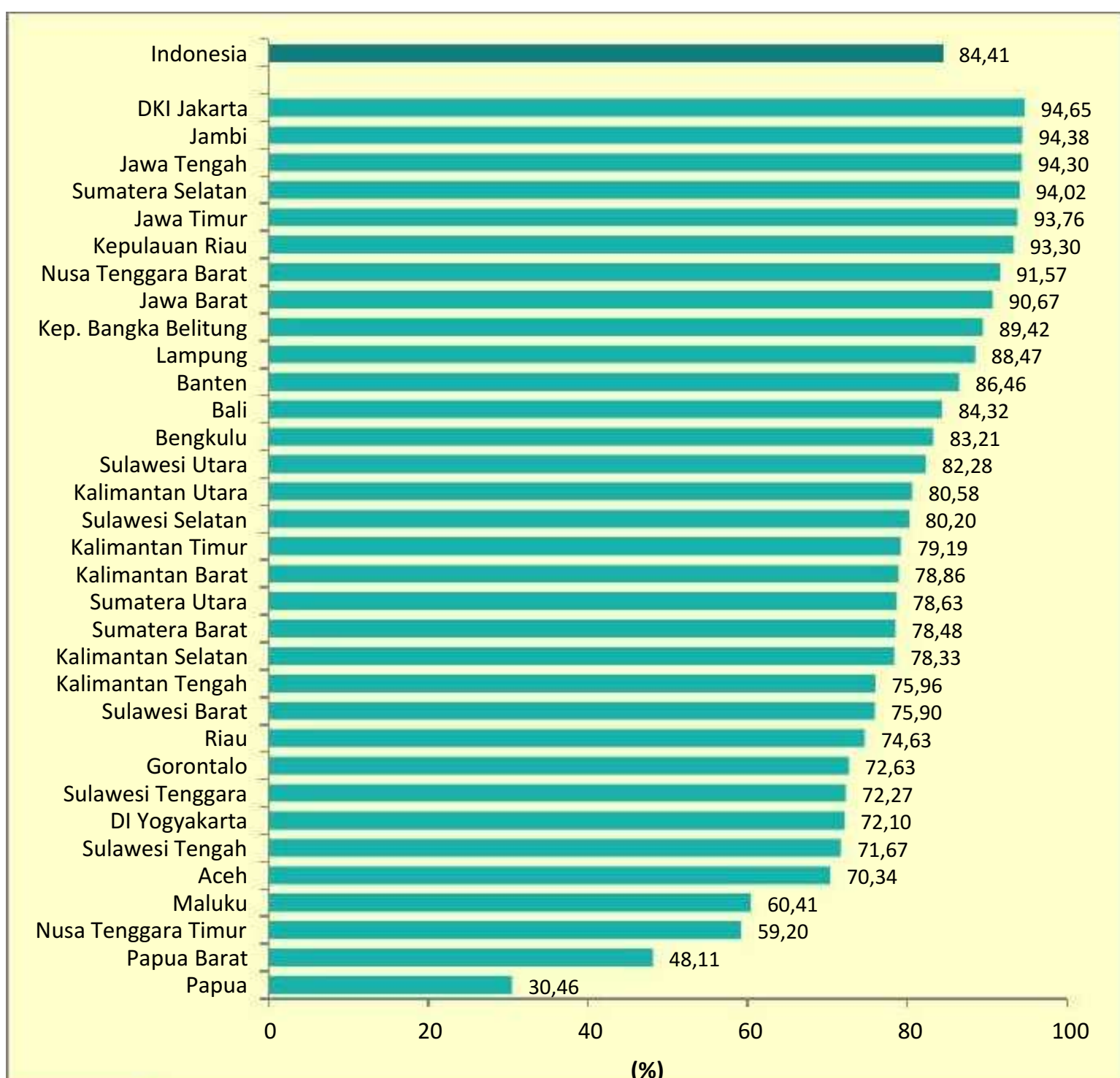


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Namun demikian nampak adanya penurunan cakupan KF3 pada tahun 2016, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya faktor, yaitu penetapan sasaran kabupaten/kota terlalu tinggi, kondisi geografi yang sulit di beberapa wilayah, belum optimalnya koordinasi dan pelaporan antar kabupaten/kota dan provinsi, dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pada saat nifas.

Capaian kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 94,65%, yang diikuti oleh Jambi sebesar 94,38%, dan Jawa Tengah sebesar 94,3%. Sedangkan provinsi dengan cakupan kunjungan nifas terendah yaitu Papua sebesar 30,46%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 48,11%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 59,2%. Data dan informasi lebih rinci mengenai pelayanan ibu nifas tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

5. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

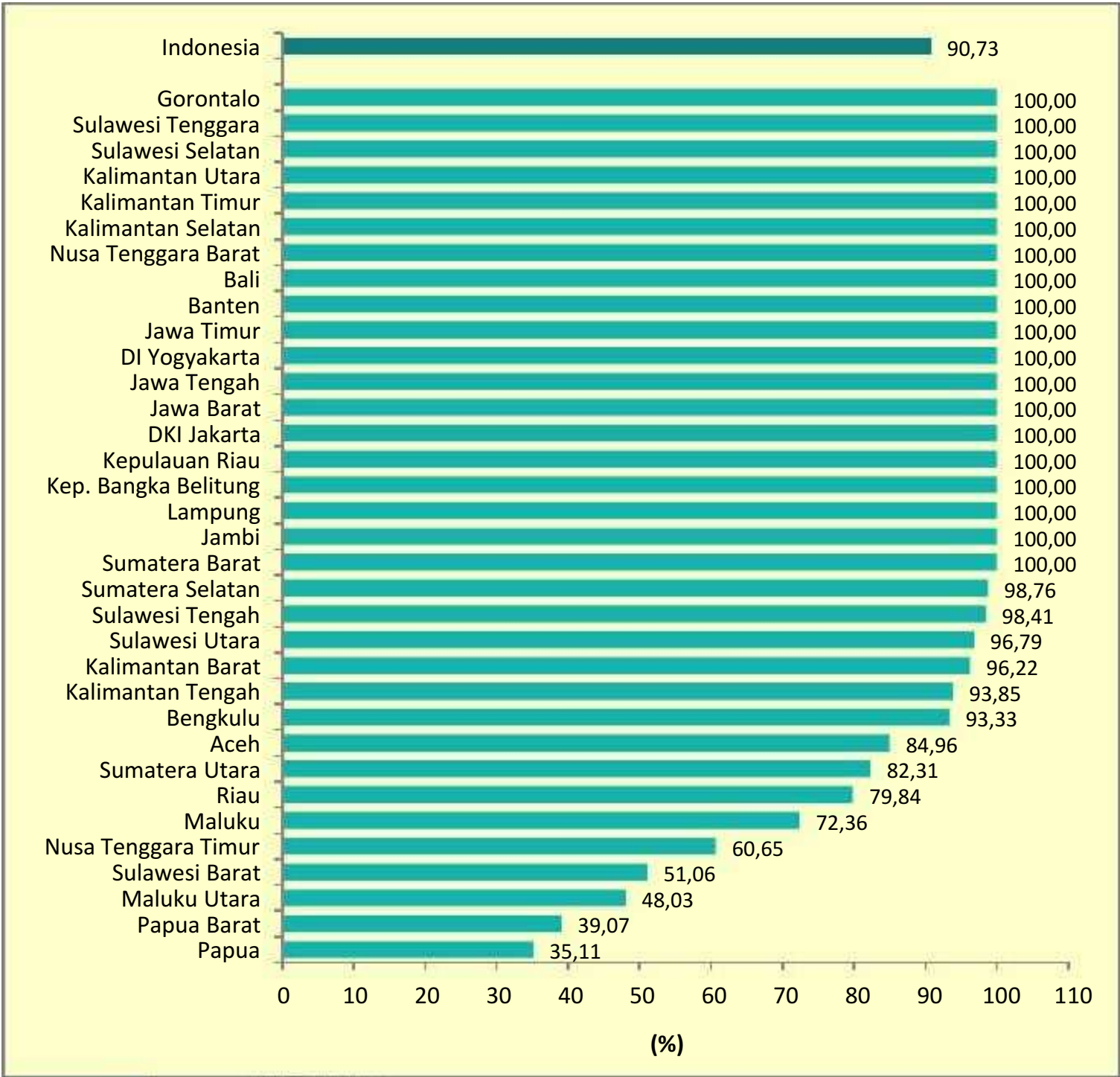
Sebagai upaya menurunkan kematian ibu dan kematian anak, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan persentase puskesmas melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

Kelas ibu hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil.

Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini ibu-ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu Buku KIA, *Flip Chart* (lembar balik), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, dan Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Hamil.

Cakupan ini didapatkan dengan menghitung puskesmas yang telah melaksanakan dibandingkan dengan seluruh puskesmas di wilayah kabupaten/kota. Puskesmas dikatakan telah melaksanakan apabila telah melakukan kelas ibu hamil sebanyak 4 kali.

GAMBAR 5.9
PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

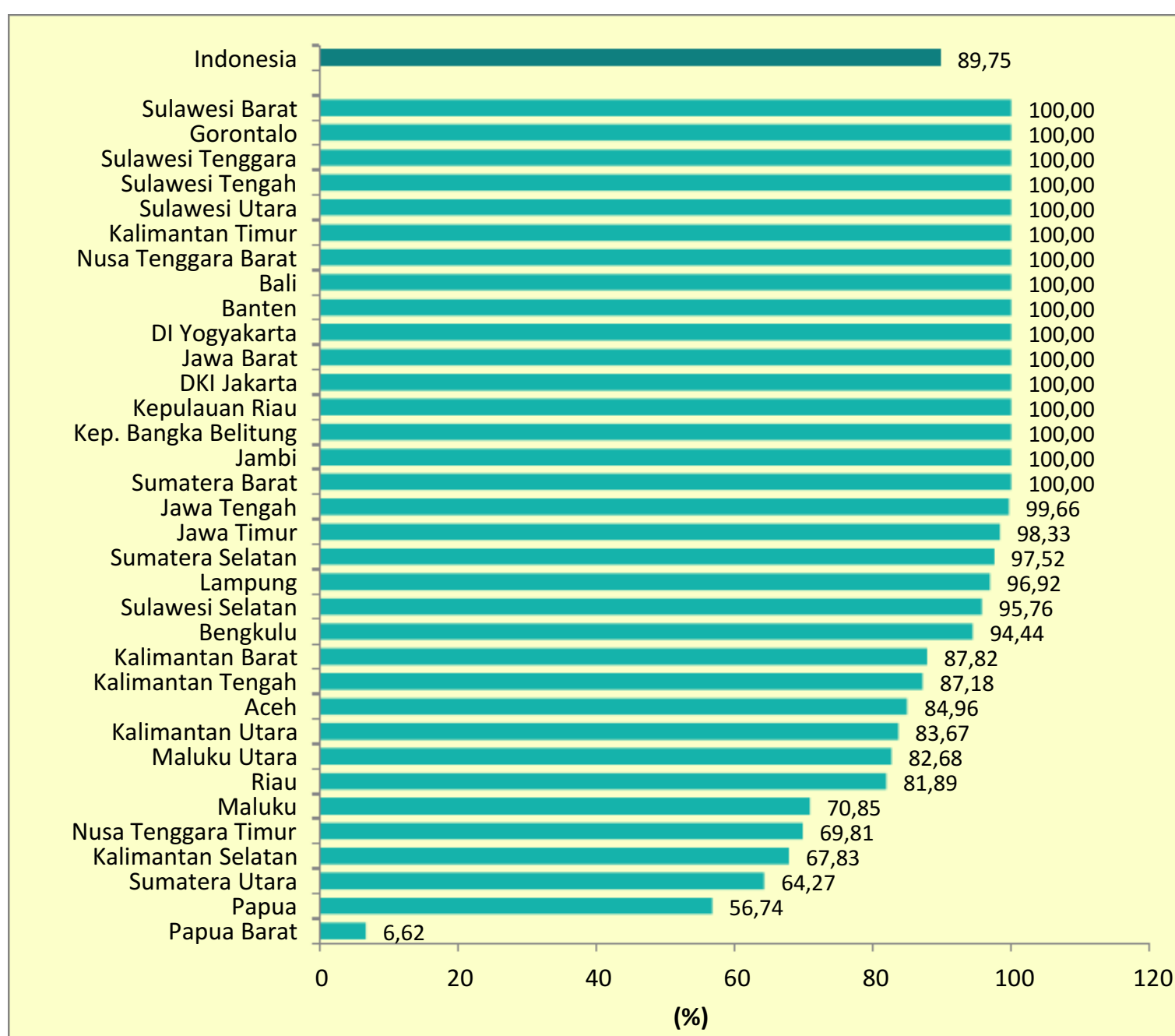
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa 19 Provinsi sudah mencapai capaian 100%. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Papua sebesar 35,11%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 39,07%, dan Maluku Utara sebesar 48,03%. Data dan informasi lebih rinci mengenai puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dapat dilihat pada Lampiran 5.2.

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan suatu program yang dijalankan untuk mencapai target penurunan AKI yaitu menekan angka kematian ibu melahirkan. Program ini menitikberatkan fokus totalitas monitoring terhadap ibu hamil dan bersalin.

Dalam pelaksanaan P4K, bidan diharapkan berperan sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasif dan setara di wilayah kerjanya agar dapat terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Indikator Puskesmas melaksanakan orientasi P4K menghitung Persentase Puskesmas yang melaksanakan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Adapun yang dimaksud orientasi tersebut adalah Pertemuan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan mengundang kader dan/ atau bidan desa dari seluruh desa yang ada di wilayahnya dalam rangka pembekalan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, ibu hamil serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.

GAMBAR 5.10
PUSKESMAS MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa 16 Provinsi sudah mencapai capaian 100%. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Papua Barat sebesar 6,62%, diikuti oleh Papua sebesar 56,74%, dan Sumatera Utara sebesar 64,27%. Data dan informasi lebih rinci mengenai puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dapat dilihat pada Lampiran 5.2.

6. Pelayanan Kontrasepsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

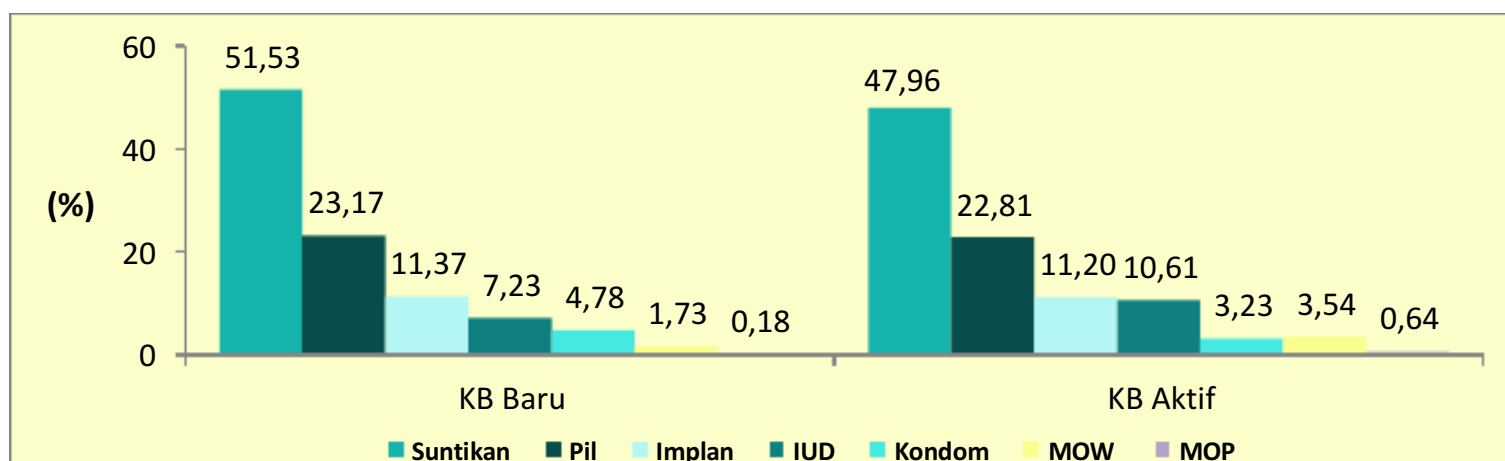
KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T yaitu Terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), Terlalu sering melahirkan, Terlalu dekat jarak melahirkan, dan Terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak.

Melalui tahapan konseling pelayanan KB, Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, serta risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. Untuk selanjutnya, diharapkan Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan benar.

Pengertian Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB dibagi menjadi dua yaitu Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

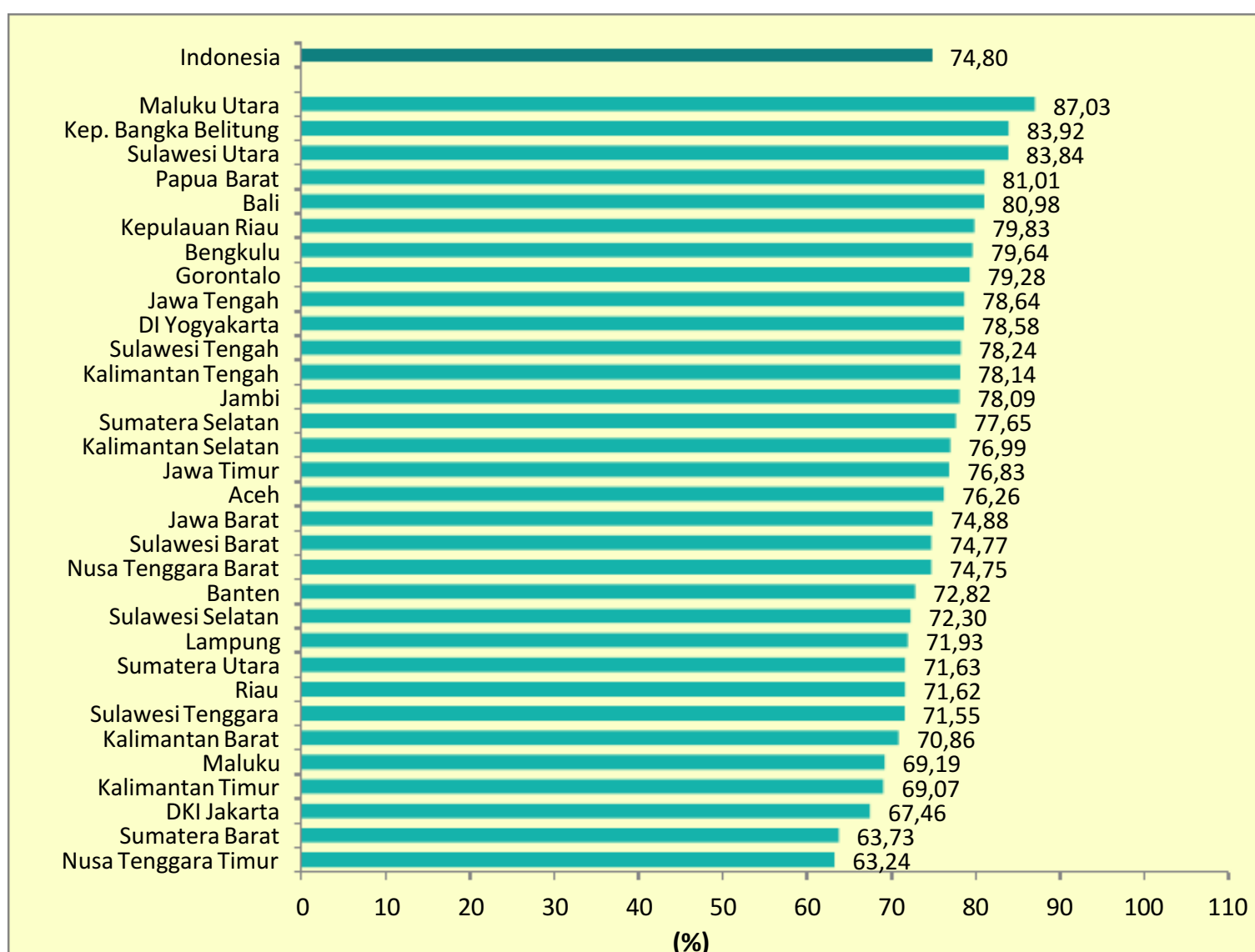
GAMBAR 5.11
CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2016



Sumber : Statistik Rutin Desember 2016, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017

Peserta KB Baru dan KB Aktif menunjukkan pola yang sama dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi seperti yang disajikan pada gambar di atas. Sebagian besar Peserta KB Baru maupun Peserta KB Aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat efektifitas suntikan dan pil dalam pengendalian kehamilan dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya.

GAMBAR 5.12
CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2016

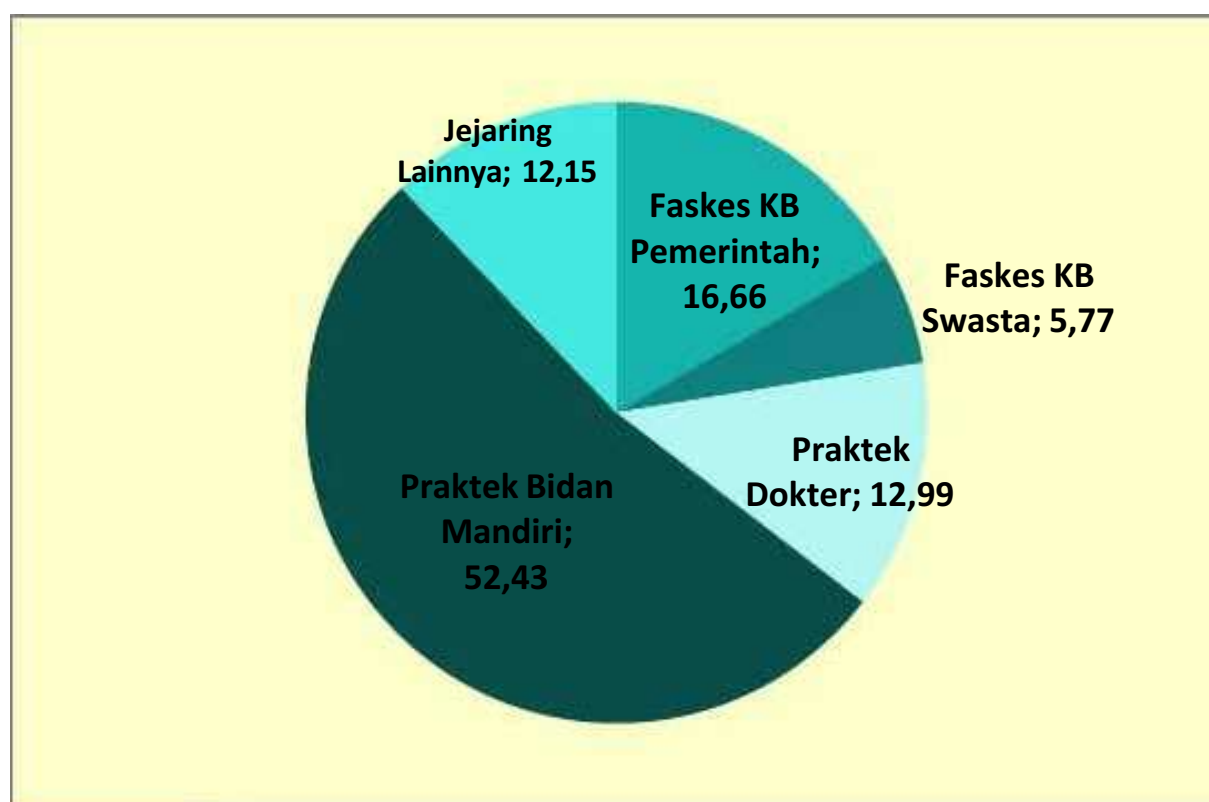


Sumber: Statistik Rutin Desember 2016, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017

Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 74,8%. Tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi yaitu Maluku Utara sebesar 87,03%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,92%, dan Sulawesi Utara sebesar 83,84%. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 63,24%, Sumatera Barat sebesar 63,73%, dan DKI Jakarta sebesar 67,46%.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.16 berikut ini.

GAMBAR 5.13
PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA
TAHUN 2016



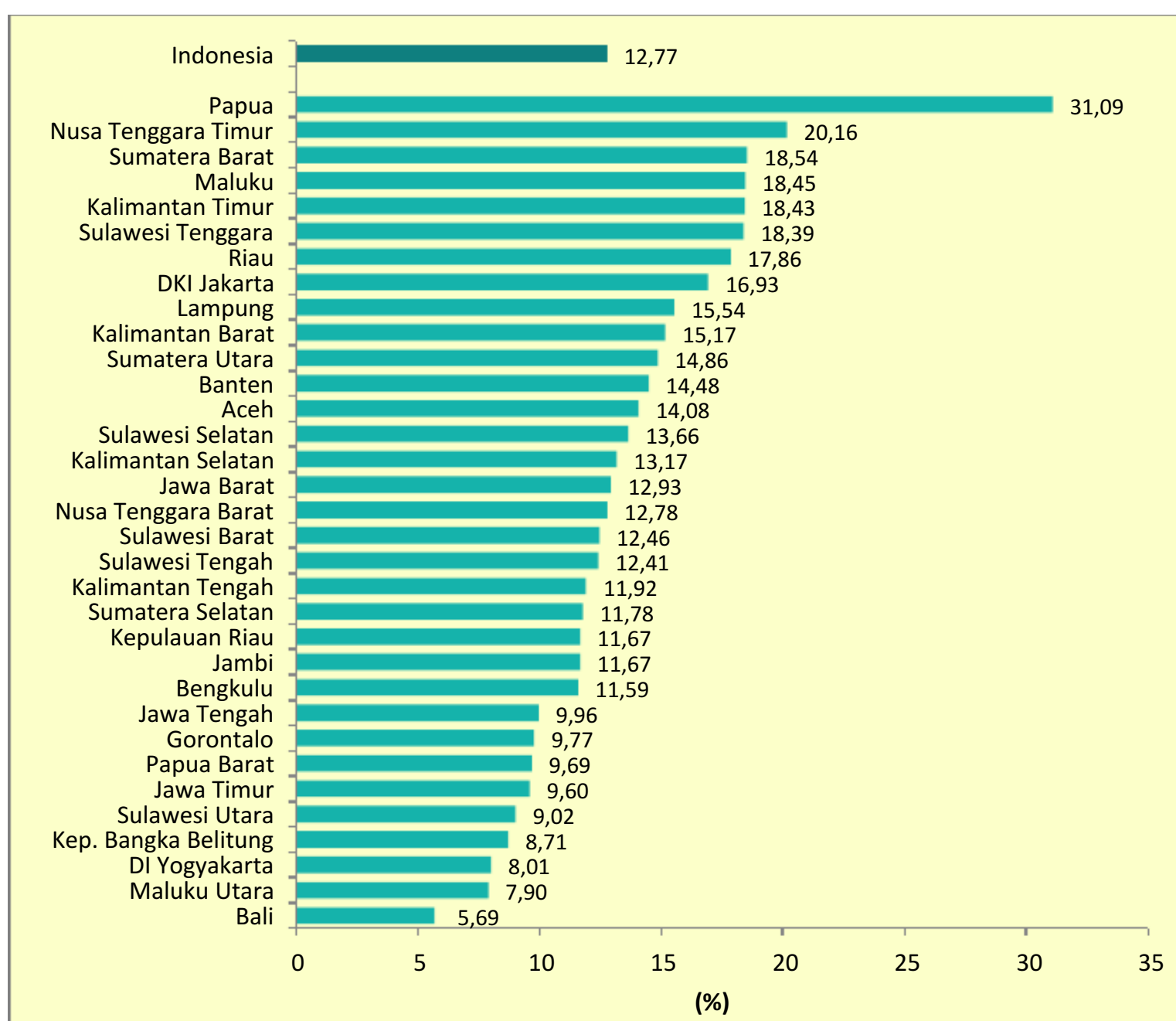
Sumber : Statistik Rutin Desember 2016, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017

Dari sisi ketersediaan jenis tempat pelayanan KB menunjukkan bahwa sebagian besar adalah praktek bidan mandiri. Fasilitas KB ini memiliki proporsi yang sangat besar (52,43%). Sedangkan fasilitas KB milik pemerintah memiliki persentase sebesar 16,66%. Pemerintah melalui BKKBN dan Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terhadap semua jenis fasilitas KB tersebut, tidak hanya kepada fasilitas KB milik pemerintah saja. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi program KB.

Meskipun secara jumlah fasilitas milik pemerintah lebih sedikit dibandingkan praktek bidan mandiri, namun sebagian besar peserta KB baru (58,93%) lebih memilih fasilitas milik pemerintah sebagai tempat untuk mendapatkan layanan KB. Dengan tingginya tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas milik pemerintah maka hal ini bisa menjadi peluang bagi BKKBN dan Kementerian Kesehatan untuk lebih mengendalikan penyelenggaraan program KB.

Dari seluruh pasangan usia subur yang menjadi sasaran program KB, terdapat sebagian yang memutuskan untuk tidak memanfaatkan program tersebut dengan berbagai alasan di antaranya ingin menunda memiliki anak atau tidak ingin memiliki anak lagi. Kelompok PUS ini disebut sebagai *unmet need*. Persentase PUS yang merupakan kelompok *unmet need* di Indonesia sebesar 12,77%. Dari seluruh PUS yang memutuskan tidak memanfaatkan program KB, sebanyak 6,22% beralasan ingin menunda memiliki anak, dan sebanyak 6,55% beralasan tidak ingin memiliki anak lagi.

GAMBAR 5.14
PERSENTASE PUS BUKAN PESERTA KB (*UNMET NEED*) DI INDONESIA TAHUN 2016



Sumber: Statistik Rutin Desember 2016, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017

Semakin rendah angka *unmet need* dapat mengindikasikan keberhasilan penyelenggaraan program KB. Provinsi Bali memiliki persentase *unmet need* terendah sebesar 5,69%, diikuti oleh Maluku Utara sebesar 7,9%, dan DI Yogyakarta sebesar 8,01%. Sedangkan Provinsi Papua memiliki angka *unmet need* tertinggi sebesar 31,09%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 20,16%, dan Sumatera Barat sebesar 18,54%. Gambaran lebih rinci mengenai pelaksanaan program KB menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Lampiran 5.5 sampai dengan Lampiran 5.11.

7. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Indonesia termasuk negara berpenduduk struktur tua, karena persentase penduduk lanjut usia yang telah mencapai di atas 7% dari total penduduk. Keadaan ini berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Struktur penduduk yang menua tersebut, selain merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara nasional, sekaligus juga merupakan tantangan dalam pembangunan.

Keberhasilan pembinaan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup yang dimulai sejak dari seorang ibu mempersiapkan kehamilannya, sampai bayi lahir, balita, anak usia sekolah dan remaja, dewasa, dan pra lanjut usia, akan sangat menentukan kuantitas dan kualitas kehidupan dan kesehatan lanjut usia. Bila pelayanan kesehatan di semua tahapan siklus hidup dilakukan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa kualitas kehidupan di masa lanjut usia akan menjadi lebih tinggi.

Dengan bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses degeneratif (penuaan), sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia. Selain itu proses degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular.

Penyakit terbanyak pada lanjut usia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 adalah hipertensi (57,6%), artritis (51,9%), stroke (46,1%), masalah gigi dan mulut (19,1%), penyakit paru obstruktif menahun (8,6%) dan diabetes mellitus (4,8%). Sementara itu dengan bertambahnya usia, gangguan fungsional akan meningkat dengan ditunjukkan terjadinya disabilitas. Dilaporkan bahwa disabilitas ringan yang diukur berdasarkan kemampuan melakukan aktivitas hidup sehari-hari atau *Activity of Daily Living (ADL)* dialami sekitar 51% lanjut usia, dengan distribusi prevalensi sekitar 51% pada usia 55-64 tahun dan 62% pada usia 65 ke atas; disabilitas berat dialami sekitar 7 % pada usia 55-64 tahun, 10% pada usia 65–74 tahun, dan 22 % pada usia 75 tahun ke atas.

Pada dasarnya penyakit yang diderita lanjut usia jarang dengan diagnosis tunggal, melainkan hampir selalu multidiagnosis (Sumber Riskesdas 2013). Sekitar 34,6% lanjut usia menderita satu penyakit, sekitar 28% dengan 2 (dua) penyakit, sekitar 14,6% dengan 3 (tiga)

penyakit, sekitar 6,2% dengan 4 (empat) penyakit, sekitar 2,3% dengan 5 (lima) penyakit, sekitar 0,8% dengan 6 (enam) penyakit, dan sisanya dengan tujuh penyakit atau lebih.

Lanjut usia sehat berkualitas, mengacu pada konsep *Active Ageing* WHO yaitu proses penuaan yang tetap sehat secara fisik, sosial dan jiwa sehingga dapat tetap sejahtera sepanjang hidup dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sebagai anggota masyarakat. Sementara pemerintah juga harus memfasilitasi dengan menyediakan fasilitas dan perlindungan yang memadai, keamanan, serta perawatan ketika dibutuhkan.

Pelaksanaannya di Indonesia diterjemahkan dalam bentuk pelayanan kesehatan santun lanjut usia baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pemberian pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dilakukan mengacu kepada hasil penapisan dan pengelompokan berdasarkan status fungsional, dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- 1) lanjut usia mandiri/ketergantungan ringan;
- 2) lanjut usia dengan ketergantungan sedang; dan
- 3) lanjut usia dengan ketergantungan berat dan total.

Setiap kelompok mendapat intervensi program tertentu. Kelompok lanjut usia mandiri dan lanjut usia dengan ketergantungan ringan, mengikuti kegiatan di kelompok lanjut usia secara aktif. Untuk lanjut usia dengan ketergantungan sedang, dan lanjut usia dengan ketergantungan berat dan total mendapatkan intervensi program layanan *home care* atau dirujuk ke puskesmas/rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan akan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kesehatan lanjut usia sesuai pengelompokan tersebut di atas. Khusus untuk lanjut usia yang sehat harus diberdayakan agar dapat tetap sehat dan mandiri selama mungkin.

Berdasarkan hasil Risfaskes 2011, diperoleh data bahwa jumlah Puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan komprehensif bervariasi antar provinsi, dengan angka rata-rata nasional sekitar 42,3%, dan proporsi tertinggi ditemukan di Provinsi DIY yaitu 71,9%. Khusus untuk pelayanan kesehatan pada lanjut usia, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan komprehensif adalah pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan mulai dari tingkat keluarga dan masyarakat (Poksila dan *home care*), sampai ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Berdasarkan data Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar tahun 2015, jumlah puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan santun lanjut usia adalah 824 puskesmas atau sekitar 10% dari jumlah puskesmas seluruhnya. Pada tahun 2016, jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang santun lansia sebesar 2.432 puskesmas atau sebesar 24,84 dari jumlah Puskesmas seluruhnya. Capaian ini sudah memenuhi target Renstra Kemenkes sebesar 20%.

Untuk pelayanan di masyarakat, Kelompok Lanjut Usia yang dibina oleh puskesmas, mencapai 76.547 Kelompok dan tersebar di semua provinsi. Pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan, rumah sakit rujukan dengan Klinik Geriatri Terpadu terdapat di 10 rumah sakit di 8 provinsi yaitu DKI Jakarta (RSCM), Jawa Barat (RS Hasan Sadikin-Bandung), Jawa Tengah (RSUP Karyadi-Semarang dan RSUD Moewardi-Solo), Yogyakarta (RSUD Sardjito), Jawa Timur (RSUD Soetomo-Surabaya dan RSU Syaiful Anwar-Malang), Bali (RSUP Sanglah-Denpasar), Sulawesi Selatan (RSUP Wahidin-Makasar) dan Sumatera Utara (RSUP Adam Malik-Medan). Beberapa rumah sakit lain telah mulai berproses untuk memiliki poliklinik khusus geriatri.

Mengingat penanganan pasien geriatri sangat kompleks, maka dibutuhkan Pelayanan Kesehatan Geriatri Komprehensif (preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif) dengan pendekatan holistik oleh tim terpadu. Pelayanan tersebut diselenggarakan secara berjenjang (*Geriatric Health Continuum Care*), mulai dari pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lanjut usia di fasilitas kesehatan telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 tahun 2014 tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lanjut Usia di puskesmas.

Perencanaan pelayanan kesehatan harus dirancang berdasarkan kondisi lanjut usia dan pola pelayanan yang dibutuhkan, mengacu pada pilihan sarana pelayanan kesehatan yang diakses lanjut usia dalam mencari pengobatan. Data lanjut usia dengan tempat berobat menunjukkan bahwa proporsi terbesar (33,71%) berobat ke tenaga kesehatan, diikuti dengan yang berobat ke praktek dokter 31,70%, ke puskesmas/pustu 27,05%, ke rumah sakit pemerintah 7,83% dan rumah sakit swasta 5,12% (Susenas 2014).

Sebagai sasaran pelayanan kesehatan, yang harus diperhatikan pada lanjut usia adalah bahwa penyakit kronis dan kecacatan di usia tua mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan dan merupakan tantangan bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah secara nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi sejak dini sesuai dengan tahapan siklus hidup, agar ketika memasuki masa lanjut usia, mereka tidak sakit-sakitan, lemah, dan kurang mandiri.

Untuk mewujudkan lanjut usia sehat berkualitas, harus dilakukan pembinaan kesehatan sedini mungkin dan selama siklus hidup manusia sampai memasuki masa lanjut usia dengan meminimalkan faktor risiko yang harus dihindari dan memaksimalkan faktor protektif yang dapat melindungi dan meningkatkan status kesehatan.

Salah satu upaya untuk memberdayakan lanjut usia di masyarakat adalah melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Lanjut Usia yang di beberapa daerah disebut dengan Kelompok Usia Lanjut (Poksila), Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) atau Pos Pembinaan Terpadu Lanjut Usia (Posbindu Lansia). Pelaksanaan Kelompok

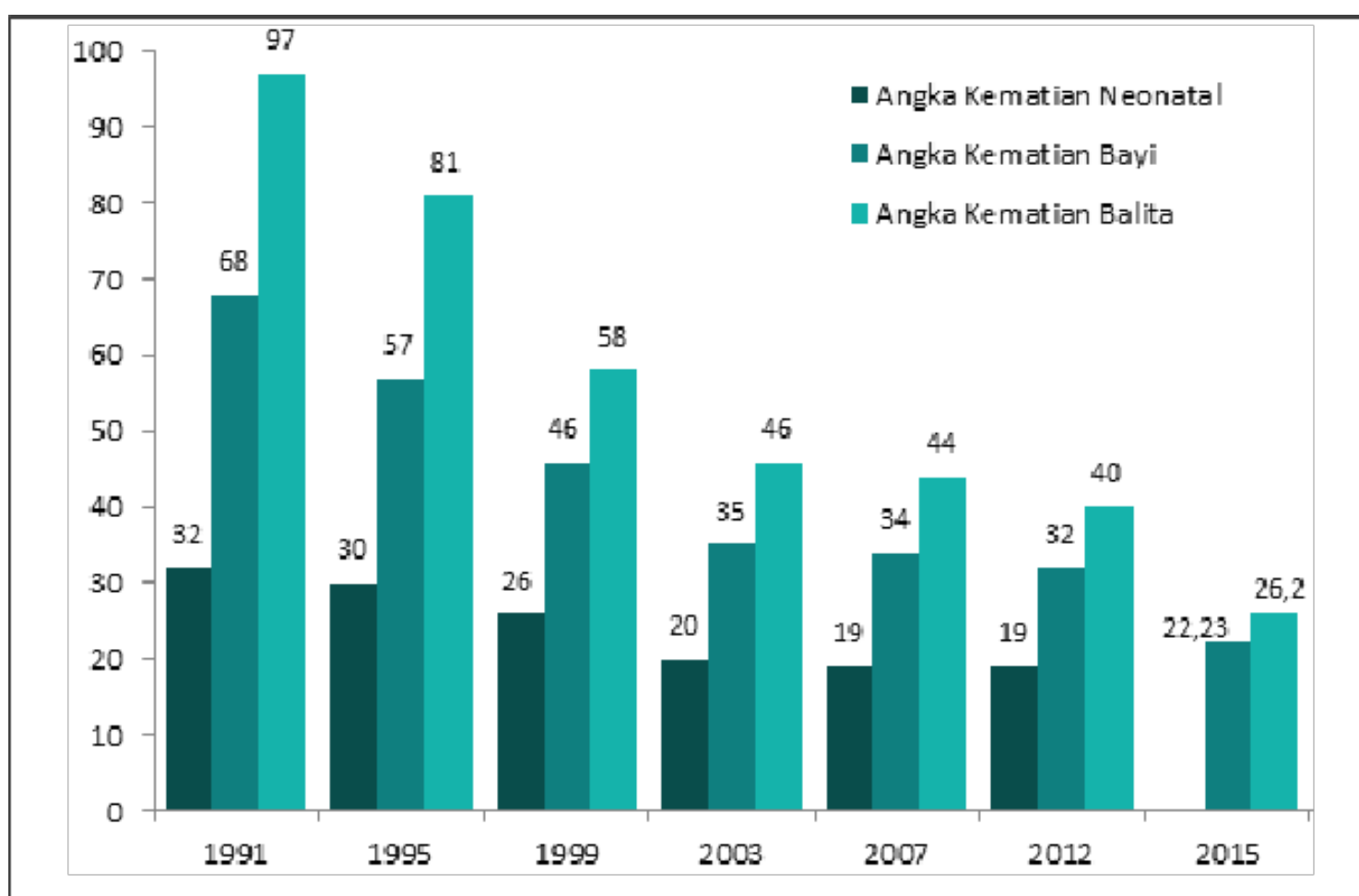
Lanjut Usia ini, selain mendorong peran aktif masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, juga harus melibatkan lintas sektor terkait.

B. KESEHATAN ANAK

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun.

Dengan upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun 2007 dan hanya menurun 1 poin dibanding SDKI tahun 2002-2003 yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup.

GAMBAR 5.15
TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA
TAHUN 1991 – 2015



Sumber: SDKI tahun 1991-2012, SUPAS tahun 2015

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan Angka Kematian Balita (AKABA) hasil SUPAS 2015 sebesar 26,29 per 1.000 kelahiran hidup, juga sudah memenuhi target MDG 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Data dan informasi yang akan disajikan berikut ini menerangkan berbagai indikator kesehatan anak yang meliputi: penanganan komplikasi neonatal, pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi dasar, pelayanan kesehatan pada siswa SD/setingkat, dan pelayanan kesehatan peduli remaja.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

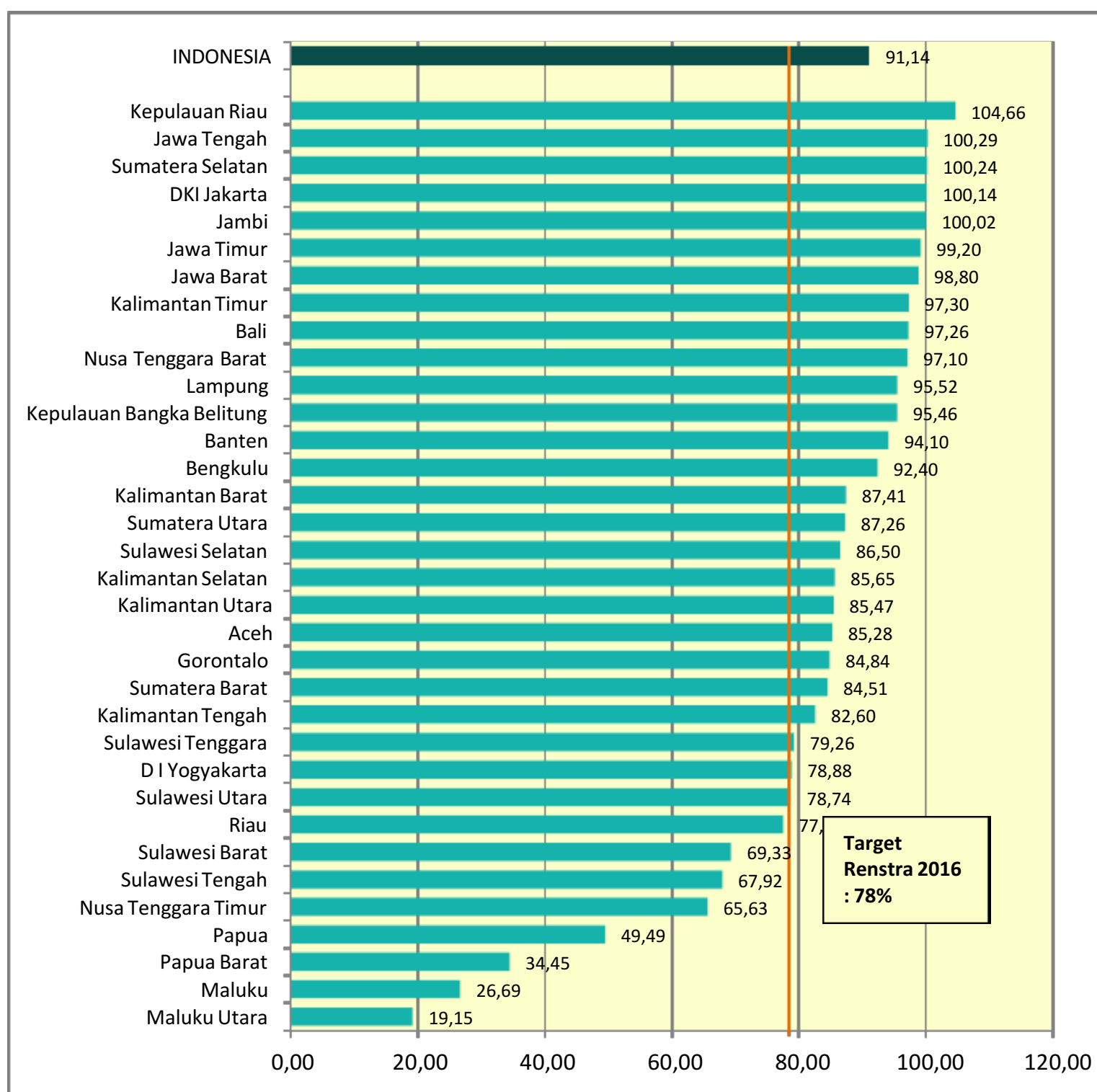
Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan.

Capaian KN1 Indonesia pada tahun 2016 sebesar 91,14% lebih tinggi dari tahun 2015 yaitu sebesar 83,67%. Capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2016 yang sebesar 78%. Sejumlah 26 provinsi (71%) yang telah memenuhi target tersebut. Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.16.

Hasil capaian nasional per provinsi masih terdapat disparitas Cakupan KN1. Disparitas terbesar terjadi di 4 provinsi dengan cakupan KN1 terkecil yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Beberapa provinsi mendapatkan cakupan lebih dari 100% dikarenakan data sasaran BPS lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran riil yang didapatkan.

GAMBAR 5.16
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

2. Imunisasi

Dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi dan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling *cost-effective* (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya.

Proses perjalanan penyakit diawali ketika virus/bakteri/protozoa/jamur, masuk ke dalam tubuh. Setiap makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dianggap benda asing oleh tubuh atau yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi berinteraksi dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi belum mengenali antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yang kedua dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh sudah mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat.

Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin merupakan upaya menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit tertentu dengan melumpuhkan antigen yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin.

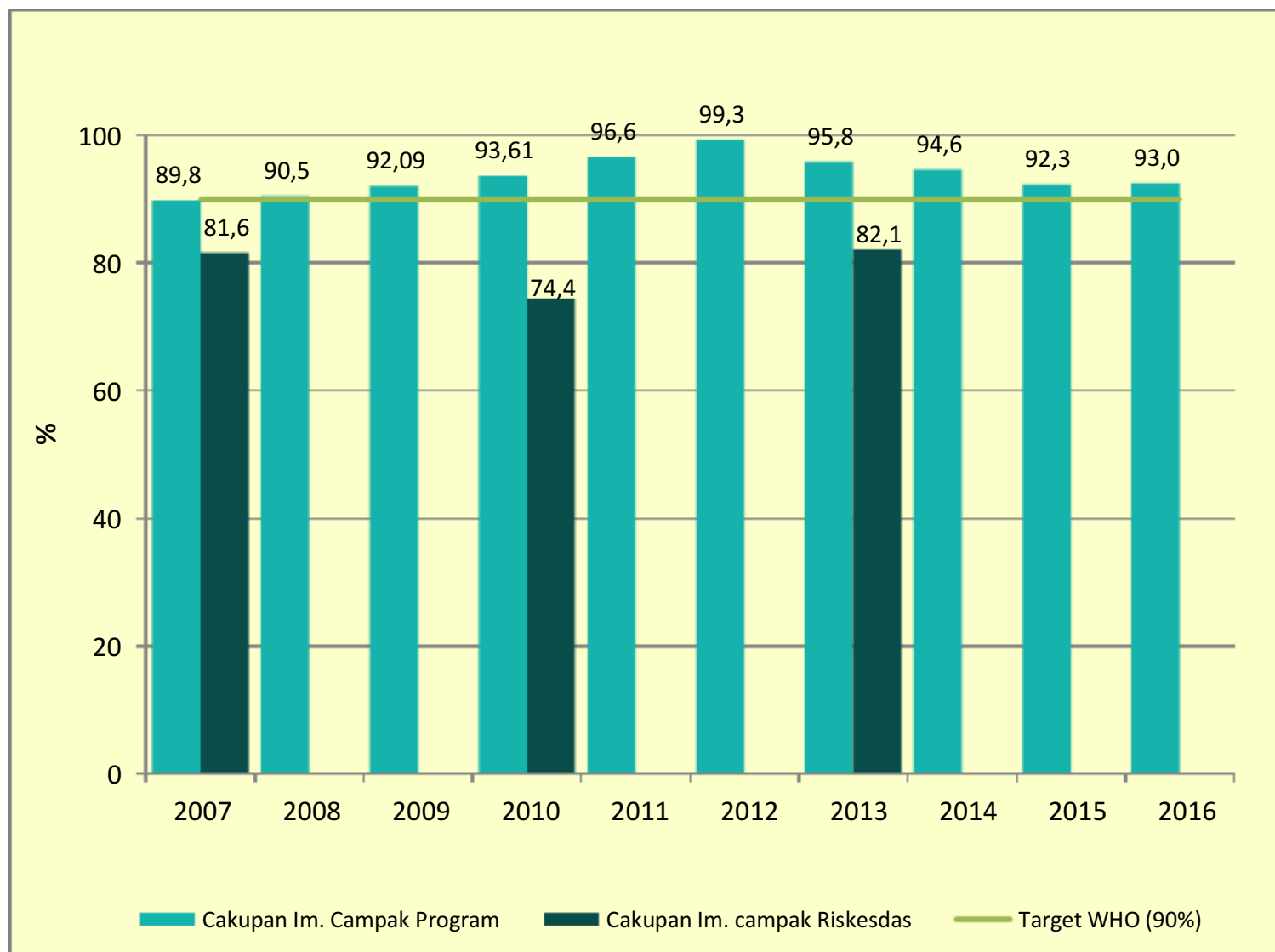
Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, balita, anak-anak, wanita usia subur, dan ibu hamil.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Di Indonesia, program imunisasi mewajibkan setiap bayi (usia 0-11 bulan) mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Dari imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki

peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita. Tren Cakupan Campak di Indonesia cenderung menurun meskipun tetap berusaha mencapai target sebesar 95% seperti yang disajikan pada Gambar 5.17 berikut.

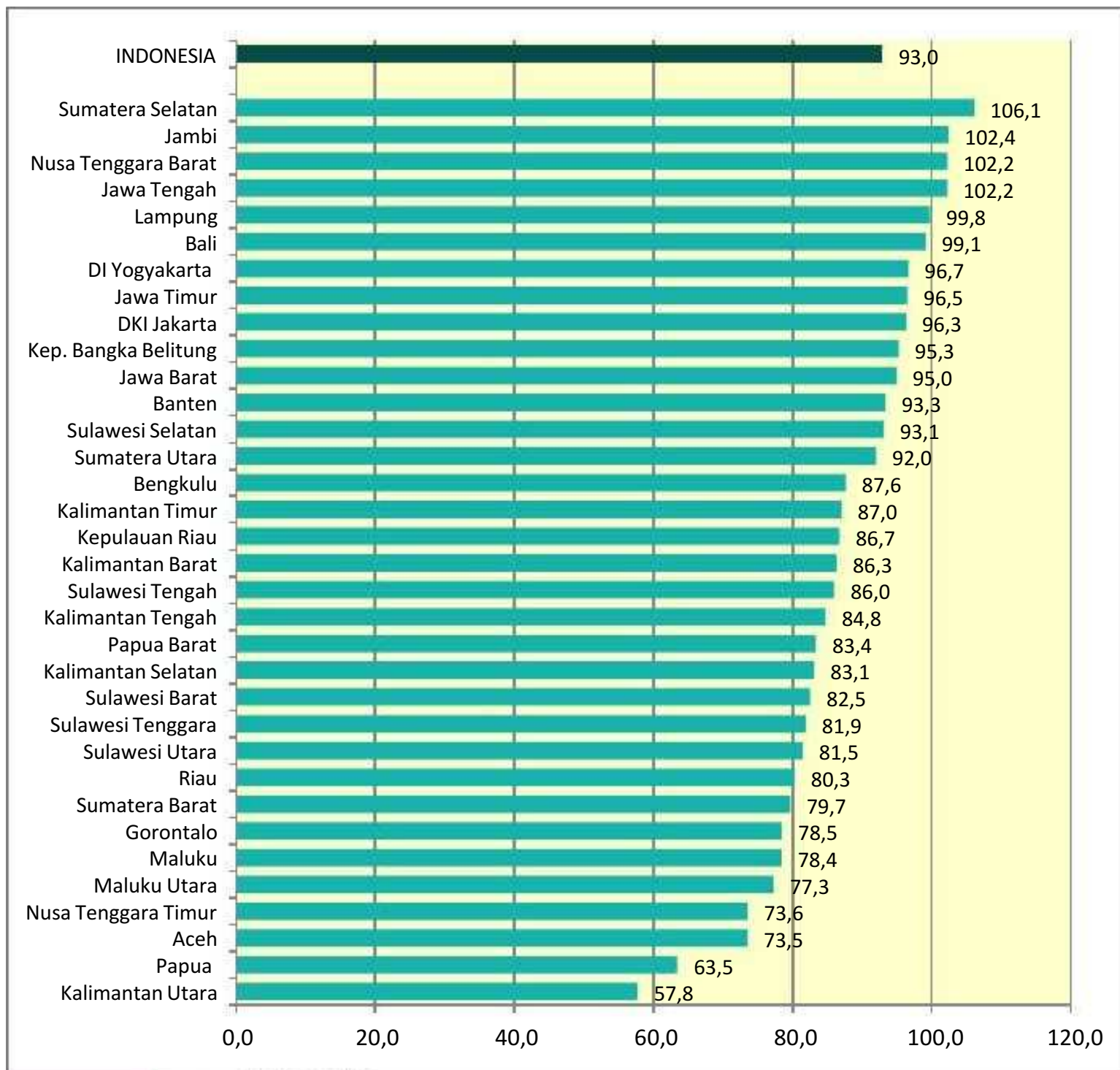
GAMBAR 5.17
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA
TAHUN 2007-2016



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2017

Indonesia memiliki cakupan imunisasi campak program di atas 90% sejak tahun 2008. Tahun 2016 sedikit meningkat dari tahun 2015, yaitu sebesar 93,0%. Menurut provinsi, terdapat sebelas provinsi yang telah berhasil mencapai target 95%. Pada gambar di bawah dapat diketahui bahwa seluruh bayi di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah telah mendapatkan imunisasi campak. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Kalimantan Utara sebesar 57,8%, Papua 63,5% dan Aceh 73,5%.

GAMBAR 5.18
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016

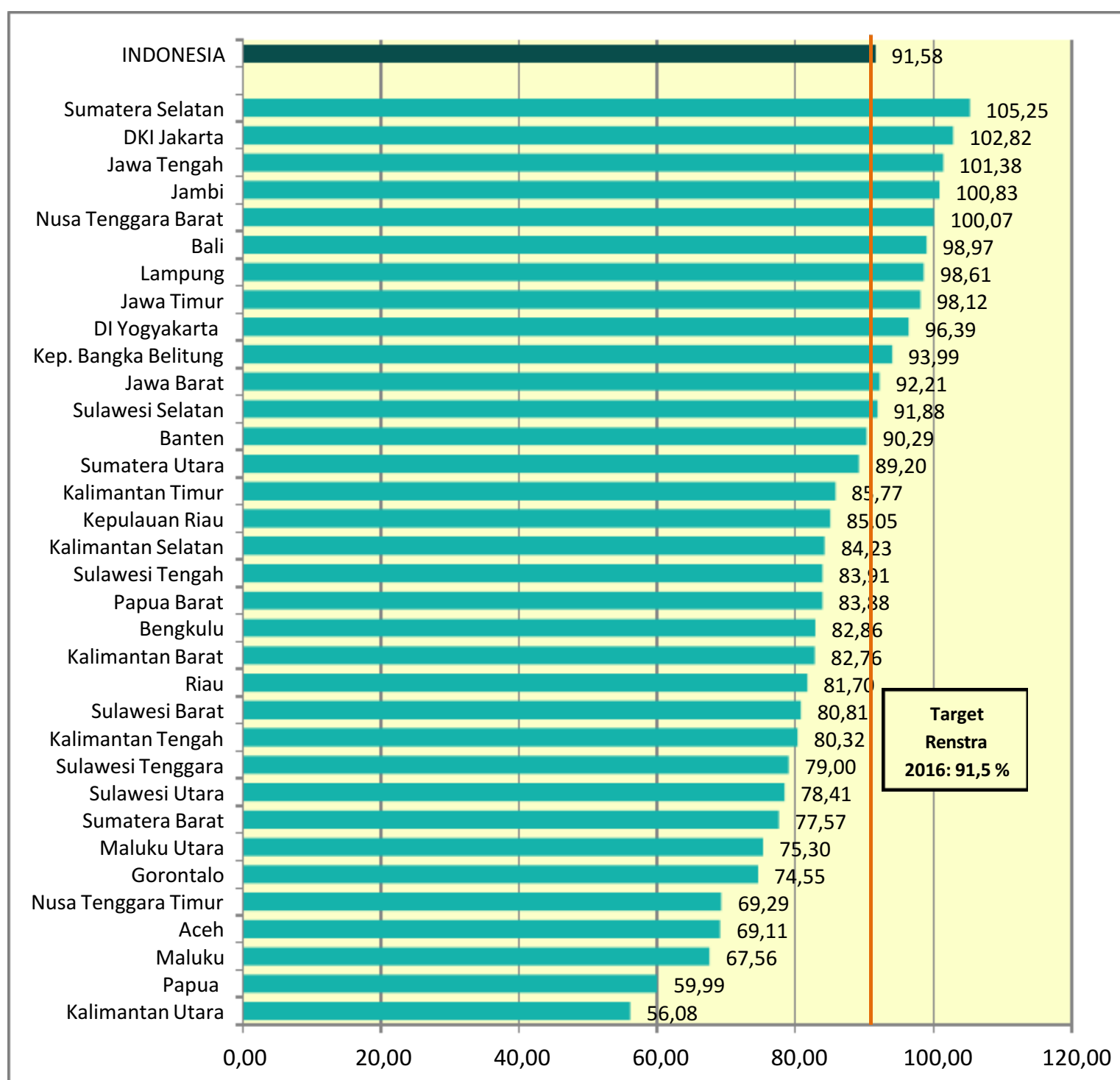


Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2017

b. Imunisasi Lengkap pada Bayi

Program imunisasi pada bayi bertujuan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Capaian indikator ini di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 91,58%. Capaian ini lebih besar dari capaian tahun 2015 sebesar 86,54%. Angka ini mencapai target Renstra tahun 2016 sebesar 91,5%. Sedangkan menurut provinsi, terdapat dua belas provinsi yang mencapai target Renstra tahun 2016.

GAMBAR 5.19
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2017

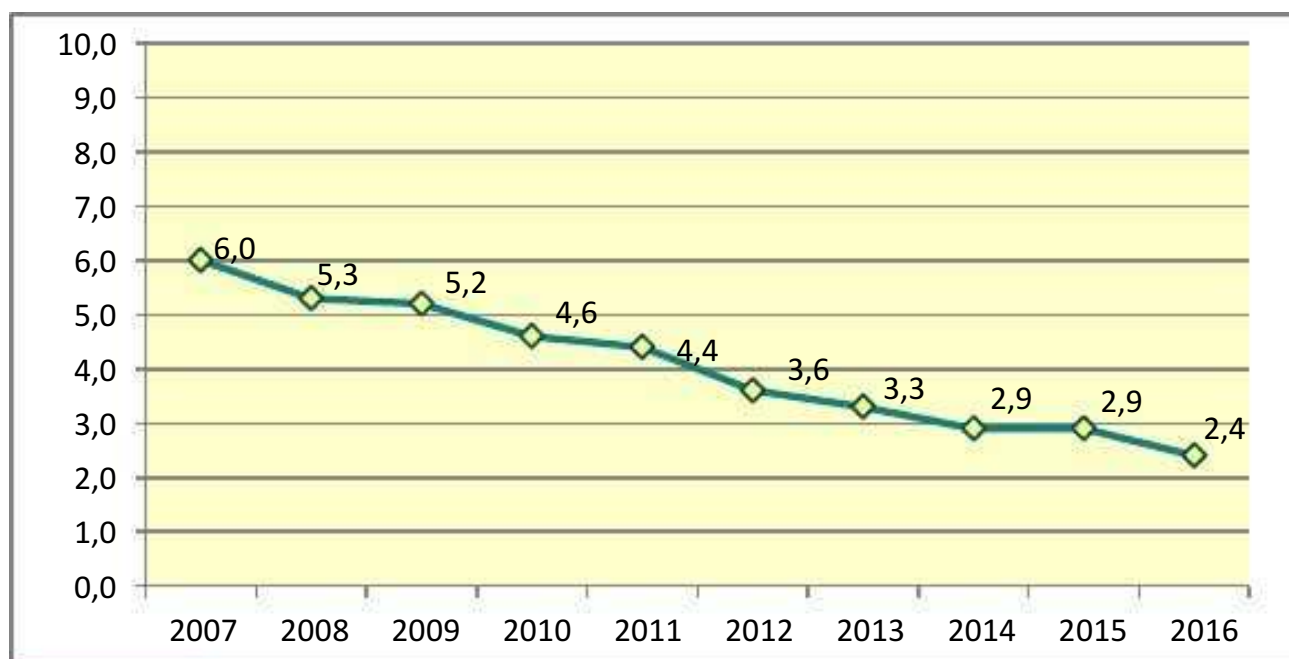
Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa seluruh bayi di Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Kalimantan Utara (56,08%), Papua (59,99%), dan Maluku (67,56%). Data dan informasi terkait imunisasi dasar pada bayi yang dirinci menurut provinsi tahun 2016 terdapat pada Lampiran 5.14.

c. Angka *Drop Out* Cakupan Imunisasi DPT/HB1-Campak

Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya sebelum anak berusia satu tahun. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Namun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi Campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1.

Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2016 sebesar 2,4%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 2,9%. Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 yang asumsinya semakin banyak bayi yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kecenderungan penurunan tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.20
ANGKA *DROP OUT* IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI
TAHUN 2007-2016



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2017

DO rate DPT/HB1-Campak diharapkan tidak melebihi 5%. Batas maksimal tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Data dan informasi lebih rinci mengenai angka *drop out* cakupan imunisasi DPT/HB1-Campak dan DPT/HB(1)-DPT/HB(3) pada tahun 2013-2015 terdapat pada Lampiran 5.15.

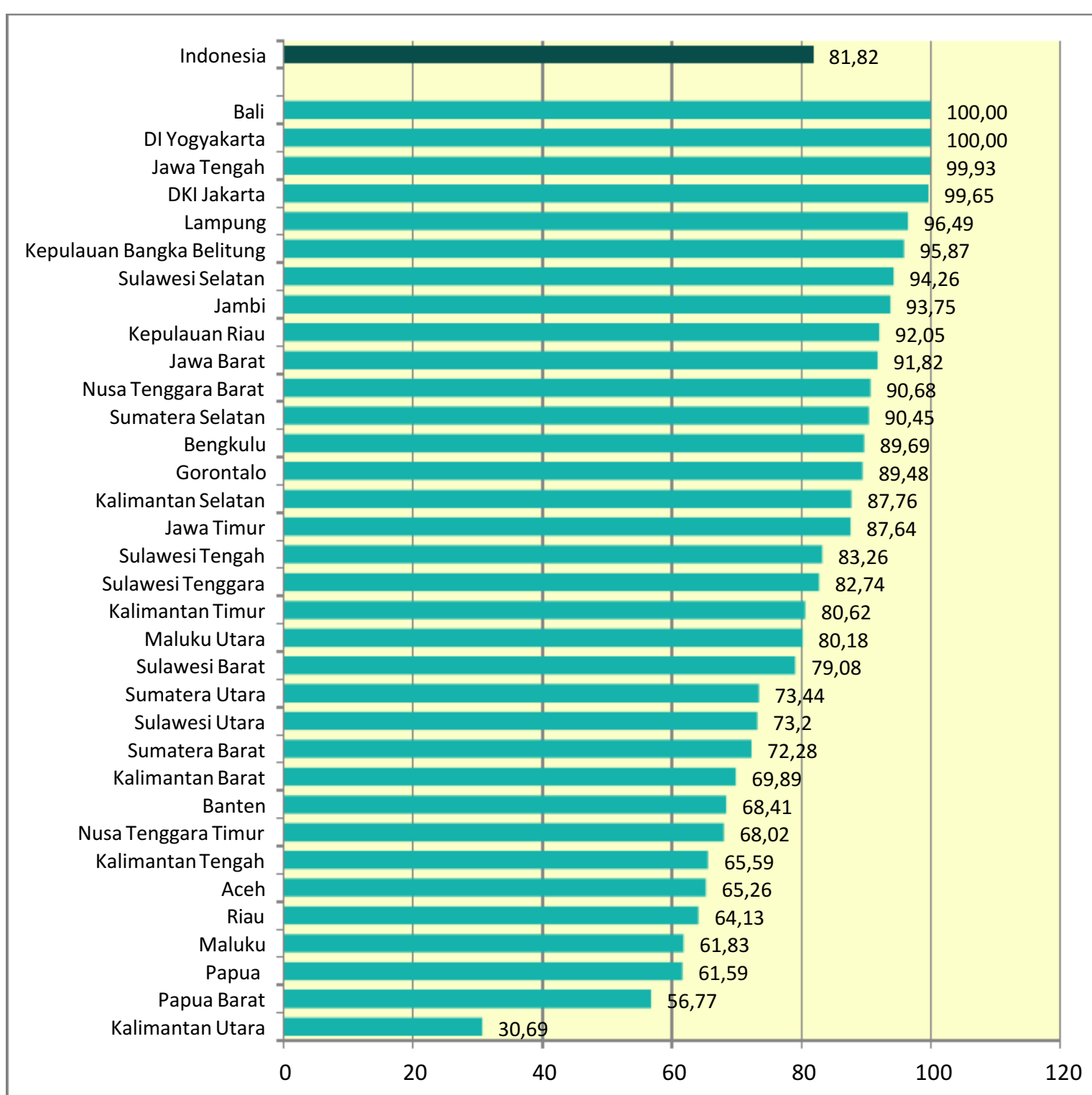
d. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi yaitu *Universal Child Immunization* (UCI) desa/kelurahan. UCI desa/kelurahan adalah gambaran

suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Cakupan desa/kelurahan UCI menurut provinsi terdapat pada Gambar 5.20.

Pada tahun 2016 terdapat tiga provinsi memiliki capaian tertinggi yaitu Bali (100%), DI Yogyakarta (100%), dan Jawa Tengah sebesar 99.93%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Kalimantan Utara (30,69%), Papua Barat (56,77%) dan Papua (61.59%). Informasi terkait Cakupan Desa UCI pada tahun 2014-2016 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.16.

GAMBAR 5.21
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2017

3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Mulai masuk sekolah merupakan hal penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah, seperti misalnya karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan, masalah gizi, dan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, dan lain - lain. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/ sederajat kelas satu. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKGS dan dokter kecil). Tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

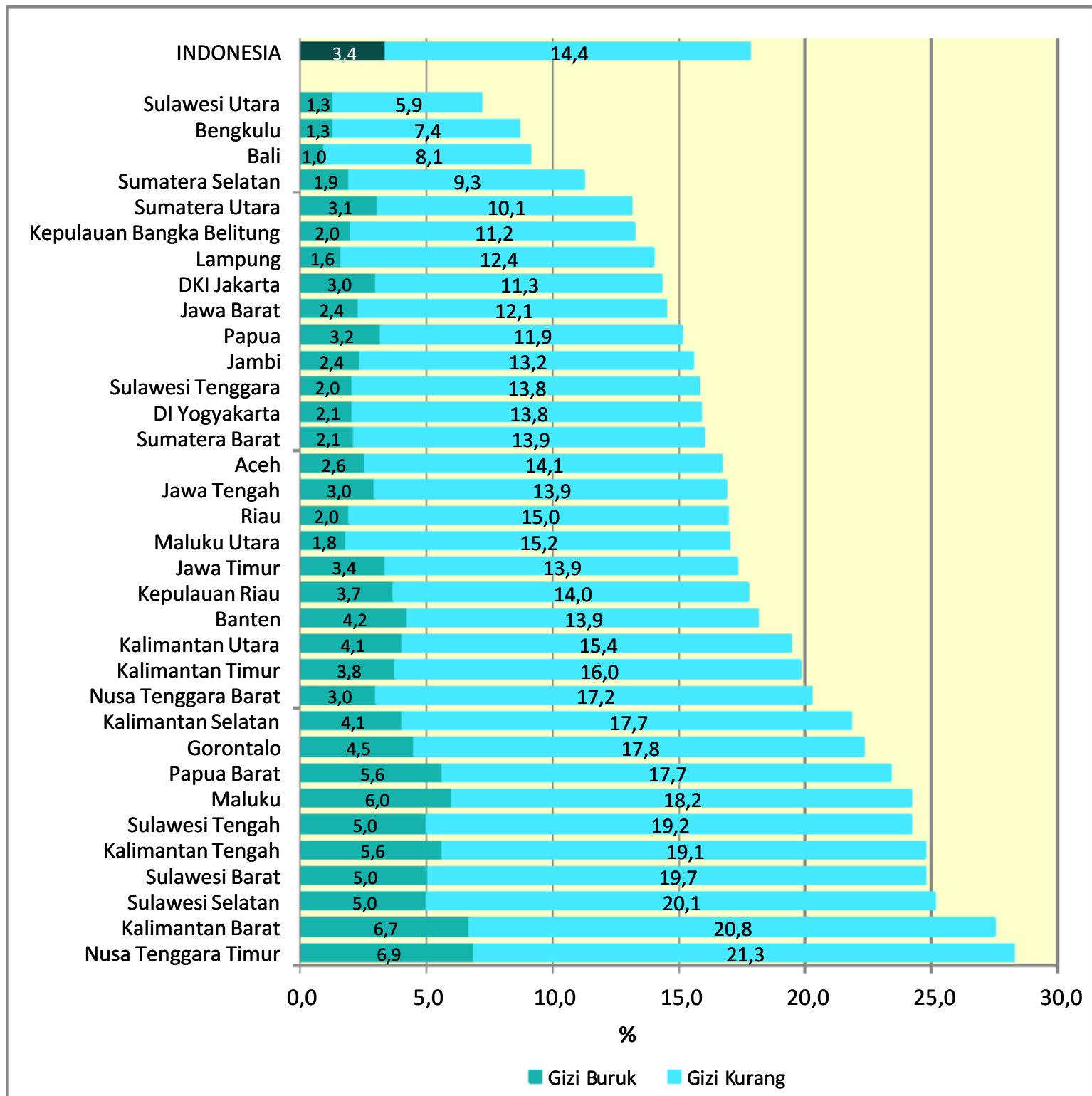
Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya.

Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid SD/MI kelas satu juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya melalui Renstra Kementerian Kesehatan. Kegiatan penjangkaran kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

a. Puskesmas yang melaksanakan Penjangkaran Kesehatan Peserta Didik Kelas I

Penjangkaran kesehatan peserta didik merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap peserta didik untuk memilah siswa yang mempunyai masalah Kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Kegiatan penjangkaran kesehatan ini terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku) pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran), pemeriksaan

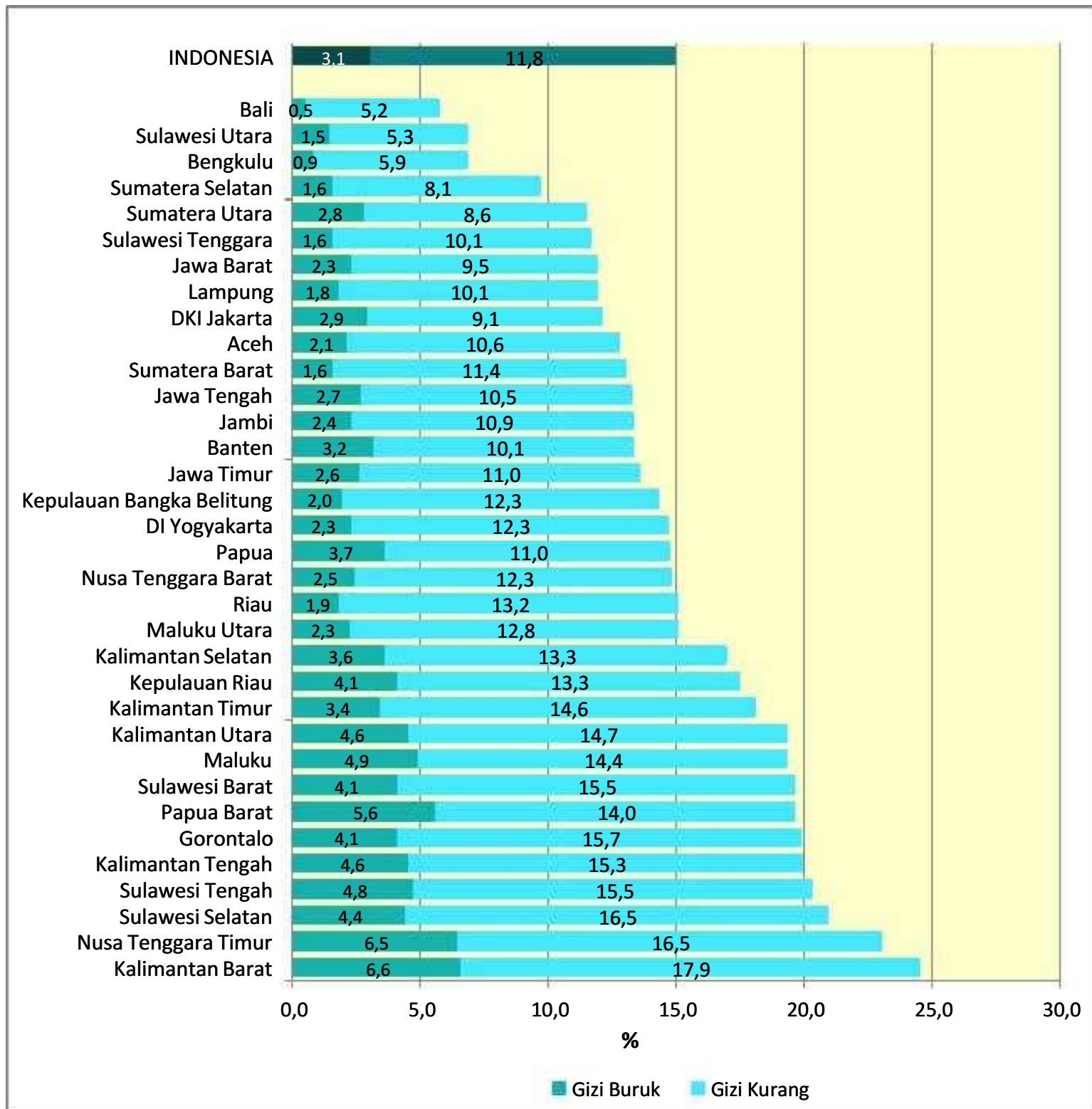
GAMBAR 5.27
PERSENTASE GIZI BURUK DAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pemantauan Status Gizi 2016, Kemenkes RI

Hasil pengukuran status gizi PSG 2016 dengan indeks BB/U pada balita 0-23 bulan mendapatkan persentase gizi buruk sebesar 3,1%, gizi kurang sebesar 11,8% dan gizi lebih sebesar 1,5%. Dibandingkan hasil PSG 2015 juga relatif sama yaitu gizi buruk sebesar 3,2%, gizi kurang sebesar 11,9% dan gizi lebih sebesar 1,6%. Provinsi dengan gizi buruk dan kurang tertinggi tahun 2016 adalah Kalimantan Barat (24,5%) dan terendah Sulawesi Utara (5,7%).

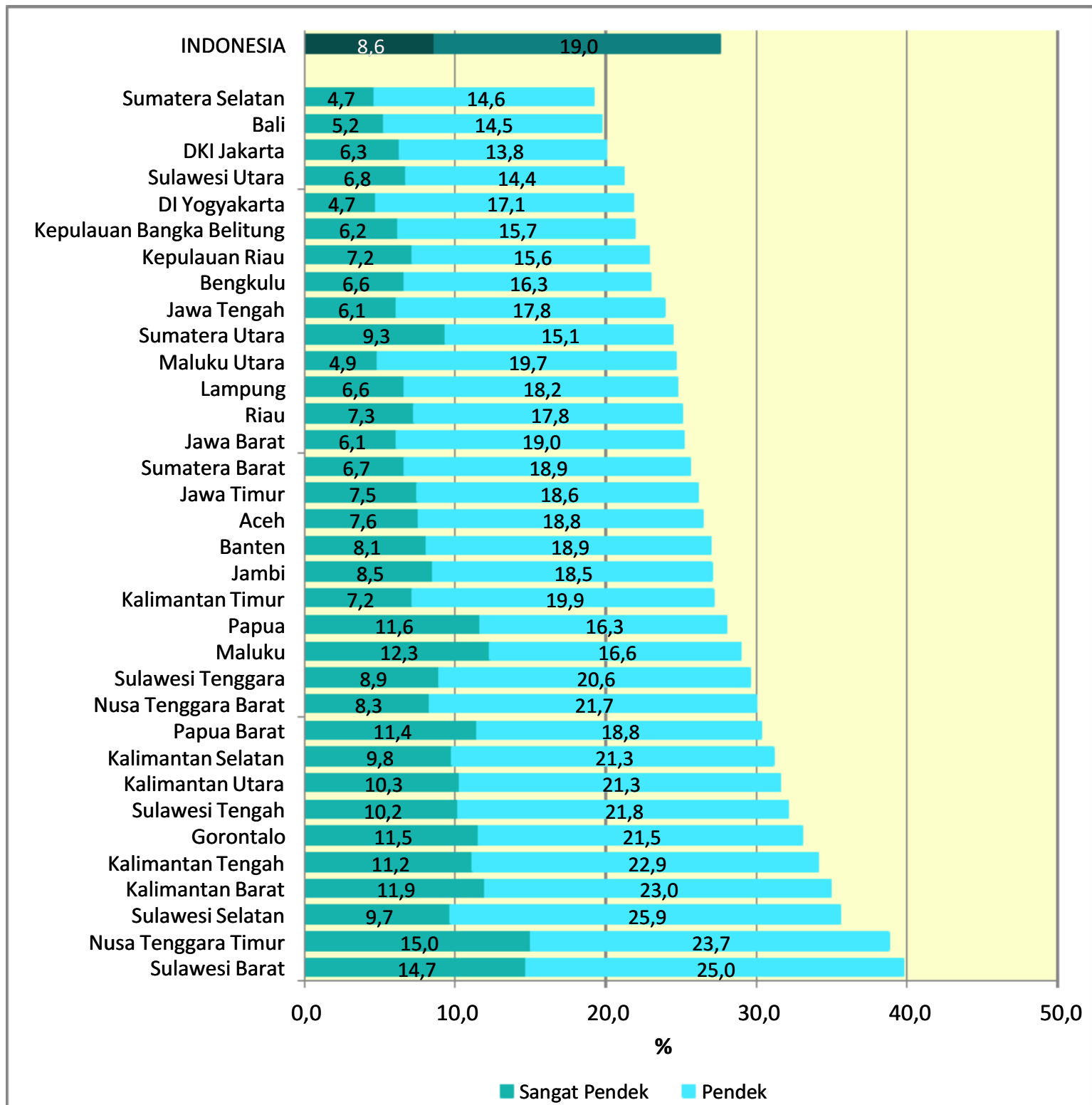
GAMBAR 5.28
PERSENTASE GIZI BURUK DAN KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pemantauan Status Gizi 2016, Kemenkes RI

Status gizi balita 0-59 bulan dengan indeks TB/U menunjukkan persentase balita pendek dan sangat pendek. Hasil PSG 2016 mendapatkan persentase balita sangat pendek sebesar 8,6% dan pendek sebesar 19,0%. Target persentase balita pendek dan sangat pendek adalah kurang dari 20%. Provinsi dengan persentase balita pendek dan sangat pendek terbesar adalah Sulawesi Barat (39,7%) dan terendah adalah Sumatera Selatan (19,2%). Hanya Provinsi Sumatera Selatan dan Bali yang kurang dari 20%.

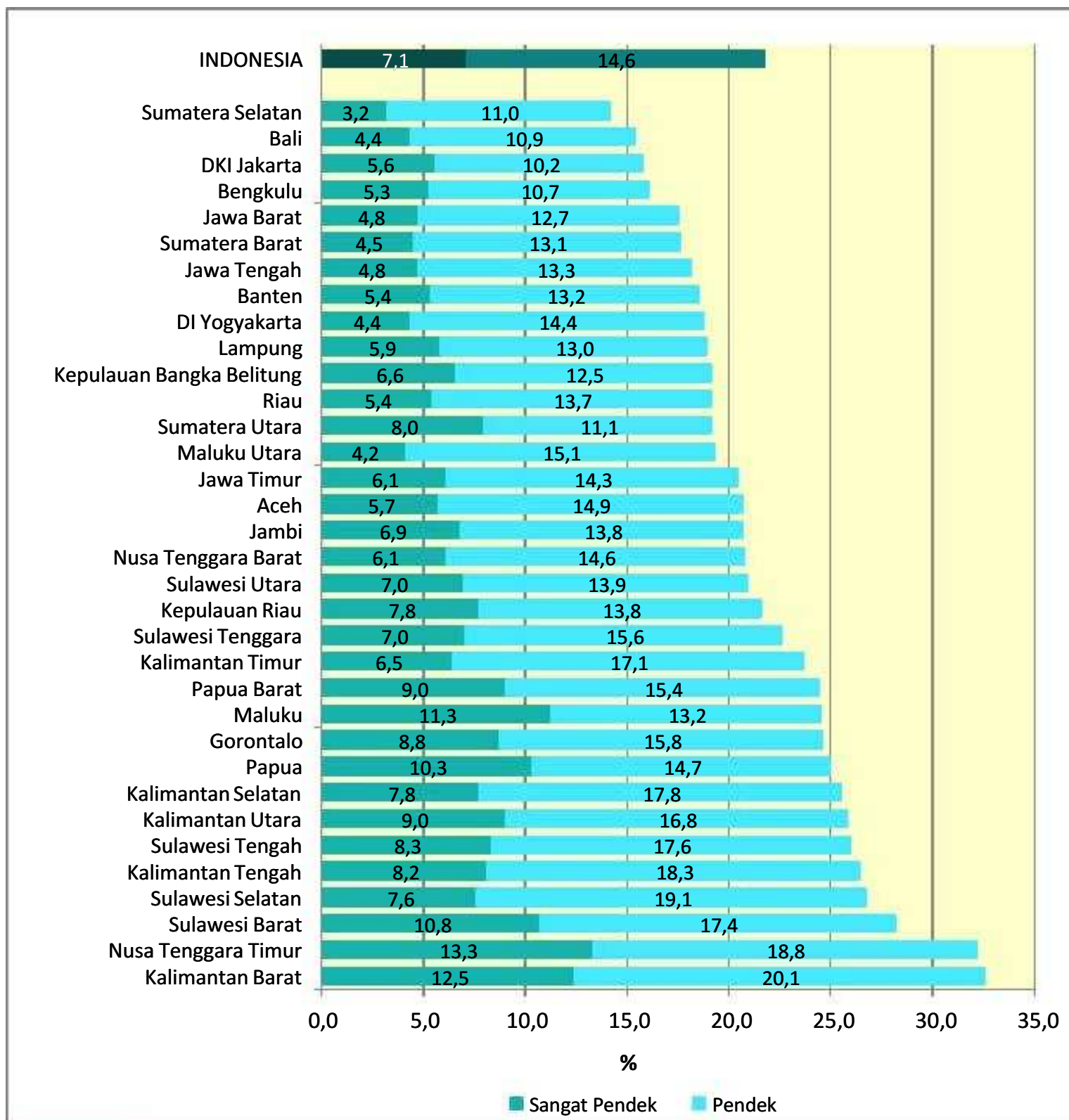
GAMBAR 5.29
PERSENTASE PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pemantauan Status Gizi 2016, Kemenkes RI

Sedangkan pada balita 0-23 bulan persentase sangat pendek sebesar 7,1% dan pendek sebesar 14,6%. Provinsi dengan persentase balita pendek dan sangat pendek terbesar adalah Kalimantan Barat (32,5%) dan terendah adalah Sumatera Selatan (14,2%).

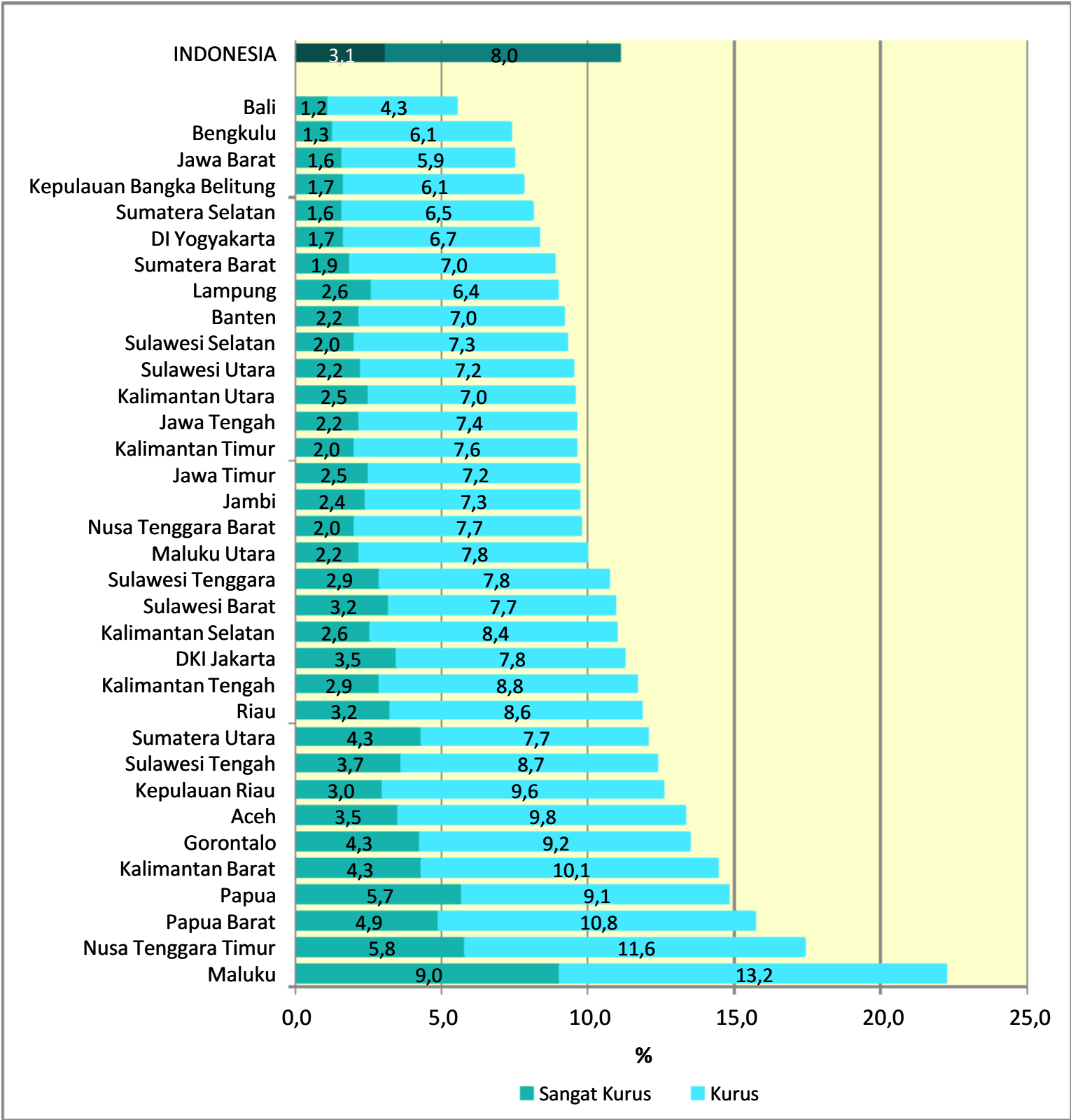
GAMBAR 5.30
PERSENTASE BALITA PENDEK DAN SANGAT PENDEK BERUMUR 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pemantauan Status Gizi 2016, Kemenkes RI

Status gizi balita 0-59 bulan dengan indeks TB/BB menunjukkan persentase kurus dan sangat kurus. Hasil PSG 2016 mendapatkan persentase balita 0-23 bulan yang sangat kurus sebesar 3,1%, kurus sebesar 8,0% dan gemuk sebesar 4,3%. Provinsi dengan persentase balita kurus dan sangat kurus terbesar adalah Maluku (22,2%) dan terendah adalah Bali (5,5%).

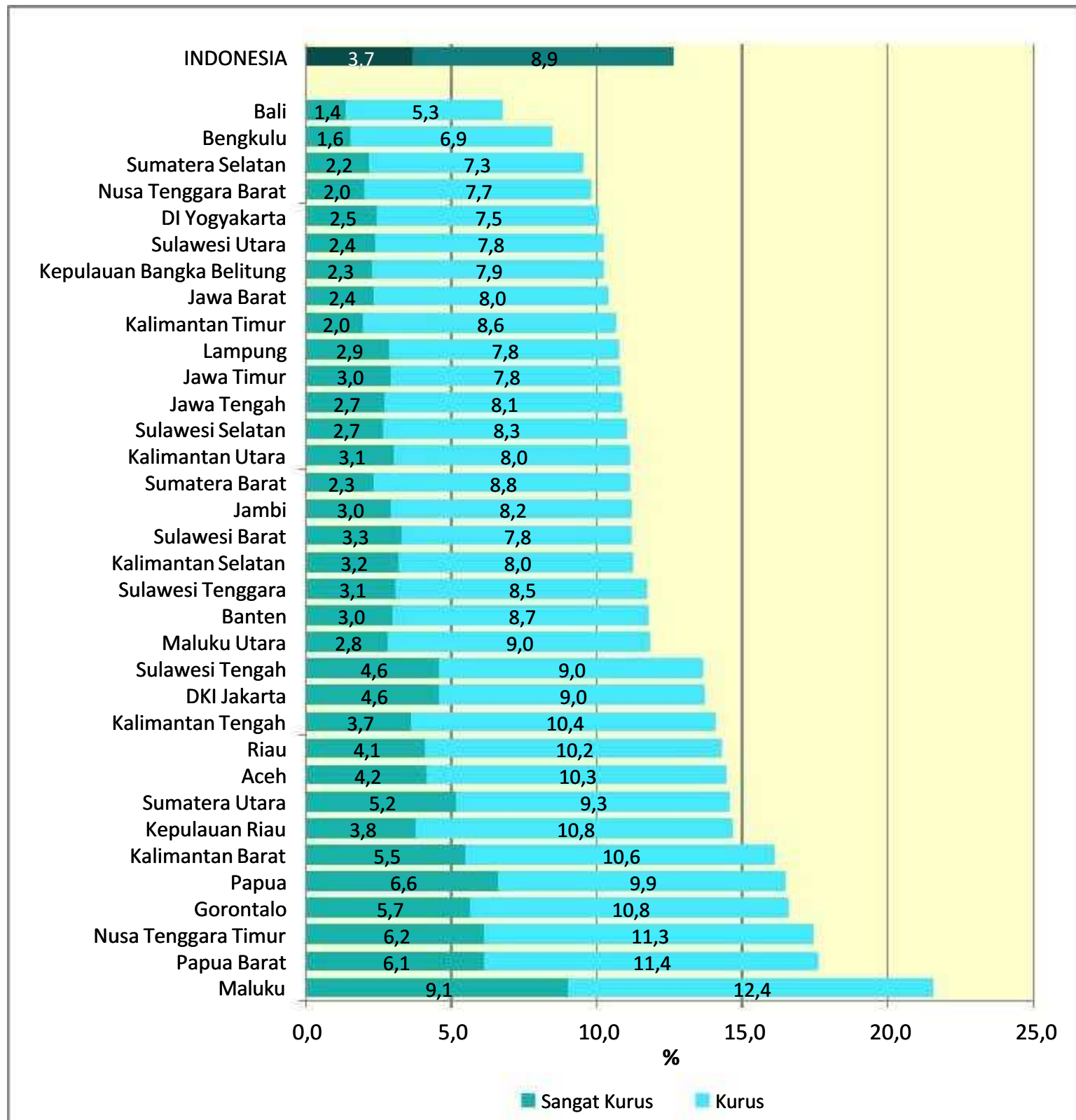
GAMBAR 5.31
PERSENTASE BALITA KURUS DAN SANGAT KURUS BERUMUR 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pemantauan Status Gizi 2016, Kemenkes RI

Sedangkan pada balita 0-23 bulan persentase sangat kurus sebesar 3,7%, kurus sebesar 8,9% dan gemuk sebesar 4,3%. Provinsi dengan persentase balita kurus dan sangat kurus terbesar adalah Papua (16,5%) dan terendah adalah Aceh (14,4%).

GAMBAR 5.32
PERSENTASE BALITA KURUS DAN SANGAT KURUS BERUMUR 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pemantauan Status Gizi 2016, Kemenkes RI

Data mengenai status gizi balita dapat dilihat pada lampiran 5.23-5.28

Salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi balita adalah kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita kurus. Pemberian makanan tambahan diberikan pada balita usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 23 bulan 29 hari dengan status gizi kurus, diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan sebesar minus 3 standar deviasi

(-3SD) sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi (<-2SD), yang mendapat makanan tambahan selama 90 hari berturut-turut. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus dapat diberikan berupa PMT lokal maupun PMT pabrikan seperti biskuit MP-ASI. Bila berat badan telah mencapai atau sesuai perhitungan berat badan sesuai tinggi badan, maka pemberian makanan tambahan balita dihentikan. Selanjutnya dapat mengonsumsi makanan keluarga gizi seimbang dan dilakukan monitoring berat badan terus menerus agar balita tidak kembali jatuh dalam status gizi kurus.

Hasil PSG 2016, 36,8% balita kurus mendapatkan makanan tambahan, lebih rendah dibandingkan target nasional Tahun 2016 sebesar 75%.

4. Gizi Ibu Hamil

Gizi ibu hamil perlu mendapat perhatian karena sangat berpengaruh pada perkembangan janin yang dikandungnya. Sejak janin sampai anak berumur dua tahun atau 1000 hari pertama kehidupan kecukupan gizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan kognitif. Kekurangan gizi pada masa ini juga dikaitkan dengan risiko terjadinya penyakit kronis pada usia dewasa, yaitu kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, stroke dan diabetes. Pada masa kehamilan gizi ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin karena gizi janin tergantung pada gizi ibu dan kebutuhan gizi ibu juga harus tetap terpenuhi.

Hasil PSG 2016, persentase ibu hamil menurut konsumsi energi terhadap standar kecukupan gizi sebesar 73,6%, artinya rata-rata tingkat konsumsi energi pada ibu hamil per hari di Indonesia sebesar 73,6% Angka Kecukupan Energi (AKE). Persentase ibu hamil menurut konsumsi protein terhadap standar kecukupan gizi sebesar 86,4%, karbohidrat 76,8% dan lemak 70,0%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.31.

Berdasarkan kecukupan energi, 53,9% ibu hamil mengalami defisit energi (<70% AKE) dan 13,1% mengalami defisit ringan (70-90% AKE). Untuk kecukupan protein, 51,9% ibu hamil mengalami defisit protein (<80%AKP) dan 18,8% mengalami defisit ringan (80-99% AKP). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.32.

Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan Kurang Energi Kronis (KEK). Ibu hamil dengan KEK berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR) juga dapat menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu. Untuk itu bagi ibu hamil risiko KEK, yaitu yang memiliki Lingkar Lengan Atas (LLA) <23,5cm, diberikan makanan tambahan. Hasil PSG 2016 didapatkan 79,3% ibu hamil risiko KEK mendapatkan makanan tambahan lebih besar dari target nasional tahun 2016 sebesar 50%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.29.

Anemia pada ibu hamil dihubungkan dengan meningkatnya kelahiran prematur, kematian ibu dan anak dan penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun

setelahnya. Riskesdas 2013 mendapatkan anemia terjadi pada 37,1% ibu hamil di Indonesia, 36,4% ibu hamil di perkotaan dan 37,8% ibu hamil di perdesaan. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan. Hasil PSG 2016 mendapatkan hanya 40,2% ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet lebih rendah dari target nasional tahun 2016 sebesar 85%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.30.

BAB VI

PENGENDALIAN PENYAKIT



BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Angka kesakitan dan kematian penyakit merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, WHO menargetkan untuk menurunkan kematian akibat tuberkulosis sebesar 90% dan menurunkan insidens sebesar 80% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2014.

Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 10,4 juta kasus baru tuberkulosis atau 142 kasus/100.000 populasi, dengan 480.000 kasus *multidrug-resistant*. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus baru terbanyak kedua di dunia setelah India. Sebesar 60% kasus baru terjadi di 6 negara yaitu India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan. Kematian akibat tuberkulosis diperkirakan sebanyak 1,4 juta kematian ditambah 0,4 juta kematian akibat tuberkulosis pada orang dengan HIV. Meskipun jumlah kematian akibat tuberkulosis menurun 22% antara tahun 2000 dan 2015, tuberkulosis tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia pada tahun 2015 (WHO, *Global Tuberculosis Report*, 2016).

Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam positif (BTA positif) melalui percik

renik dahak yang dikeluarkannya. Tuberkulosis dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil.

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insidens, prevalensi, dan mortalitas/kematian.

a. Insidens dan Prevalens Tuberkulosis

Menurut *Global Tuberculosis Report WHO* (2016), diperkirakan insidens tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 395 kasus/100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 40/100.000 penduduk (penderita HIV dengan tuberkulosis tidak dihitung) dan 10/100.000 penduduk pada penderita HIV dengan tuberkulosis. Menurut perhitungan *model prediction* yang berdasarkan data hasil survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014, estimasi prevalensi tuberkulosis tahun 2015 sebesar 643 per 100.000 penduduk dan estimasi prevalensi tuberkulosis tahun 2016 sebesar 628 per 100.000 penduduk.

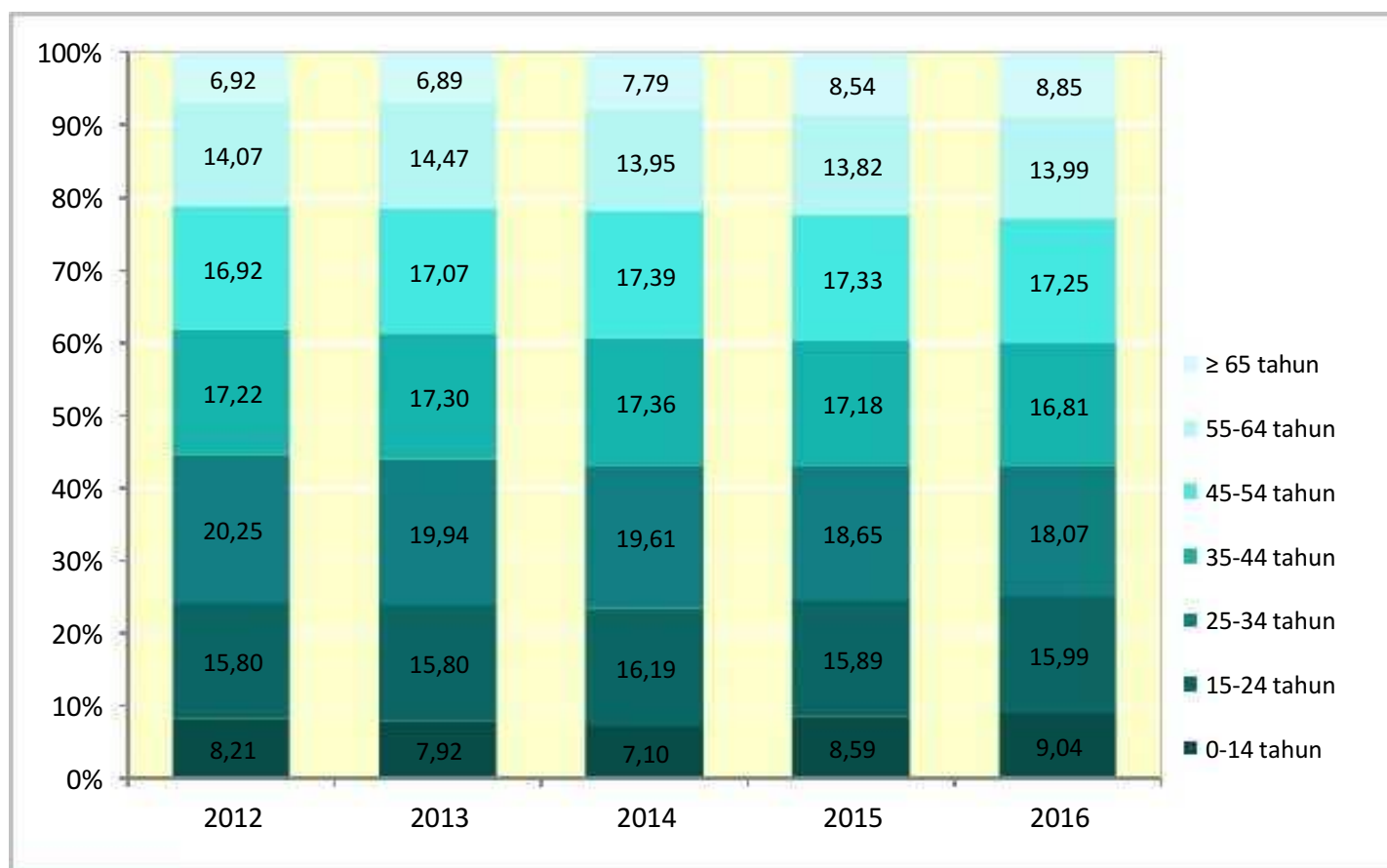
Pada RPJMN 2015-2019, indikator yang digunakan adalah prevalensi tuberkulosis berbasis mikroskopis saja sehingga angkanya lebih rendah dari hasil survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014 yang telah menggunakan metode yang lebih sensitif yaitu konfirmasi bakteriologis yang mencakup pemeriksaan mikroskopis, molekuler dan kultur. Target prevalensi tuberkulosis tahun 2015 dalam RPJMN sebesar 280 per 100.000 penduduk dengan capaian sebesar 263 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2016 target sebesar 271 per 100.000 penduduk dengan capaian sebesar 257 per 100.000 penduduk. Berdasarkan capaian tahun 2015 dan 2016 tersebut, maka dapat diprediksi bahwa target tahun 2019 dengan metode lama sebesar 245 per 100.000 penduduk dapat tercapai.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2016 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 351.893 kasus, meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2015 yang sebesar 330.729 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia.

Menurut jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu 1,4 kali dibandingkan pada perempuan. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan.

GAMBAR 6.1
PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2012-2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

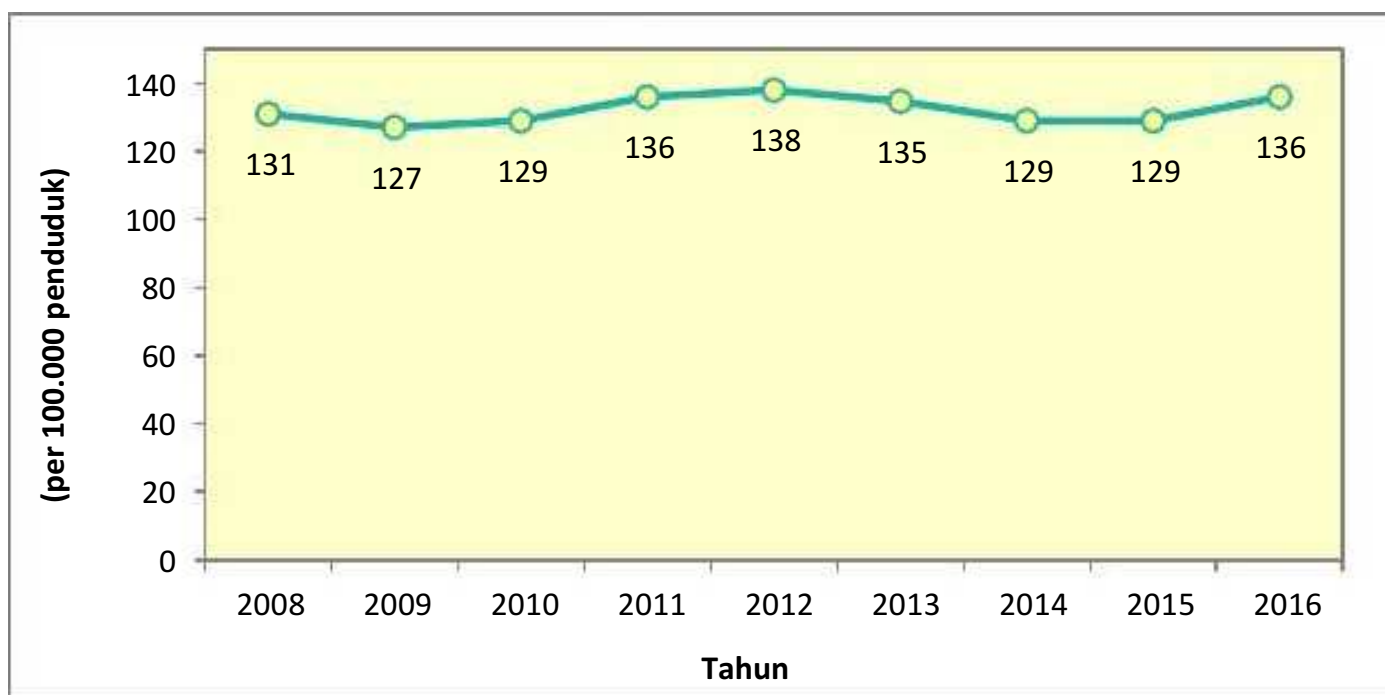
Gambar 6.1. menunjukkan proporsi kasus TB menurut kelompok umur. Pada Tahun 2016 kasus tuberkulosis terbanyak ditemukan pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebesar 18,07% diikuti kelompok umur 45-54 tahun sebesar 17,25% dan pada kelompok umur 35-44 tahun sebesar 16,81%. Pada gambar diatas terlihat bahwa perbedaan proporsi kasus tuberkulosis berdasarkan golongan umur dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak terjadi perubahan signifikan.

c. Angka Notifikasi Kasus atau *Case Notification Rate (CNR)*

Angka notifikasi kasus adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah.

Gambar 6.2 menunjukkan angka notifikasi kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2008-2016. Angka notifikasi kasus tuberkulosis pada tahun 2016 sebesar 136 per 100.000 penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 130 per 100.000 penduduk.

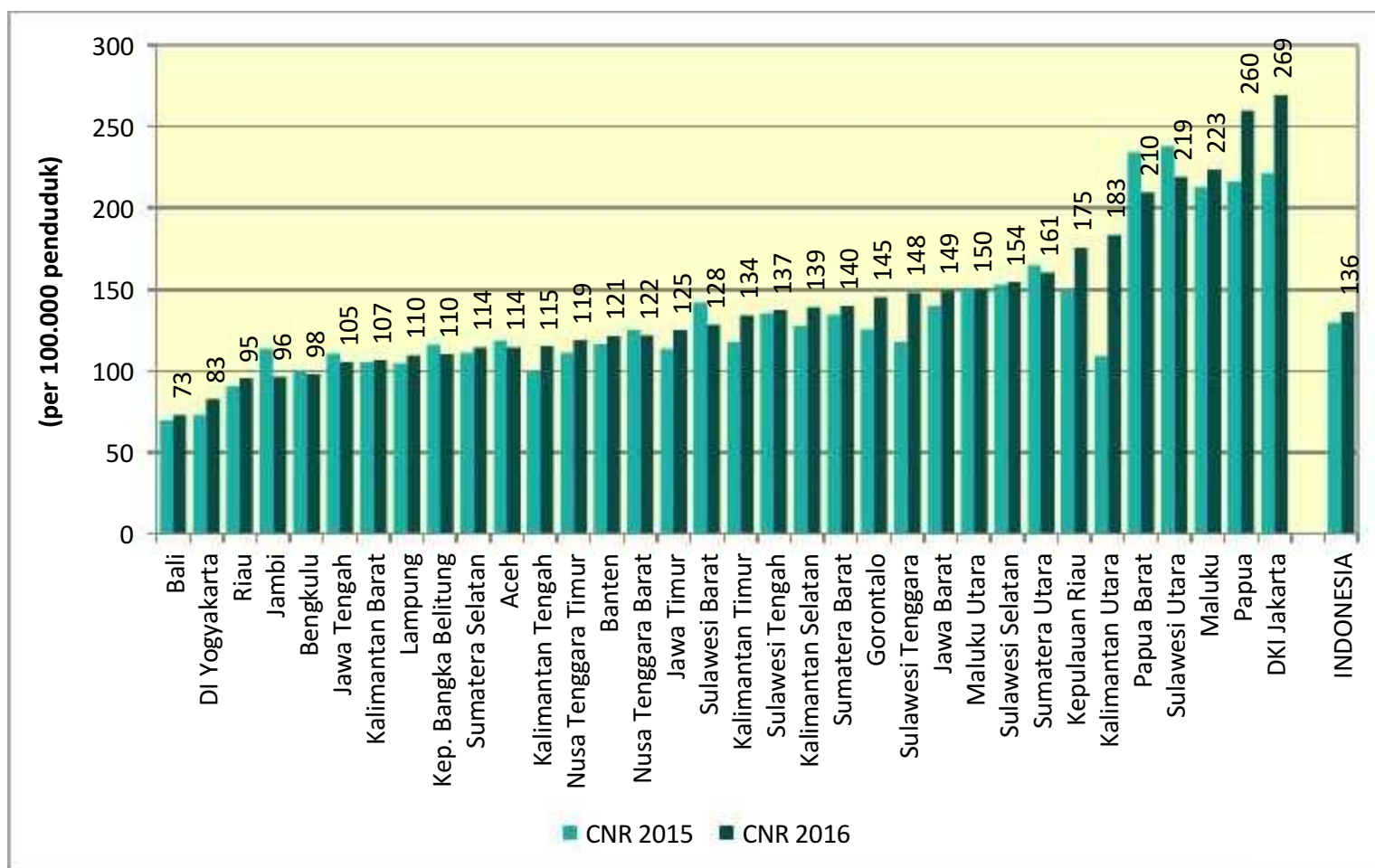
GAMBAR 6.2
ANGKA NOTIFIKASI KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Gambar 6.5 berikut memperlihatkan besarnya angka notifikasi atau *Case Notification Rate* (CNR) semua kasus tuberkulosis menurut provinsi tahun 2016.

GAMBAR 6.3
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



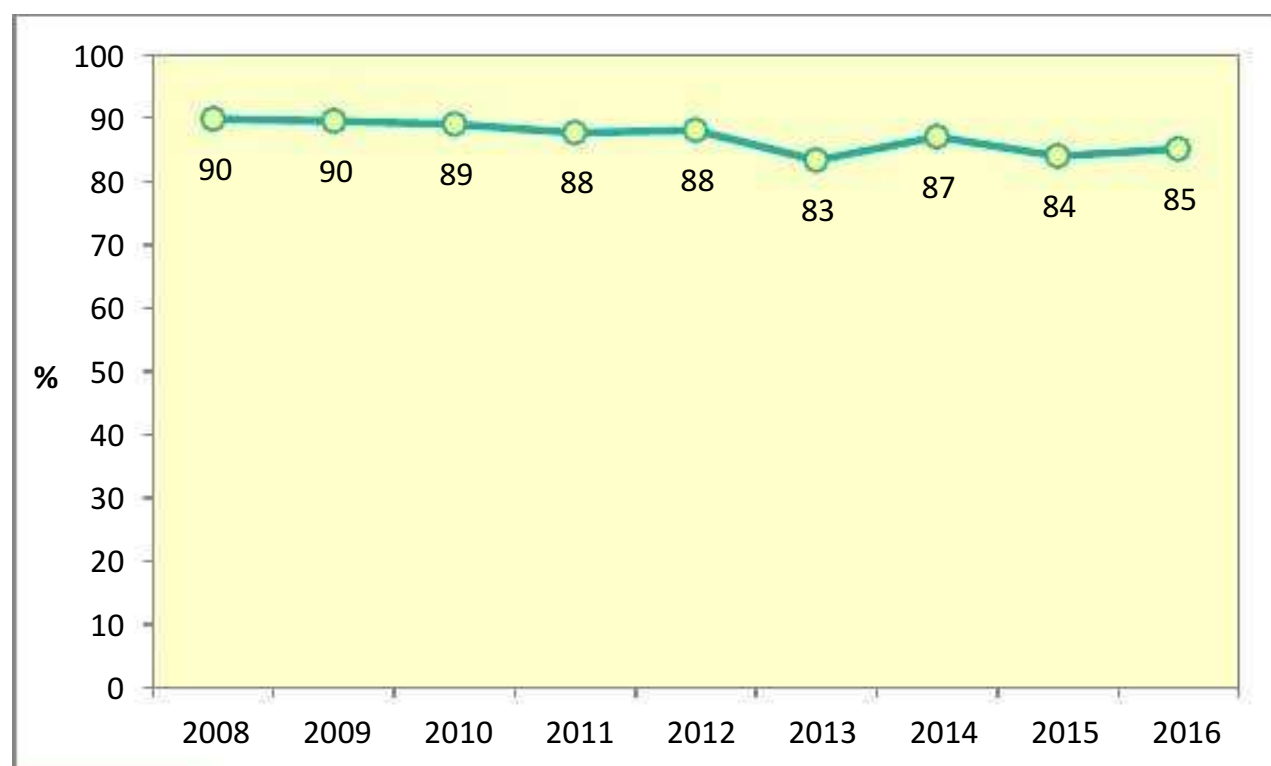
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Provinsi dengan CNR semua kasus tuberkulosis tertinggi yaitu DKI Jakarta (269), Papua (260) dan Maluku (209), dan Papua (223). Sedangkan CNR semua kasus tuberkulosis terendah yaitu Provinsi Bali (73), DI Yogyakarta (83) dan Riau (95). Bila dibandingkan dengan CNR semua kasus TB tahun 2015 terdapat 24 provinsi (71%) yang mengalami kenaikan CNR dan 10 provinsi (29%) yang mengalami penurunan CNR.

d. Angka Keberhasilan Pengobatan

Salah satu upaya untuk mengendalikan tuberkulosis yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis melalui angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*). Angka keberhasilan pengobatan merupakan jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh (*cure*) dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Berikut ini digambarkan angka keberhasilan pengobatan tahun 2008-2016.

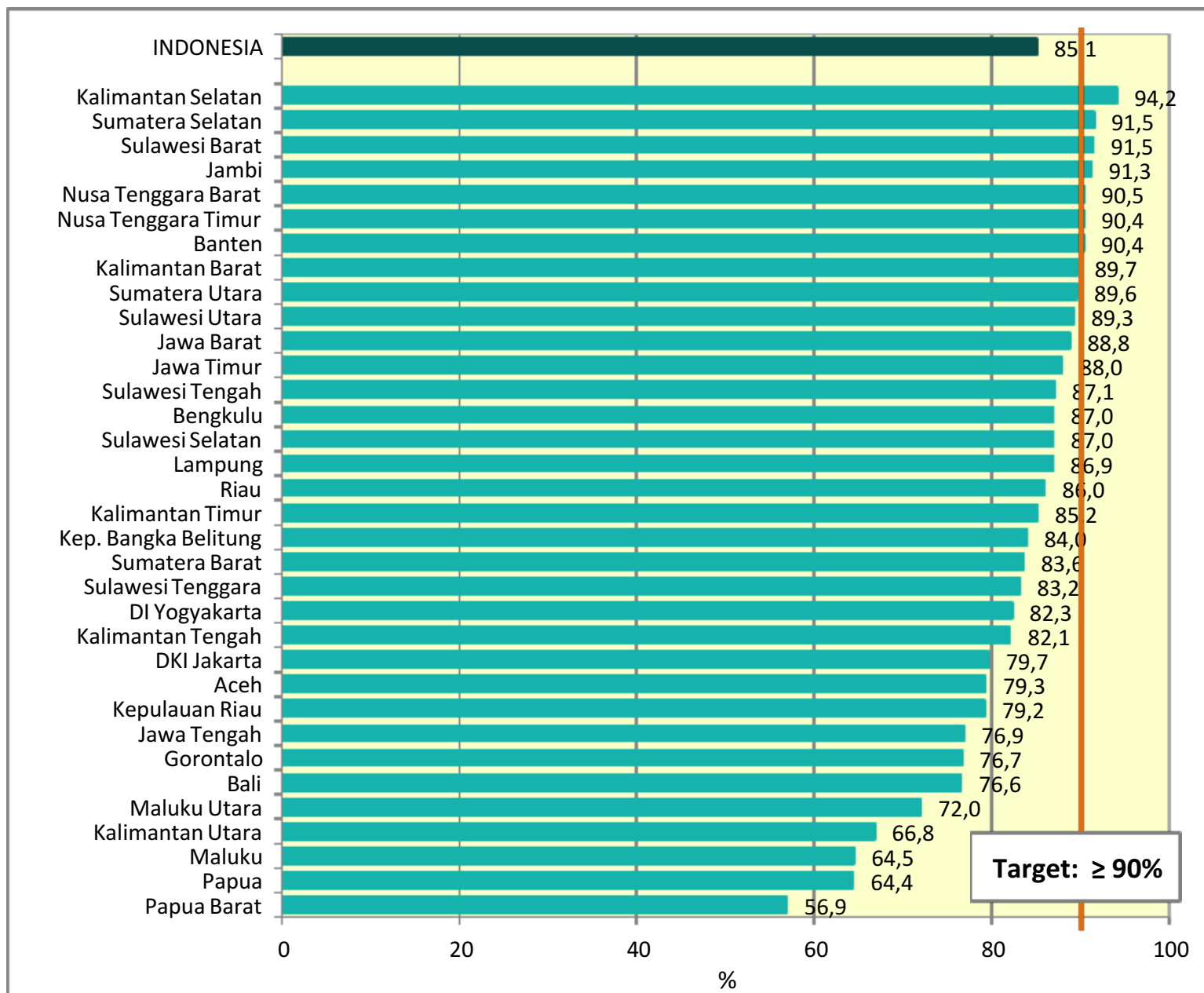
GAMBAR 6.4
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2008-2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Pada Gambar 6.4 terlihat penurunan angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis pada tahun 2013 dan 2015 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis sebesar 85%. Angka kesembuhan semua kasus yang harus dicapai minimal 85% sedangkan angka keberhasilan pengobatan semua kasus minimal 90%.

GAMBAR 6.5
ANGKA KEBERHASILAN PENGobatan PASIEN TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan angka keberhasilan pengobatan kasus tuberkulosis semua tipe per provinsi tertinggi Kalimantan Selatan (94,2%) dan terendah Papua Barat (56,9%). Ada 7 provinsi atau 20,6% provinsi yang sudah mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus tuberkulosis semua tuberkulosis diatas 90% yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Banten.

Informasi mengenai tuberkulosis menurut indikator, jenis kelamin, dan provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.1-6.7.

2. HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut

menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.

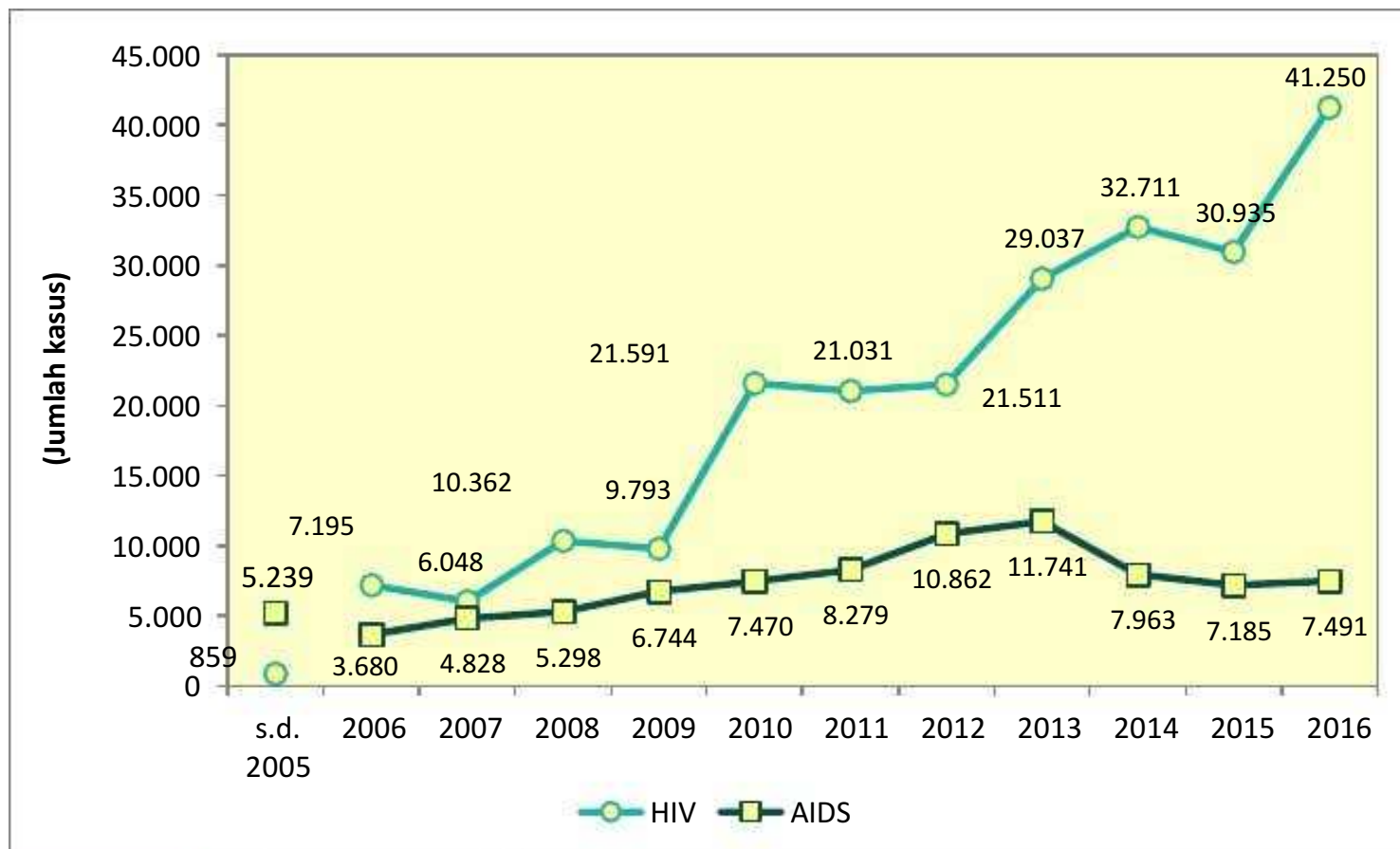
Estimasi dan proyeksi jumlah orang dengan HIV/AIDS pada umur ≥ 15 tahun di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebanyak 785.821 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 90.915 orang dan kematian sebanyak 40.349 orang (Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011-2016, Kemenkes RI).

a. Jumlah Kasus HIV Positif dan AIDS

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode *sero survey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Jumlah kasus baru HIV positif dan AIDS yang dilaporkan sampai dengan tahun 2016 disajikan pada Gambar 6.8.

GAMBAR 6.6
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA
SAMPAI TAHUN 2016



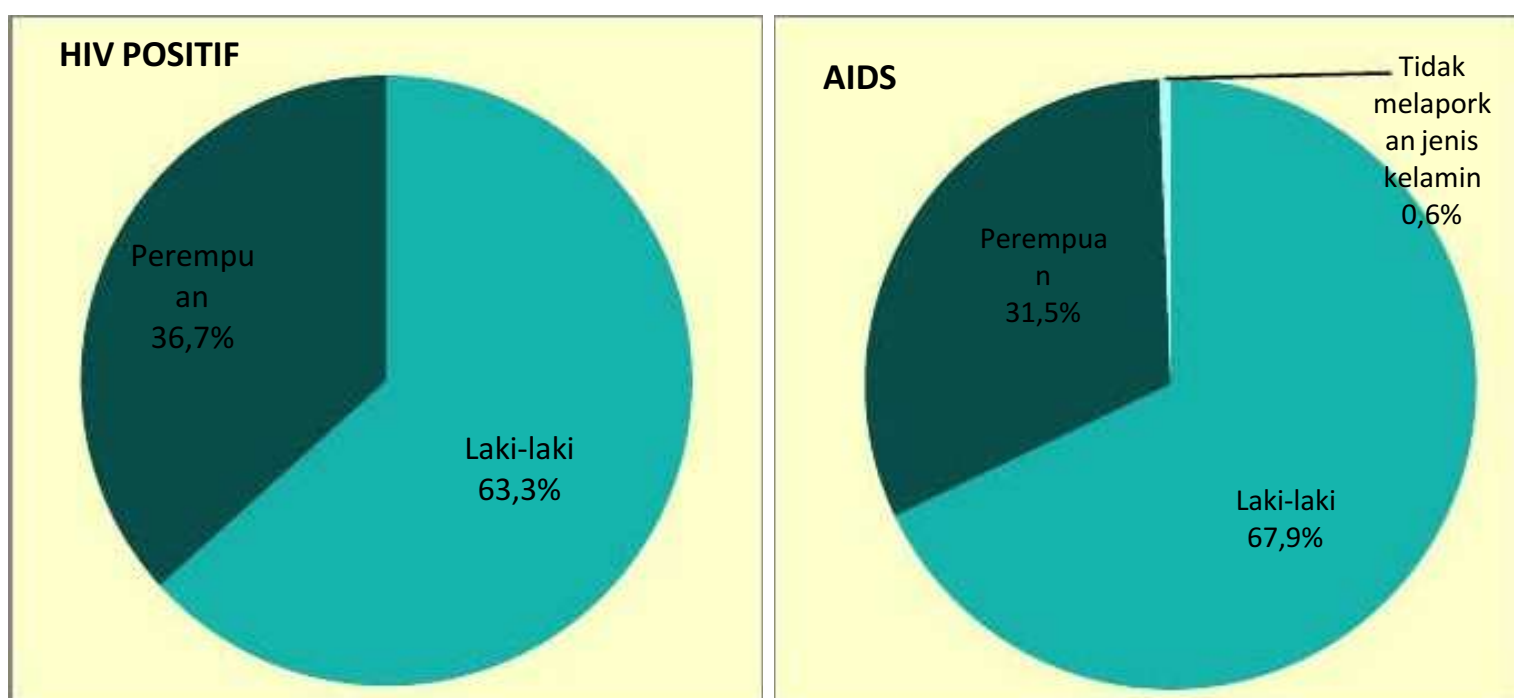
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Jumlah kasus baru HIV positif yang dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan pada tahun 2016 dilaporkan sebanyak 41.250 kasus.

Sedangkan jumlah kasus AIDS terlihat adanya kecenderungan peningkatan penemuan kasus baru sampai tahun 2013 yang kemudian cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi karena jumlah pelaporan kasus AIDS dari daerah masih rendah. Pada tahun 2016 kasus AIDS yang dilaporkan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 7.491. Secara kumulatif, kasus AIDS sampai dengan tahun 2016 sebesar 86.780 kasus.

Menurut jenis kelamin, persentase kasus baru HIV positif dan AIDS tahun 2016 pada laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan seperti digambarkan di bawah ini.

GAMBAR 6.7
PROPORSI KASUS BARU HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2016

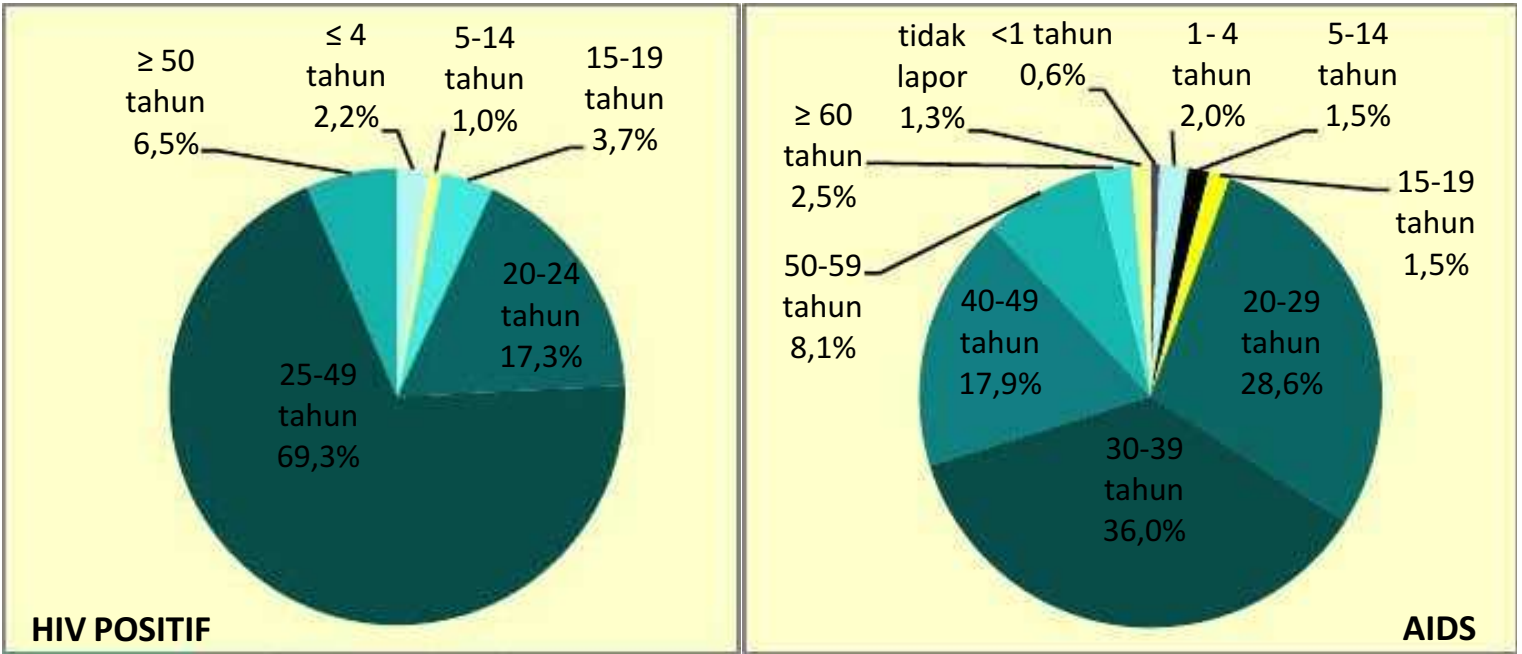


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Penderita HIV positif pada laki-laki sebesar 63,3% dan pada perempuan sebesar 36,7%. Sedangkan penderita AIDS pada laki-laki sebesar 67,9% dan pada perempuan sebesar 31,5%.

Menurut kelompok umur, persentase kasus baru HIV positif dan AIDS tahun 2016 seperti digambarkan di bawah ini.

GAMBAR 6.8
PERSENTASE KASUS BARU HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2016

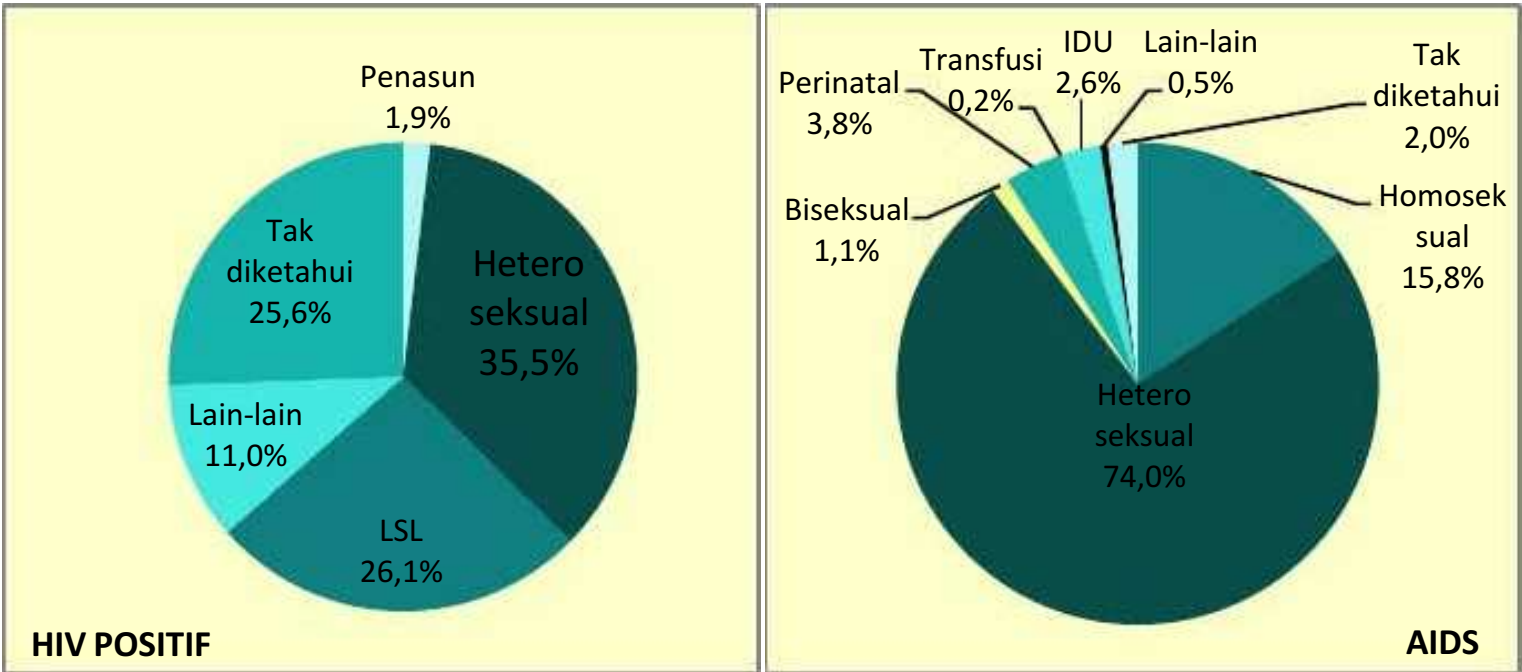


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Penemuan Kasus HIV dan AIDS pada usia di bawah 4 tahun menandakan masih ada penularan HIV dari ibu ke anak yang diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya sebagai upaya mencapai tujuan nasional dan global dalam rangka *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi. Proporsi terbesar kasus HIV dan AIDS masih pada penduduk usia produktif (15-49 tahun), dimana kemungkinan penularan terjadi pada usia remaja.

HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, tranfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian dan penularan dari ibu ke anak (perinatal). Berikut ini disajikan persentase kasus HIV positif dan AIDS menurut faktor risiko penularan yang dilaporkan pada tahun 2016.

GAMBAR 6.9
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA
TAHUN 2016



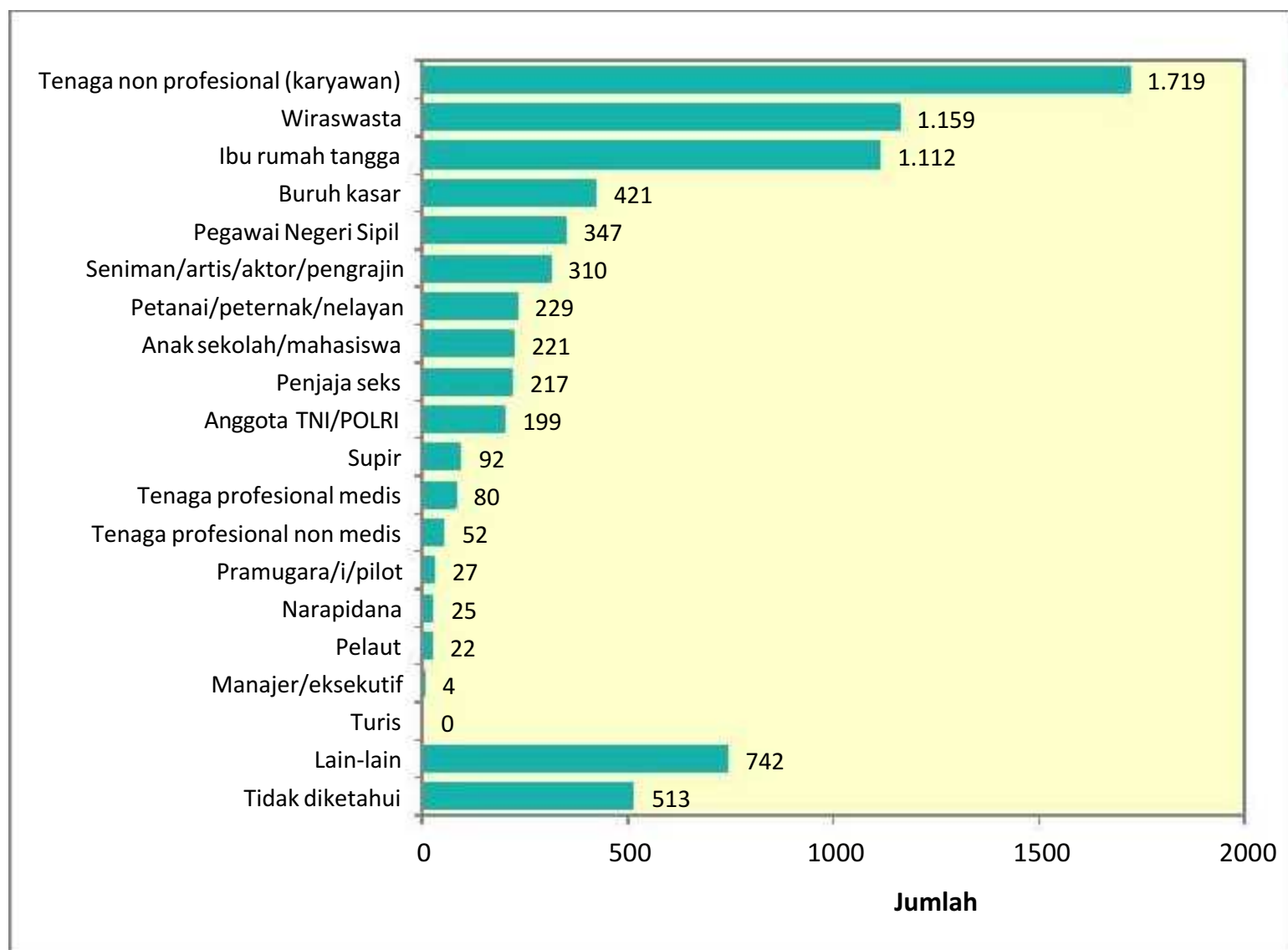
Keterangan: LSL: Laki-laki Seks Laki-laki

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Pada gambar di atas terlihat bahwa pada kasus yang dilaporkan tahun 2016, proporsi kasus HIV AIDS terbesar terjadi pada heteroseksual diikuti oleh homoseksual. Sedangkan kasus AIDS pada perinatal sebesar 3,8%. Sedangkan proporsi pengguna narkoba suntikan (penasun) sebesar 1,9% kasus HIV positif dan 2,6% kasus AIDS.

Distribusi kasus AIDS menurut jenis pekerjaan terbanyak pada tenaga non profesional (karyawan) (22,9%), wiraswasta (15,5%) dan ibu rumah tangga (14,8%).

GAMBAR 6.10
JUMLAH KASUS AIDS MENURUT PEKERJAAN
DI INDONESIA TAHUN 2016



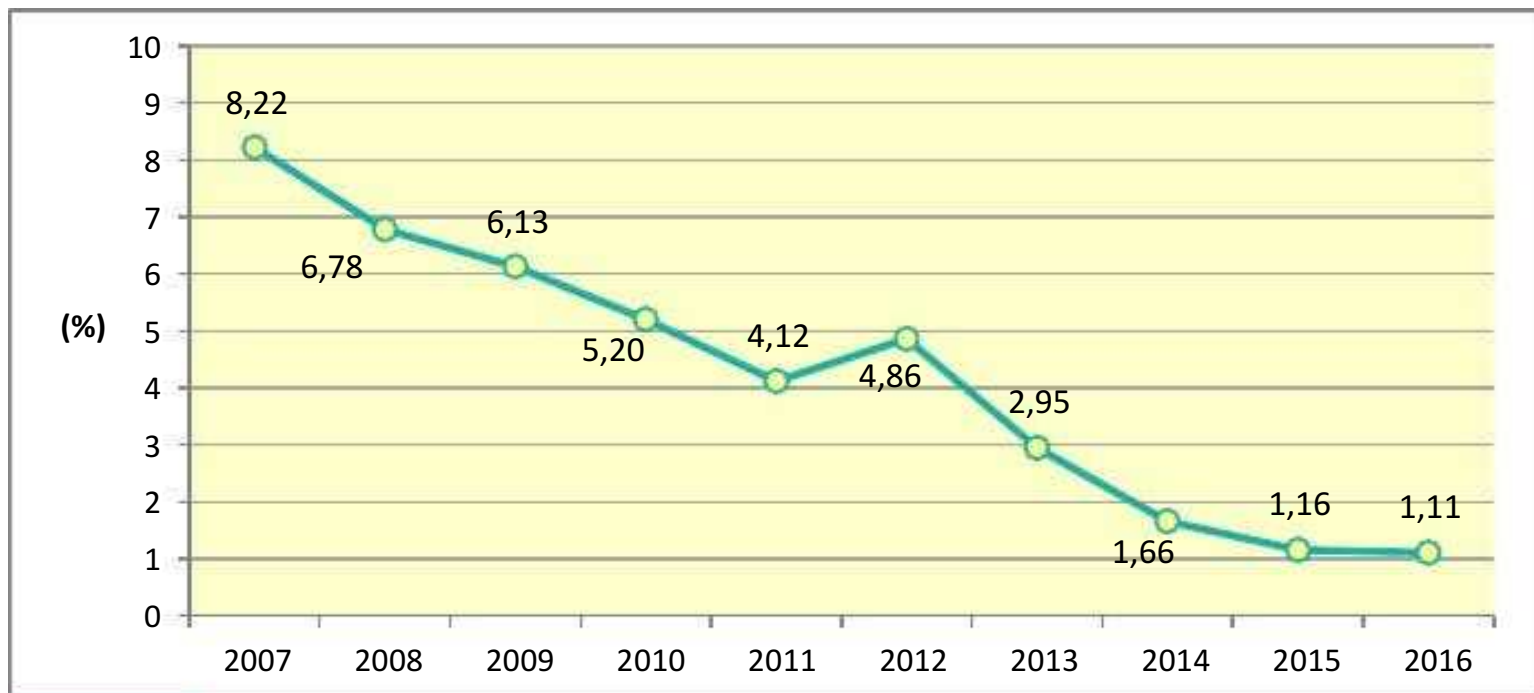
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Pada tahun 2016 AIDS dilaporkan bersamaan dengan penyakit penyerta terbanyak adalah kandidiasis (280 kasus), tuberkulosis (194 kasus) dan diare (173 kasus).

b. Angka Kematian Akibat AIDS

Angka kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) akibat AIDS dari tahun ke tahun cenderung menurun seperti terlihat pada Gambar 6.13 berikut ini. Pada tahun 2016 CFR AIDS di Indonesia sebesar 1,1%.

GAMBAR 6.11
ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN
TAHUN 2004-2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

c. Layanan Konseling dan Tes HIV Sukarela

Layanan Tes dan Konseling HIV (TKHIV), adalah suatu layanan untuk mengetahui adanya infeksi HIV di tubuh seseorang. Konseling dan tes HIV merupakan pintu masuk utama pada layanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV.

Proses TKHIV dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling (TIPK) yaitu tes HIV yang dianjurkan atau ditawarkan oleh petugas kesehatan kepada pasien pengguna layanan kesehatan sebagai komponen standar layanan kesehatan di fasilitas tersebut.
2. Konseling dan tes HIV Sukarela (KTS) yaitu layanan tes HIV secara pasif. Pada layanan tersebut klien datang sendiri untuk meminta dilakukan tes HIV atas berbagai alasan baik ke fasilitas kesehatan atau layanan tes HIV berbasis komunitas.

Selama tahun 2016 terdapat 3.771 layanan tes dan konseling HIV yang aktif melaporkan data layanannya. Dari layanan tersebut didapatkan jumlah klien berkunjung sebanyak 1.545.285 orang. Sebanyak 98,1 % atau 1.515.725 orang menjalani tes HIV dan 2,7% (41.250 orang) mendapatkan hasil positif HIV. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.11.

3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan bakteri. Gejala penyakit

pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak, dan sesak napas.

Pneumonia merupakan penyebab dari 16% kematian balita, yaitu diperkirakan sebanyak 920.136 balita di tahun 2015. Pneumonia menyerang semua umur di semua wilayah, namun terbanyak adalah di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara (www.who.int, *fact sheet, pneumonia*, updated September 2016). Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Tahun 2016 perkiraan kasus pneumonia secara nasional sebesar 3,55% namun angka perkiraan kasus di masing-masing provinsi menggunakan angka yang berbeda-beda sesuai angka yang telah ditetapkan.

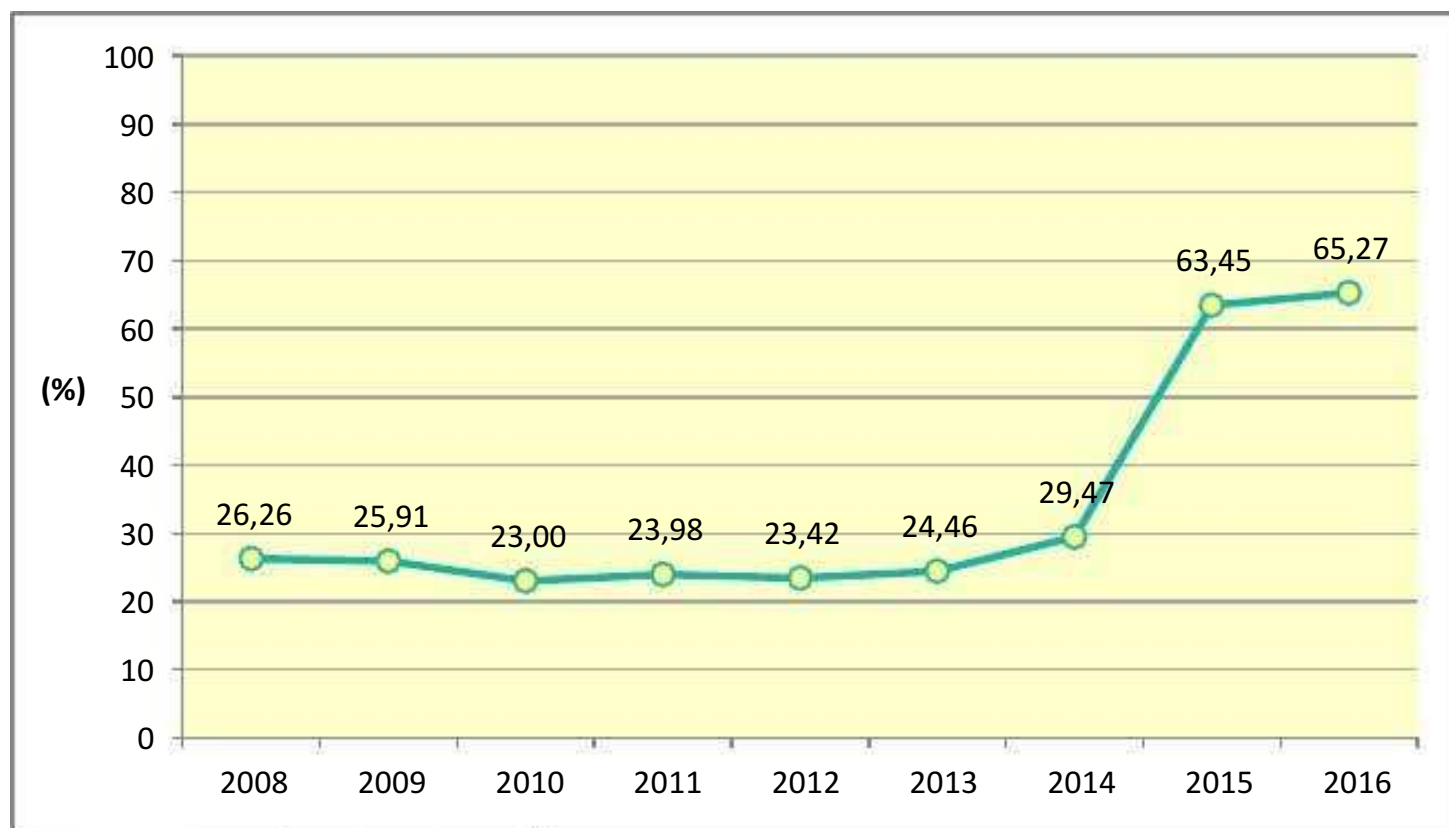
TABEL 6.1
PERKIRAAN PERSENTASE KASUS PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2016

No	Provinsi	Perkiraan Kasus (%)	No	Provinsi	Perkiraan Kasus (%)
1	Aceh	4,46	18	Nusa Tenggara Barat	6,38
2	Sumatera Utara	2,99	19	Nusa Tenggara Timur	4,28
3	Sumatera Barat	3,91	20	Kalimantan Barat	2,12
4	Riau	2,67	21	Kalimantan Tengah	4,37
5	Jambi	3,15	22	Kalimantan Selatan	5,53
6	Sumatera Selatan	3,61	23	Kalimantan Timur	2,86
7	Bengkulu	2,00	24	Sulawesi Utara	2,68
8	Lampung	2,23	25	Sulawesi Tengah	5,19
9	Kep. Bangka Belitung	6,05	26	Sulawesi Selatan	3,79
10	Kepulauan Riau	3,98	27	Sulawesi Tenggara	3,84
11	DKI Jakarta	4,24	28	Gorontalo	4,84
12	Jawa Barat	4,62	29	Sulawesi Barat	4,88
13	Jawa Tengah	3,61	30	Maluku	3,74
14	DI Yogyakarta	4,32	31	Maluku Utara	2,29
15	Jawa Timur	4,45	32	Papua Barat	2,88
16	Banten	4,12	33	Papua	2,80
17	Bali	2,05		INDONESIA	3,55

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI

Cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 6.12
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2008-2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Sampai dengan tahun 2014, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 20%-30%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 63,45% dan menjadi 65,27% pada tahun 2016. Peningkatan cakupan pada tahun 2015 karena perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%, selain itu ada peningkatan dalam kelengkapan pelaporan dari 83,08% pada tahun 2014 menjadi 91,91% pada tahun 2015 dan 94,12% pada tahun 2016.

Sejak tahun 2015 indikator Renstra yang digunakan adalah persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit). Pada tahun 2015 tercapai 14,62% dari 513 kab/kota yang dilaporkan, sedangkan target sebesar 20%. Pada tahun 2016 tercapai 28,07% dari target 30%. Belum tercapainya target disebabkan antara lain belum tersosialisasinya penambahan variabel untuk mengukur indikator Renstra sampai di tingkat puskesmas, sehingga banyak puskesmas tidak melaporkan variabel tersebut. Selain itu sosialisasi tata laksana standar juga belum merata ke seluruh puskesmas.

Angka kematian akibat pneumonia pada balita tahun 2016 sebesar 0,11% sedangkan tahun 2015 sebesar 0,16%. Pada tahun 2016 Angka kematian akibat pneumonia pada kelompok umur 1-4 sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 0,13% dibandingkan pada kelompok bayi yang sebesar 0,06%. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 6.12 dan 6.13.

4. Kusta

Penyakit kusta atau lepra atau penyakit Hansen merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae* dan utamanya mempengaruhi kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Bakteri lepra mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2–3 minggu, daya tahan hidup di luar tubuh manusia mencapai 9 hari, dan memiliki masa inkubasi 2–5 tahun bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

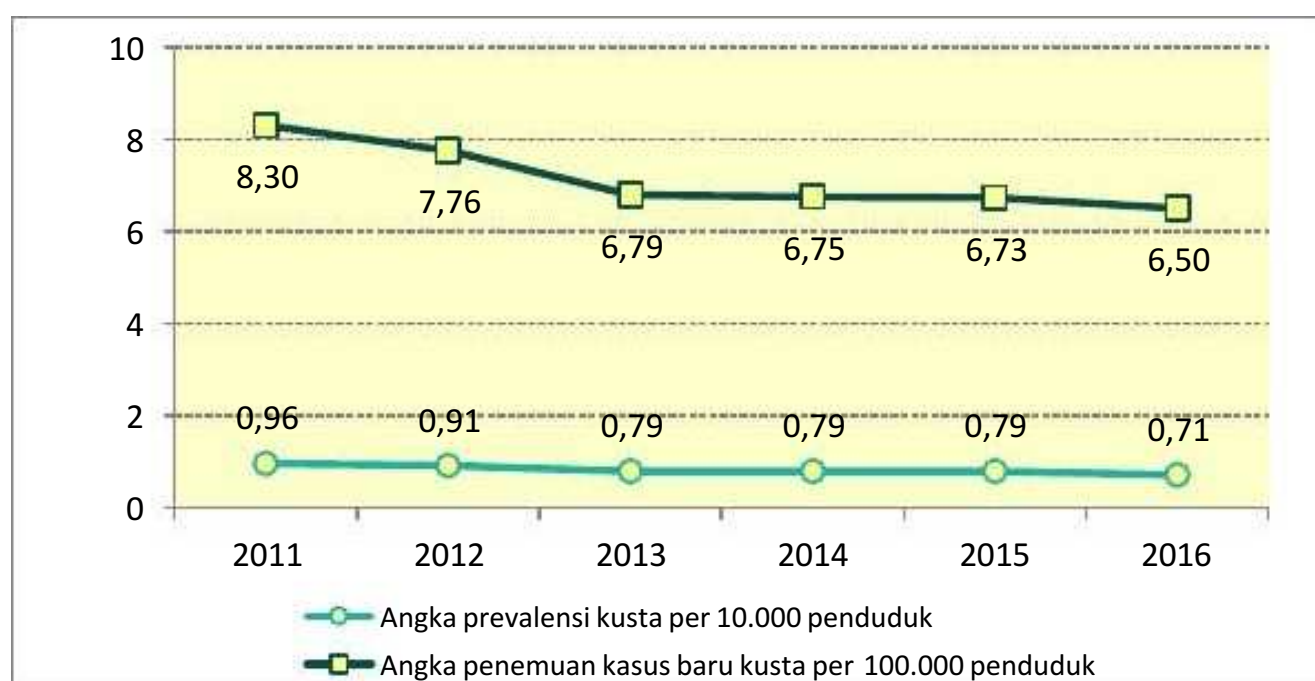
Jumlah penderita kusta yang dilaporkan dari 38 negara di semua regional WHO adalah sebanyak 176.176 kasus di akhir tahun 2015 atau 0,18 kasus per 10.000 penduduk dengan 211.973 kasus baru atau 0,21 kasus per 10.000 penduduk (www.who.int, *Leprosy Fact Sheet, Updated Februari 2017*).

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta, yaitu prevalensi kusta <1 per 10.000 penduduk (<10 per 100.000 penduduk), pada tahun 2000. Setelah itu Indonesia masih bisa menurunkan angka kejadian kusta meskipun relatif lambat. Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 0,71 kasus/10.00 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 6,50 kasus per 100.000 penduduk. Angka kejadian dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 6.16

Pada tahun 2016 dilaporkan 16.826 kasus baru kusta (6,5/100.000 penduduk) dengan 84,19% kasus di antaranya merupakan tipe *Multi Basiler* (MB). Sedangkan menurut jenis kelamin, 62,47% penderita baru kusta berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 37,53% lainnya berjenis kelamin perempuan.

GAMBAR 6.13
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2011-2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Berdasarkan status eliminasi, kusta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu provinsi yang belum eliminasi dan provinsi yang sudah mencapai eliminasi. Provinsi yang sudah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Pada Gambar 6.17 terlihat bahwa dari 34 provinsi, sebanyak 11 provinsi (32,35%) termasuk dalam provinsi yang belum eliminasi. Sedangkan 23 provinsi lainnya (67,65%) termasuk dalam provinsi yang sudah eliminasi.

GAMBAR 6.14
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2015 DAN 2016



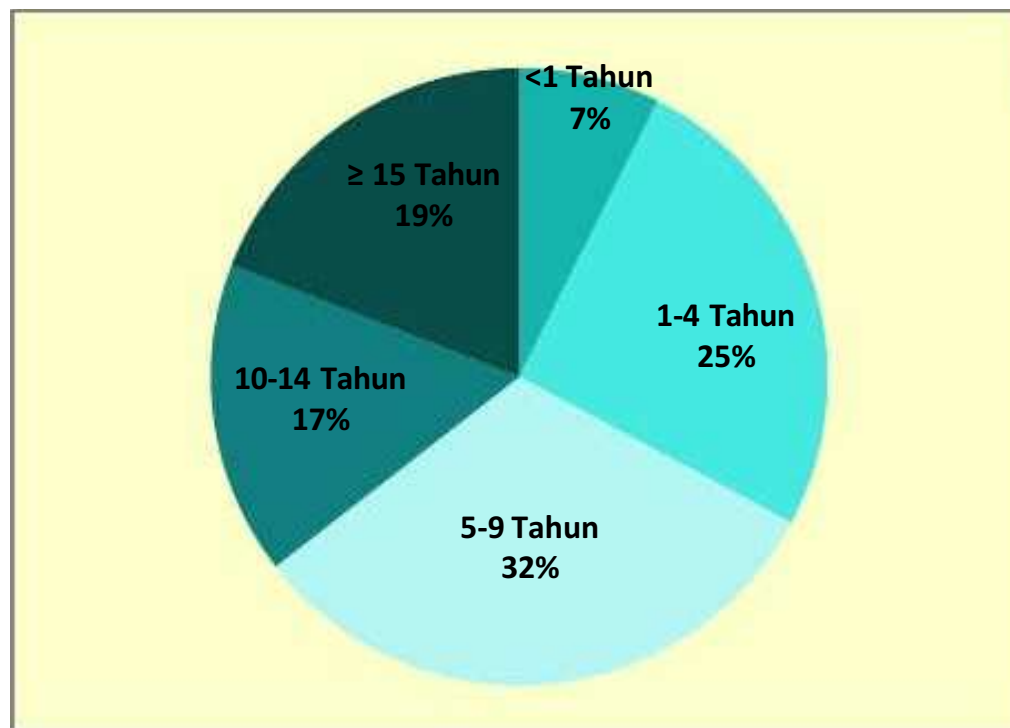
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Di tahun 2016, terdapat penambahan provinsi yang mencapai eliminasi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun 11 provinsi yang belum mencapai eliminasi adalah Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.

b. Angka Cacat Tingkat 2

Pengendalian kasus kusta antara lain dengan meningkatkan deteksi kasus sejak dini. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta salah satunya adalah angka cacat tingkat 2. Angka cacat tingkat 2 pada tahun 2016 adalah sebesar 5,27 per 1.000.000 penduduk, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,60 per 1.000.000 penduduk. Berikut ini grafik angka cacat tingkat 2 tahun 2011-2016.

GAMBAR 6.21
PROPORSI KASUS CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Campak dinyatakan sebagai KLB apabila terdapat 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun 2016, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 129 KLB dengan jumlah kasus sebanyak 1.511 kasus. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan 68 KLB dan jumlah kasus sebanyak 831 kasus.

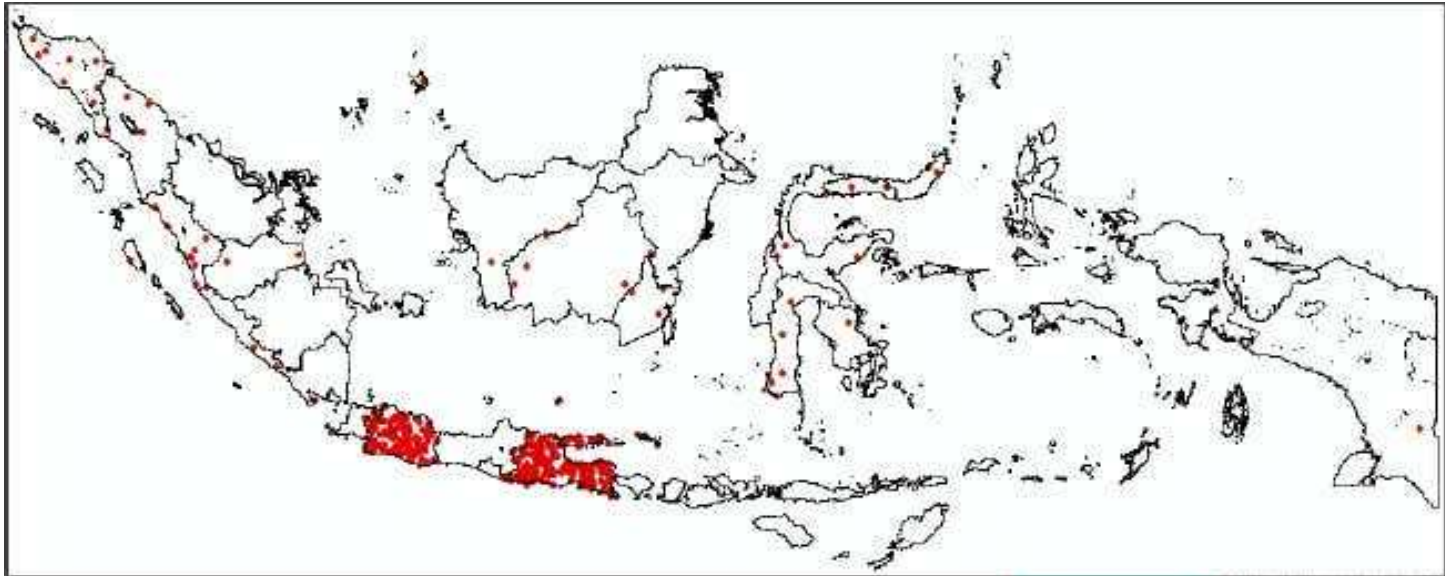
Frekuensi KLB campak tertinggi terjadi di Sumatera Barat sebanyak 33 kejadian KLB dengan 495 kasus dan 1 orang meninggal. Frekuensi KLB campak tertinggi selanjutnya terjadi di Provinsi Jambi sebanyak 27 KLB dengan jumlah 256 kasus campak dan Sumatera Selatan 14 KLB dengan 125 kasus campak. Tidak ada penderita yang meninggal dari kejadian KLB di dua provinsi tersebut. Frekuensi dan jumlah kasus pada KLB campak menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.21.

3. Difteri

Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada umumnya menyerang anak-anak usia 1-10 tahun.

Jumlah kasus difteri pada tahun 2016 sebanyak 415 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 24 kasus sehingga CFR difteri yaitu sebesar 5,8%. Dari jumlah tersebut, kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 209 kasus dan Jawa Barat yaitu sebanyak 133 kasus. Dari seluruh kasus difteri, sebesar 51 % diantaranya tidak mendapatkan vaksinasi.

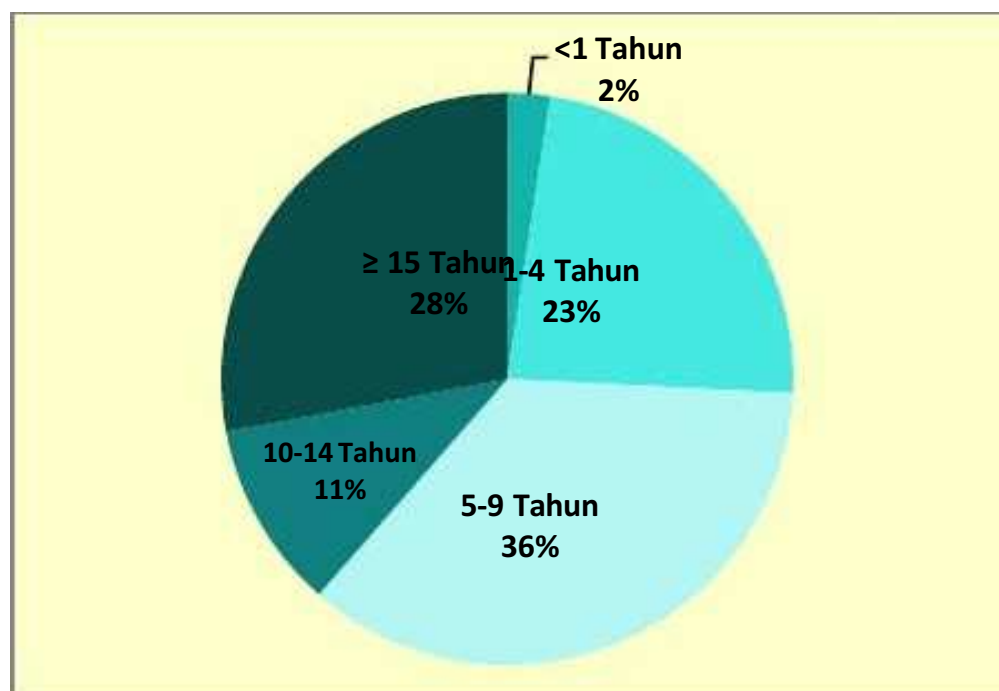
GAMBAR 6.22
SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Gambaran kasus menurut kelompok umur pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 59% kasus difteri terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun dan 1-4 Tahun. Kelompok umur ≥ 15 tahun memiliki rentang usia yang lebih panjang dibanding kelompok umur lainnya sehingga meskipun proporsinya besar, jika dihitung per umur tunggal, kelompok ini memiliki jumlah kasus yang rendah. Rincian kasus difteri per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6. 23.

GAMBAR 6.23
PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

4. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut)

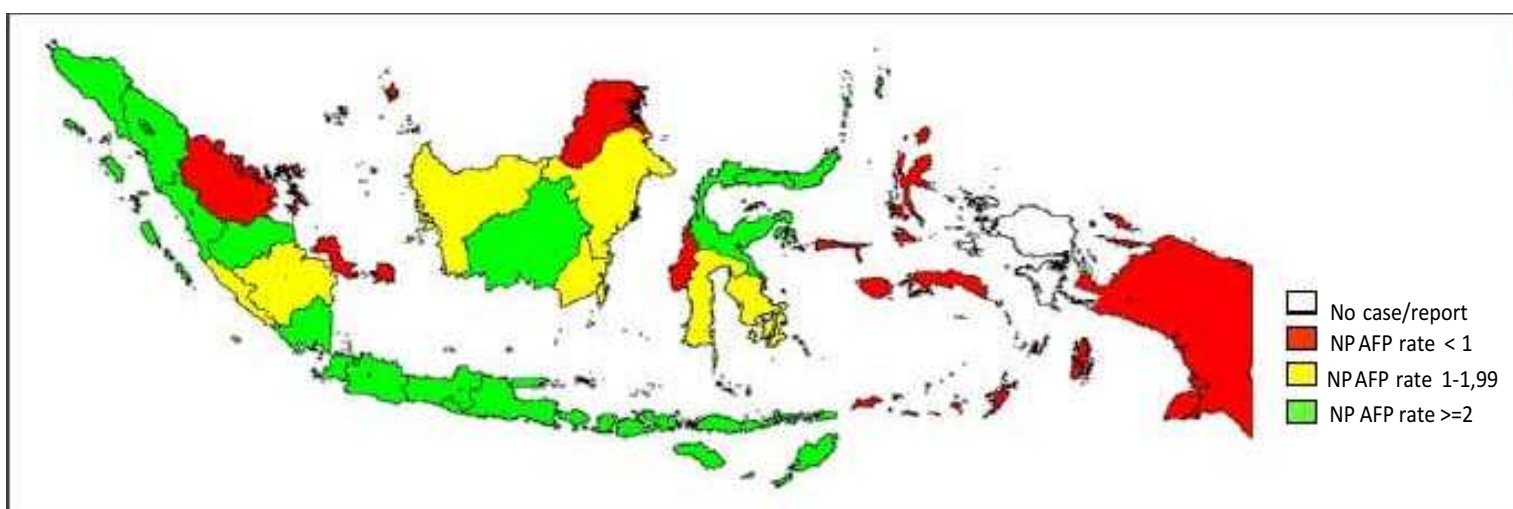
Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf, utamanya menyerang anak balita dan menular terutama melalui fekal-oral. Polio ditandai dengan gejala awal demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. Pada 1 dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya pada tungkai), dan 5-10% dari yang menderita kelumpuhan meninggal karena kelumpuhan pada otot-otot pernafasan.

Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara *South East Asia Region (SEARO)* pada tanggal 27 Maret 2014. Saat ini tinggal 2 negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan yang masih endemik polio. Setelah Indonesia dinyatakan bebas polio, bukan berarti Indonesia menurunkan upaya imunisasi dan surveilans AFP, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan hingga seluruh dunia benar-benar terbebas dari polio.

Surveilans AFP adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut (AFP) pada anak usia <15 tahun, yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio, dalam upaya untuk menemukan adanya transmisi virus polio liar. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans AFP juga penting untuk dokumentasi tidak adanya virus polio liar untuk sertifikasi bebas polio.

Non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan *non polio AFP rate* minimal 2/100.000 populasi anak usia <15 tahun. Pada tahun 2016, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 1,96/100.000 populasi anak <15 tahun yang berarti belum mencapai standar minimal penemuan.

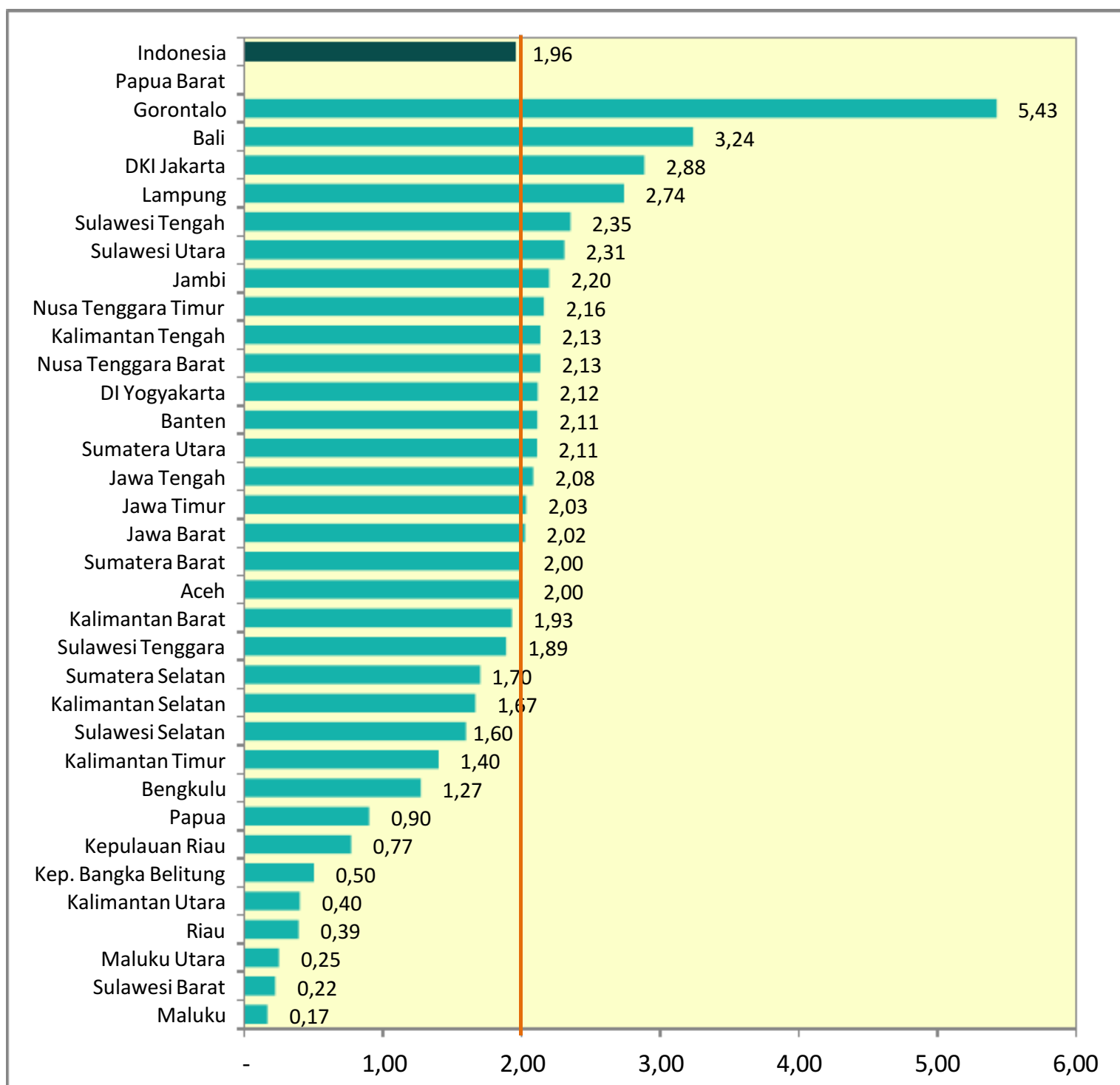
GAMBAR 6.24
PENCAPAIAN *NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 ANAK USIA < 15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Dari 34 provinsi, 18 di antaranya (52,94%) telah mencapai target *non polio AFP rate* ≥ 2 per 100.000 penduduk kurang dari 15 tahun pada tahun 2016, 15 provinsi masih < 2 dan 1 provinsi yaitu Papua Barat belum menyampaikan laporannya.

GAMBAR 6.25
NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2017

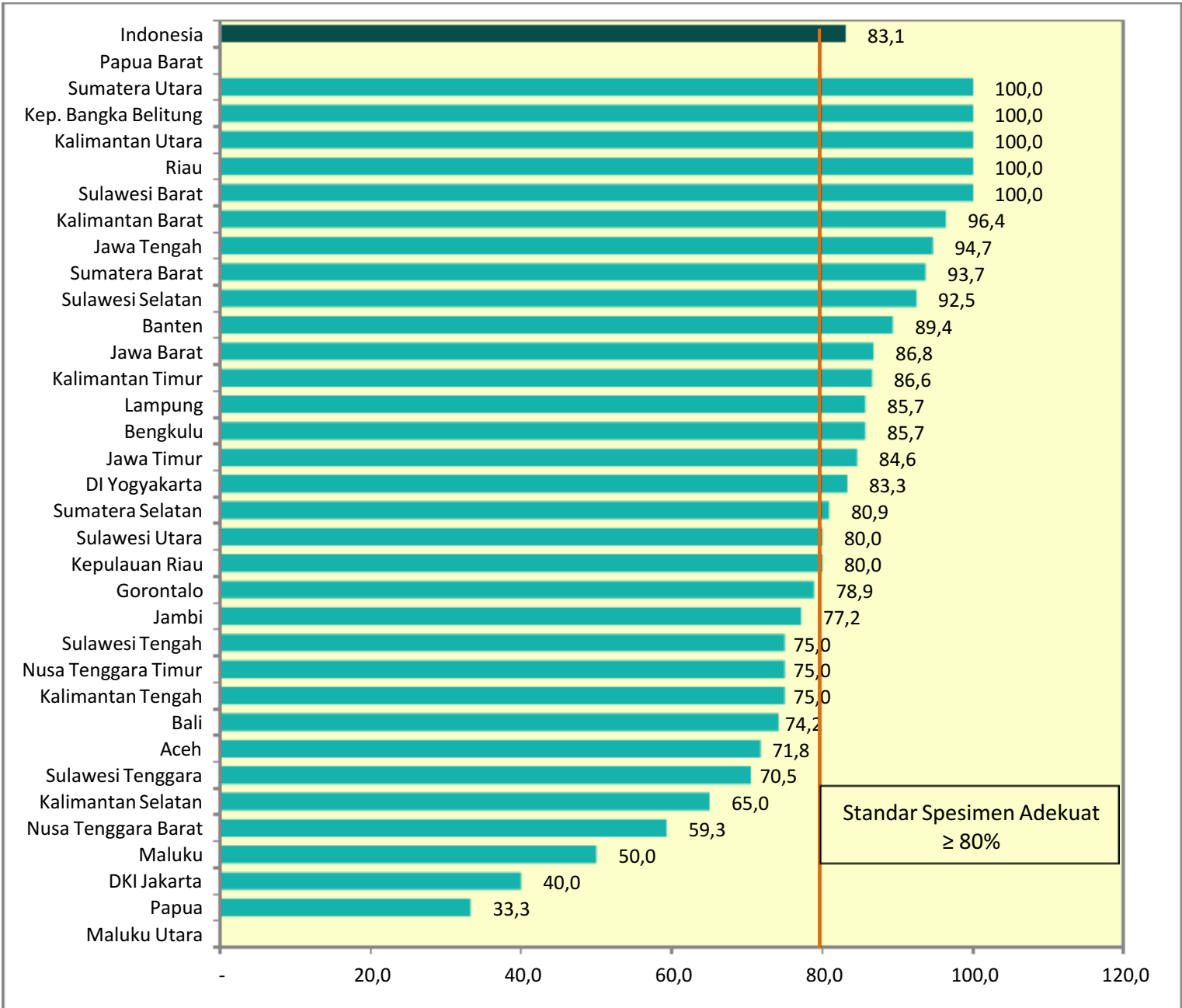
Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar. Untuk itu diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen $0^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ sampai di laboratorium.

GAMBAR 6.26
PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

GAMBAR 6.27
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Standar spesimen adekuat yaitu $\geq 80\%$. Pada tahun 2016 spesimen adekuat di Indonesia sebesar 83,1%. Dengan demikian spesimen adekuat secara nasional telah sesuai standar.

Sebanyak 19 provinsi (55,8%) telah mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2016, 14 provinsi belum mencapai standar dan 1 provinsi yaitu Papua Barat belum menyampaikan laporan.

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.18 - 6.24.

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong *Arthropod-Borne Virus*, genus *Flavivirus*, dan famili *Flaviviridae*. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, terutama *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

a. Incidence Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR)

Tahun 2016 terdapat jumlah kasus DBD sebanyak 204.171 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.598 orang. Jumlah kasus DBD tahun 2016 meningkat dibandingkan jumlah kasus tahun 2015 (129.650 kasus). Jumlah kematian akibat DBD tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015 (1.071 kematian). *IR* atau angka kesakitan DBD tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015, yaitu 50,75 menjadi 78,85 per 100.000 penduduk. Namun, *Case Fatality Rate (CFR)* mengalami penurunan dari 0,83% pada tahun 2015 menjadi 0,78% pada tahun 2016. Berikut tren angka kesakitan DBD selama kurun waktu 2010-2016.

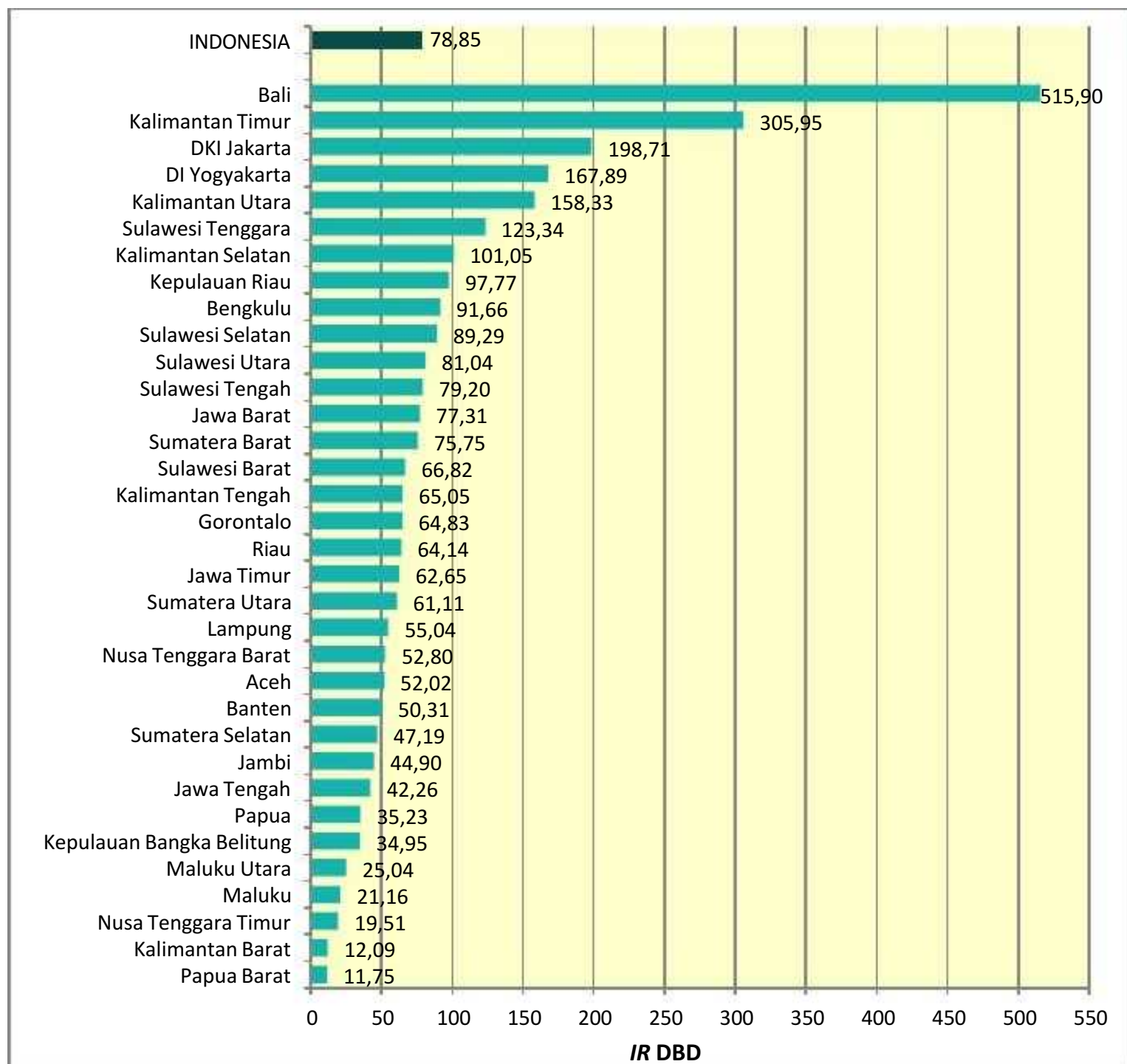
GAMBAR 6.28
ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2010-2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Gambaran angka kesakitan DBD menurut provinsi tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 6.29. Pada tahun 2016 terdapat 10 provinsi dengan angka kesakitan kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan angka kesakitan DBD tertinggi yaitu Bali sebesar 515,90 per 100.000 penduduk, Kalimantan Timur sebesar 305,95 per 100.000 penduduk, dan DKI Jakarta sebesar 198,71 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan pada provinsi Bali dan Kalimantan Timur meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2015, dimana Bali sebesar 257,75 per 100.000 penduduk dan Kalimantan Timur sebesar 188,46 per 100.000 penduduk. Kenaikan drastis juga terjadi di DKI Jakarta yaitu pada tahun 2015 angka kesakitan DBD hanya 48,55 per 100.000 penduduk menjadi 198,71 per 100.000 pada tahun 2016. Kenaikan angka kesakitan tersebut perlu mendapat perhatian khusus.

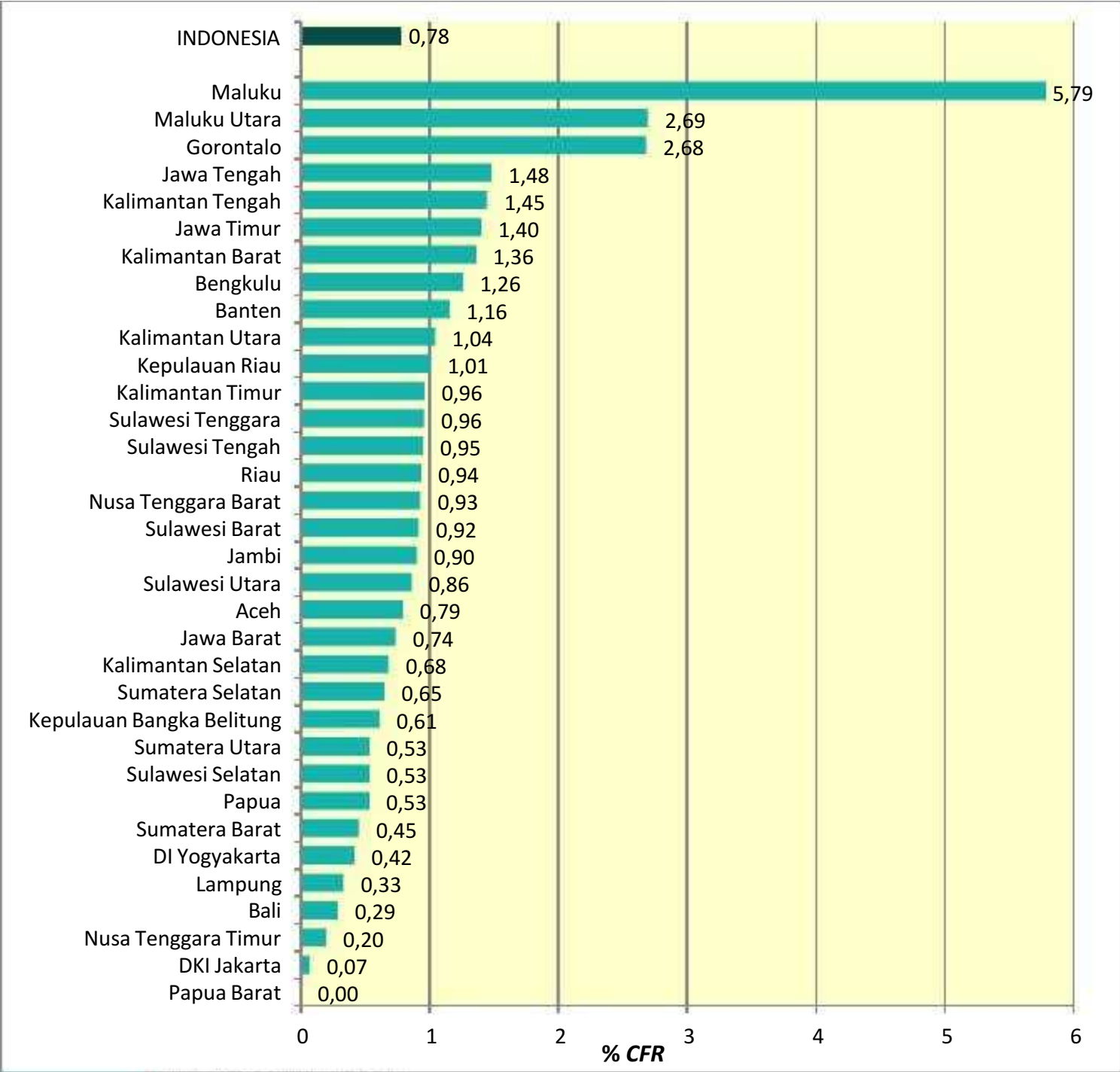
GAMBAR 6.29
ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Kematian *CFR* akibat DBD lebih dari 1% dikategorikan tinggi. Pada tahun 2016 terdapat 11 provinsi yang memiliki *CFR* tinggi dimana 3 provinsi dengan *CFR* tertinggi adalah Maluku (5,79%), Maluku Utara (2,69%), dan Gorontalo (2,68%). Pada provinsi-provinsi dengan *CFR* tinggi masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan pengetahuan masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan jika ada gejala DBD sehingga tidak terlambat ditangani dan bahkan menyebabkan kematian. *CFR* menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 6.30.

GAMBAR 6.30
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



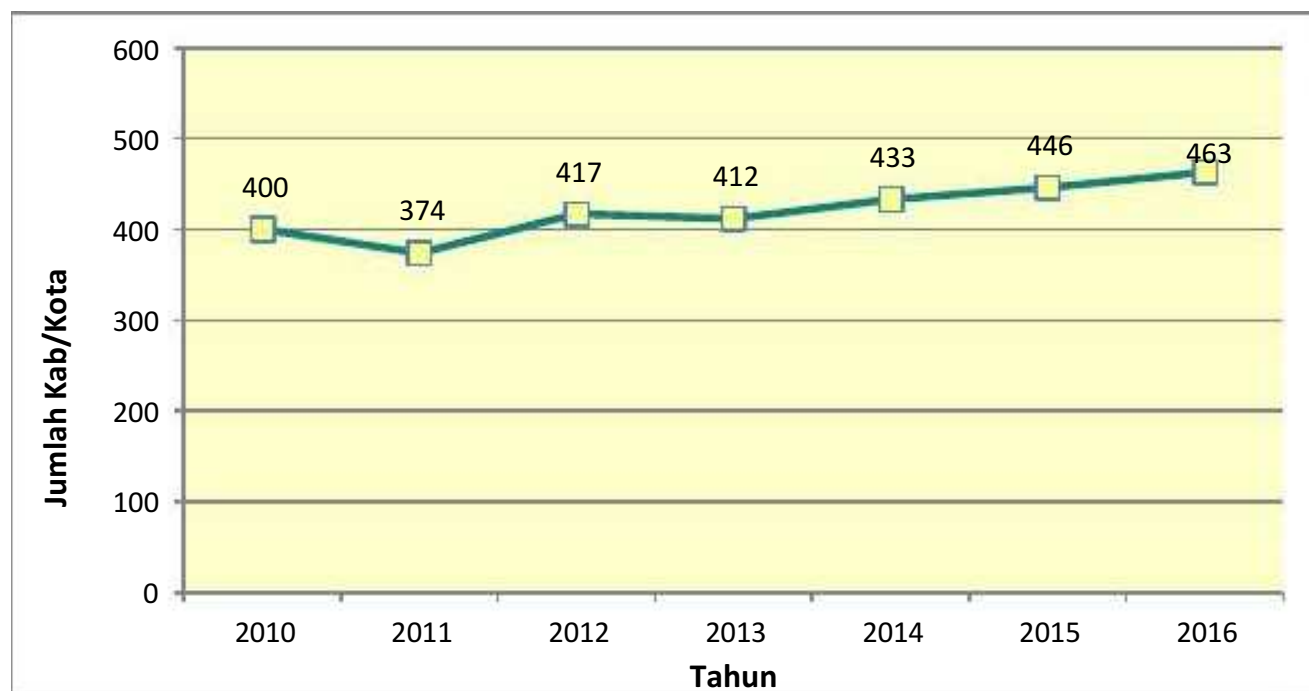
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

b. Kabupaten/kota Terjangkit DBD

Kenaikan angka kesakitan DBD pada tahun 2016 juga diiringi oleh peningkatan jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD. Pada tahun 2015 terdapat 446 (86,77%) menjadi 463 Kabupaten/Kota (90,07%) pada tahun 2016. Gambar 6.31 menunjukkan tren jumlah

kabupaten/kota terjangkit pada tahun 2010-2016. Selama periode tahun 2010 sampai tahun 2016 terlihat jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD mengalami kenaikan.

GAMBAR 6.31
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2010-2016



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2017

c. Angka Bebas Jentik

Salah satu indikator yang digunakan untuk upaya pengendalian penyakit DBD yaitu angka bebas jentik (ABJ). Sampai dengan tahun 2016, ABJ secara nasional belum mencapai target program yang sebesar $\geq 95\%$.

GAMBAR 6.32
ANGKA BEBAS JENTIK
DI INDONESIA TAHUN 2010-2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Walaupun belum memenuhi target program, ABJ tahun 2016, yaitu sebesar 67,6% meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 54,2%. Hal ini dapat disebabkan Puskesmas sudah mulai menggalakkan kembali kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) secara rutin sehingga kegiatan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) sudah mulai digalakkan kembali. Selain itu, pelaporan data ABJ sudah mulai mencakup sebagian wilayah kabupaten/kota di Indonesia sehingga cakupan ABJ juga semakin meningkat.

Data penyakit DBD lebih rinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.27 dan Lampiran 6.28.

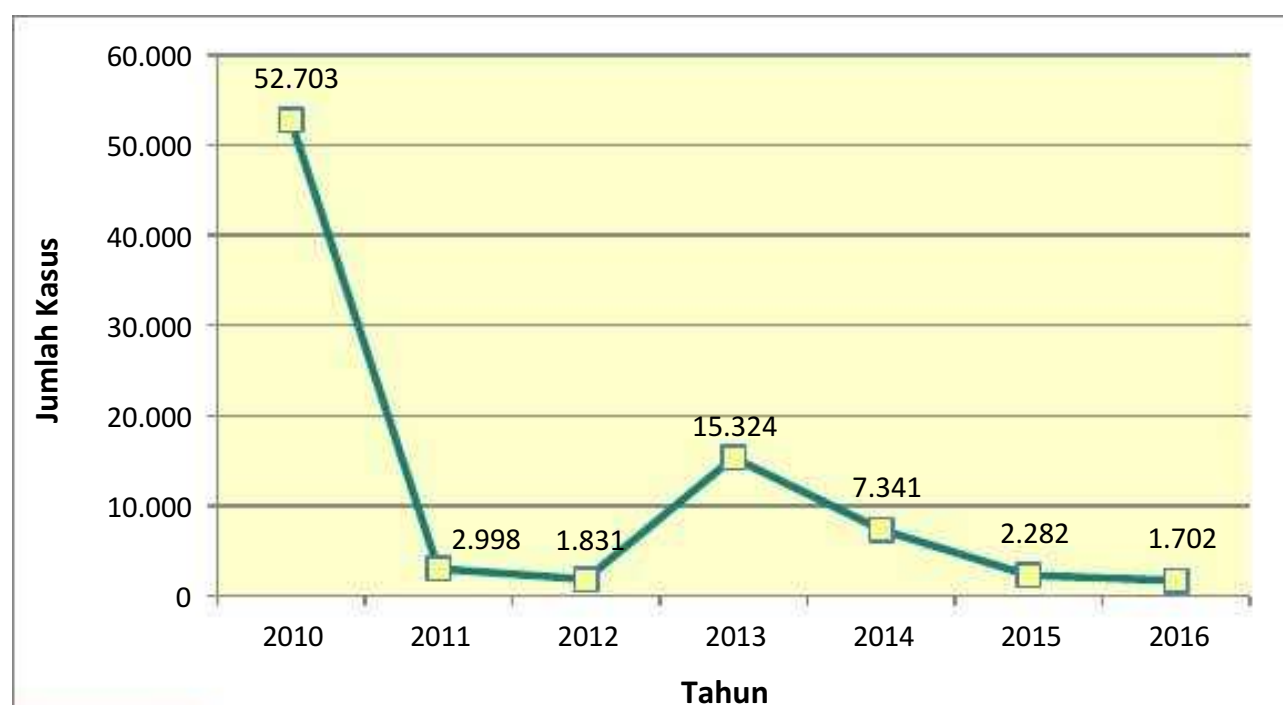
2. Chikungunya

Demam chikungunya (demam chik) adalah suatu penyakit menular dengan gejala utama demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD.

Demam chik dijumpai terutama di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.

Selama tahun 2016 terjadi demam chikungunya sebanyak 1.702 kasus di 20 kabupaten/kota dari 4 provinsi yaitu Jawa Barat (1 kabupaten/kota), Jawa Timur (13 kabupaten/kota), Sulawesi Tengah (5 kabupaten/kota), dan Bali (1 kabupaten/kota). Jumlah kasus demam chikungunya terbanyak terjadi di Jawa Timur sebanyak 1.489 kasus.

GAMBAR 6.33
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2010-2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

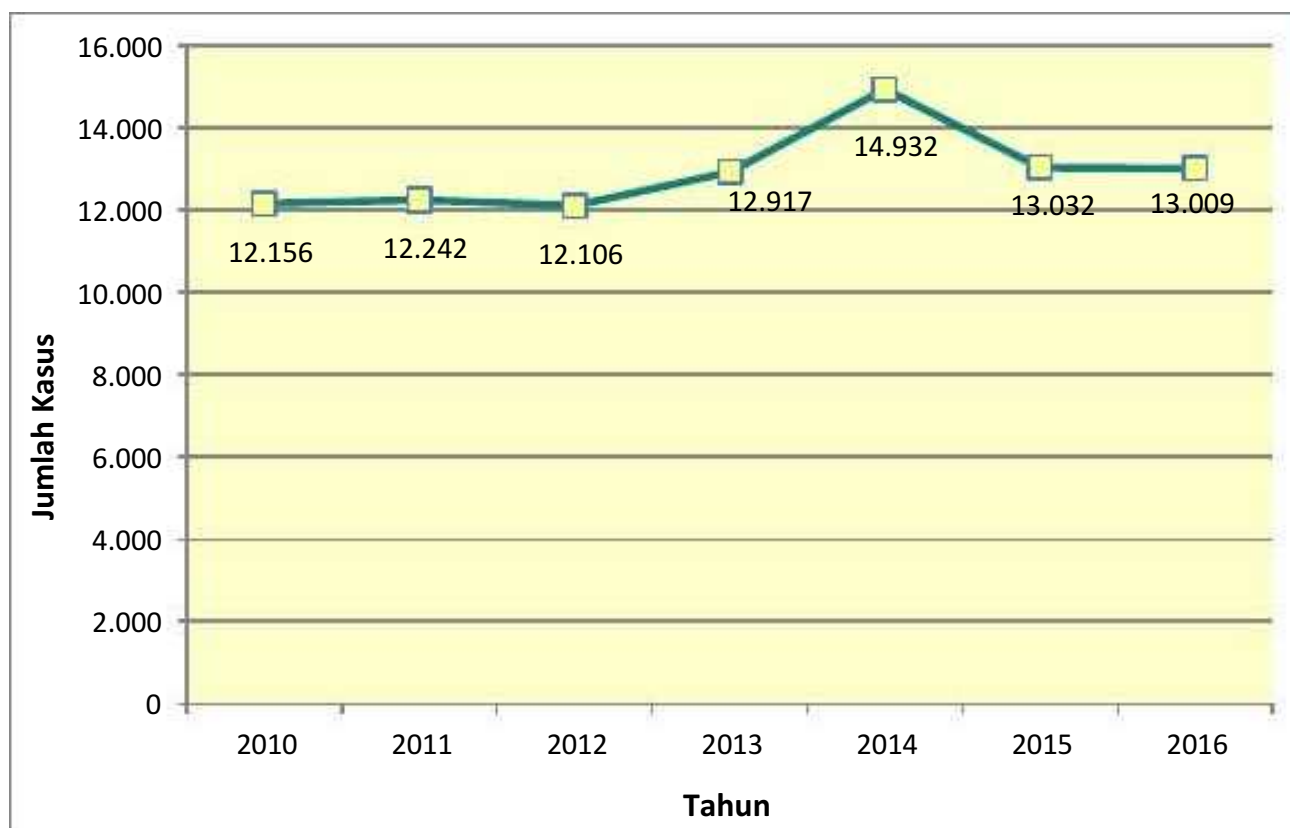
Kejadian demam chikungunya mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan pada tahun 2010-2012, namun kembali meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 dan turun kembali sampai tahun 2016. Hingga saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya. Faktor penyebab turunnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif kering dengan curah hujan yang rendah, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit, sebagian daerah tidak melaporkan kasus chikungunya dan lain-lain.

3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria, yang terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

Sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 WHO menetapkan kesepakatan global (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan penyakit kaki gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara. Di Indonesia, pada tahun 2016 terdapat 13.009 kasus filariasis. Grafik berikut menggambarkan peningkatan kasus filariasis di Indonesia sejak tahun 2010.

GAMBAR 6.34
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS
DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Lima Provinsi dengan kasus kronis filariasis tertinggi pada tahun 2016 yaitu Nusa Tenggara Timur (2.864), Aceh (2.372), dan Papua Barat (1.244), Papua (1.184), dan Jawa Barat (955). Jumlah kasus kronis filariasis di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan pada tahun 2016 menurun menjadi 249 dan 178 kasus dari 270 dan 232 kasus pada tahun 2015. Sedangkan terdapat pula provinsi dengan jumlah kasus kronis filariasis meningkat, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah sebesar 904 dan 504 kasus pada tahun 2015 menjadi 955 dan 505 kasus pada tahun 2016.

Pemberantasan filariasis diwujudkan dengan melaksanakan program eliminasi filariasis agar filariasis tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia pada tahun 2020. Tujuan khusus program eliminasi adalah menurunkan angka mikrofilaria menjadi kurang dari 1% di setiap kabupaten/kota dan mencegah serta membatasi kecacatan karena filariasis. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 22 kabupaten/kota yang melaksanakan eliminasi filariasis. Sebanyak 46 kabupaten/kota berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi kurang dari 1%. Jumlah kabupaten/kota tersebut mencapai target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2016 sebanyak 45 kabupaten/kota.

Indonesia memberantas filariasis sebagai bagian dari eliminasi filariasis global melalui dua pilar kegiatan yaitu: 1. memutuskan mata rantai penularan filariasis dengan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis di daerah endemis sekali setahun selama lima tahun berturut-turut (obat yang dipakai adalah DEC (*Diethylcarbamazine Citrate*) 6 mg/kg BB dikombinasikan dengan Albendazole 400 mg); 2. mencegah dan membatasi kecacatan dengan penatalaksanaan kasus filariasis mandiri.

Pada tahun 2016, berdasarkan hasil pemetaan daerah endemis di Indonesia diperoleh sebanyak 236 kabupaten/kota merupakan daerah endemis filariasis sedangkan daerah non endemis sebanyak 278 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang berisiko tertular filariasis tinggal di daerah endemis sehingga. Sebanyak 181 kabupaten/kota atau sebesar 76,7% dari kabupaten/kota endemis melaksanakan POPM filariasis. Dengan demikian jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan POPM filariasis mencapai target program POPM filariasis tahun 2016 sebesar 170 kabupaten/kota.

Cakupan POPM filariasis selama tujuh tahun terakhir cenderung meningkat, dari 39,4% pada tahun 2010 menjadi 75,1% pada tahun 2016 seperti terlihat pada Gambar 6.35 berikut ini.

GAMBAR 6.35
CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2010 – 2016



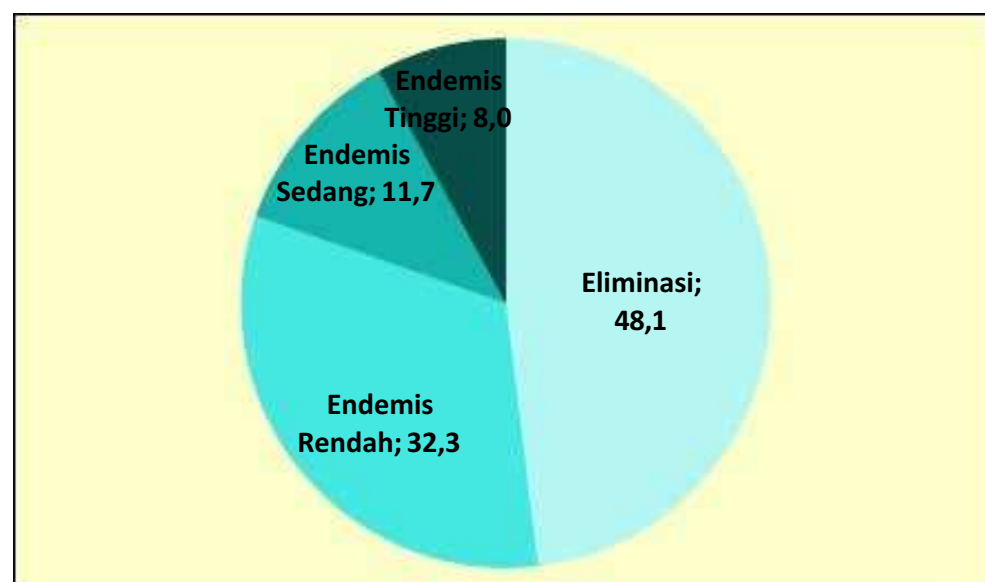
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

4. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa.

Gambar 6.36 menunjukkan bahwa menurut tingkat endemisitas malaria tahun 2016, sebanyak 48,1% kabupaten/kota sudah tersertifikasi bebas malaria, 32,2% kabupaten/kota memiliki status endemis rendah ($API < 1$), 11,7% kabupaten/kota memiliki status endemis sedang ($API 1-5$), dan 8,0% kabupaten/kota memiliki status endemis tinggi ($API > 5$).

GAMBAR 6.36
PROPORSI KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2016

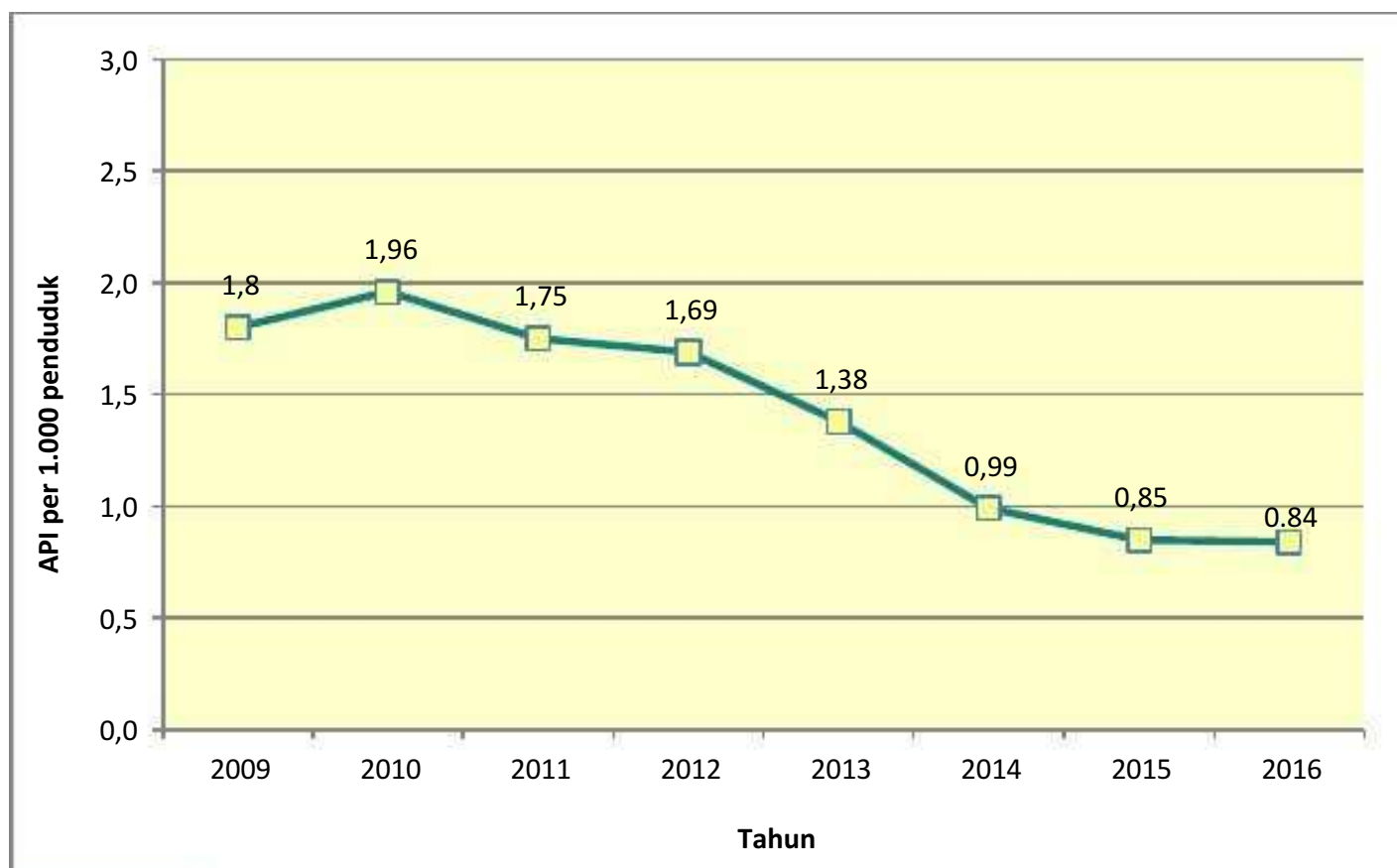


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

a. Angka Kesakitan Malaria

Secara nasional angka kesakitan malaria selama tahun 2009–2016 cenderung menurun yaitu dari 1,8 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2009 menjadi 0,84 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2016. Penurunan API tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.37.

GAMBAR 6.37
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API*)
PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2009-2016

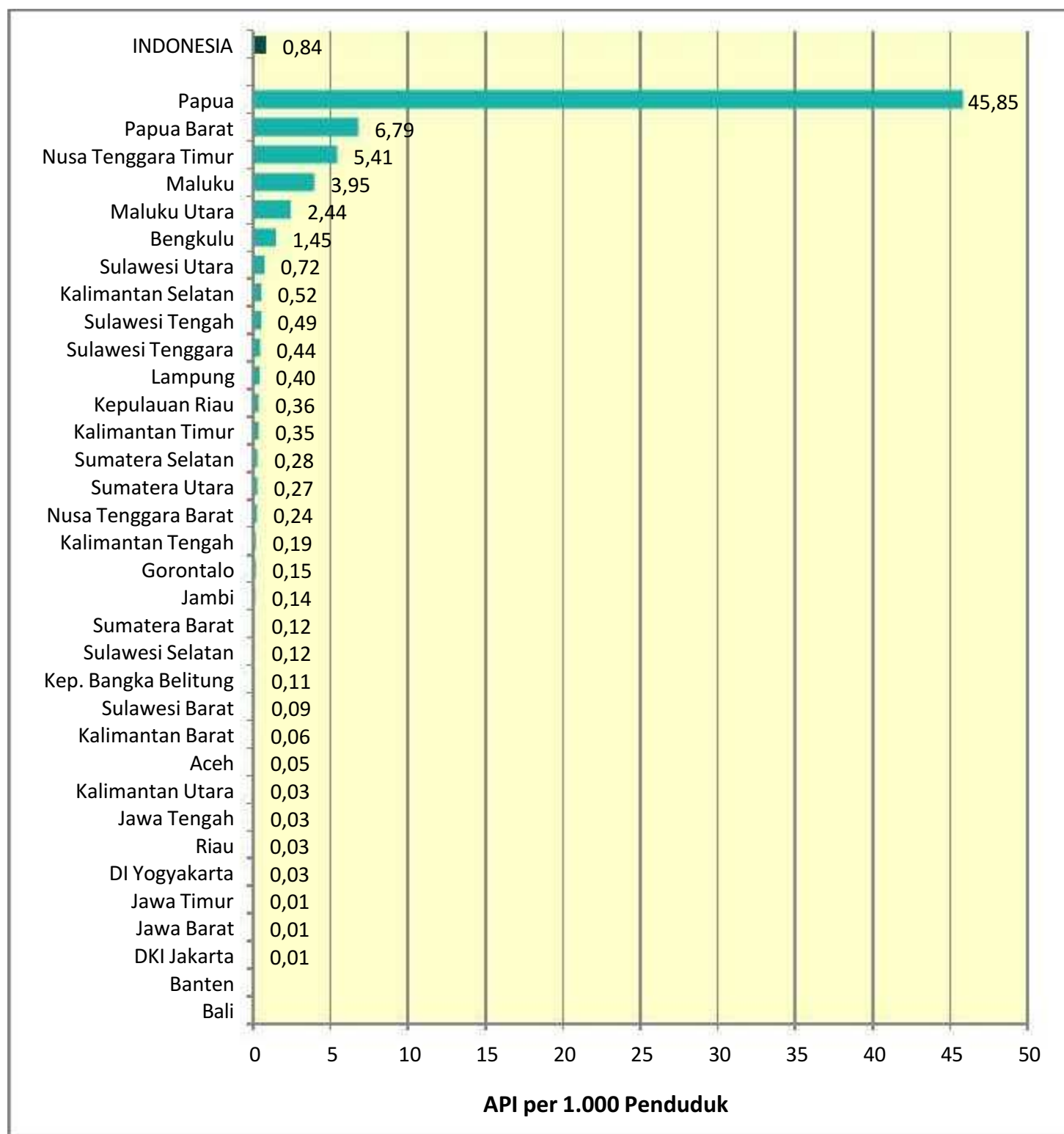


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Papua merupakan provinsi dengan *API* tertinggi, yaitu 45,85 per 1.000 penduduk. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Empat provinsi dengan *API* per 1.000 penduduk tertinggi lainnya, yaitu Papua Barat (10,20), Nusa Tenggara Timur (5,17), Maluku (3,83), dan Maluku Utara (2,44). Sebanyak 83% kasus berasal dari Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Angka kesakitan malaria menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 6.38.

Secara nasional, sebesar 95% suspek malaria diperiksa secara laboratorium (*Rapid Diagnostic Test* dan Mikroskop). Informasi lengkap mengenai jumlah kasus malaria dan jenis tes sediaan darah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.25.

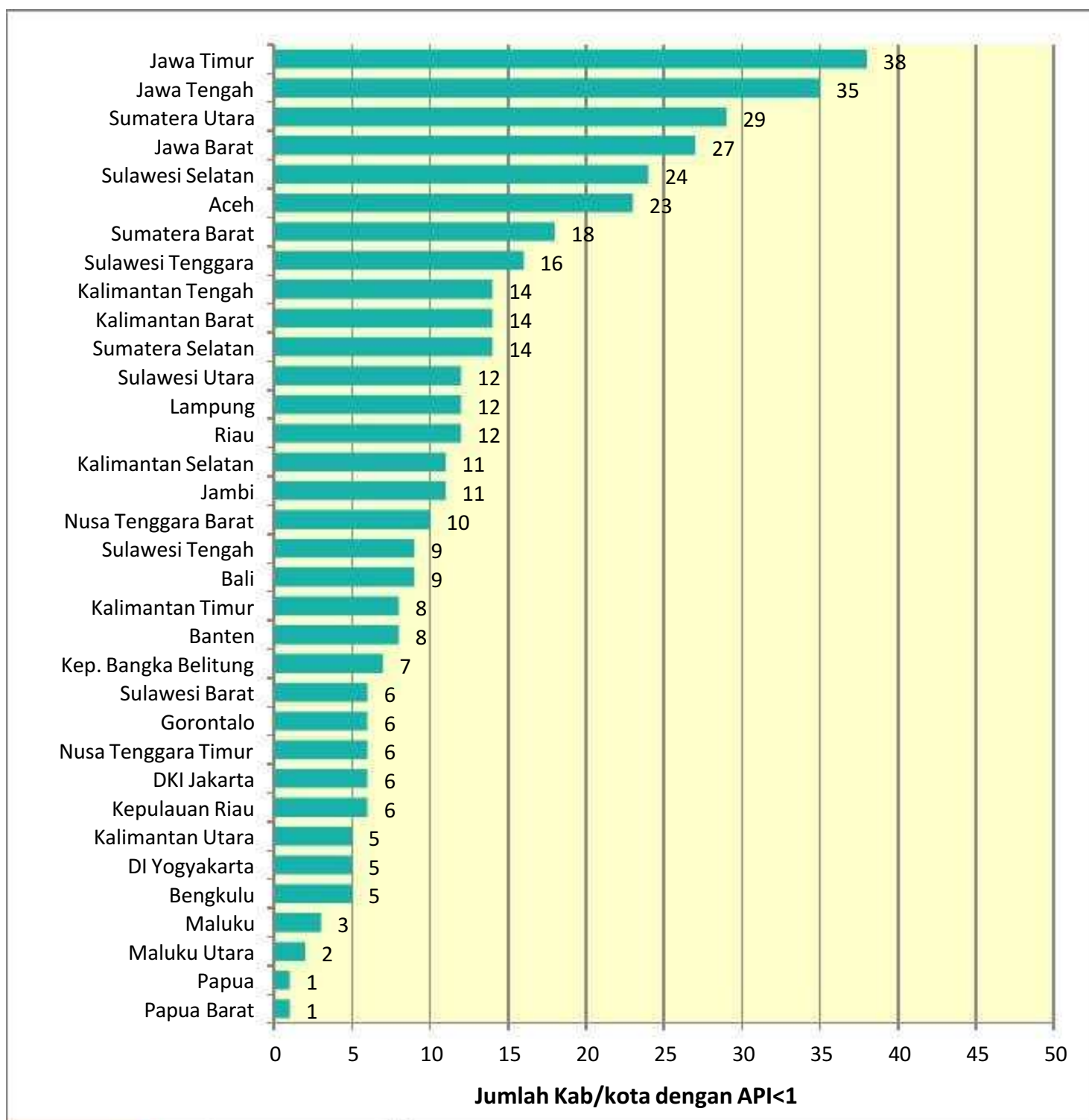
GAMBAR 6.38
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE/API*)
PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Pada tahun 2016 terdapat 413 kabupaten/kota dengan $API < 1$ per 1.000 penduduk, sementara target Rencana Strategi Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan malaria atau *Annual Parasite Incidence (API)* tahun 2016 adalah jumlah kabupaten/kota dengan $API < 1$ per 1.000 penduduk sebanyak 360 kabupaten/kota. Dengan demikian cakupan API 2016 mencapai target Renstra. Jumlah kabupaten/kota dengan $API < 1$ per 1.000 penduduk menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 6.39.

GAMBAR 6.39
JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API<1 PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

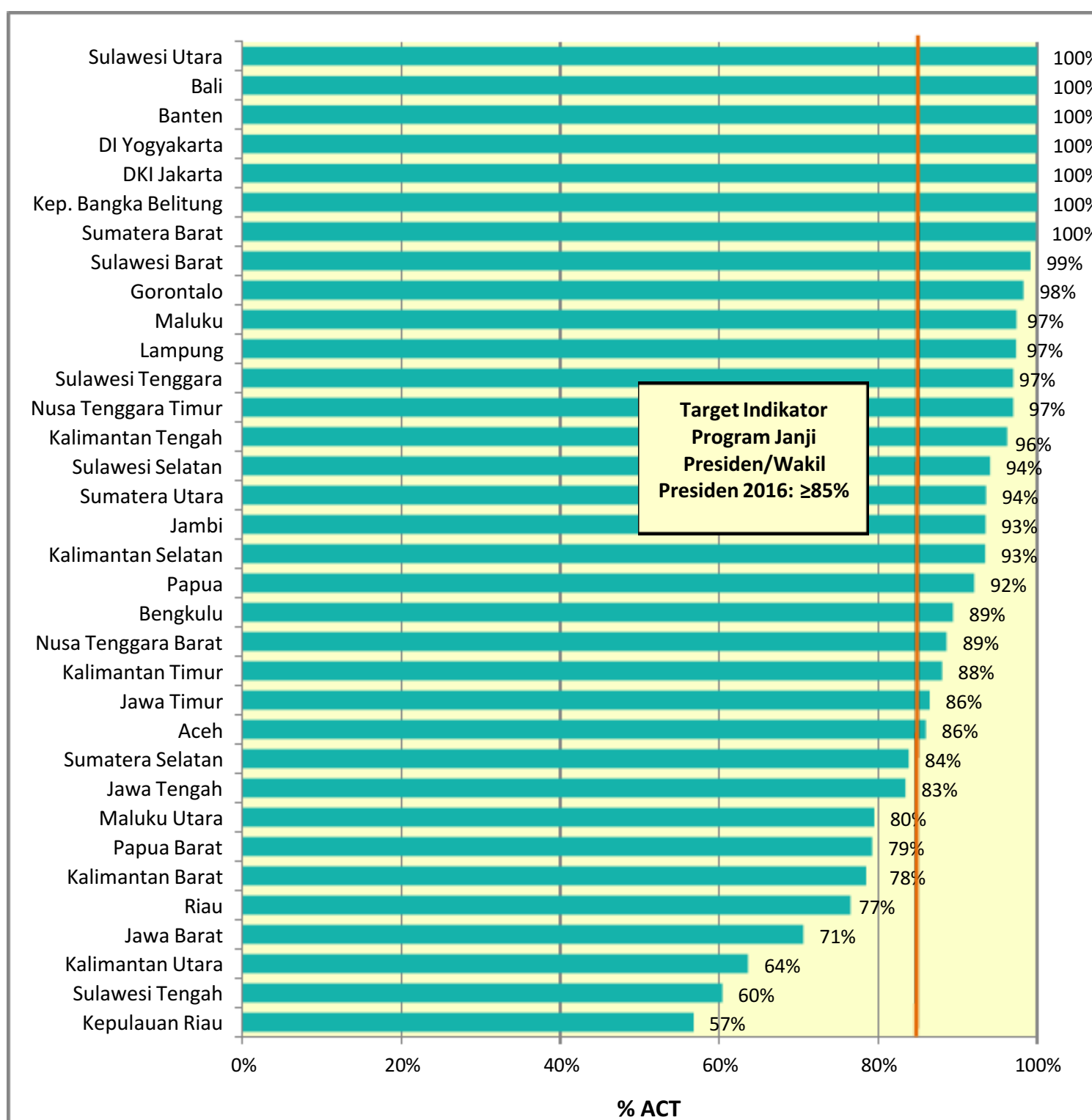


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif. Pemberian jenis obat harus benar dan cara meminumnya harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian *ACT (Artemicin-based Combination Therapy)* pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis. Persentase *ACT* menurut provinsi tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 6.40.

GAMBAR 6.40
PERSentase Pemberian Artemisin-based Combination Therapy (ACT)
Menurut Provinsi Tahun 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

5. Rabies

Rabies merupakan penyakit mematikan baik pada manusia maupun hewan yang disebabkan oleh infeksi virus (golongan Rhabdovirus) yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus.

Tahun 2016 terdapat 24 provinsi tertular rabies dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak sepuluh provinsi lainnya dinyatakan bebas Rabies, lima diantaranya provinsi bebas

Upaya pengendalian faktor risiko PTM yang telah dilakukan berupa promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres. Cek kesehatan secara berkala yaitu pemeriksaan faktor risiko PTM dapat dilakukan melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, dan mengikuti deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara di Puskesmas.

Selain itu, upaya pengendalian PTM melalui pengendalian masalah tembakau dilakukan dengan penerbitan peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Pemerintah Daerah dan membentuk Aliansi Walikota/Bupati dalam Pengendalian Tembakau dan Penyakit Tidak Menular. Sedangkan untuk pengaturan makanan berisiko, diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang gula, garam dan lemak dalam makanan yang dijual bebas. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa dukungan seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat.

Indikator program pengendalian penyakit tidak menular pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu (Puskesmas Pandu PTM).
2. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.
3. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara.
4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal pada 50% sekolah.

Beberapa kegiatan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya untuk mengendalikan penyakit tidak menular sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

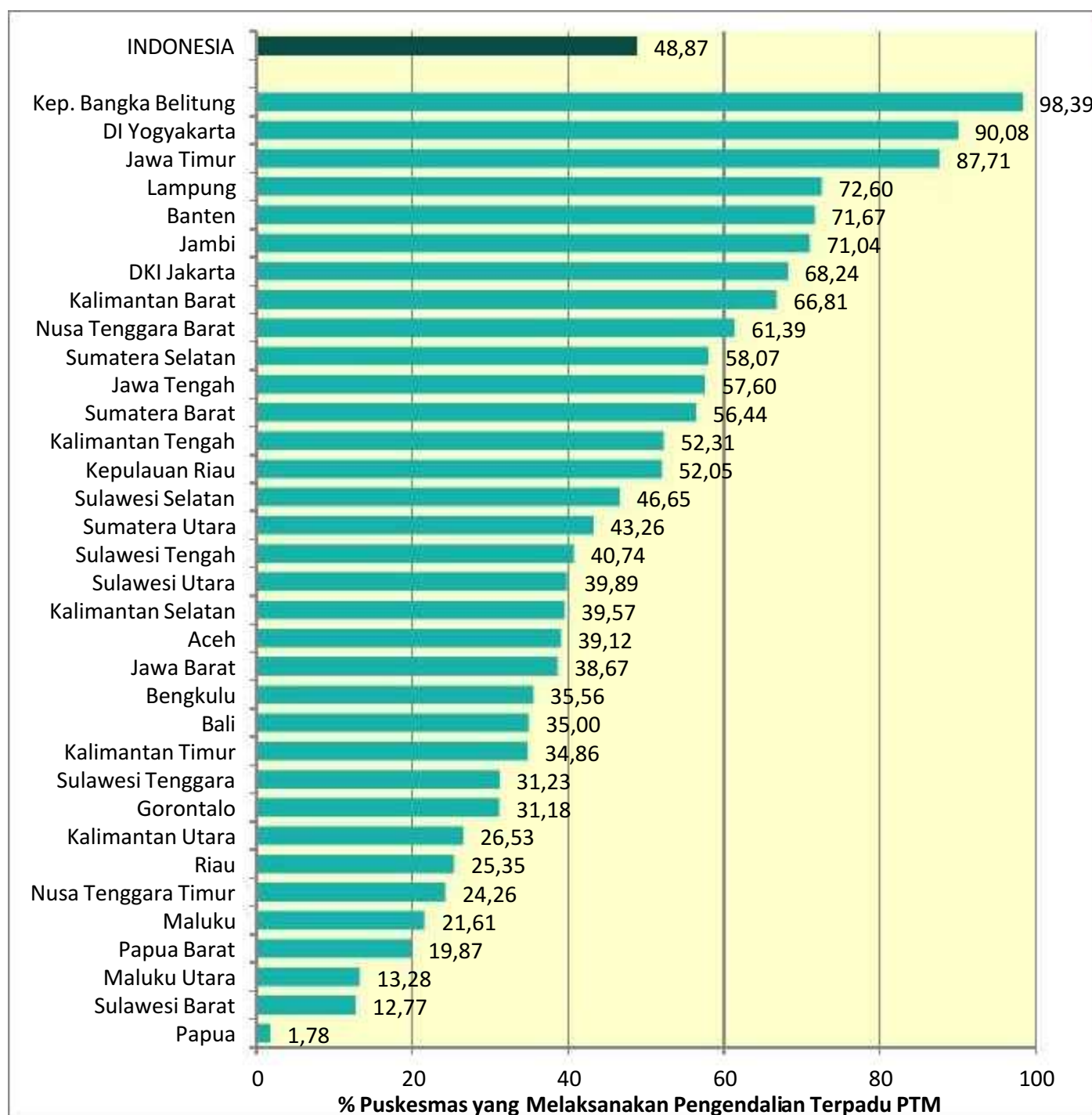
1. Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas

Pengendalian PTM di Puskesmas diwujudkan dengan adanya Puskesmas Pandu PTM. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian PTM, baik secara perorangan maupun kelompok dilakukan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.

Secara nasional terdapat 48,87% Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu (Puskesmas Pandu PTM). Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi

dengan Puskesmas Pandu PTM terbanyak dimana hampir seluruh Puskesmas atau 98,39% Puskesmas telah melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu. Sebagian besar Puskesmas di DI Yogyakarta dan Jawa Timur juga telah melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu, yaitu sebesar 90,08% dan 87,71%. Namun, proporsi Puskesmas Pandu PTM di Papua masih rendah, yaitu hanya 1,83% dari Puskesmas yang ada. Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 6.46.

GAMBAR 6.46
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

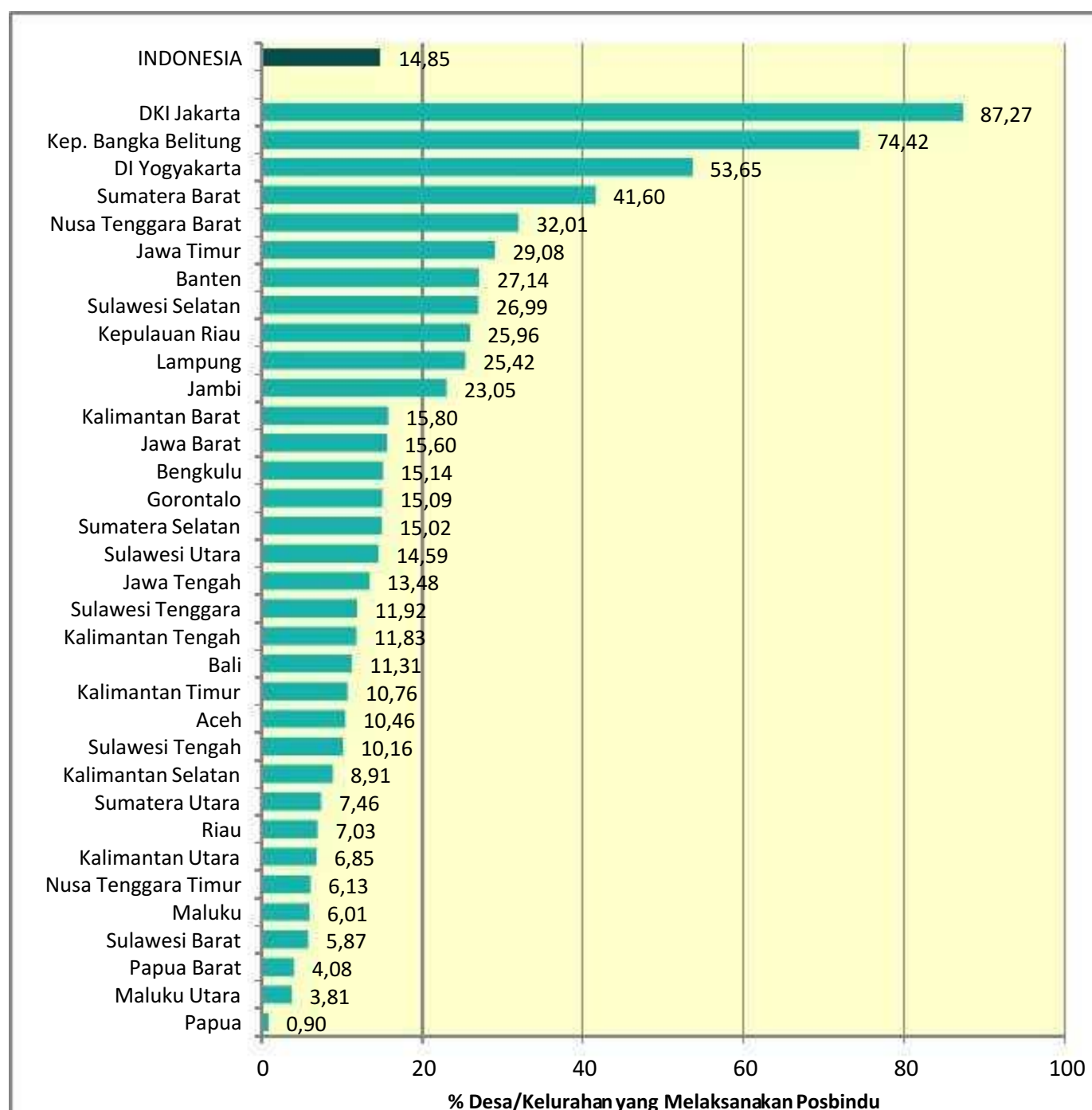
2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Posbindu PTM yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM juga

terintegrasi dengan rutin di masyarakat, seperti di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sasaran utama kegiatan adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM dapat dilihat pada Gambar 6.47 berikut. Secara nasional desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM sebesar 14,85%. Persentase ini masih di bawah target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2016 yaitu sebesar 20%. Jika dilihat menurut provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang melaksanakan Posbindu PTM, yaitu sebesar 87,27%. Provinsi dengan desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM terbanyak lainnya yaitu Kep. Bangka Belitung dan DI Yogyakarta sebesar 74,42% dan 53,65%. Sementara itu, hanya 0,9% desa di Papua yang melaksanakan Posbindu PTM.

GAMBAR 6.47
PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016



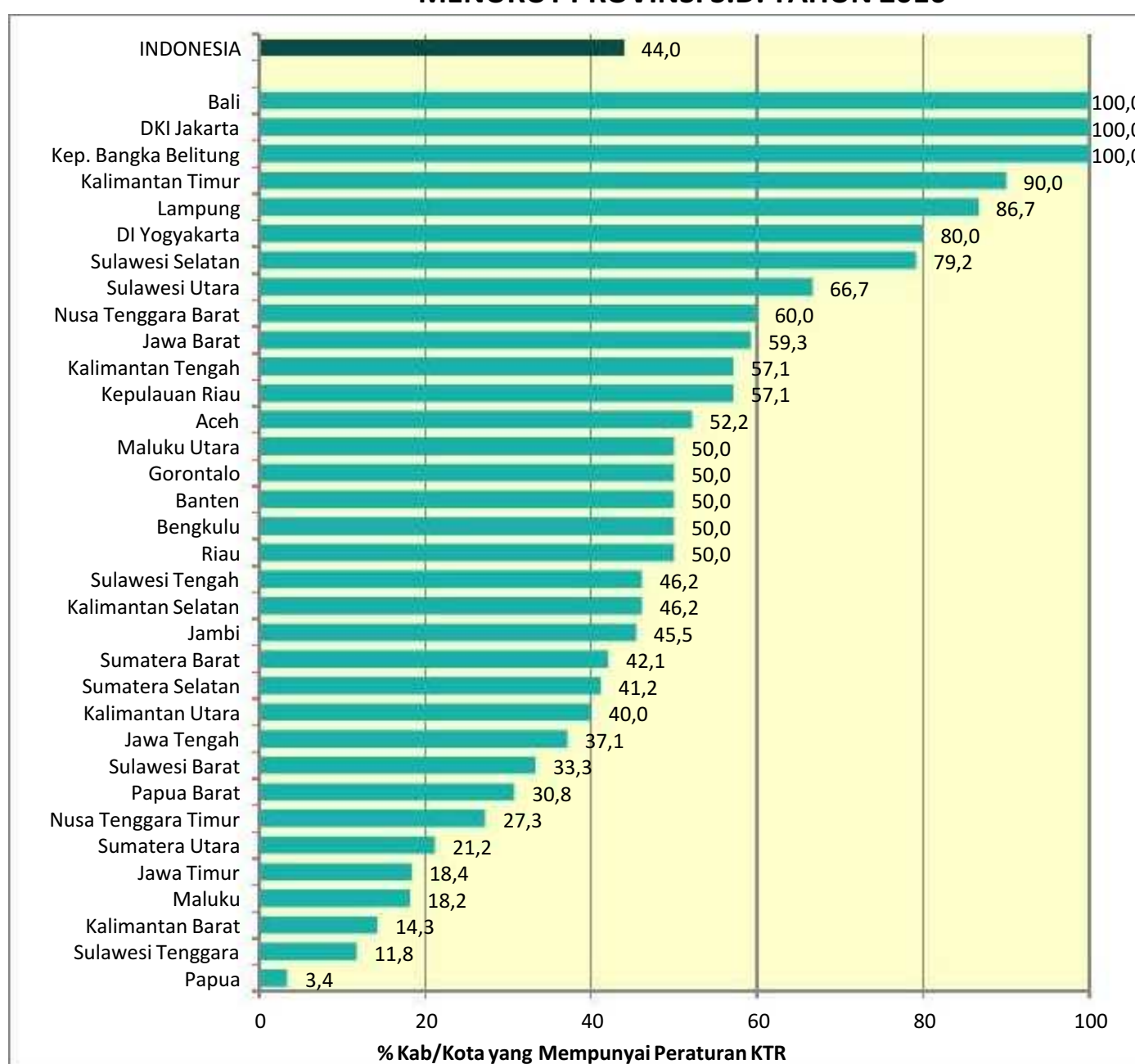
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

3. Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau

Pengendalian tembakau di Indonesia merupakan salah satu upaya pengendalian faktor risiko PTM, dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Beberapa upaya yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut.

- Perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok melalui pengembangan kawasan tanpa rokok dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya.
- Menyediakan layanan upaya berhenti rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik primer dan sekunder maupun tersier. Selain itu juga, bagi masyarakat yang tidak sempat dan tidak dapat datang ke Fasyankes, disiapkan layanan konseling upaya berhenti merokok melalui telepon tanpa bayar.
- Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok termasuk akibat merokok melalui iklan layanan masyarakat serta promosi kesehatan.
- Melakukan monitoring dan implementasi kebijakan pengendalian konsumsi hasil tembakau.

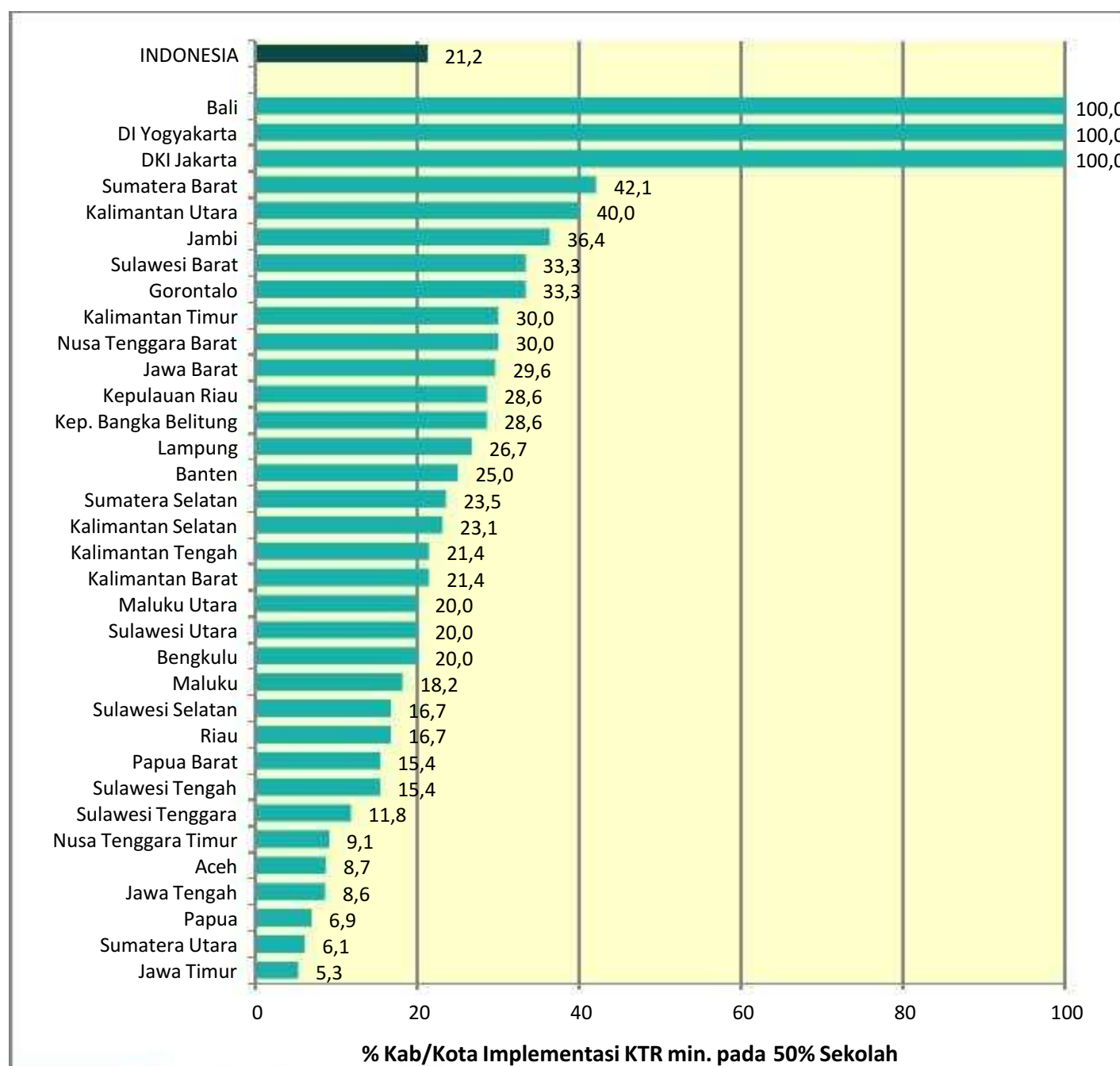
GAMBAR 6.48
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMPUNYAI PERATURAN KTR
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Sampai dengan tahun 2016 terdapat 226 atau 44,0% kabupaten/kota yang sudah mempunyai peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Jika dilihat menurut provinsi, semua kabupaten/kota di Bali, DKI Jakarta, dan Kep. Bangka Belitung sudah mempunyai peraturan KTR, diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 90,0%, dan Lampung sebesar 86,7%. Sementara itu, di Papua hanya terdapat 3,4% kabupaten/kota yang mempunyai peraturan KTR. Target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2016 adalah secara nasional, sebesar 20,2% kabupaten/kota sudah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal pada 50% sekolah. Berdasarkan implementasi KTR, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2016, sebesar 21,2% kabupaten/kota sudah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal pada 50% sekolah. Dengan demikian, target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2016 sudah tercapai. Kabupaten/kota yang sudah mempunyai peraturan KTR dan sudah melaksanakan kebijakan KTR minimal pada 50% sekolah dapat dilihat pada Gambar 6.48 dan 6.49.

GAMBAR 6.49
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN KTR
MINIMAL PADA 50% SEKOLAH
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016



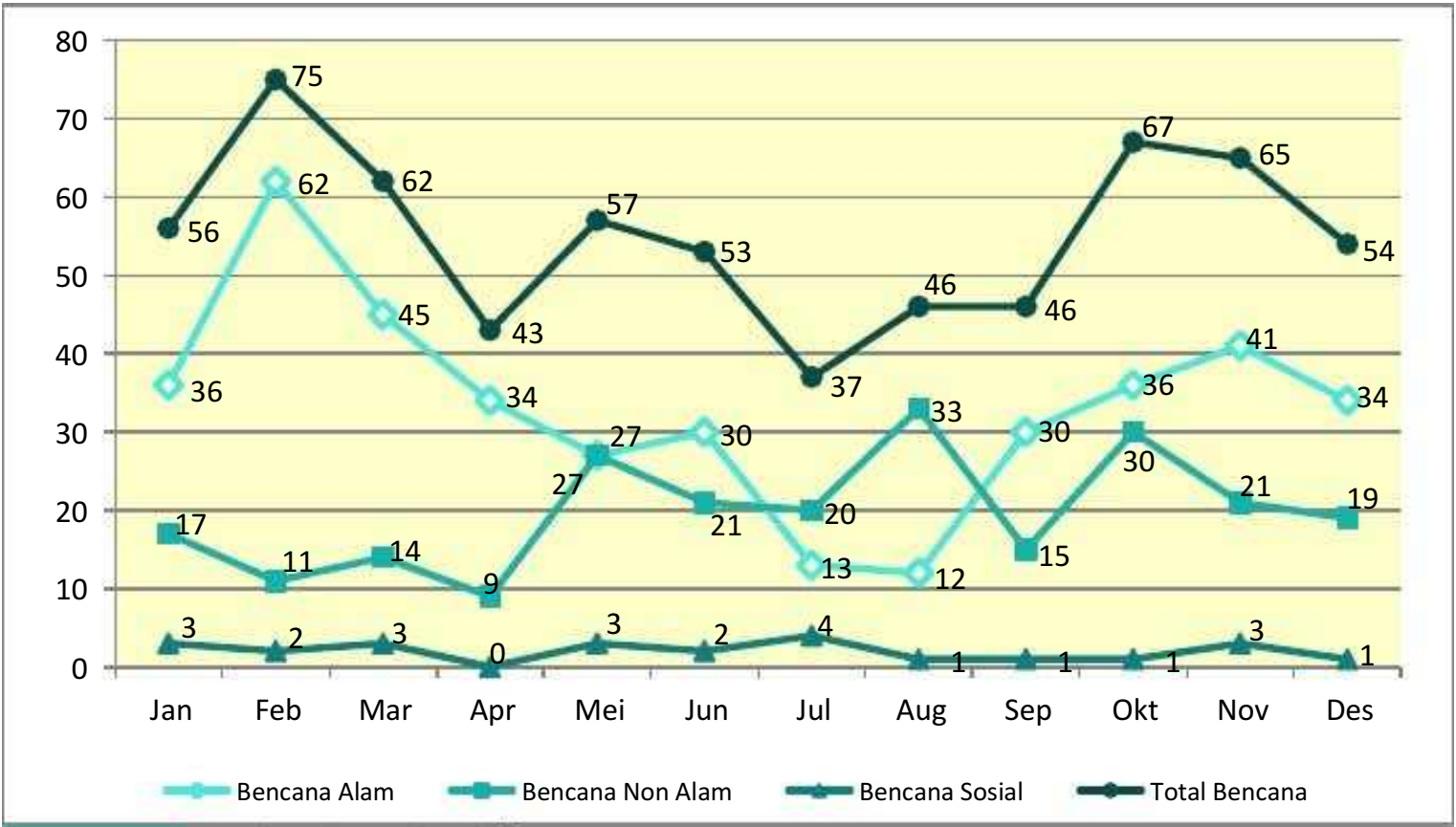
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

E. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah langsor. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. Bencana sosial yang dimaksud yaitu diantaranya berupa konflik sosial atau kerusuhan sosial dalam masyarakat yang terjadi.

Selama tahun 2016 di Indonesia tercatat 661 kejadian bencana yang menimbulkan krisis kesehatan. Bencana yang terjadi tersebut terdiri dari 17 jenis bencana. Pada tahun 2016, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan bencana dengan jumlah provinsi yang paling banyak terkena. Frekuensi banjir sebanyak 145 kejadian (22%) dan meliputi 26 provinsi. Jumlah total korban meninggal akibat banjir sebanyak 42 orang, luka berat/rawat inap sebanyak 566 orang, luka ringan/rawat jalan sebanyak 4.435 orang, hilang sebanyak 3 orang, dan menyebabkan 143.805 orang mengungsi. Berikut gambaran kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2016.

GAMBAR 6.51
JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT JENIS PER BULAN DI INDONESIA
TAHUN 2016

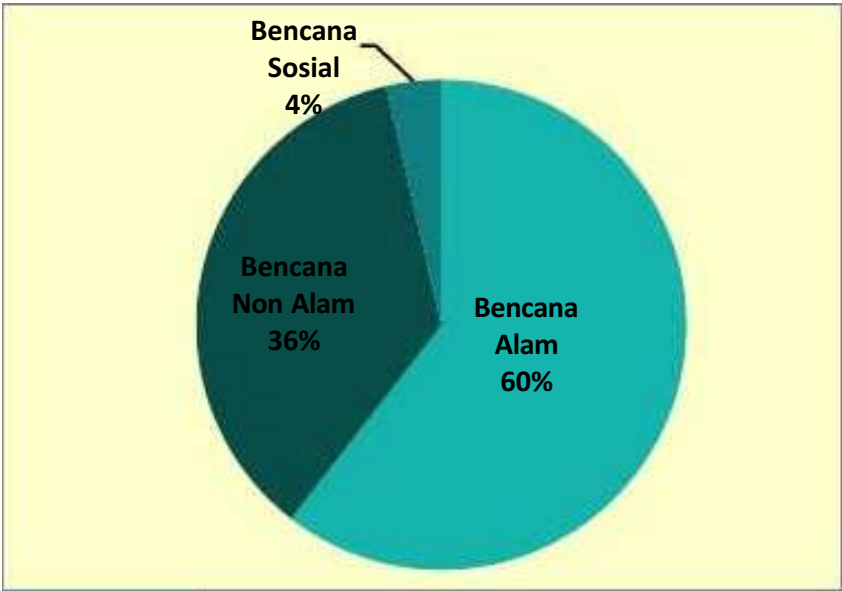


Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah bencana alam terendah terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi di bulan Februari. Sedangkan jumlah bencana non alam terendah

terjadi di bulan April dan tertinggi di bulan Agustus. Selain itu, tidak terjadi bencana sosial pada bulan April dan tercatat jumlah kejadiannya tertinggi di bulan Juli. Secara total, jumlah bencana paling sedikit terjadi di bulan Juli dan tertinggi di bulan Februari.

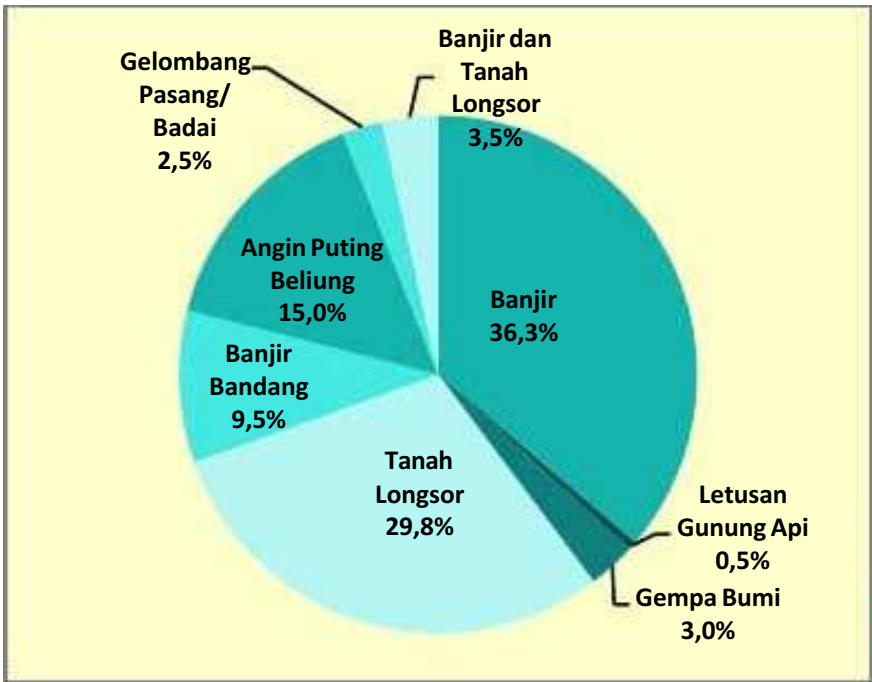
GAMBAR 6.52
PERSENTASE KEJADIAN BENCANA MENURUT JENIS DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Bencana alam merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2016 dengan persentase 60%. Sisanya, sebanyak 36% merupakan bencana non alam, dan 4% dari kejadian bencana termasuk kedalam bencana sosial.

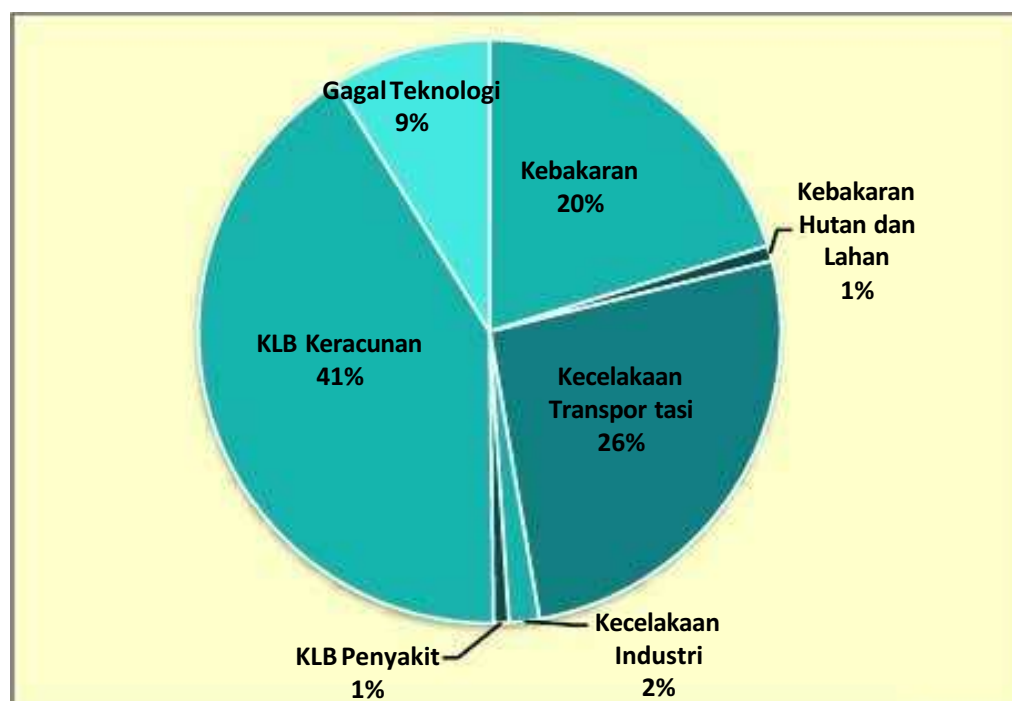
GAMBAR 6.53
PERSENTASE KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu bencana banjir (36,3%), diikuti oleh tanah longsor (29,8%), dan angin puting beliung (15%). Sedangkan bencana gempa bumi dan tsunami, dan kekeringan, tidak terjadi pada tahun 2016.

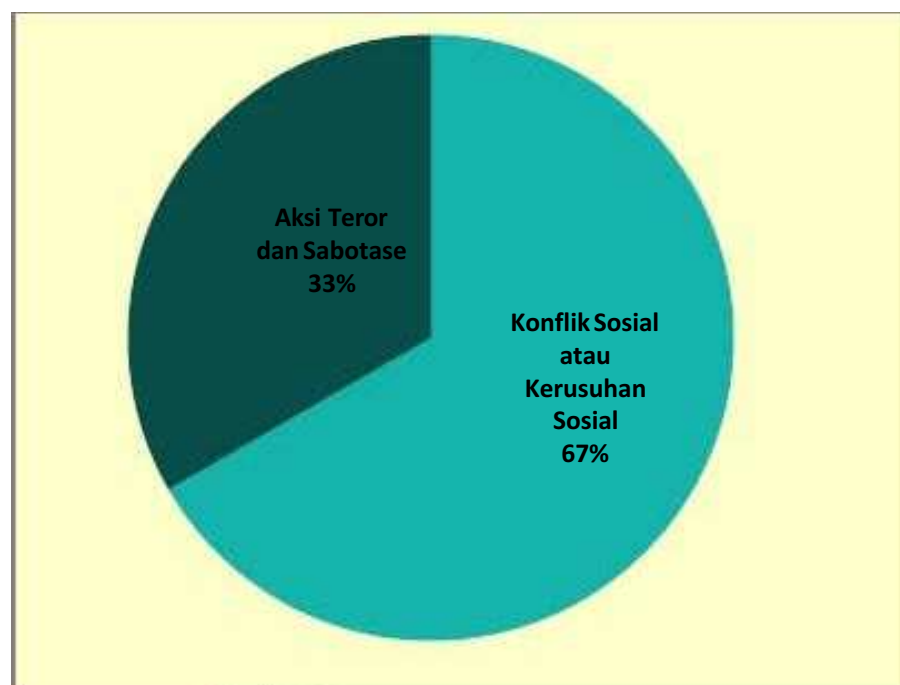
GAMBAR 6.54
PERSENTASE KEJADIAN BENCANA NON ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu bencana KLB-Keracunan (41%), diikuti oleh kecelakaan transportasi (26%), dan kebakaran (20%). Bencana wabah penyakit (epidemi - pandemi) tidak terjadi pada tahun 2016.

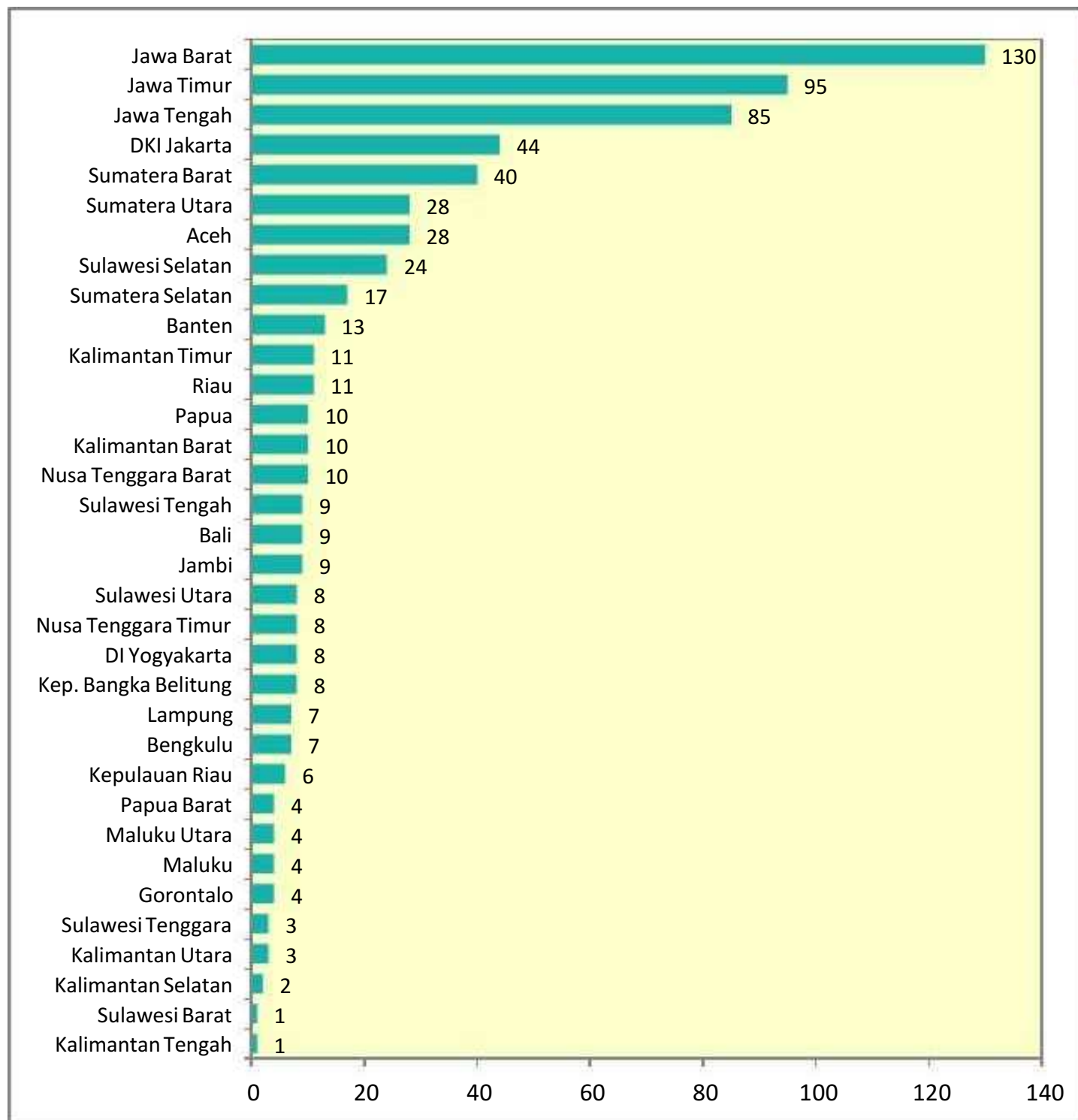
GAMBAR 6.55
PERSENTASE KEJADIAN BENCANA SOSIAL DI INDONESIA
TAHUN 2016



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Konflik sosial atau kerusuhan sosial merupakan bencana sosial yang paling sering terjadi di Indonesia tahun 2016, yaitu sebesar 67%. Sedangkan 33% bencana sosial terjadi akibat aksi teror dan sabotase di masyarakat.

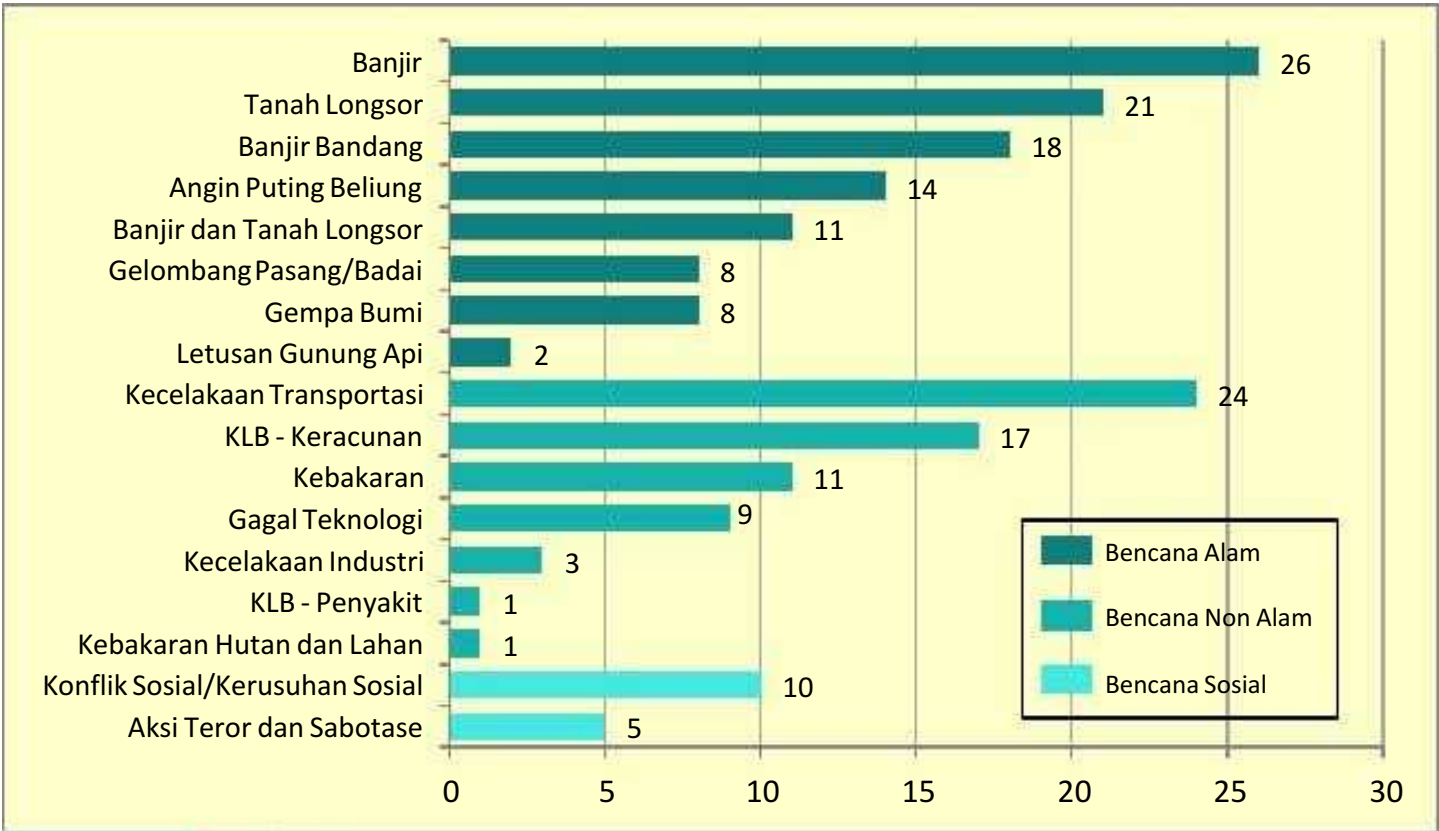
GAMBAR 6.56
JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Jawa Barat merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana di tahun 2016, yakni sebanyak 130 kejadian. Provinsi berikutnya yang mengalami kejadian bencana terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur dengan 95 kejadian dan Provinsi Jawa Tengah dengan 85 kejadian bencana. Sedangkan provinsi yang paling sedikit mengalami bencana yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat (1 bencana) dan Kalimantan Selatan (2 bencana).

GAMBAR 6.57
JUMLAH PROVINSI TERKENA BENCANA MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2016



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Bencana alam dengan jumlah provinsi terkena terbanyak yaitu bencana banjir, dengan 26 provinsi terkena, kemudian bencana non alam kecelakaan transportasi dengan 24 provinsi, dan bencana alam tanah longsor dengan 21 provinsi.

TABEL 6.5
JUMLAH KEJADIAN BENCANA ALAM DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2016

Bencana Alam	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Korban Luka Berat/ Rawat Inap	Jumlah Korban Luka Ringan/ Rawat Jalan	Jumlah Korban Hilang	Jumlah Pengungsi
Banjir	145	42	566	4.435	3	143.805
Letusan Gunung Api	2	9	2	0	0	1.840
Gempa Bumi	12	107	456	755	0	92.699
Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	119	168	76	1.356	24	11.906
Banjir Bandang	38	81	480	44.854	27	16.704
Kekeringan	0	0	0	0	0	0
Angin Puting Beliung	60	20	50	97	0	1.150
Gelombang Pasang/Badai	10	4	6	3.230	2	1.737
Banjir dan Tanah Longsor	14	11	28	851	1	7.541
Jumlah	400	442	1.664	55.578	57	277.382

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Jumlah korban meninggal terbanyak diakibatkan oleh bencana tanah longsor, yakni sebanyak 168 orang (38%), diikuti oleh gempa bumi sebanyak 107 orang (16%), dan banjir bandang sebanyak 81 orang (12%). Sedangkan bencana yang paling banyak menimbulkan korban luka berat/rawat inap yaitu bencana banjir dengan 566 orang (34%), kemudian banjir bandang sebanyak 480 orang (29%), dan gempa bumi dengan 456 orang (27%). Bencana dengan korban luka ringan/rawat jalan terbanyak yakni bencana banjir bandang dengan 44.854 orang (81%), kemudian banjir dengan 4.435 orang (8%) dan gelombang pasang/badai dengan 3.230 orang (6%). Untuk korban hilang, bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2016 merupakan bencana alam dengan korban hilang terbanyak, yakni menyebabkan 27 orang hilang (47%). Bencana banjir merupakan bencana dengan korban pengungsi terbanyak, yakni sebanyak 143.805 orang (52%). Bencana dengan korban pengungsi terbanyak ke dua yaitu bencana gempa bumi dengan 92.699 orang (33%) dan banjir bandang dengan 16.704 orang (6%).

TABEL 6.6
JUMLAH KEJADIAN BENCANA NON ALAM DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2016

Bencana Non Alam	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Korban Luka Berat/ Rawat Inap	Jumlah Korban Luka Ringan/ Rawat Jalan	Jumlah Korban Hilang	Jumlah Pengungsi
Kebakaran	48	42	34	112	0	3.104
Kebakaran Hutan dan Lahan	2	0	0	103	0	500
Kecelakaan Transportasi	62	252	193	391	45	0
Kecelakaan Industri	4	1	10	5	0	0
KLB - Penyakit	2	0	4	77	0	0
KLB - Keracunan	98	34	1.945	2.566	0	0
Gagal Teknologi	21	20	67	55	0	0
Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah	237	349	2.253	3.309	45	3.604

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Jumlah korban meninggal terbanyak diakibatkan oleh kecelakaan transportasi, yakni sebanyak 252 orang, diikuti oleh kebakaran sebanyak 42 orang, dan KLB keracunan sebanyak 34 orang. Tidak hanya merupakan bencana non alam dengan jumlah korban meninggal terbanyak, kecelakaan transportasi juga merupakan bencana dengan persentase korban meninggal terbanyak bila dibandingkan dengan jumlah kejadiannya, yakni sebesar 406%,

lebih banyak dari seluruh bencana lainnya yang terjadi. Sedangkan bencana non alam yang paling banyak menimbulkan korban luka berat/rawat inap yaitu KLB keracunan dengan 1.945 orang, kemudian kecelakaan transportasi sebanyak 193 orang, dan gagal teknologi dengan 67 orang. Bencana dengan korban luka ringan/rawat jalan terbanyak yakni bencana KLB keracunan dengan 2.566 orang, kemudian kecelakaan transportasi dengan 391 orang dan kebakaran dengan 112 orang. Untuk korban hilang, hanya kecelakaan transportasi yang menimbulkan korban, yaitu sebanyak 45 orang. Hanya terdapat dua bencana non alam yang menimbulkan korban pengungsi, yaitu kebakaran dan kebakaran hutan dan lahan, yaitu sebanyak 3.104 dan 500 orang.

TABEL 6.7
JUMLAH KEJADIAN BENCANA SOSIAL DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2016

Bencana Sosial	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Korban Luka Berat/ Rawat Inap	Jumlah Korban Luka Ringan/ Rawat Jalan	Jumlah Korban Hilang	Jumlah Pengungsi
Konflik Sosial/Kerusuhan Sosial	16	13	91	1.808	0	5.391
Aksi Teror dan Sabotase	8	13	37	23	0	0
Jumlah	24	26	128	1.831	0	5.391

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2017

Jenis bencana sosial yang menimbulkan paling banyak korban luka berat/rawat inap, korban luka ringan/rawat jalan, dan korban pengungsi, yaitu konflik sosial/kerusuhan sosial, yakni sebanyak 91, 1.808, dan 5.391 orang. Sedangkan kedua jenis bencana sosial mengakibatkan jumlah korban meninggal yang sama banyak, yaitu 13 orang. Selain itu, kedua jenis bencana sosial baik konflik sosial/kerusuhan sosial maupun aksi teror dan sabotase tidak menimbulkan korban hilang.

F. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Indonesia merupakan negara dengan jamaah haji terbesar di dunia. Jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 168.800 orang.

Tahun 2016, penyelenggaraan kesehatan haji memasuki era baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Permenkes ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan

kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan istithaah kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten.

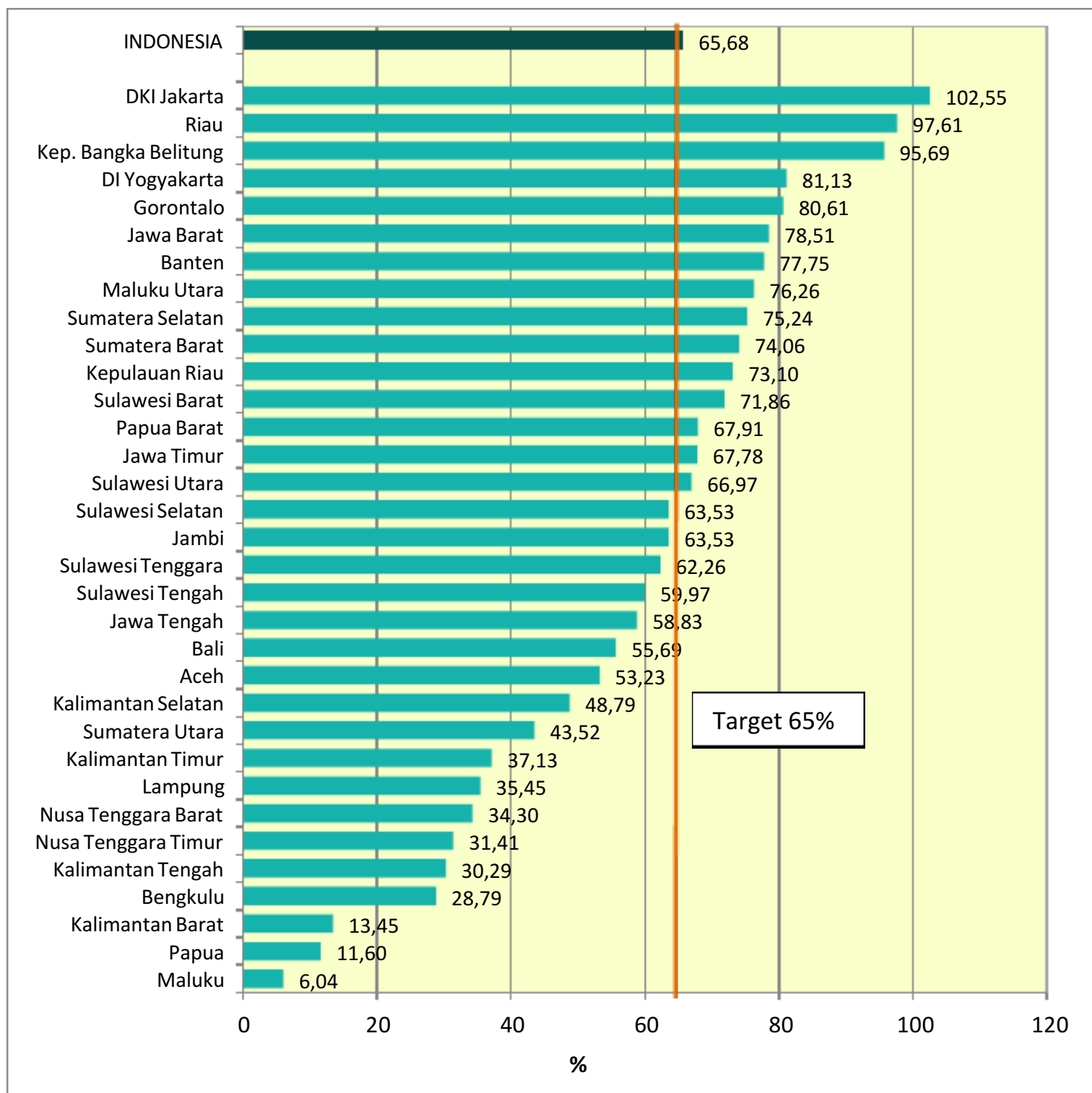
Konsekuensi dari pelaksanaan Permenkes tersebut juga mengubah orientasi penyelenggaraan kesehatan haji dengan penguatan upaya promotif dan preventif pada setiap tahap kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji. Kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada jemaah haji yang dilaksanakan di Indonesia sampai Arab Saudi diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi dengan memberikan penghargaan *The Ambassador of Health Awareness in Hajj season 2016* kepada Misi Kesehatan Haji Indonesia.

Jemaah Haji selama menjalankan ibadah haji mendapat pendampingan petugas kesehatan yang menyertai di kelompok terbang (kloter) terdiri dari petugas 1 dokter dan 2 para medis serta petugas non kloter kesehatan atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Pada tahun 2016, petugas kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi terdiri dari Tim Promotif dan Preventif (TPP), Tim Gerak Cepat (TGC), Tim Kuratif dan Rehabilitatif (TKR) dan Tenaga Pendamping Kesehatan (TPK).

1. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji sudah dimulai pada awal tahun 2016. Data hasil kegiatan tersebut kemudian diinput ke aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes). Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah cakupan hasil pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji yang diinput kedalam Siskohatkes 3 (tiga) bulan sebelum operasional haji. Karena pemberangkatan kloter pertama musim haji tahun 2016 jatuh pada tanggal 8 Agustus 2016, maka Indikator tersebut harus sudah tercapai pada tanggal 8 Mei 2016, dengan target sebesar 65%. Sedangkan hasil cakupan yang dicapai pada tahun 2016 secara nasional adalah 65,68% atau 109.720 pemeriksaan, dan telah mencapai target yang ditentukan. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah DKI Jakarta (102,55%) dan terendah Maluku (6,04%). Capaian hasil pemeriksaan pertama jemaah haji berdasarkan tempat pemeriksaan adalah sebagai berikut.

GAMBAR 6.58
CAPAIAN PEMERIKSAAN PERTAMA JAMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2016



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2017

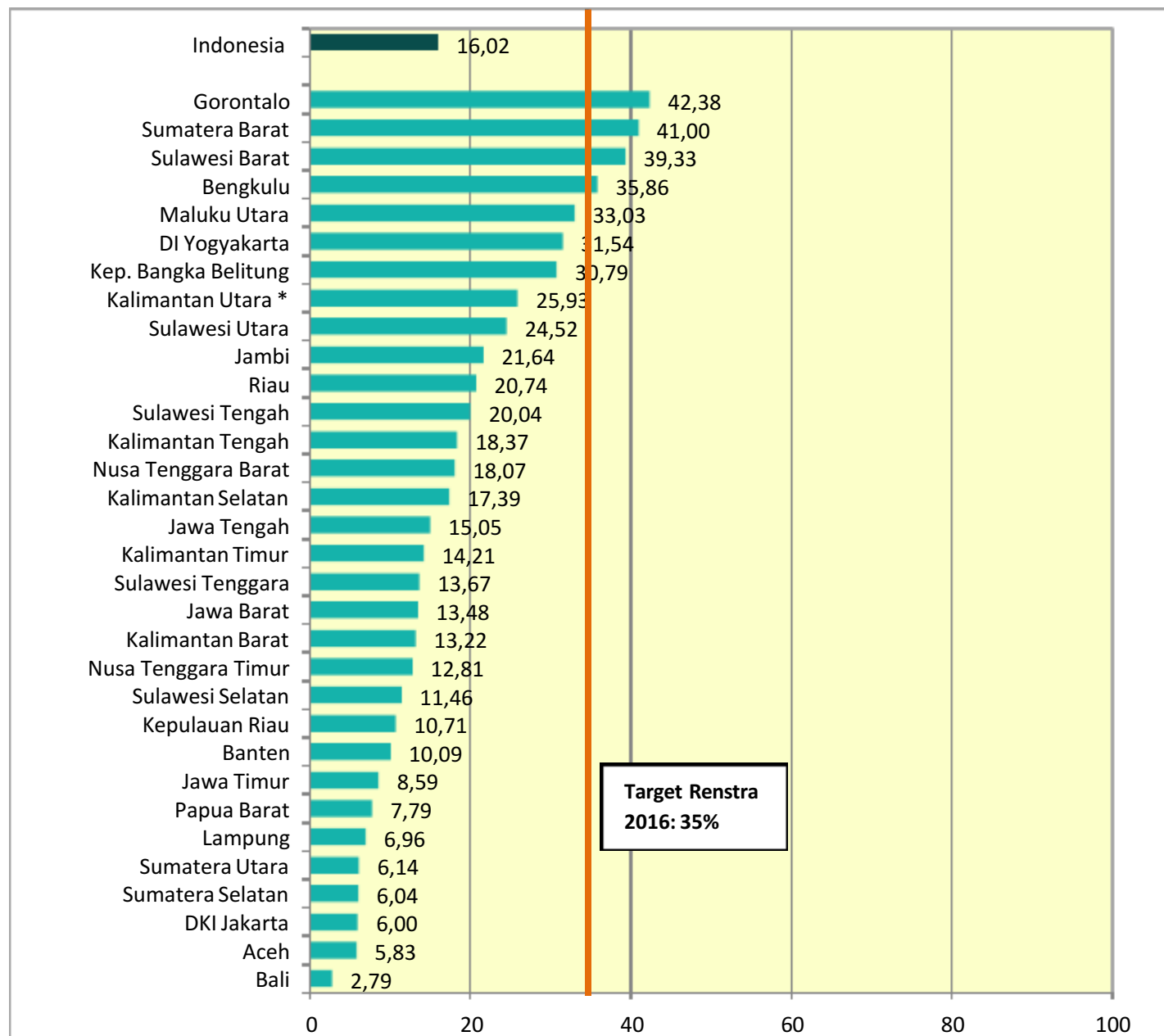
Dibandingkan tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 5% yang dapat dilaksanakan dengan membangun kemitraan dan kerja sama dengan lintas sektor terkait serta dilaksanakan sejak awal Januari 2016.

2. Kondisi Jemaah Haji Indonesia

Jemaah haji Indonesia tahun 2016 terdiri dari 84.244 orang (55%) perempuan dan 68.853 orang laki-laki (45%). Jumlah ini adalah jumlah di luar petugas haji.

Gambar 7.4 menunjukkan bahwa secara nasional persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 71,14%. Provinsi dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tertinggi yaitu DKI Jakarta (92,44%), Bali (88,71%) dan Kepulauan Riau (85,31%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga menurut akses air minum layak terendah adalah Bengkulu (37,35%), Lampung (52,41%), dan Papua (52,69%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga menurut akses air minum layak tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 7.3.

GAMBAR 7.5
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN TAHUN 2016



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

Pengawasan kualitas air minum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan Pengawasan Kualitas Air Minum, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum komersial dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawas kualitas air minum internal adalah penyelenggara air minum yang diawasi kualitas hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan KKP yang dibuktikan dengan jumlah sampel pengujian kualitas

air. Penyelenggara air minum adalah PDAM/BPAM/PT yang terdaftar di Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi); Sarana air minum perpipaan non PDAM; dan Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal.

Data yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sampai Maret 2017, secara nasional pada tahun 2016 dari 32.578 sarana air minum terdapat 16,02% (5.218) sarana air minum yang diawasi (Gambar 7.5), hasil ini belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2016 yaitu 35% sarana air minum yang dilakukan pengawasan. Terdapat 4 (empat) provinsi sudah memenuhi target Renstra Kemenkes tahun 2016 dengan memperoleh hasil lebih dari 35% persentase sarana air minum yang diawasi, yaitu Gorontalo (42,38%), Sumatera Barat (41%), Sulawesi Barat (39,33%), dan Bengkulu (35,86%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah diantaranya Bali (2,79%), Aceh (5,83%), dan DKI Jakarta (6%).

Gambaran persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan tahun 2016 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, secara nasional dari 234.002 sarana air minum terdapat 43,58% (101.972) sarana air minum yang diawasi, angka ini telah mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 yaitu 30% sarana air minum yang dilakukan pengawasan. Gambaran sarana air minum yang dilakukan pengawasan tahun 2015 dan tahun 2016 belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2015 jumlah sarana air minum mencapai 234.002, merupakan jumlah seluruh jenis air minum yaitu PDAM, perpipaan non PDAM, sarana kumonal non perpipaan (DAM = Depot Air Minum, sumur gali, dll), sedangkan pada tahun 2016 jumlah 32.578 sarana air minum yang telah terdata hanyalah DAM saja. Rincian lengkap tentang persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 7.4.

D. Akses Sanitasi Layak

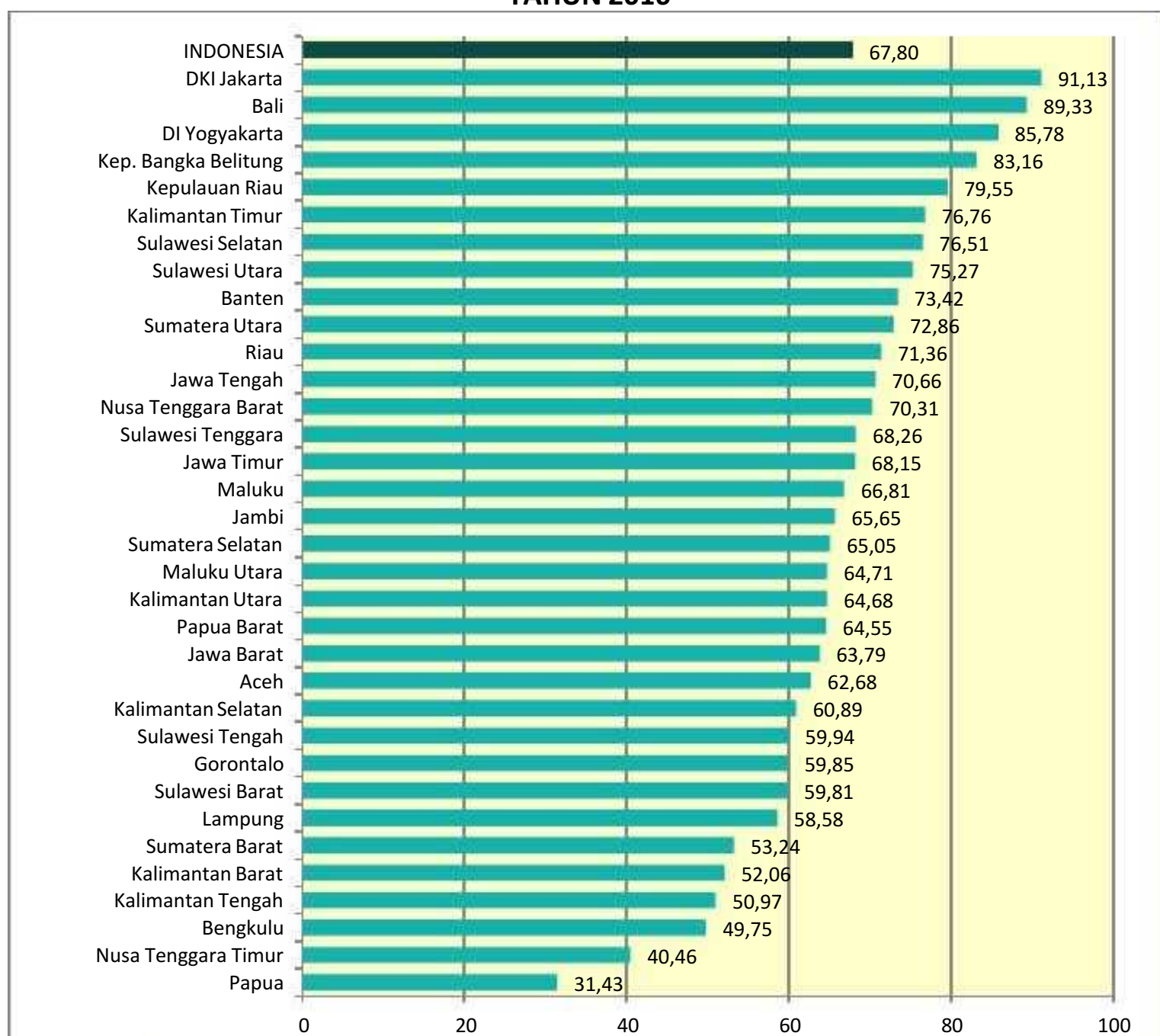
Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti *urine* dan *faeces*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Mulai tahun 2015 definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain dilengkapi

dengan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan merupakan fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu menggunakan jamban dengan syarat sebagai berikut:

1. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi.
2. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur.
3. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan.
4. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain.
5. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin.
6. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.
7. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
TAHUN 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2016

Gambar 7.6 menunjukkan hasil Susenas Kor 2016 mengenai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Secara nasional, terdapat 67,80% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu DKI Jakarta (91,13%), Bali (89,33%), dan DI Yogyakarta sebesar (85,78%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Papua (31,43%) Nusa Tenggara Timur (40,46%), dan Bengkulu (49,75%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Lampiran 7.5.

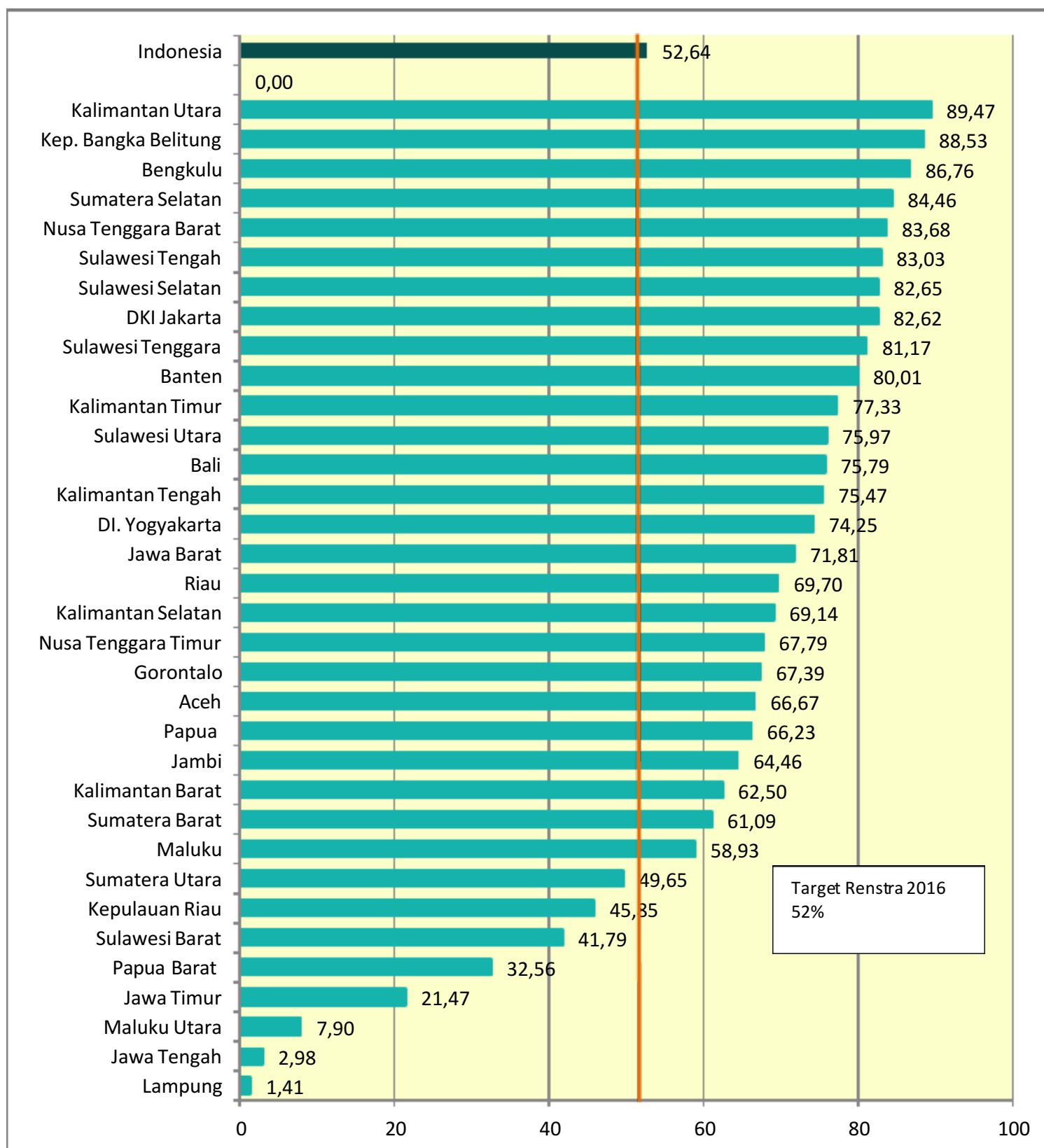
E. Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya. TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan. TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Pemerintah Daerah minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum, yaitu:

1. Sarana pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yang sederajat milik pemerintah dan swasta yang terintegrasi.
2. Pasar rakyat yang dimaksud adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, sebagian besar barang yang diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pada Gambar 7.7 menunjukkan secara nasional persentase TTU yang telah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 adalah mencapai 52,64%, pencapaian ini telah melebihi target Renstra Kementerian Kesehatan 2016 yaitu 52%. Namun capaian tersebut cenderung menurun dibandingkan capaian tahun 2015 (61,44%). Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Kalimantan Utara (89,47%), Kep. Bangka Belitung (88,53%), dan Bengkulu (86,76%). Terdapat 8 (delapan) provinsi yang belum mencapai target 2016 diantaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan provinsi dengan persentase terendah adalah Lampung (1,41%). Rincian lengkap tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 7.6.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2016



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya peningkatan jumlah TTU yang memenuhi syarat diantaranya adalah anggaran daerah untuk program kesehatan lingkungan masih rendah, belum semua daerah (kabupaten/kota termasuk puskesmas) memiliki peralatan pengukuran parameter kualitas lingkungan yang sesuai, pendataan ulang di daerah untuk akurasi data yang tercatat, tumpang tindih regulasi antar kementerian/lembaga yang belum bersinergi, dan masih belum optimalnya koordinasi baik

lintas program maupun lintas sektor, serta institusi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan TTU diantaranya melakukan advokasi dan sosialisasi secara terpadu bersama lintas program di lingkungan Kemenkes), dan lintas sektor (Kemendagri, Kemenparekraf, Kemendikbud, dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD terkait, serta institusi (Perguruan Tinggi, HAKLI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI, dan lainnya), serta mitra yang terkait lainnya baik di pusat dan daerah, melengkapi daerah dengan peralatan pengukuran parameter kualitas lingkungan, meningkatkan dan memperkuat strategi kemitraan, serta meningkatkan kapasitas pemilik/penyelenggara TTU agar ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

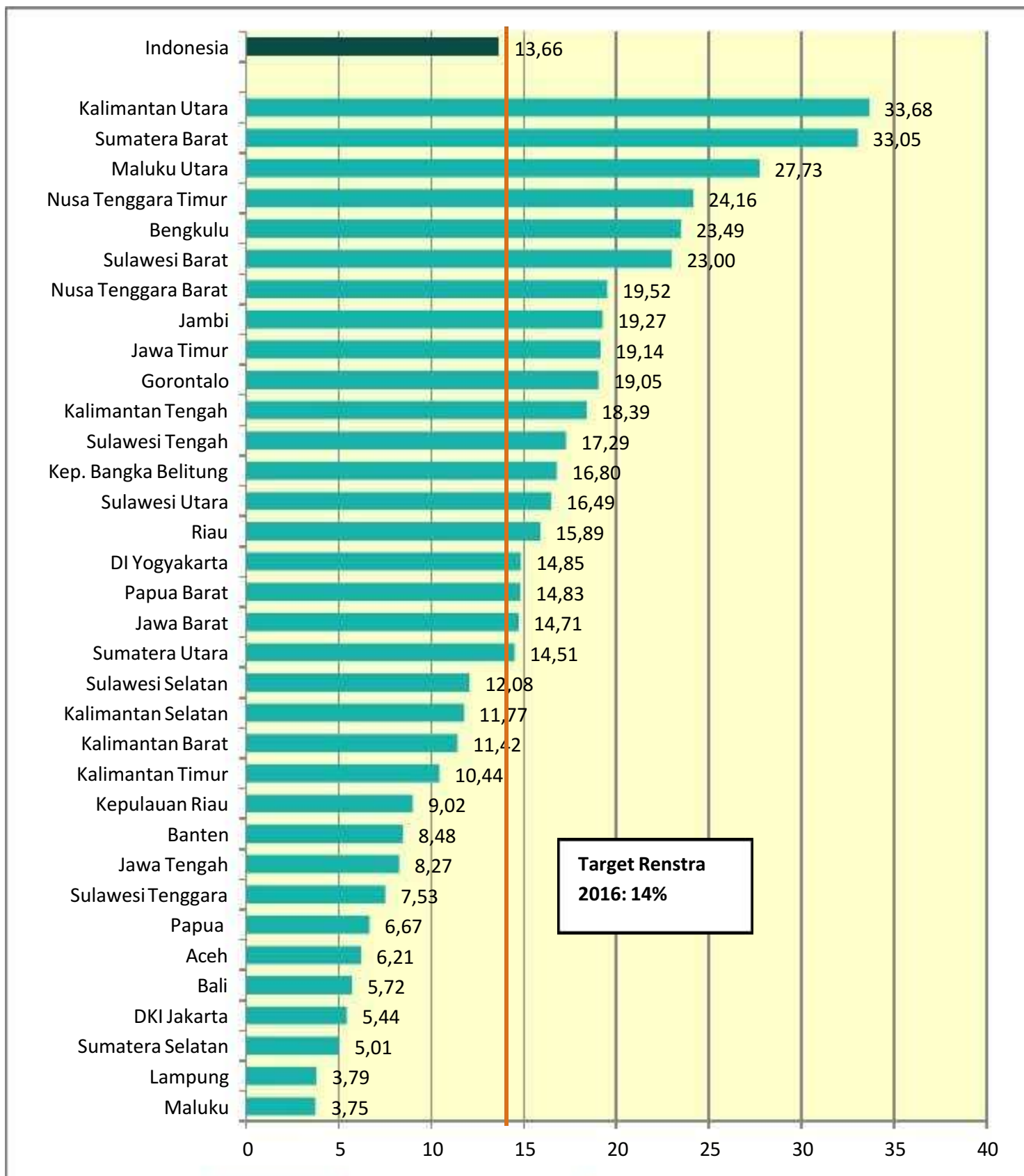
F. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat banyak, maka Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. TPM adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran, persyaratan higiene sanitasi yang harus dipenuhi meliputi:

1. persyaratan lokasi dan bangunan,
2. persyaratan fasilitas sanitasi,
3. persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan,
4. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi,
5. persyaratan pengolahan makanan,
6. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi,
7. persyaratan penyajian makanan jadi,
8. persyaratan peralatan yang digunakan.

Pelaksanaan kegiatan higiene sanitasi pangan merupakan salah satu aspek dalam menjaga keamanan pangan yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan terukur dengan kegiatan, sasaran dan ukuran kinerja yang jelas, salah satunya dengan mewujudkan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan. TPM siap saji yang terdiri dari Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, Sentra Makanan Jajanan, Kantin Sekolah yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPM yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang dibuktikan dengan sertifikat layak higiene sanitasi.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI
SYARAT KESEHATAN TAHUN 2016



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

Gambar 7.8 menunjukkan bahwa persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan secara nasional pada tahun 2016 adalah 13,66%, capaian ini meningkat dari sebelumnya tahun 2015 (10,39%). Persentase ini belum memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan 2016 untuk TPM memenuhi syarat kesehatan yaitu sebesar 14%. Provinsi dengan persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan tertinggi adalah Kalimantan Utara (33,68%), Sumatera Barat (33,05%), dan Maluku Utara (27,73%). Sedangkan provinsi dengan

persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan terendah adalah Maluku (3,75%), Lampung (3,79%) dan Sumatera Selatan (5,01%). Rincian lengkap tentang persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 7.7.

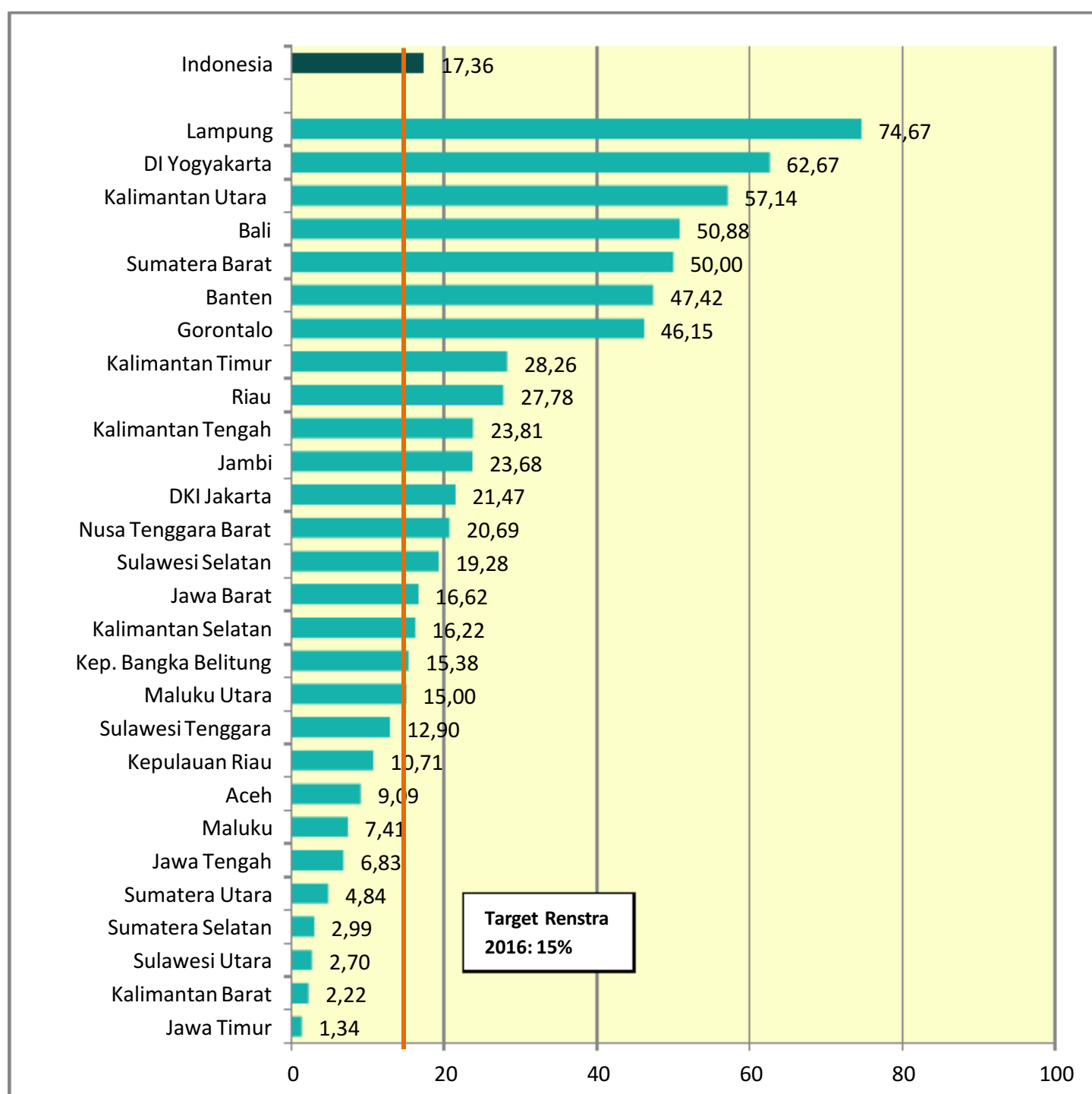
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah TPM yang memenuhi syarat di antaranya dengan memberikan dukungan aspek legal untuk operasionalisasi pembinaan dan pengawasan TPM dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), meningkatkan jejaring kemitraan, meningkatkan kapasitas SDM, menyediakan sarana dan prasarana seperti media Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) tentang higiene sanitasi pangan dan alat deteksi cepat sistem kewaspadaan dini KLB keracunan pangan, menyediakan pengelolaan data dan informasi yang *up to date* dan *real time* dengan e-monev Higiene Sanitasi Pangan (HSP), mengembangkan daerah intervensi kabupaten/kota yang berkomitmen untuk pelaksanaan pembinaan dan pengendalian TPM terstandar, dan memfasilitasi tugas perbantuan sentra pangan jajanan di kabupaten/kota.

G. Pengelolaan Limbah Medis

Berdasarkan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, definisi limbah medis adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Pengelolaan limbah medis tentunya berbeda dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Penempatan limbah medis dilakukan pada wadah yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Limbah medis yang telah terkumpul tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah medis yang berbentuk gas dilengkapi alat pereduksi emisi gas dan debu pada proses pembuangannya. Selain itu perlu dilakukan pula upaya minimalisasi limbah yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Penghijauan juga baik dilakukan untuk mengurangi polusi dari limbah yang berbentuk gas dan untuk menyerap debu.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH
MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2016



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

Cakupan Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2015 adalah sebesar 15,29%, pada Gambar 7.9 menunjukkan persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,36% pada tahun 2016. Capaian ini telah melampaui Renstra 2016 yaitu sebesar 15%. Provinsi dengan presentase tertinggi adalah Provinsi Lampung (74,67%), DI Yogyakarta (62,67%), dan Kalimantan Utara (57,14%). Sedangkan Provinsi dengan persentase terendah adalah Jawa timur (1,34%), Kalimantan Barat (2,22%), dan Sulawesi Utara (2,70%). Ada 6 (enam) provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, NTT, dan Bengkulu yang belum melakukan pengelolaan limbah medis rumah sakit sesuai standar.

Rincian lengkap tentang persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 7.8.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah medis, seperti masih sedikitnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar, masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan alat kesehatan yang bermerkuri, serta hambatan teknis dan perizinan dalam pengolahan limbah medis. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah di atas, di antaranya dengan:

1. mempermudah proses perizinan pengolahan limbah terutama dengan metode non insinerasi,
2. mengadakan pelatihan tingkat internasional bagi Kementerian Kesehatan dan RSUP,
3. menyusun peraturan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) fasilitas pelayanan kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
4. mengembangkan sistem pengumpulan data dan informasi elektronik serta manajemen data sebagai bahan penentu kebijakan,
5. mencetak media poster pengamanan limbah medis.

H. Perumahan

Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dan sehat, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat bersama keluarga. Rumah yang layak harus menjamin kepentingan keluarga salah satunya menjamin kesehatan keluarga.

Definisi perumahan (*housing*) menurut WHO (*World Health Organisation*) adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Persyaratan rumah sehat yang tercantum dalam *Residential Environment* dari WHO (1974) antara lain:

1. Harus dapat terlindung dari hujan, panas, dingin, dan berfungsi sebagai tempat istirahat.
2. Mempunyai tempat-tempat untuk tidur, memasak, mandi, mencuci, kakus dan kamar mandi.
3. Dapat melindungi bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran.
4. Bebas dari bahan bangunan berbahaya.
5. Terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan, dan penyakit menular.
6. Memberi rasa aman dan lingkungan tetangga yang serasi.

Salah satu Instrumen Penilaian Rumah Sehat mengacu pada Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat Departemen Kesehatan RI Tahun 2007, dengan pembagian bobot penilaian meliputi bobot komponen rumah, bobot sarana sanitasi, serta bobot pada perilaku penghuni. Sesuai dengan pedoman ini, secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (1) memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-masing penghuni, (2) memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup, dan (3) memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah.

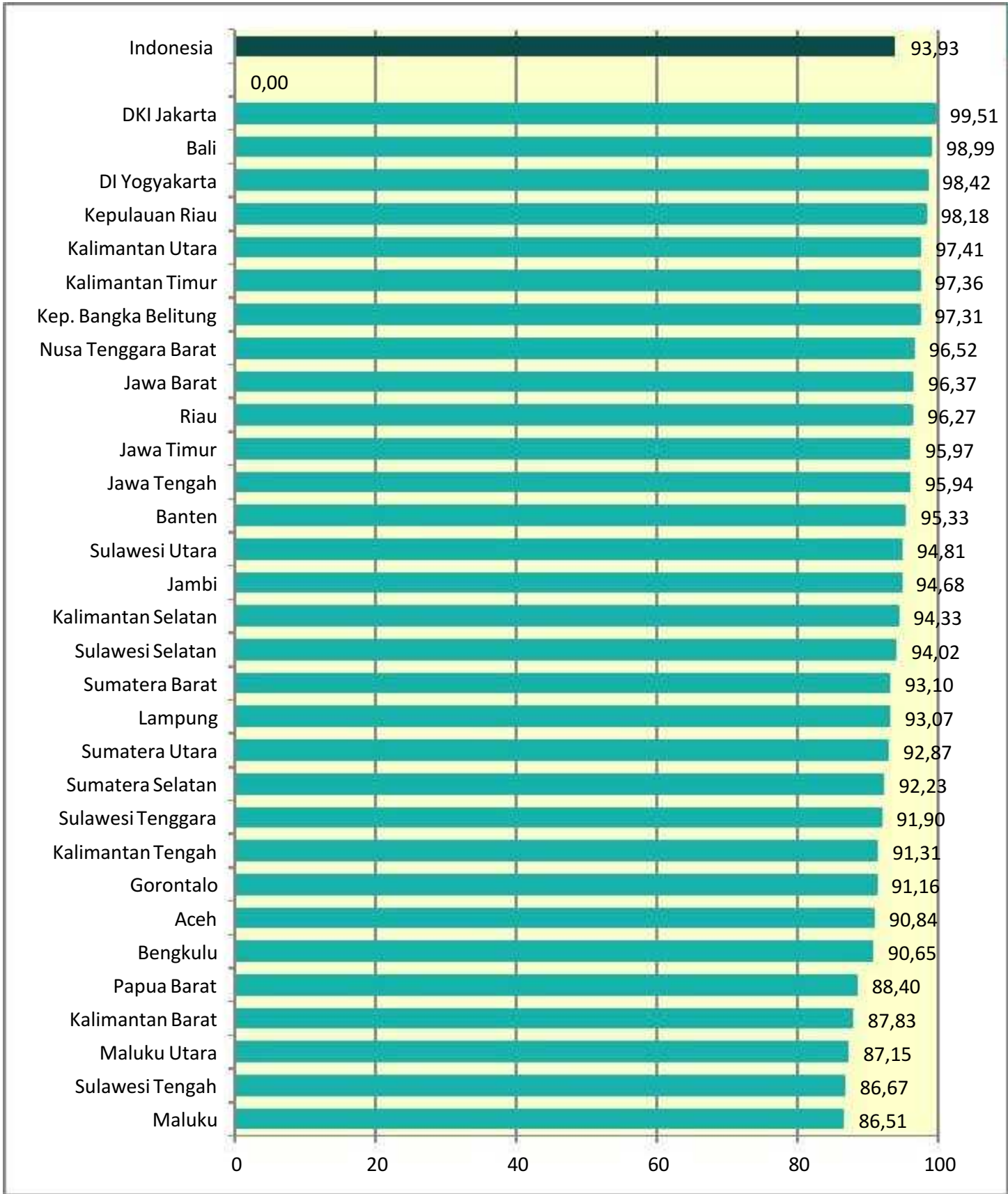
Rumah layak huni mendukung terciptanya rumah yang sehat. Definisi rumah layak huni menurut Badan Pusat Statistik 2015, adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Penilaian rumah layak huni diperoleh melalui indikator komposit dari tujuh indikator terkait yaitu;

1. Akses Air Layak.
2. Akses Sanitasi Layak.
3. *Sufficient Living Area* (Luas lantai per kapita > 7,2 m²).
4. Jenis Lantai.
5. Jenis Dinding.
6. Jenis Atap.
7. Penerangan Listrik.

Rumah yang dikategorikan layak huni, adalah rumah yang maksimum hanya memiliki dua indikator pembentuk yang kurang baik dari tujuh indikator rumah layak huni. Indikator rumah layak huni dapat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin

tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat mengindikasikan semakin terpenuhi kebutuhan dasar akan perumahan sehat.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2016

Gambar 7.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 capaian rumah tangga di Indonesia yang telah menempati rumah layak huni 93,93%, meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar 92,80% rumah tangga. Provinsi dengan rumah layak huni

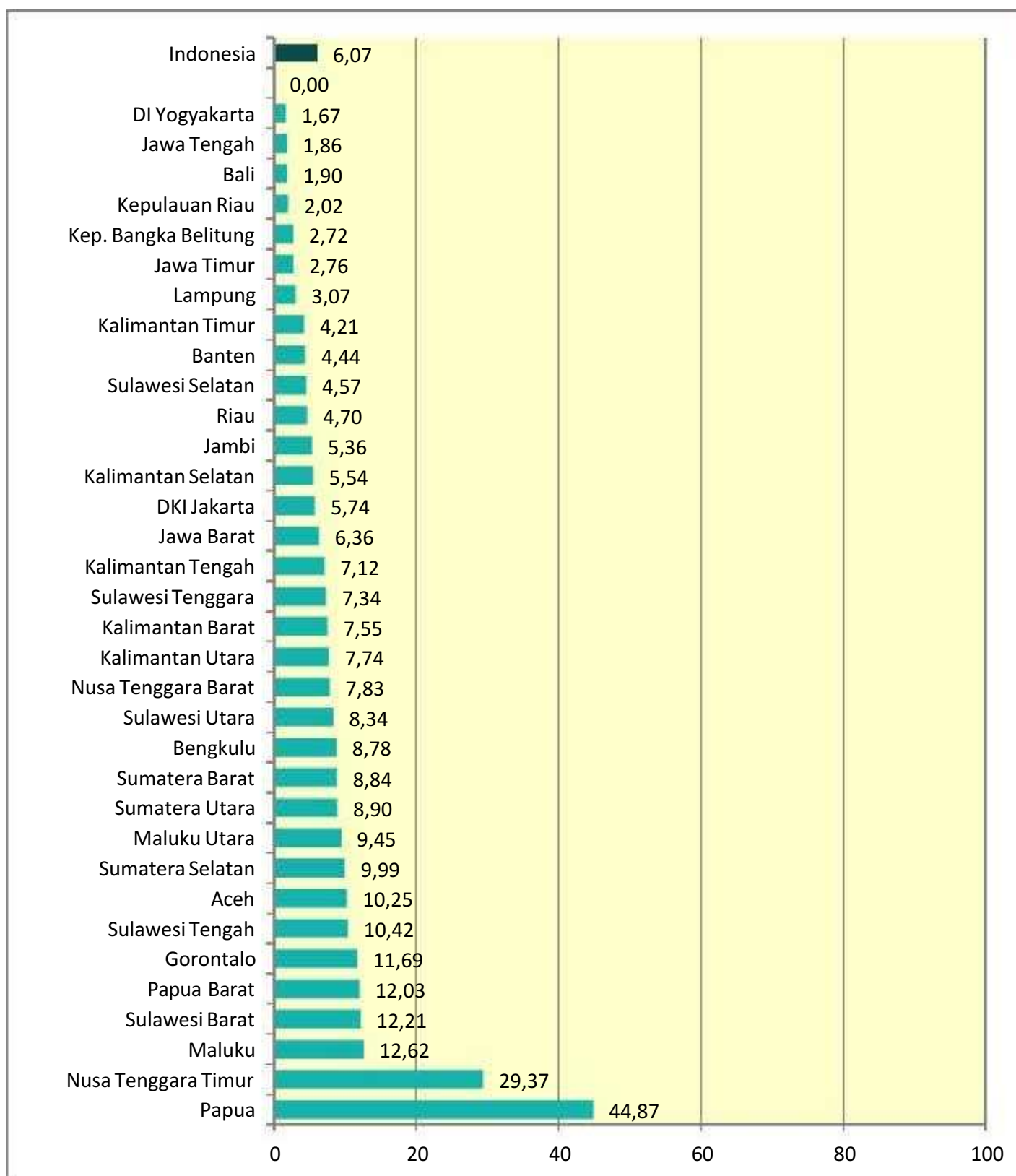
terbesar yaitu DKI Jakarta (99,51%), Bali (98,99%), dan DI Yogyakarta (98,42%). Provinsi dengan persentase rumah layak huni terendah yaitu Maluku (86,51%), Sulawesi Tengah (86,67%), dan Maluku Utara (87,15%). Data dari BPS 2015, jika dikategorikan menurut tipe daerah, persentase rumah tangga di daerah perkotaan relatif lebih besar dibanding dengan daerah perdesaan, yaitu (97,65% berbanding 87,92%). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dalam upaya peningkatan penyediaan rumah layak huni di daerah perdesaan lebih besar dari daerah perkotaan. Rincian lengkap mengenai rumah layak huni menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 7.9.

Rumah tangga kumuh adalah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni, merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta memenuhi syarat bagi kesehatan penghuninya. Seperti halnya indikator rumah layak huni, indikator penilaian rumah kumuh merupakan indikator komposit. Indikator pembentuk rumah tangga kumuh sama dengan indikator pembentukan rumah layak huni/rumah tidak layak huni. Perbedaannya ada pada pembobotan penghitungan rumah tangga kumuh. Komponen yang digunakan dalam penghitungan indikator Rumah Tangga Kumuh adalah :

1. Akses Air Layak.
2. Akses Sanitasi Layak.
3. *Sufficient Living Area* (Luas lantai per kapita > 7,2 m²).
4. Jenis Lantai, Dinding dan Atap.

Gambar 7.11 menunjukkan persentase rumah tangga kumuh menurut provinsi secara nasional pada tahun 2016 sebesar 6,07%, menurun dari tahun sebelumnya tahun 2015 persentase rumah tangga kumuh 7,07%. Angka nasional rumah tangga kumuh menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah cukup baik. Terdapat 20 provinsi yang persentase rumah tangga kumuh lebih tinggi dari angka nasional, provinsi dengan persentase rumah tangga kumuh terendah yaitu DI Yogyakarta (1,67%), Jawa Tengah (1,86%), dan Bali (1,90%). Sedangkan provinsi dengan rumah tangga kumuh terbesar yaitu Papua (44,87%), NTT (29,37%), dan Maluku (12,62%). Data dari BPS tahun 2015, persentase rumah tangga kumuh di daerah perdesaan lebih besar dari daerah perkotaan (9,20 persen berbanding 4.96%). Sehingga memperlihatkan kebutuhan akan penurunan angka rumah tangga kumuh di perdesaan lebih besar dari daerah perkotaan. Rincian lengkap rumah tangga kumuh menurut provinsi pada tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Lampiran 7.10.

GAMBAR 7.11
PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Buku 1 Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Susenas Maret 2016*, Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2012-2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik RI
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Juli 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik RI
- Direktorat Kesehatan Lingkungan, 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2006. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2010 tentang Pengendalian Vektor*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 299 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan Pengawasan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33/MENKES/PER/2012 tentang ASI*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011-2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Survei Prevalensi Tuberkulosis 2013-2014*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2013. *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2011. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2014. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 193*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 184*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 259*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Health Organization. 2016. *Global Tuberculosis Report 2016*. Jenewa: WHO.

* * *

Lampiran 1.6

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF DAN USIA NON PRODUKTIF, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)			Angka Beban Tanggungan (ABT)
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	814.226	780.890	1.595.116	1.642.610	1.656.746	3.299.356	88.277	113.499	201.776	54,46
2	Sumatera Utara	2.290.502	2.195.106	4.485.608	4.494.280	4.539.617	9.033.897	252.544	330.862	583.406	56,11
3	Sumatera Barat	806.562	774.753	1.581.315	1.684.864	1.701.138	3.386.002	125.847	166.364	292.211	55,33
4	Riau	1.029.602	982.034	2.011.636	2.215.418	2.086.041	4.301.459	91.854	96.022	187.876	51,13
5	Jambi	488.349	473.177	961.526	1.208.938	1.149.480	2.358.418	67.648	71.334	138.982	46,66
6	Sumatera Selatan	1.197.130	1.142.445	2.339.575	2.783.725	2.681.212	5.464.937	166.285	190.104	356.389	49,33
7	Bengkulu	274.716	261.632	536.348	659.684	632.161	1.291.845	36.886	39.714	76.600	47,45
8	Lampung	1.176.505	1.121.198	2.297.703	2.826.542	2.668.030	5.494.572	202.647	210.219	412.866	49,33
9	Kep. Bangka Belitung	195.757	187.039	382.796	505.457	456.399	961.856	27.366	29.809	57.175	45,74
10	Kep. Riau	318.284	304.085	622.369	693.819	664.229	1.358.048	23.408	24.344	47.752	49,34
11	DKI Jakarta	1.306.745	1.247.190	2.553.935	3.664.443	3.659.948	7.324.391	188.495	210.807	399.302	40,32
12	Jawa Barat	6.522.018	6.210.095	12.732.113	16.329.470	15.835.946	32.165.416	1.159.773	1.322.087	2.481.860	47,30
13	Jawa Tengah	4.249.536	4.032.863	8.282.399	11.398.138	11.609.441	23.007.579	1.223.520	1.505.597	2.729.117	47,86
14	DI Yogyakarta	415.136	395.050	810.186	1.274.454	1.291.311	2.565.765	150.361	194.600	344.961	45,02
15	Jawa Timur	4.573.298	4.379.248	8.952.546	13.407.248	13.733.047	27.140.295	1.307.460	1.674.851	2.982.311	43,97
16	Banten	1.770.680	1.690.050	3.460.730	4.266.685	4.083.523	8.350.208	184.275	207.935	392.210	46,14
17	Bali	523.119	495.787	1.018.906	1.459.689	1.432.450	2.892.139	132.134	156.890	289.024	45,22
18	Nusa Tenggara Barat	746.262	715.539	1.461.801	1.517.829	1.674.396	3.192.225	111.659	130.477	242.136	53,38
19	Nusa Tenggara Timur	921.064	892.135	1.813.199	1.538.356	1.596.518	3.134.874	118.533	136.908	255.441	65,99
20	Kalimantan Barat	728.653	697.145	1.425.798	1.645.296	1.582.916	3.228.212	101.717	106.011	207.728	50,60
21	Kalimantan Tengah	367.381	351.202	718.583	925.300	827.293	1.752.593	39.593	39.423	79.016	45,51
22	Kalimantan Selatan	593.913	566.907	1.160.820	1.389.930	1.341.196	2.731.126	72.235	91.298	163.533	48,49
23	Kalimantan Timur	502.230	475.071	977.301	1.279.077	1.138.432	2.417.509	54.986	51.436	106.422	44,83
24	Kalimantan Utara	104.511	99.223	203.734	237.677	203.978	441.655	11.341	9.603	20.944	50,87
25	Sulawesi Utara	319.198	303.748	622.946	856.022	808.313	1.664.335	68.223	81.417	149.640	46,42
26	Sulawesi Tengah	430.370	409.566	839.936	995.545	950.157	1.945.702	66.237	69.840	136.077	50,16
27	Sulawesi Selatan	1.252.938	1.199.445	2.452.383	2.736.192	2.907.770	5.643.962	214.980	295.050	510.030	52,49
28	Sulawesi Tenggara	436.345	415.002	851.347	798.224	797.016	1.595.240	47.755	56.666	104.421	59,91
29	Gorontalo	165.394	157.958	323.352	388.378	388.217	776.595	22.710	28.108	50.818	48,18
30	Sulawesi Barat	210.682	201.154	411.836	420.326	420.885	841.211	24.444	28.987	53.431	55,31
31	Maluku	290.877	276.633	567.510	540.723	536.154	1.076.877	33.568	37.593	71.161	59,31
32	Maluku Utara	202.304	194.172	396.476	383.223	366.678	749.901	19.541	19.994	39.535	58,14
33	Papua Barat	141.106	134.411	275.517	318.900	279.538	598.438	10.562	8.845	19.407	49,28
34	Papua	497.621	471.894	969.515	1.164.235	1.024.135	2.188.370	28.115	21.444	49.559	46,57
Indonesia		35.863.014	34.233.847	70.096.861	87.650.697	86.724.311	174.375.008	6.474.979	7.758.138	14.233.117	48,36

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 1.7

ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN),
IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	Jumlah WUS Imunisasi (15 - 39 tahun)	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin/Nifas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.393.653	1.093.724	128.497	122.657
2	Sumatera Utara	3.675.463	2.815.356	343.978	328.342
3	Sumatera Barat	1.347.451	1.025.125	122.662	117.087
4	Riau	1.786.991	1.391.407	168.360	160.708
5	Jambi	956.727	732.896	73.434	70.096
6	Sumatera Selatan	2.205.108	1.692.567	181.085	172.854
7	Bengkulu	526.265	403.079	41.298	39.421
8	Lampung	2.167.475	1.623.773	173.699	165.803
9	Kepulauan Bangka Belitung	377.443	289.232	29.868	28.511
10	Kepulauan Riau	586.799	459.647	46.926	44.793
11	DKI Jakarta	3.014.528	2.291.305	194.270	185.439
12	Jawa Barat	12.884.324	9.685.146	975.780	931.427
13	Jawa Tengah	8.832.601	6.377.151	596.722	569.599
14	DI Yogyakarta	976.903	708.585	59.524	56.819
15	Jawa Timur	10.451.422	7.462.261	638.168	609.161
16	Banten	3.462.770	2.650.918	270.246	257.962
17	Bali	1.124.552	801.612	71.720	68.460
18	Nusa Tenggara Barat	1.377.346	1.050.406	116.301	111.014
19	Nusa Tenggara Timur	1.306.263	1.009.409	148.553	141.800
20	Kalimantan Barat	1.311.861	1.015.002	112.679	107.558
21	Kalimantan Tengah	705.445	541.872	58.955	56.275
22	Kalimantan Selatan	1.104.519	823.916	91.310	87.159
23	Kalimantan Timur	962.853	732.070	82.224	78.486
24	Kalimantan Utara	172.519	134.318	13.338	12.731
25	Sulawesi Utara	629.994	461.264	45.942	43.853
26	Sulawesi Tengah	785.974	594.309	69.549	66.387
27	Sulawesi Selatan	2.353.301	1.775.145	188.046	179.499
28	Sulawesi Tenggara	672.140	523.196	68.140	65.042
29	Gorontalo	320.115	243.561	26.008	24.826
30	Sulawesi Barat	357.753	275.686	35.437	33.826
31	Maluku	446.156	351.912	48.326	46.130
32	Maluku Utara	310.774	243.758	31.942	30.490
33	Papua Barat	242.251	192.336	23.450	22.384
34	Papua	909.463	700.899	78.157	74.605
Indonesia		69.739.202	52.172.843	5.354.594	5.111.204

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 1.8

ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)			Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)			Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	114.218	110.055	224.273	55.413	52.764	108.177	313.747	299.429	613.176
2	Sumatera Utara	321.192	309.929	631.121	155.304	148.871	304.175	899.003	855.039	1.754.042
3	Sumatera Barat	111.134	106.865	217.999	54.147	51.939	106.086	316.850	303.554	620.404
4	Riau	142.516	136.403	278.919	67.088	63.140	130.228	392.167	370.939	763.106
5	Jambi	65.089	63.011	128.100	31.655	30.975	62.630	194.663	189.546	384.209
6	Sumatera Selatan	164.594	157.148	321.742	79.960	75.661	155.621	470.470	445.458	915.928
7	Bengkulu	37.097	35.360	72.457	18.334	17.283	35.617	109.381	103.162	212.543
8	Lampung	164.851	156.895	321.746	80.146	75.798	155.944	462.789	438.183	900.972
9	Kep. Bangka Belitung	26.315	25.155	51.470	12.962	12.343	25.305	77.288	73.509	150.797
10	Kep. Riau	45.162	43.441	88.603	21.775	20.684	42.459	124.825	118.066	242.891
11	DKI Jakarta	193.367	186.986	380.353	88.694	84.453	173.147	490.126	460.701	950.827
12	Jawa Barat	887.330	843.267	1.730.597	430.818	407.335	838.153	2.556.237	2.421.673	4.977.910
13	Jawa Tengah	572.536	538.859	1.111.395	284.647	269.265	553.912	1.712.967	1.628.318	3.341.285
14	DI Yogyakarta	57.008	54.333	111.341	27.473	26.071	53.544	163.203	154.449	317.652
15	Jawa Timur	610.066	584.015	1.194.081	307.849	293.755	601.604	1.862.783	1.778.266	3.641.049
16	Banten	251.522	240.141	491.663	120.198	113.709	233.907	681.298	645.399	1.326.697
17	Bali	68.704	65.043	133.747	35.562	33.344	68.906	217.630	204.499	422.129
18	Nusa Tenggara Barat	102.906	98.888	201.794	50.802	48.420	99.222	294.103	280.409	574.512
19	Nusa Tenggara Timur	123.679	120.145	243.824	60.827	60.579	121.406	362.597	353.377	715.974
20	Kalimantan Barat	100.254	95.928	196.182	48.287	45.955	94.242	283.280	269.737	553.017
21	Kalimantan Tengah	48.829	46.622	95.451	24.464	23.112	47.576	144.272	136.340	280.612
22	Kalimantan Selatan	84.326	81.289	165.615	39.874	37.668	77.542	230.415	217.702	448.117
23	Kalimantan Timur	68.586	64.845	133.431	32.882	30.821	63.703	193.173	180.990	374.163
24	Kalimantan Utara	14.413	13.691	28.104	6.910	6.507	13.417	40.361	38.132	78.493
25	Sulawesi Utara	43.042	40.548	83.590	20.751	20.039	40.790	127.272	121.168	248.440
26	Sulawesi Tengah	60.214	58.041	118.255	27.558	25.861	53.419	163.824	153.883	317.707
27	Sulawesi Selatan	169.931	162.995	332.926	82.525	79.377	161.902	493.775	471.627	965.402
28	Sulawesi Tenggara	60.928	57.997	118.925	30.559	28.870	59.429	172.590	163.019	335.609
29	Gorontalo	22.077	21.131	43.208	10.917	10.363	21.280	65.066	61.679	126.745
30	Sulawesi Barat	28.349	27.183	55.532	14.006	13.205	27.211	81.394	76.766	158.160
31	Maluku	39.472	37.526	76.998	19.276	18.020	37.296	111.877	105.095	216.972
32	Maluku Utara	27.449	26.500	53.949	13.547	12.947	26.494	79.799	76.272	156.071
33	Papua Barat	18.624	17.754	36.378	9.248	8.649	17.897	55.221	51.878	107.099
34	Papua	65.675	63.729	129.404	32.725	31.703	64.428	196.822	185.196	382.018
Indonesia		4.911.455	4.691.718	9.603.173	2.397.183	2.279.486	4.676.669	14.141.268	13.433.460	27.574.728

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 1.9

JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2000 - 2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2000	12,31	26,43	38,74	14,6	22,38	19,14	91.632,00	73.648,00
2	2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41	100.011,00	80.382,00
3	2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,1	18,2	130.499,00	96.512,00
4	2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42	138.803,00	105.888,00
5	2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66	143.455,00	108.725,00
6	2005	12,40	22,7	35,1	11,68	19,98	15,97	165.565,00	117.365,00
7	2006	14,49	24,81	39,3	13,47	21,81	17,75	174.290,00	130.584,00
8	2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187.942,00	146.837,00
9	2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204.895,99	161.830,79
10	2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222.123,10	179.834,57
11	2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232.989,00	192.353,83
12	Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253.015,51	213.394,51
13	September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263.593,84	223.180,69
14	Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267.407,53	229.225,78
15	September 2012	10,51	18,09	28,59	8,6	14,7	11,66	277.381,99	240.441,35
16	Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289.042,00	253.273,00
17	September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308.626,00	275.779,00
18	Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318.514,00	286.097,00
19	September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326.853,00	296.681,00
20	Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342.541,00	317.881,00
21	September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356.378,00	333.034,00
22	Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364.527,00	343.647,00
23	September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372.114,00	350.420,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Lampiran 1.10

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2016

No	Provinsi	Maret									September								
		Perkotaan			Perdesaan			Total			Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribuorang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribuorang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribuorang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribuorang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	427.970	159,50	10,82	403.985	688,94	19,15	410.956	848,44	16,73	445.488	163,02	10,79	415.826	678,29	18,80	424.765	841,31	16,43
2	Sumatera Utara	398.408	690,80	9,75	377.748	765,15	10,97	388.156	1.455,95	10,35	413.835	690,34	9,69	388.707	762,21	10,86	401.832	1.452,55	10,27
3	Sumatera Barat	441.523	118,96	5,54	413.790	252,59	8,16	425.141	371,55	7,09	454.674	119,51	5,52	425.520	257,00	8,27	438.075	376,51	7,14
4	Riau	426.346	162,45	6,40	425.777	352,95	9,00	426.001	515,40	7,98	439.542	164,12	6,38	433.960	337,47	8,51	437.259	501,59	7,67
5	Jambi	438.600	115,35	10,86	342.137	174,46	7,32	371.875	289,81	8,41	448.615	116,33	10,73	349.735	174,48	7,30	379.648	290,81	8,37
6	Sumatera Selatan	388.060	374,53	12,74	331.570	726,67	13,99	351.984	1.101,20	13,54	400.159	377,88	12,73	339.874	718,62	13,77	361.696	1.096,50	13,39
7	Bengkulu	430.572	97,34	16,19	409.863	231,27	17,85	416.427	328,61	17,32	458.435	98,07	16,16	427.315	227,53	17,43	437.184	325,60	17,03
8	Lampung	392.488	233,39	10,53	354.678	936,21	15,69	364.922	1.169,60	14,29	398.378	227,44	10,15	357.792	912,34	15,24	368.592	1.139,78	13,86
9	Kep. Bangka Belitung	521.773	19,63	2,78	546.998	53,13	7,72	534.229	72,76	5,22	553.681	19,37	2,67	573.582	51,70	7,57	564.391	71,07	5,04
10	Kep. Riau	494.418	87,78	5,16	466.989	32,63	10,43	490.157	120,41	5,98	505.980	86,19	4,99	481.687	32,95	10,47	502.653	119,14	5,84
11	DKI Jakarta	510.359	384,30	3,75				510.359	384,30	3,75	520.690	385,84	3,75				520.690	385,84	3,75
12	Jawa Barat	325.017	2.497,59	7,67	324.937	1.726,73	11,80	324.992	4.224,32	8,95	332.145	2.543,30	7,55	331.237	1.624,81	11,72	332.119	4.168,11	8,77
13	Jawa Tengah	315.269	1.824,08	11,44	319.188	2.682,81	14,89	317.348	4.506,89	13,27	322.799	1.879,55	11,38	322.489	2.614,20	14,88	322.748	4.493,75	18,19
14	DI Yogyakarta	364.786	297,71	11,79	331.308	197,23	16,63	354.084	494,94	13,34	370.510	301,25	11,68	337.230	187,58	16,27	360.169	488,83	13,10
15	Jawa Timur	319.662	1.518,79	7,94	323.779	3.184,51	16,01	321.761	4.703,30	12,05	329.241	1.552,77	7,91	328.846	3.085,76	15,83	329.172	4.638,53	11,85
16	Banten	377.052	377,10	4,51	347.765	281,01	7,45	367.949	658,11	5,42	382.903	380,16	4,49	351.708	277,58	7,32	373.365	657,74	5,36
17	Bali	348.571	96,98	3,68	322.660	81,20	5,23	338.967	178,18	4,25	357.427	93,74	3,53	328.033	81,20	5,21	346.398	174,94	4,15
18	Nusa Tenggara Barat	343.580	385,22	18,20	326.656	419,23	15,17	333.996	804,45	16,48	346.581	378,83	17,55	328.775	407,75	14,82	336.573	786,58	16,02
19	Nusa Tenggara Timur	386.139	112,02	10,58	306.721	1.037,90	25,17	322.947	1.149,92	22,19	389.661	112,48	10,17	310.296	1.037,60	25,19	327.003	1.150,08	22,01
20	Kalimantan Barat	353.143	78,29	5,16	345.480	303,06	9,11	347.880	381,35	7,87	366.477	75,98	4,97	360.940	314,34	9,38	363.027	390,32	8,00
21	Kalimantan Tengah	348.254	41,07	4,60	387.202	102,42	6,23	373.484	143,49	5,66	357.224	40,61	4,49	392.543	96,85	5,83	380.524	137,46	5,36
22	Kalimantan Selatan	386.462	60,83	3,48	370.612	134,87	5,89	377.480	195,70	4,85	399.162	60,90	3,43	380.647	123,26	5,37	389.273	184,16	4,52
23	Kalimantan Timur	519.653	88,04	3,93	495.975	124,88	10,05	511.205	212,92	6,11	535.137	89,64	3,86	510.041	121,60	10,15	526.686	211,24	6,00
24	Kalimantan Utara	523.914	14,21	3,78	499.980	26,91	9,47	513.614	41,12	6,23	539.499	17,25	4,50	518.305	29,78	10,29	530.566	47,03	6,99
25	Sulawesi Utara	312.328	60,62	5,34	321.985	142,20	10,97	317.478	202,82	8,34	314.004	59,73	5,22	322.366	140,62	10,82	318.984	200,35	8,20
26	Sulawesi Tengah	391.070	75,45	10,18	370.392	345,07	15,91	375.659	420,52	14,45	399.413	75,90	10,07	376.658	337,25	15,48	382.775	413,15	14,09
27	Sulawesi Selatan	281.676	149,13	4,51	263.674	657,90	12,46	270.601	807,03	9,40	286.669	150,60	4,47	267.428	646,21	12,30	275.361	796,81	9,24
28	Sulawesi Tenggara	289.827	51,01	6,74	271.961	275,86	15,49	277.288	326,87	12,88	294.286	53,18	6,87	276.978	274,11	15,31	282.161	327,29	12,77
29	Gorontalo	284.308	24,08	5,84	284.190	179,11	24,41	284.232	203,19	17,72	287.156	24,02	5,78	285.999	179,67	24,30	286.968	203,69	17,63
30	Sulawesi Barat	273.224	22,85	8,59	290.340	129,88	12,56	286.840	152,73	11,74	280.117	25,07	8,43	295.739	121,83	12,00	292.519	146,90	11,19
31	Maluku	412.980	52,08	7,66	415.177	275,64	26,82	7.414.302	327,72	19,18	424.788	54,24	7,86	423.698	277,55	26,88	424.656	331,79	19,26
32	Maluku Utara	390.788	10,57	3,32	371.289	64,10	7,44	376.554	74,67	6,33	405.368	12,45	3,76	379.454	63,95	7,43	386.489	76,40	6,41
33	Papua Barat	487.727	20,96	6,14	466.996	204,85	37,48	474.967	225,81	25,43	508.262	20,11	5,69	480.945	203,49	37,33	492.969	223,60	24,88
34	Papua	466.985	37,08	4,42	412.991	874,25	37,14	427.176	911,33	28,54	479.294	35,77	4,21	425.264	879,10	37,07	440.021	914,87	28,40
	Indonesia	364.527	10.339,79	7,79	343.647	17.665,62	14,11	354.386	28.005,41	10,86	372.114	10.485,64	7,73	350.420	17.278,68	13,96	361.990	27.764,32	10,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
Catatan : DKI Jakarta tidak memiliki kidesa

Lampiran 1.11

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Maret						September					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparah an Kemiskinan (P2)**			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparah an Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	2,30	3,96	3,48	0,70	1,12	1,00	1,45	3,74	3,06	0,28	1,11	0,87
2	Sumatera Utara	1,75	1,79	1,77	0,47	0,52	0,50	1,62	2,30	1,96	0,42	0,70	0,56
3	Sumatera Barat	0,75	1,33	1,10	0,15	0,30	0,24	1,04	1,18	1,12	0,25	0,30	0,28
4	Riau	0,93	1,63	1,36	0,20	0,42	0,34	1,33	1,37	1,36	0,45	0,36	0,40
5	Jambi	2,10	1,19	1,47	0,55	0,29	0,37	2,41	0,97	1,42	0,71	0,21	0,36
6	Sumatera Selatan	1,79	2,14	2,02	0,37	0,46	0,43	1,89	2,00	1,96	0,47	0,49	0,48
7	Bengkulu	2,83	3,29	3,14	0,70	0,81	0,77	2,89	2,74	2,79	0,65	0,64	0,64
8	Lampung	1,86	2,91	2,63	0,48	0,79	0,70	1,29	2,16	1,92	0,27	0,46	0,41
9	Kep. Bangka Belitung	0,38	0,98	0,67	0,08	0,22	0,15	0,29	1,25	0,75	0,04	0,28	0,16
10	Kep. Riau	0,77	1,53	0,89	0,18	0,31	0,20	0,62	1,23	0,71	0,13	0,25	0,15
11	DKI Jakarta	0,46	***	0,46	0,08	***	0,08	0,43	***	0,43	0,08	***	0,08
12	Jawa Barat	1,17	2,20	1,49	0,26	0,62	0,37	1,08	1,77	1,28	0,24	0,37	0,28
13	Jawa Tengah	1,78	2,90	2,37	0,40	0,83	0,63	1,94	2,30	2,12	0,49	0,59	0,54
14	DI Yogyakarta	1,78	3,41	2,30	0,38	1,05	0,59	1,27	2,83	1,75	0,22	0,67	0,36
15	Jawa Timur	1,10	2,83	1,99	0,23	0,71	0,47	1,33	2,57	1,95	0,34	0,61	0,47
16	Banten	0,61	1,21	0,80	0,13	0,25	0,17	0,69	0,93	0,76	0,16	0,17	0,17
17	Bali	0,45	0,62	0,51	0,08	0,12	0,09	0,40	0,76	0,53	0,06	0,18	0,11
18	Nusa Tenggara Barat	3,14	2,90	3,00	0,78	0,77	0,77	3,03	2,31	2,63	0,78	0,55	0,65
19	Nusa Tenggara Timur	1,75	5,44	4,69	0,46	1,51	1,30	1,70	4,40	3,83	0,46	1,09	0,96
20	Kalimantan Barat	0,66	1,59	1,30	0,13	0,40	0,32	0,67	1,35	1,13	0,12	0,30	0,24
21	Kalimantan Tengah	0,54	1,03	0,86	0,10	0,25	0,20	0,68	0,63	0,65	0,17	0,14	0,15
22	Kalimantan Selatan	0,58	0,81	0,71	0,14	0,19	0,16	0,72	0,67	0,69	0,19	0,15	0,16
23	Kalimantan Timur	0,55	1,94	1,04	0,12	0,56	0,28	0,59	1,23	0,81	0,13	0,25	0,17
24	Kalimantan Utara	0,59	1,04	0,78	0,16	0,19	0,17	0,74	1,06	0,88	0,23	0,20	0,21
25	Sulawesi Utara	0,78	2,19	1,53	0,17	0,71	0,46	0,79	1,89	1,38	0,19	0,46	0,34
26	Sulawesi Tengah	1,89	3,01	2,72	0,53	0,79	0,73	1,93	2,40	2,28	0,56	0,56	0,56
27	Sulawesi Selatan	0,65	2,56	1,83	0,16	0,79	0,55	0,92	1,93	1,53	0,29	0,45	0,38
28	Sulawesi Tenggara	1,33	3,37	2,76	0,44	1,09	0,90	1,14	2,35	1,98	0,29	0,53	0,46
29	Gorontalo	0,90	5,93	4,12	0,20	2,18	1,47	0,72	3,95	2,79	0,14	0,94	0,65
30	Sulawesi Barat	0,90	2,22	1,95	0,14	0,57	0,48	1,69	1,90	1,85	0,40	0,45	0,44
31	Maluku	1,47	5,06	3,63	0,37	1,40	0,99	1,25	5,44	3,76	0,37	1,65	1,13
32	Maluku Utara	0,37	0,86	0,73	0,06	0,22	0,18	0,25	1,18	0,92	0,02	0,28	0,21
33	Papua Barat	0,86	11,19	7,21	0,19	4,46	2,82	1,30	9,51	6,28	0,36	3,44	2,23
34	Papua	0,88	12,39	9,37	0,22	5,60	4,19	0,79	9,82	7,44	0,20	3,53	2,65
Indonesia		1,19	2,74	1,94	0,27	0,79	0,53	1,21	2,32	1,74	0,29	0,59	0,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Catatan :

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparah an Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2016

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34
2	Sumatera Utara	0,33	0,33	0,31	0,33	0,31
3	Sumatera Barat	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31
4	Riau	0,38	0,39	0,38	0,37	0,35
5	Jambi	0,36	0,33	0,34	0,34	0,35
6	Sumatera Selatan	0,40	0,38	0,38	0,33	0,36
7	Bengkulu	0,36	0,37	0,36	0,37	0,35
8	Lampung	0,36	0,36	0,33	0,35	0,36
9	Kep. Bangka Belitung	0,31	0,31	0,30	0,28	0,29
10	Kep. Riau	0,39	0,38	0,44	0,34	0,35
11	DKI Jakarta	0,44	0,40	0,44	0,42	0,40
12	Jawa Barat	0,42	0,41	0,40	0,43	0,40
13	Jawa Tengah	0,37	0,39	0,39	0,38	0,36
14	DI Yogyakarta	0,45	0,42	0,44	0,42	0,43
15	Jawa Timur	0,36	0,37	0,40	0,40	0,40
16	Banten	0,38	0,38	0,42	0,39	0,39
17	Bali	0,40	0,44	0,44	0,40	0,37
18	Nusa Tenggara Barat	0,35	0,35	0,39	0,36	0,37
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,34	0,36	0,35	0,36
20	Kalimantan Barat	0,40	0,38	0,40	0,33	0,33
21	Kalimantan Tengah	0,33	0,36	0,37	0,30	0,35
22	Kalimantan Selatan	0,36	0,36	0,33	0,33	0,35
23	Kalimantan Timur	0,36	0,37	0,36	0,32	0,33
24	Kalimantan Utara	-	-	-	0,31	0,31
25	Sulawesi Utara	0,43	0,45	0,44	0,37	0,38
26	Sulawesi Tengah	0,39	0,39	0,35	0,37	0,35
27	Sulawesi Selatan	0,42	0,43	0,45	0,40	0,40
28	Sulawesi Tenggara	0,40	0,39	0,40	0,38	0,39
29	Gorontalo	0,41	0,45	0,45	0,40	0,41
30	Sulawesi Barat	0,34	0,32	0,38	0,36	0,37
31	Maluku	0,38	0,35	0,33	0,34	0,34
32	Maluku Utara	0,31	0,32	0,32	0,29	0,31
33	Papua Barat	0,41	0,42	0,41	0,43	0,40
34	Papua	0,45	0,44	0,46	0,39	0,40
Indonesia		0,41	0,41	0,41	0,40	0,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Keterangan : Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan, nilai koefisien adalah 0 - 1

Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang

Lampiran 1.13
 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK BARANG DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL TAHUN 2016

No	Kelompok Barang	Persentase (%)		
		Per kota an	Per de sa an	Per ko ta an + Per de sa an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Makanan			
1	Padi-padian	4,98	10,04	6,82
2	Umbi-umbian	0,38	0,80	0,53
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,06	4,40	3,55
4	Daging	2,30	1,94	2,17
5	Telur dan Susu	3,06	2,79	2,96
6	Sayur-sayuran	3,01	4,75	3,65
7	Kacang-kacangan	0,97	1,30	1,09
8	Buah-buahan	2,05	2,02	2,04
9	Minyak dan kelapa	1,06	1,84	1,34
10	Bahan minuman	1,34	2,30	1,69
11	Bumbu-bumbuan	0,79	1,28	0,97
12	Konsumsi lainnya	0,89	1,19	1,00
13	Makanan dan Minuman Jadi	15,22	12,27	14,14
14	Rokok	5,45	8,91	6,72
	Jumlah Makanan	44,57	55,83	48,68
II	Bukan Makanan			
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	28,67	22,99	26,60
2	Aneka Barang dan jasa	14,45	10,23	12,91
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	3,01	3,12	3,05
4	Barang tahan lama	4,81	4,65	4,75
5	Pajak, pungutan dan asuransi	2,67	1,60	2,28
6	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1,81	1,58	1,72
	Jumlah Bukan Makanan	55,43	44,17	51,32
	Jumlah Makanan + Bukan Makanan	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
 Keterangan : Susenas,Maret 2016

Lampiran 1.14

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2016

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	Aneka barang dan jasa	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	Barang-barang tahan lama	Pajak, pungutan dan asuransi	Keperluan pesta dan upacara	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	49,50	23,91	10,57	7,84	5,83	2,36	100,00
2	Sumatera Utara	51,16	28,86	7,80	4,76	4,87	2,56	100,00
3	Sumatera Barat	46,06	25,15	9,40	11,19	3,94	4,27	100,00
4	R i a u	53,10	23,41	8,08	8,56	4,13	2,72	100,00
5	J a m b i	54,75	21,71	8,16	7,59	4,18	3,60	100,00
6	Sumatera Selatan	56,87	23,89	5,85	6,84	3,81	2,74	100,00
7	Bengkulu	50,04	22,29	7,00	13,09	4,75	2,83	100,00
8	Lampung	51,13	23,34	7,16	9,91	4,01	4,45	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	57,24	20,93	5,81	7,68	5,15	3,19	100,00
10	Kepulauan Riau	56,94	24,74	5,64	5,62	4,97	2,10	100,00
11	DKI Jakarta	55,12	26,87	4,22	6,04	5,42	2,34	100,00
12	Jawa Barat	52,20	26,17	6,12	8,13	4,12	3,25	100,00
13	Jawa Tengah	45,83	26,78	5,68	13,04	4,48	4,19	100,00
14	DI Yogyakarta	45,68	29,32	4,85	10,97	5,18	4,01	100,00
15	Jawa Timur	48,82	25,52	5,57	11,53	4,83	3,74	100,00
16	B a n t e n	51,82	25,40	5,69	9,54	4,67	2,88	100,00
17	B a l i	53,22	21,51	3,05	9,74	4,94	7,54	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	53,64	23,70	6,11	10,36	3,17	3,02	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	57,64	23,44	5,02	8,45	3,29	2,17	100,00
20	Kalimantan Barat	57,51	22,20	6,24	7,53	3,23	3,29	100,00
21	Kalimantan Tengah	57,64	21,97	5,23	8,27	4,19	2,69	100,00
22	Kalimantan Selatan	52,68	22,50	6,69	11,32	3,74	3,07	100,00
23	Kalimantan Timur	58,76	22,36	4,71	6,78	4,47	2,91	100,00
24	Kalimantan Utara	57,39	22,95	5,03	8,97	3,89	1,77	100,00
25	Sulawesi Utara	51,29	25,70	7,37	8,16	3,16	4,31	100,00
26	Sulawesi Tengah	53,38	19,87	6,50	12,99	3,48	3,78	100,00
27	Sulawesi Selatan	50,52	21,40	6,49	12,48	4,59	4,52	100,00
28	Sulawesi Tenggara	51,60	21,56	5,83	13,99	4,13	2,89	100,00
29	Gorontalo	49,09	23,92	6,87	12,59	3,95	3,59	100,00
30	Sulawesi Barat	51,64	20,25	6,28	13,87	5,04	2,92	100,00
31	Maluku	58,78	24,06	5,72	6,88	2,76	1,80	100,00
32	Maluku Utara	61,22	24,21	6,13	4,55	1,99	1,90	100,00
33	Papua Barat	60,47	22,29	4,41	8,20	2,69	1,94	100,00
34	P a p u a	68,02	20,51	3,87	3,70	2,41	1,49	100,00
Indonesia		51,73	26,08	5,44	8,68	4,82	3,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Keterangan : Susenas,Maret 2016

Lampiran 1.15

JUMLAH PENGANGURAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Februari		Agustus	
		Jumlah (1000 orang)	TPT (%)	Jumlah (1000 orang)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	181,8	8,13	170,9	7,57
2	Sumatera Utara	428,0	6,49	371,7	5,84
3	Sumatera Barat	149,7	5,81	125,9	5,09
4	Riau	176,9	5,94	222,0	7,43
5	Jambi	79,1	4,66	67,7	4,00
6	Sumatera Selatan	159,5	3,94	180,2	4,31
7	Bengkulu	38,3	3,84	32,9	3,30
8	Lampung	183,5	4,54	190,3	4,62
9	Kepulauan Bangka Belitung	42,4	6,17	18,3	2,60
10	Kepulauan Riau	82,5	9,03	71,6	7,69
11	DKI Jakarta	306,2	5,77	317,0	6,12
12	Jawa Barat	1.899,7	8,57	1.873,9	8,89
13	Jawa Tengah	752,5	4,20	801,3	4,63
14	DI Yogyakarta	59,0	2,81	57,0	2,72
15	Jawa Timur	849,3	4,14	839,3	4,21
16	Banten	452,1	7,95	498,6	8,92
17	Bali	50,4	2,12	46,5	1,89
18	Nusa Tenggara Barat	87,2	3,66	97,0	3,94
19	Nusa Tenggara Timur	87,7	3,59	76,6	3,25
20	Kalimantan Barat	110,8	4,58	100,9	4,23
21	Kalimantan Tengah	47,2	3,67	63,2	4,82
22	Kalimantan Selatan	74,4	3,63	113,3	5,45
23	Kalimantan Timur	146,2	8,86	136,7	7,95
24	Kalimantan Utara	11,2	3,92	15,1	5,23
25	Sulawesi Utara	92,6	7,82	73,2	6,18
26	Sulawesi Tengah	51,7	3,46	49,7	3,29
27	Sulawesi Selatan	193,0	5,11	186,3	4,80
28	Sulawesi Tenggara	45,8	3,78	34,1	2,72
29	Gorontalo	21,9	3,88	15,5	2,76
30	Sulawesi Barat	17,4	2,72	21,5	3,33
31	Maluku	51,2	6,98	52,4	7,05
32	Maluku Utara	18,2	3,43	21,0	4,01
33	Papua Barat	25,0	5,73	32,5	7,46
34	Papua	51,7	2,97	57,7	3,35
Indonesia		7.024,2	5,50	7.031,8	5,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Lampiran 1.16

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016

No	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	11,07	10,86	10,96	8,90	8,49	8,69	9,54	9,18	9,36
2	Sumatera Utara	10,61	10,23	10,42	8,66	8,19	8,42	9,67	9,25	9,46
3	Sumatera Barat	10,40	10,48	10,44	7,93	7,89	7,91	8,96	8,98	8,97
4	R i a u	10,61	10,39	10,50	8,10	7,79	7,95	9,09	8,83	8,97
5	J a m b i	10,35	9,95	10,15	8,21	7,41	7,82	8,87	8,21	8,55
6	Sumatera Selatan	10,31	9,90	10,10	7,51	7,06	7,29	8,52	8,12	8,32
7	Bengkulu	11,11	10,83	10,97	8,04	7,54	7,80	9,01	8,63	8,82
8	Lampung	9,77	9,64	9,70	7,72	7,26	7,50	8,27	7,93	8,10
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,45	8,96	9,22	7,02	6,58	6,81	8,25	7,80	8,04
10	Kepulauan Riau	10,59	10,38	10,49	6,96	6,38	6,68	10,02	9,78	9,90
11	DKI Jakarta	11,28	10,57	10,92	-	-	-	11,28	10,57	10,92
12	Jawa Barat	9,41	8,80	9,11	7,17	6,50	6,84	8,72	8,09	8,41
13	Jawa Tengah	8,92	8,20	8,55	7,36	6,51	6,93	8,10	7,31	7,70
14	DI Yogyakarta	10,89	10,14	10,51	8,12	7,35	7,71	10,03	9,22	9,62
15	Jawa Timur	9,39	8,61	8,99	7,12	6,13	6,61	8,24	7,33	7,78
16	Banten	10,04	9,29	9,67	7,15	6,33	6,75	9,16	8,40	8,79
17	B a l i	10,39	9,13	9,77	8,05	6,46	7,25	9,53	8,14	8,84
18	Nusa Tenggara Barat	8,91	7,85	8,35	7,52	6,45	6,96	8,13	7,07	7,57
19	Nusa Tenggara Timur	10,51	10,12	10,31	6,87	6,65	6,75	7,69	7,39	7,54
20	Kalimantan Barat	9,76	9,03	9,39	6,95	6,20	6,59	7,83	7,14	7,49
21	Kalimantan Tengah	10,54	9,74	10,15	7,89	7,32	7,62	8,81	8,20	8,52
22	Kalimantan Selatan	9,86	9,28	9,57	7,66	6,90	7,29	8,62	7,94	8,28
23	Kalimantan Timur	10,65	10,11	10,39	8,32	7,58	7,98	9,81	9,25	9,55
24	Kalimantan Utara	9,90	9,58	9,74	8,48	7,45	8,02	9,27	8,71	9,01
25	Sulawesi Utara	10,24	10,19	10,22	8,33	8,68	8,50	9,22	9,41	9,31
26	Sulawesi Tengah	10,67	10,29	10,48	8,04	7,72	7,88	8,71	8,41	8,56
27	Sulawesi Selatan	10,51	10,01	10,25	7,23	6,94	7,08	8,52	8,12	8,31
28	Sulawesi Tenggara	11,18	10,77	10,97	8,30	7,55	7,92	9,18	8,54	8,86
29	Gorontalo	8,58	9,40	9,00	6,64	7,30	6,97	7,34	8,08	7,71
30	Sulawesi Barat	9,08	9,16	9,12	7,59	7,23	7,41	7,89	7,64	7,76
31	Maluku	11,04	10,95	10,99	8,95	8,59	8,77	9,81	9,58	9,69
32	Maluku Utara	11,24	10,67	10,96	8,51	7,79	8,16	9,28	8,62	8,96
33	Papua Barat	11,19	10,87	11,04	8,95	8,24	8,62	9,83	9,29	9,57
34	Papua	10,68	10,19	10,45	5,70	4,15	4,96	7,12	5,76	6,48
Indonesia		9,87	9,25	9,56	7,52	6,84	7,18	8,75	8,09	8,42

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Lampiran 1.17

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012 - 2016

No	Provinsi	Laki-Laki					Perempuan					Total				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	97,88	98,32	98,41	98,75	99,02	94,25	95,06	96,45	96,53	96,51	96,04	96,66	97,42	97,63	97,74
2	Sumatera Utara	98,57	98,86	99,28	99,32	99,39	96,08	96,79	97,88	98,04	98,38	97,31	97,81	98,57	98,68	98,88
3	Sumatera Barat	97,80	98,41	98,94	99,29	99,37	95,48	96,40	97,95	97,85	98,27	96,62	97,38	98,44	98,56	98,81
4	R i a u	98,66	98,78	99,28	99,55	99,56	96,59	96,94	98,18	98,16	98,56	97,65	97,88	98,75	98,87	99,07
5	J a m b i	98,00	98,27	98,76	98,88	98,87	93,48	95,10	96,73	96,75	97,11	95,79	96,72	97,77	97,84	98,01
6	Sumatera Selatan	98,33	98,43	98,96	98,9	99,37	95,24	96,01	97,29	97,52	97,53	96,8	97,24	98,14	98,22	98,46
7	Bengkulu	97,81	98,52	99,13	98,94	99,07	93,24	94,37	95,85	96,27	96,37	95,56	96,48	97,52	97,63	97,75
8	Lampung	97,21	97,84	97,38	98,41	98,08	92,44	93,66	95,66	94,89	95,42	94,89	95,81	96,54	96,67	96,78
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,80	97,77	98,65	99,03	98,86	93,40	94,94	96,47	96,78	96,35	95,70	96,41	97,60	97,63	97,66
10	Kepulauan Riau	98,38	98,97	99,26	99,84	99,2	96,79	96,82	98,14	98,53	98,48	97,6	97,91	98,71	98,79	98,84
11	DKI Jakarta	99,63	99,65	99,9	98,84	99,85	98,37	98,62	99,17	99,33	99,43	99	99,14	99,54	99,59	99,64
12	Jawa Barat	97,69	99,28	98,92	98,86	98,91	94,16	95,09	96,97	97,14	97,51	95,95	96,7	97,96	98,01	98,22
13	Jawa Tengah	94,20	95,33	95,64	96,36	96,33	85,83	87,38	90,42	90,01	90,38	89,93	91,27	92,98	93,12	93,3
14	DI Yogyakarta	95,77	96,74	96,99	97,35	97,21	88,42	89,06	91,98	91,78	92,07	92	92,82	94,44	94,5	94,59
15	Jawa Timur	93,26	94,42	93,89	94,94	94,93	84,62	86,07	88,96	88,17	88,41	88,82	90,14	91,36	91,47	91,59
16	Banten	98,3	98,34	98,51	98,57	98,67	94,19	94,89	95,92	96,14	96,38	96,28	96,64	97,24	97,37	97,55
17	B a l i	95,16	95,93	96,28	90,83	96,37	84,65	85,73	88,85	88,94	89,23	89,92	90,84	92,56	92,77	92,82
18	Nusa Tenggara Barat	88,31	89,22	90,56	92,84	91,12	78,12	80,6	83,76	83,5	83,42	82,92	84,67	86,96	86,97	87,06
19	Nusa Tenggara Timur	90,58	92,13	92,39	95,41	93,16	87,05	88,69	90,04	90,12	89,97	88,77	90,36	91,18	91,45	91,52
20	Kalimantan Barat	94,61	95,33	95,36	99,26	95,74	86,7	87,21	89,14	89,1	88,93	90,72	91,34	92,3	92,32	92,39
21	Kalimantan Tengah	98,44	98,84	99,46	99,23	99,52	96,31	96,91	98,12	98,45	98,36	97,43	97,93	98,82	98,88	98,97
22	Kalimantan Selatan	98,06	98,72	99,32	99,2	99,33	94,34	95,34	97,05	97,17	97,22	96,2	97,04	98,19	98,21	98,28
23	Kalimantan Timur	98,26	98,52	99,19	96,66	99,32	96,3	96,38	97,92	98,12	98,25	97,34	97,51	98,59	98,69	98,82
24	Kalimantan Utara	-	-	-	99,69	95,95	-	-	-	93,08	94,01	-	-	-	94,99	95,05
25	Sulawesi Utara	99,02	99,32	99,78	99,69	99,87	98,63	98,92	99,42	99,56	99,71	98,83	99,13	99,60	99,63	99,79
26	Sulawesi Tengah	95,92	96,98	97,99	98,24	98,11	93,34	94,87	96,11	96,41	96,88	94,66	95,95	97,08	97,34	97,51
27	Sulawesi Selatan	90,69	92,53	93,1	93,26	93,59	86,5	87,99	89,58	89,47	89,63	88,5	90,16	91,26	91,29	91,52
28	Sulawesi Tenggara	94,07	95,75	96,82	96,57	96,52	88,35	89,55	91,29	91,69	91,97	91,18	92,61	94,03	94,1	94,25
29	Gorontalo	94,94	96,56	97,16	98,02	98,49	95,3	97,10	98,63	98,45	98,39	95,12	96,83	97,9	98,24	98,44
30	Sulawesi Barat	91,12	93,58	93,79	94,44	94,22	86,79	88,06	90,77	90,88	91,31	88,93	90,79	92,27	92,64	92,75
31	Maluku	98,02	98,53	99,17	99,31	99,27	96,15	97,14	98,38	98,39	98,61	97,09	97,83	98,77	98,85	98,94
32	Maluku Utara	97,75	98,34	99,18	99,08	99,11	94,9	96,37	97,51	97,87	98,2	96,35	97,37	98,36	98,49	98,67
33	Papua Barat	96,02	97,51	98,72	98,07	98	90,94	93,41	94,49	95,5	95,97	93,62	95,59	96,75	96,88	97,05
34	Papua	71,28	73,63	76,7	75,59	76,72	58,49	60,15	64,13	65,47	64,6	65,3	67,31	70,78	70,83	71,02
Indonesia		95,69	96,47	96,79	97,11	97,17	90,27	91,4	93,45	93,34	93,59	92,97	93,92	95,12	95,22	95,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan : Angka Melek Huruf tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

7,03

6,08

4,88

4,7821

4,62

Lampiran 1.18

ANGKA PARTISIPASISEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 - 2016

No	Provinsi	2013				2014				2015				2016			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	99,66	95,23	74,70	29,18	99,84	97,38	80,89	32,93	99,90	97,71	81,43	33,07	99,82	97,89	81,82	33,94
2	Sumatera Utara	99,03	92,11	71,24	21,81	99,26	96,06	75,78	24,82	99,35	96,34	76,23	25,16	99,42	96,48	76,43	26,62
3	Sumatera Barat	98,81	92,20	74,10	30,66	99,27	95,84	81,97	32,89	99,44	95,98	82,53	33,13	99,43	96,17	82,62	34,71
4	Riau	98,59	90,35	69,79	22,04	98,67	94,36	75,30	24,48	98,79	94,48	75,57	24,85	98,87	94,62	75,68	26,18
5	Jambi	98,81	91,96	63,97	20,25	99,46	94,88	70,41	22,11	99,55	95,06	70,75	22,22	99,57	95,35	71,20	23,86
6	Sumatera Selatan	98,57	89,47	60,74	14,08	99,47	93,36	67,84	16,87	99,53	93,52	68,40	17,00	99,61	93,68	68,67	18,07
7	Bengkulu	99,50	93,16	71,21	24,12	99,45	96,71	77,92	28,14	99,65	96,83	78,16	28,37	99,70	96,96	78,37	28,93
8	Lampung	99,03	91,06	64,41	16,19	99,56	94,01	68,75	18,67	99,62	94,24	69,04	18,81	99,63	94,32	69,31	19,72
9	Kep. Bangka Belitung	98,13	84,63	56,42	9,46	99,16	91,53	65,78	12,22	99,22	91,82	66,17	12,73	99,25	92,03	66,35	13,81
10	Kep.Riau	98,63	96,67	73,66	14,85	99,12	98,56	81,57	17,40	99,34	98,67	81,84	17,69	99,33	98,78	82,04	18,58
11	DKI Jakarta	99,40	95,47	66,09	19,65	99,47	96,69	70,23	22,52	99,56	97,19	70,73	22,71	99,61	97,47	70,83	23,06
12	Jawa Barat	98,85	89,40	59,98	17,34	99,30	92,84	65,48	19,27	99,57	93,19	65,72	19,40	99,54	93,41	65,82	20,37
13	Jawa Tengah	99,28	90,73	59,88	17,42	99,51	94,85	67,54	20,48	99,56	95,30	67,66	20,57	99,58	95,41	67,95	21,59
14	DI Yogyakarta	99,96	96,79	81,41	45,86	99,94	99,48	86,44	49,08	99,89	99,68	86,78	49,17	99,84	99,62	87,20	49,95
15	Jawa Timur	99,05	92,83	62,32	19,49	99,38	96,36	70,25	21,84	99,45	96,53	70,44	21,95	99,46	96,69	70,54	22,67
16	Banten	98,60	91,32	62,89	18,08	99,29	94,87	66,25	19,61	99,41	95,29	66,73	19,68	99,43	95,59	67,00	20,74
17	Bali	99,26	95,90	74,03	19,84	99,36	97,23	81,59	23,59	99,41	97,41	81,69	23,75	99,35	97,55	81,98	25,36
18	Nusa Tenggara Barat	98,20	92,23	66,40	22,64	99,11	97,27	75,68	26,73	99,48	97,44	75,86	26,84	99,42	97,60	76,24	27,79
19	Nusa Tenggara Timur	97,34	89,43	64,81	22,88	97,99	94,26	73,96	26,22	98,13	94,39	74,25	26,54	98,24	94,60	74,56	26,75
20	Kalimantan Barat	96,91	85,94	58,80	19,27	98,18	91,76	66,48	23,18	98,27	91,91	66,83	23,32	98,39	92,12	67,16	24,75
21	Kalimantan Tengah	99,05	86,14	59,18	19,89	99,46	92,94	65,84	22,31	99,54	93,13	66,00	22,47	99,49	93,25	66,12	22,72
22	Kalimantan Selatan	98,76	86,60	60,19	16,95	99,24	91,83	67,18	20,36	99,43	91,91	67,49	20,53	99,48	92,21	67,91	21,89
23	Kalimantan Timur	99,46	96,49	73,92	25,04	99,35	97,89	80,50	27,34	99,63	97,92	80,68	27,55	99,54	98,18	80,81	28,88
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	98,39	93,55	74,41	17,87	98,45	93,79	74,72	19,07
25	Sulawesi Utara	98,92	90,48	66,88	16,36	98,95	94,34	71,98	20,91	99,33	94,59	72,22	21,31	99,36	94,89	72,57	22,82
26	Sulawesi Tengah	97,70	87,49	66,12	21,76	97,71	91,23	73,64	25,05	98,02	91,80	73,80	25,13	98,00	92,08	73,96	25,57
27	Sulawesi Selatan	98,24	89,66	62,67	27,80	98,91	92,57	69,38	30,23	99,03	92,66	69,66	30,64	99,12	92,85	70,09	31,48
28	Sulawesi Tenggara	98,00	89,12	65,84	24,00	99,11	93,53	72,25	28,78	99,30	93,67	72,42	28,89	99,28	93,94	72,67	29,31
29	Gorontalo	97,90	86,23	59,91	23,27	98,40	90,47	68,69	27,94	98,69	90,75	69,03	28,38	98,71	91,01	69,12	28,98
30	Sulawesi Barat	95,20	84,55	59,62	18,04	97,91	89,26	66,97	21,53	98,00	89,84	67,14	21,97	98,08	89,93	67,34	22,36
31	Maluku	98,79	94,44	70,28	33,80	99,19	96,35	77,48	36,44	99,38	96,44	77,87	36,60	99,39	96,60	78,19	37,51
32	Maluku Utara	98,02	93,40	69,04	26,42	98,89	96,24	74,83	30,85	99,08	96,68	75,16	31,25	99,14	96,90	75,58	31,75
33	Papua Barat	95,59	92,94	71,89	24,10	96,65	96,28	79,87	29,66	96,74	96,58	79,99	29,96	96,85	96,86	80,28	31,45
34	Papua	75,23	72,64	53,19	17,50	80,69	78,07	61,63	22,48	81,04	78,14	61,96	22,55	81,11	78,86	62,07	23,75
Indonesia		98,42	90,81	63,84	20,14	98,92	94,44	70,31	22,82	99,09	94,72	70,61	22,95	99,09	94,88	70,83	23,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Keterangan : APS tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.19

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	99,90	97,56	79,71	32,95	99,73	98,24	83,91	34,96	99,82	97,89	81,82	33,94
2	Sumatera Utara	99,34	95,84	73,90	25,23	99,50	97,15	79,13	28,07	99,42	96,48	76,43	26,62
3	Sumatera Barat	99,32	94,67	78,66	31,70	99,54	97,86	86,31	37,87	99,43	96,17	82,62	34,71
4	Riau	98,75	92,89	75,27	25,76	99,01	96,33	76,13	26,65	98,87	94,62	75,68	26,18
5	Jambi	99,57	94,70	66,94	25,12	99,57	96,05	75,73	22,47	99,57	95,35	71,20	23,86
6	Sumatera Selatan	99,47	92,89	64,66	16,97	99,75	94,54	72,87	19,22	99,61	93,68	68,67	18,07
7	Bengkulu	99,61	96,31	76,68	29,57	99,78	97,62	80,28	28,24	99,70	96,96	78,37	28,93
8	Lampung	99,67	91,05	67,03	20,01	99,58	97,70	71,71	19,42	99,63	94,32	69,31	19,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,29	91,98	64,27	12,71	99,22	92,09	68,70	15,05	99,25	92,03	66,35	13,81
10	Kepulauan Riau	99,12	98,72	82,54	16,75	99,53	98,84	81,57	20,35	99,33	98,78	82,04	18,58
11	DKI Jakarta	99,30	96,50	72,60	23,44	99,92	98,42	69,04	22,71	99,61	97,47	70,83	23,06
12	Jawa Barat	99,57	92,06	63,65	21,34	99,51	94,79	68,06	19,34	99,54	93,41	65,82	20,37
13	Jawa Tengah	99,57	94,65	68,09	19,88	99,59	96,17	67,80	23,31	99,58	95,41	67,95	21,59
14	DI Yogyakarta	100,00	99,78	86,04	51,66	99,66	99,46	88,40	48,22	99,84	99,62	87,20	49,95
15	Jawa Timur	99,48	96,07	69,81	21,87	99,44	97,38	71,29	23,49	99,46	96,69	70,54	22,67
16	Banten	99,23	94,54	63,54	19,43	99,65	96,62	70,66	22,11	99,43	95,59	67,00	20,74
17	Bali	99,62	97,77	83,95	27,02	99,08	97,33	79,47	23,60	99,35	97,55	81,98	25,36
18	Nusa Tenggara Barat	99,80	97,71	81,28	29,38	99,03	97,48	71,33	26,30	99,42	97,60	76,24	27,79
19	Nusa Tenggara Timur	98,35	91,80	73,25	28,92	98,12	97,50	75,94	24,59	98,24	94,60	74,56	26,75
20	Kalimantan Barat	98,10	91,41	65,33	27,08	98,69	92,88	68,91	22,30	98,39	92,12	67,16	24,75
21	Kalimantan Tengah	99,55	91,87	66,48	23,42	99,43	94,67	65,74	21,84	99,49	93,25	66,12	22,72
22	Kalimantan Selatan	99,69	91,44	66,80	20,49	99,24	92,94	69,02	23,35	99,48	92,21	67,91	21,89
23	Kalimantan Timur	99,56	97,92	81,68	29,06	99,53	98,45	79,78	28,68	99,54	98,18	80,81	28,88
24	Kalimantan Utara	98,46	94,42	72,07	16,69	98,43	93,23	77,59	22,09	98,45	93,79	74,72	19,07
25	Sulawesi Utara	99,15	93,23	67,15	20,48	99,57	96,59	78,73	25,47	99,36	94,89	72,57	22,82
26	Sulawesi Tengah	97,14	90,73	75,83	27,07	98,88	93,57	71,92	24,12	98,00	92,08	73,96	25,57
27	Sulawesi Selatan	99,02	91,15	68,27	29,92	99,23	94,54	72,10	33,06	99,12	92,85	70,09	31,48
28	Sulawesi Tenggara	99,24	91,44	73,63	26,85	99,32	96,46	71,59	31,89	99,28	93,94	72,67	29,31
29	Gorontalo	98,53	87,38	63,44	27,66	98,91	94,83	75,71	30,31	98,71	91,01	69,12	28,98
30	Sulawesi Barat	97,34	86,71	65,24	22,05	98,90	93,23	69,71	22,66	98,08	89,93	67,34	22,36
31	Maluku	99,26	96,09	77,98	39,00	99,54	97,12	78,44	35,93	99,39	96,60	78,19	37,51
32	Maluku Utara	99,06	96,37	75,86	29,05	99,24	97,43	75,28	34,93	99,14	96,90	75,58	31,75
33	Papua Barat	96,59	96,28	80,72	32,67	97,10	97,48	79,81	29,85	96,85	96,86	80,28	31,45
34	Papua	81,56	79,02	63,49	25,71	80,61	78,66	60,45	21,27	81,11	78,86	62,07	23,75
Indonesia		99,05	93,82	69,62	23,64	99,12	95,98	72,11	24,23	99,09	94,88	70,83	23,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 - 2016

No	Provinsi	2013			2014			2015			2016		
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	110,71	94,39	75,09	111,66	95,87	81,53	113,36	97,88	83,33	111,26	99,15	87,47
2	Sumatera Utara	110,01	86,84	77,15	110,34	90,29	82,96	112,62	95,41	84,14	110,89	90,71	93,25
3	Sumatera Barat	109,92	85,46	71,00	110,89	88,05	80,46	113,25	90,94	81,42	110,39	91,05	84,70
4	Riau	107,30	88,49	69,60	109,42	90,79	76,33	110,40	94,14	76,16	110,04	93,84	78,30
5	Jambi	109,41	85,17	65,61	110,73	87,83	73,63	111,99	91,78	76,12	112,97	90,75	80,36
6	Sumatera Selatan	110,74	86,07	63,78	112,01	88,43	72,51	114,47	93,56	73,18	114,33	88,54	82,51
7	Bengkulu	111,36	85,00	72,71	113,95	88,23	79,49	116,16	88,79	82,79	113,13	90,38	83,56
8	Lampung	110,73	85,47	63,81	112,74	86,76	68,49	113,38	100,83	73,90	111,44	93,58	82,98
9	Kep. Bangka Belitung	109,97	73,38	68,50	113,22	82,52	75,51	111,07	87,60	76,41	111,75	84,38	79,10
10	Kep. Riau	108,85	90,21	80,26	108,99	91,06	81,36	108,27	92,38	93,20	108,86	90,40	89,47
11	DKI Jakarta	103,91	86,35	72,72	104,18	90,86	74,71	105,26	88,35	76,35	104,32	90,89	73,09
12	Jawa Barat	106,75	85,26	60,12	106,98	87,50	68,55	109,42	90,07	70,23	108,09	89,58	70,56
13	Jawa Tengah	108,95	87,42	64,02	110,18	89,40	73,55	110,36	91,40	82,15	109,46	89,96	86,27
14	DI Yogyakarta	108,50	83,37	90,04	109,11	90,66	94,62	106,69	97,88	82,64	106,75	93,15	91,87
15	Jawa Timur	105,82	90,34	62,91	106,88	91,98	72,24	108,64	91,13	80,02	108,17	92,54	81,23
16	Banten	107,47	89,85	63,32	109,89	89,55	72,94	112,07	92,27	69,76	109,05	92,17	71,65
17	Bali	105,60	93,88	79,92	105,59	95,99	85,27	105,00	96,82	86,61	104,97	96,19	86,41
18	Nusa Tenggara Barat	107,90	88,72	65,00	109,08	92,44	76,68	111,54	91,94	89,51	110,78	93,40	91,25
19	Nusa Tenggara Timur	113,44	80,25	64,85	114,68	88,66	71,86	116,46	88,96	75,54	114,12	89,56	79,34
20	Kalimantan Barat	110,61	75,68	59,02	113,75	80,15	65,72	114,82	82,30	81,88	113,75	79,79	87,00
21	Kalimantan Tengah	110,83	80,85	58,85	112,01	84,89	67,74	114,76	95,94	70,70	114,01	86,30	78,44
22	Kalimantan Selatan	108,81	79,52	62,14	110,52	82,45	71,36	111,14	82,81	73,88	111,63	85,78	76,88
23	Kalimantan Timur	107,14	90,79	83,02	110,32	92,04	85,97	112,61	97,90	90,31	110,04	95,28	95,38
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	101,66	100,48	83,77	103,96	96,60	89,85
25	Sulawesi Utara	107,39	84,68	80,88	108,86	87,70	83,48	111,23	91,06	86,30	110,26	89,50	86,32
26	Sulawesi Tengah	103,12	86,10	77,98	104,71	88,53	83,35	107,28	90,73	82,87	105,78	89,48	83,45
27	Sulawesi Selatan	108,48	78,72	74,71	109,06	82,77	78,51	111,33	85,56	78,03	109,71	83,38	83,66
28	Sulawesi Tenggara	110,22	81,91	72,31	112,40	85,97	82,22	111,56	87,39	81,39	109,96	86,70	81,81
29	Gorontalo	109,79	73,88	65,60	111,88	78,64	76,95	110,58	81,87	86,74	108,34	83,71	88,67
30	Sulawesi Barat	105,84	70,13	71,57	108,42	80,41	76,30	105,92	80,25	84,98	106,23	81,00	83,49
31	Maluku	109,74	87,77	85,44	111,35	90,50	86,04	112,99	88,92	95,13	110,30	90,61	92,12
32	Maluku Utara	110,55	82,08	81,19	110,75	86,06	84,23	115,41	93,90	84,61	113,70	89,13	83,67
33	Papua Barat	105,23	87,45	73,24	109,36	87,86	83,12	113,46	90,33	89,00	111,49	92,44	89,59
34	Papua	85,95	65,01	53,48	90,67	71,02	61,53	95,15	73,59	66,97	94,74	72,07	66,85
Indonesia		107,71	85,96	66,61	108,87	88,63	74,26	110,50	91,17	78,02	109,31	90,12	80,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
Keterangan : APK tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.21

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMN TAHUN 2016

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	111,54	99,93	87,06	31,00	110,96	98,31	87,87	39,56	111,26	99,15	87,47	35,24
2	Sumatera Utara	110,27	91,35	90,67	19,39	111,54	90,06	96,01	29,43	110,89	90,71	93,25	24,31
3	Sumatera Barat	110,85	91,11	79,10	28,83	109,91	90,97	89,90	40,16	110,39	91,05	84,70	34,36
4	Riau	110,44	93,68	77,08	23,39	109,62	94,00	79,66	26,96	110,04	93,84	78,30	25,10
5	Jambi	113,73	90,24	76,09	21,98	112,18	91,29	84,90	23,47	112,97	90,75	80,36	22,69
6	Sumatera Selatan	115,87	86,39	80,85	17,92	112,77	90,90	84,25	18,82	114,33	88,54	82,51	18,36
7	Bengkulu	113,37	91,74	80,81	30,63	112,91	89,00	86,69	36,86	113,13	90,38	83,56	33,61
8	Lampung	112,64	89,01	81,78	12,57	110,09	98,31	84,24	14,54	111,44	93,58	82,98	13,52
9	Kepulauan Bangka Belitung	115,57	83,00	81,36	6,70	108,06	85,96	76,55	16,83	111,75	84,38	79,10	11,47
10	Kepulauan Riau	111,80	88,08	90,22	16,41	106,08	92,49	88,78	19,95	108,86	90,40	89,47	18,21
11	DKI Jakarta	105,27	92,22	73,88	27,33	103,33	89,59	72,29	27,95	104,32	90,89	73,09	27,65
12	Jawa Barat	108,43	88,04	69,39	18,50	107,73	91,16	71,77	22,88	108,09	89,58	70,56	20,63
13	Jawa Tengah	110,81	89,78	83,80	14,14	108,04	90,14	88,96	18,83	109,46	89,96	86,27	16,48
14	DI Yogyakarta	108,11	93,27	96,98	56,51	105,16	93,04	86,57	54,91	106,75	93,15	91,87	55,71
15	Jawa Timur	108,86	90,56	82,38	25,51	107,44	94,73	80,06	21,48	108,17	92,54	81,23	23,52
16	Banten	108,22	90,67	71,11	24,88	109,93	93,65	72,23	23,82	109,05	92,17	71,65	24,37
17	Bali	106,36	95,77	87,46	28,11	103,57	96,60	85,05	25,86	104,97	96,19	86,41	27,02
18	Nusa Tenggara Barat	110,92	95,93	98,57	19,75	110,64	90,80	84,11	23,29	110,78	93,40	91,25	21,57
19	Nusa Tenggara Timur	116,67	84,56	78,44	19,70	111,43	94,74	80,29	25,72	114,12	89,56	79,34	22,71
20	Kalimantan Barat	113,21	78,91	92,22	16,81	114,31	80,74	82,01	17,90	113,75	79,79	87,00	17,34
21	Kalimantan Tengah	115,52	83,17	80,67	17,04	112,44	89,52	76,01	22,82	114,01	86,30	78,44	19,59
22	Kalimantan Selatan	112,88	82,64	76,81	16,29	110,17	88,77	76,96	22,01	111,63	85,78	76,88	19,09
23	Kalimantan Timur	111,06	94,46	100,75	21,19	108,98	96,08	88,98	32,42	110,04	95,28	95,38	26,43
24	Kalimantan Utara	105,71	97,14	87,75	17,77	102,00	96,11	92,12	23,66	103,96	96,60	89,85	20,36
25	Sulawesi Utara	111,25	84,42	82,47	23,99	109,22	94,73	90,69	27,99	110,26	89,50	86,32	25,87
26	Sulawesi Tengah	105,79	88,13	85,82	25,66	105,77	90,97	80,87	33,55	105,78	89,48	83,45	29,66
27	Sulawesi Selatan	108,76	82,76	84,01	29,32	110,74	84,00	83,28	39,84	109,71	83,38	83,66	34,54
28	Sulawesi Tenggara	109,74	84,20	81,04	36,39	110,18	89,23	82,69	39,57	109,96	86,70	81,81	37,94
29	Gorontalo	109,37	83,26	79,79	22,03	107,22	84,18	98,99	30,63	108,34	83,71	88,67	26,31
30	Sulawesi Barat	106,24	77,21	79,84	21,55	106,22	84,89	87,61	24,68	106,23	81,00	83,49	23,14
31	Maluku	111,74	90,25	90,82	37,54	108,77	90,98	93,57	40,41	110,30	90,61	92,12	38,94
32	Maluku Utara	115,03	86,22	82,84	32,70	112,21	92,02	84,56	36,97	113,70	89,13	83,67	34,66
33	Papua Barat	113,51	90,07	91,50	25,20	109,52	94,94	87,54	29,50	111,49	92,44	89,59	27,06
34	Papua	97,03	68,63	75,00	16,36	92,24	76,09	57,49	18,12	94,74	72,07	66,85	17,14
Indonesia		109,93	88,91	80,51	21,84	108,66	91,38	81,29	25,09	109,31	90,12	80,89	23,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 - 2016

No	Provinsi	2013			2014			2015			2016		
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	97,09	82,57	63,43	97,80	85,20	69,20	97,99	85,55	69,82	98,16	85,73	70,00
2	Sumatera Utara	95,64	73,98	62,19	96,29	78,33	65,80	96,47	78,48	66,69	96,57	78,71	66,85
3	Sumatera Barat	97,10	72,56	61,00	97,92	75,61	66,52	98,12	76,00	66,90	98,23	76,19	67,12
4	Riau	95,33	74,23	58,74	96,42	77,67	62,31	96,63	78,22	62,60	96,74	78,53	62,76
5	Jambi	96,43	73,23	52,13	97,15	77,34	59,22	97,68	77,94	59,41	97,81	78,09	59,52
6	Sumatera Selatan	95,12	72,06	51,67	96,13	75,87	57,92	96,41	76,18	58,27	96,59	76,43	58,59
7	Bengkulu	97,37	73,07	60,32	98,03	76,44	64,61	98,10	76,88	64,97	98,22	77,02	65,29
8	Lampung	97,41	74,96	53,48	97,98	77,98	57,64	98,32	78,20	58,39	98,46	78,34	58,85
9	Kep. Bangka Belitung	95,72	63,83	50,80	96,49	71,83	56,93	96,66	72,42	57,02	96,75	72,75	57,22
10	Kep. Riau	97,64	83,31	67,62	98,22	83,36	70,52	98,68	83,77	71,23	98,83	84,06	71,58
11	DKI Jakarta	96,07	75,46	55,40	96,84	79,61	58,79	96,91	80,20	59,04	97,01	80,35	59,30
12	Jawa Barat	97,08	76,76	52,25	97,60	79,30	56,48	97,68	79,55	56,73	97,82	79,76	56,92
13	Jawa Tengah	95,68	74,94	51,81	96,45	78,57	58,11	96,57	78,66	58,27	96,64	78,89	58,49
14	DI Yogyakarta	98,75	75,64	64,86	98,98	82,20	68,46	99,23	82,86	68,60	99,21	83,05	68,96
15	Jawa Timur	96,10	77,36	53,30	96,98	80,94	60,00	97,38	81,16	60,31	97,49	81,35	60,76
16	Banten	96,24	78,17	53,28	96,69	79,56	56,87	96,98	79,84	57,04	97,22	79,93	57,21
17	Bali	94,11	80,69	67,04	95,29	84,58	70,83	95,64	84,78	71,53	95,75	84,99	71,71
18	Nusa Tenggara Barat	96,71	80,21	58,00	97,62	82,29	64,11	97,80	82,83	64,97	97,90	83,17	65,19
19	Nusa Tenggara Timur	93,53	59,32	47,30	94,56	65,86	52,15	94,95	66,32	52,51	95,24	66,56	52,87
20	Kalimantan Barat	94,39	59,53	44,79	95,75	64,23	50,06	96,09	64,55	50,32	96,22	64,69	50,43
21	Kalimantan Tengah	97,41	68,15	45,43	98,13	75,40	51,75	98,54	75,76	52,36	98,67	75,92	52,50
22	Kalimantan Selatan	96,74	69,57	50,05	97,44	72,40	55,04	97,75	72,51	55,58	98,05	72,70	55,91
23	Kalimantan Timur	95,76	75,79	62,91	96,81	78,96	67,41	97,00	79,06	67,78	97,13	79,20	67,92
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	91,83	77,25	62,34	92,18	77,46	62,80
25	Sulawesi Utara	91,61	64,55	57,26	93,42	72,32	61,69	93,97	73,02	62,23	94,12	73,15	62,50
26	Sulawesi Tengah	90,27	63,72	58,38	91,77	70,62	63,13	92,35	71,10	63,32	92,48	71,25	63,61
27	Sulawesi Selatan	95,67	69,79	54,26	96,39	73,18	59,10	96,84	73,51	59,47	96,99	73,67	59,62
28	Sulawesi Tenggara	95,15	69,68	55,50	95,97	74,77	61,91	96,15	75,43	62,23	96,27	75,54	62,63
29	Gorontalo	95,93	64,26	48,91	96,74	68,29	56,07	97,09	68,71	56,24	97,23	68,89	56,37
30	Sulawesi Barat	93,52	62,00	52,22	94,97	68,37	56,65	95,29	68,92	56,78	95,41	69,10	57,08
31	Maluku	92,25	67,06	55,59	93,74	73,10	62,60	94,34	73,29	63,07	94,50	73,40	63,49
32	Maluku Utara	95,47	70,73	59,54	96,21	75,03	63,10	96,65	75,38	63,20	96,75	75,68	63,47
33	Papua Barat	89,71	60,90	53,80	92,76	68,18	62,29	92,90	68,29	62,40	93,06	68,58	62,62
34	Papua	72,57	45,76	36,73	78,36	53,68	43,11	78,56	54,21	43,22	78,66	54,26	43,27
Indonesia		95,59	73,88	54,25	96,45	77,53	59,35	96,70	77,82	59,71	96,82	77,95	59,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
Keterangan : APM tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Total	Meninggal	Case Fatality Rate (%)	Faktor Risiko																								
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS			
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Dimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
1	Aceh	2	2	100,0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
2	Sumatera Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Sumatera Barat	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	
4	Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Jambi	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Sumatera Selatan	3	0	0,0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	1	0	2	0	1	0	2	2	0	1	
7	Bengkulu	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Lampung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kep. Bangka Bditung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kepulauan Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	DKI Jakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Jawa Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Jawa Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	DIYogyakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Jawa Timur	19	8	42,1	0	11	4	4	0	1	3	15	0	0	3	16	0	3	0	12	4	10	8	1	0	15	4	0	
16	Banten	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Bali	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kalimantan Barat	4	2	50,0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	3	1	0	2	2	0	
21	KalimantanTengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Kalimantan Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kalimantan Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Kalimantan Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Sulawesi Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Sulawesi Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Gorontalo	1	0	0,0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
30	Sulawesi Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Maluku	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Maluku Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Papua Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Papua	3	2	66,7	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	2	0	2	1	0	2	0	1	
Indonesia		33	14	42,4	0	16	5	9	3	2	4	23	4	0	4	25	4	3	7	15	8	11	16	4	2	24	6	3	

Sumber: Ditjen P2P per 15 Februari 2017

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus	Incidens Rate (per 100.000 Penduduk)	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	5.001.953	1.452	29,0	0
2	Sumatera Utara	13.937.797	186	1,3	0
3	Sumatera Barat	5.196.289	472	9,1	0
4	Riau	6.344.402	0	0,0	0
5	Jambi	3.402.052	1.156	34,0	0
6	Sumatera Selatan	8.052.315	791	9,8	0
7	Bengkulu	1.874.944	95	5,1	0
8	Lampung	8.117.268	442	5,4	0
9	Kep. Bangka Belitung	1.372.813	0	0,0	0
10	Kepulauan Riau	1.973.043	625	31,7	0
11	DKI Jakarta	10.177.924	273	2,7	0
12	Jawa Barat	46.709.569	595	1,3	1
13	Jawa Tengah	33.774.141	2.043	6,0	0
14	DI Yogyakarta	3.679.176	0	0,0	0
15	Jawa Timur	38.847.561	2.937	7,6	0
16	Banten	11.955.243	0	0,0	0
17	Bali	4.152.833	4	0,1	0
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	4	0,1	0
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	0	0,0	0
20	Kalimantan Barat	4.789.574	65	1,4	0
21	Kalimantan Tengah	2.495.035	304	12,2	0
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	0	0,0	0
23	Kalimantan Timur	3.426.638	0	0,0	0
24	Kalimantan Utara	641.936	0	0,0	0
25	Sulawesi Utara	2.412.118	239	9,9	0
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	685	23,8	0
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	67	0,8	0
28	Sulawesi Tenggara	2.499.540	95	3,8	0
29	Gorontalo	1.133.237	85	7,5	0
30	Sulawesi Barat	1.282.162	0	0,0	0
31	Maluku	1.686.469	0	0,0	0
32	Maluku Utara	1.162.345	0	0,0	0
33	Papua Barat	871.510	0	0,0	0
34	Papua	3.149.375	66	2,1	0
Indonesia		255.461.686	12.681	5,0	1

Sumber: Ditjen P2P per 20 April 2017

JUMLAH KASUS CAMPAK DAN KASUS CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)										Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		≥ 15 Tahun				
		Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	111	17	420	156	495	156	220	72	206	28	1.452	429	29,5
2	Sumatera Utara	7	0	63	26	65	25	40	19	11	1	186	71	38,2
3	Sumatera Barat	10	1	80	38	232	114	82	46	68	28	472	227	48,1
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	Jambi	62	5	218	23	324	35	211	20	341	7	1.156	90	7,8
6	Sumatera Selatan	84	48	254	200	266	176	111	69	76	43	791	536	67,8
7	Bengkulu	3	2	15	11	33	20	22	19	22	11	95	63	66,3
8	Lampung	21	12	155	124	162	88	61	37	43	31	442	292	66,1
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	74	29	176	96	224	154	64	32	87	42	625	353	56,5
11	DKI Jakarta	49	11	115	47	74	34	24	6	11	2	273	100	36,6
12	Jawa Barat	66	14	203	78	167	64	93	46	66	12	595	214	36,0
13	Jawa Tengah	93	12	414	66	665	93	372	37	499	70	2.043	278	13,6
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15	Jawa Timur	201	41	777	379	888	465	443	196	628	143	2.937	1.224	41,7
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17	Bali	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	4	3	75,0
18	Nusa Tenggara Barat	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
20	Kalimantan Barat	4	0	18	3	23	2	15	8	5	1	65	14	21,5
21	Kalimantan Tengah	33	7	62	26	84	46	50	15	75	20	304	114	37,5
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	10	2	54	12	67	25	62	25	46	15	239	79	33,1
26	Sulawesi Tengah	74	18	130	73	164	70	149	77	168	55	685	293	42,8
27	Sulawesi Selatan	2	0	14	5	11	7	14	5	26	5	67	22	32,8
28	Sulawesi Tenggara	10	2	15	4	28	18	23	15	19	9	95	48	50,5
29	Gorontalo	9	0	15	0	24	3	22	0	15	1	85	4	4,7
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
34	Papua	14	0	24	2	15	1	5	1	8	4	66	8	12,1
Indonesia		940	224	3.223	1.370	4.013	1.597	2.083	745	2.422	530	12.681	4.466	35,2

Sumber: Ditjen P2P per 20 April 2017

FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5	5	5	0	82	0
2	Sumatera Utara	10	9	9	0	116	0
3	Sumatera Barat	33	26	26	0	495	1
4	Riau	10	9	9	0	114	0
5	Jambi	27	20	20	0	256	0
6	Sumatera Selatan	14	14	13	0	125	0
7	Bengkulu	5	0	0	0	52	0
8	Lampung	7	4	4	0	58	1
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	4	2	2	0	32	0
21	Kalimantan Tengah	1	0	0	0	11	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	0	0	0	36	0
26	Sulawesi Tengah	2	1	1	0	12	0
27	Sulawesi Selatan	2	1	1	0	11	0
28	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	69	2
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	2	0	0	0	20	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	2	0	0	0	22	0
Indonesia		129	91	90	0	1.511	4

Sumber: Ditjen P2P per 20 April 2017

KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Konfirmasi Laboratorium											Tanpa Spesimen	
		Total Darah (Serum) Sampel	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab.			
			Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	26	0	0	0	0	0	0	0	0	5	82	0	0
2	Sumatera Utara	55	3	19	0	0	0	0	0	0	7	97	0	0
3	Sumatera Barat	230	0	0	0	0	0	0	0	0	33	495	0	0
4	Riau	88	7	86	2	23	1	5	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	153	0	0	0	0	0	0	0	0	27	256	0	0
6	Sumatera Selatan	101	3	21	3	18	0	0	0	0	8	86	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	0	0
8	Lampung	32	0	0	0	0	0	0	0	0	7	58	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4	32	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	36	0	0
26	Sulawesi Tengah	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0
27	Sulawesi Selatan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	69	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	0	0
Indonesia		718	13	126	5	41	1	5	0	0	110	1.339	0	0

Sumber: Ditjen P2P per 20 April 2017

JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2016

5-9																
No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)										Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi Terhadap Total Kasus	Total Meninggal	Case Fatality Rate (%)
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		≥ 15 Tahun						
		Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	0	0	2	0	3	0	3	0	1	0	9	0	0,0	3	33,3
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2	66,7	1	33,3
3	Sumatera Barat	1	0	2	2	6	6	0	0	0	0	9	8	88,9	0	0,0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
5	Jambi	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	66,7	0	0,0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
7	Bengkulu	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	50,0	0	0,0
8	Lampung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0	0	0,0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0	1	100,0
11	DKI Jakarta	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	4	2	50,0	1	25,0
12	Jawa Barat	2	1	21	7	46	14	12	6	52	6	133	34	25,6	13	9,8
13	Jawa Tengah	1	0	10	6	4	3	1	0	0	0	16	9	56,3	0	0,0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
15	Jawa Timur	3	2	48	42	75	64	22	18	61	14	209	140	67,0	4	1,9
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
20	Kalimantan Barat	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	50,0	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	3	2	1	1	0	0	5	3	60,0	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0,0	0	0,0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	4	1	25,0	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	5	5	100,0	0	0,0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100,0	0	0,0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0	1	50,0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
34	Papua	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0	0	0,0
Indonesia		10	5	97	63	148	96	44	27	116	20	415	211	50,8	24	5,8

Sumber: Ditjen P2P per 15 Maret 2017

Lampiran 6.24

NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN
DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Kasus Non Polio AFP	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Spesimenadekuat (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	32	2,00	71,8
2	Sumat era Utara	95	2,11	100,0
3	Sumat era Barat	32	2,00	93,7
4	Riau	8	0,39	100,0
5	Jambi	22	2,20	77,2
6	Sumat era Selatan	42	1,70	80,9
7	Bengkulu	7	1,27	85,7
8	Lampung	63	2,74	85,7
9	Kep. Bangka Belitung	2	0,50	100,0
10	Kepulauan Riau	5	0,77	80,0
11	DKI Jakarta	75	2,88	40,0
12	Jawa Barat	258	2,02	86,8
13	Jawa Tengah	173	2,08	94,7
14	DI Yogyakarta	18	2,12	83,3
15	Jawa Timur	183	2,03	84,6
16	Banten	76	2,11	89,4
17	Bali	35	3,24	74,2
18	Nusa Tenggara Barat	32	2,13	59,3
19	Nusa Tenggara Timur	41	2,16	75,0
20	Kalimantan Barat	28	1,93	96,4
21	Kalimantan Tengah	16	2,13	75,0
22	Kalimantan Selatan	20	1,67	65,0
23	Kalimantan Timur	15	1,40	86,6
24	Kalimantan Utara	1	0,40	100,0
25	Sulawesi Utara	15	2,31	80,0
26	Sulawesi Tengah	20	2,35	75,0
27	Sulawesi Selatan	40	1,60	92,5
28	Sulawesi Tenggara	17	1,89	70,5
29	Gorontalo	19	5,43	78,9
30	Sulawesi Barat	1	0,22	100,0
31	Maluku	2	0,17	50,0
32	Maluku Utara	1	0,25	-
33	Papua Barat	*	*	*
34	Papua	9	0,90	33,3
Indonesia		1.403	1,96	83,1

Sumber: Ditjen P2P per 2 Juni 2017

Keterangan: * = Tidak ada data

Lampiran 6.25

JUMLAH KASUS, ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK, JUMLAH KAB/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA DAN API<1
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Populasi	Suspek	Sediaan Darah Diperiksa			Positif	Peng obatan ACT	% Konfirmasi	% ACT	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah Kabupaten/Kota dengan API<1
				Pemeriksaan Mikroskopik	Rapid Diagnostic Test	Total							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	5.096.248	48.243	37.694	10.031	47.725	243	209	99%	86%	0,05	18	23
2	Sumatera Utara	14.102.911	46.466	14.479	29.241	43.720	3.807	3.562	94%	94%	0,27	18	29
3	Sumatera Barat	5.259.528	5.094	4.296	679	4.975	650	649	98%	100%	0,12	16	18
4	Riau	6.500.971	14.760	6.887	7.814	14.701	166	127	100%	77%	0,03	7	12
5	Jambi	3.458.926	45.138	25.249	16.207	41.456	492	460	92%	93%	0,14	3	11
6	Sumatera Selatan	8.160.901	33.598	16.252	14.586	30.838	2.286	1.917	92%	84%	0,28	7	14
7	Bengkulu	1.904.793	34.297	22.920	10.922	33.842	2.770	2.477	99%	89%	1,45	3	5
8	Lampung	8.205.141	24.793	18.222	6.571	24.793	3.298	3.210	100%	97%	0,40	5	12
9	Kep. Bangka Belitung	1.401.827	31.564	29.375	2.189	31.564	158	158	100%	100%	0,11	5	7
10	Kepulauan Riau	2.028.169	9.190	4.418	4.189	8.607	721	409	94%	57%	0,36	3	6
11	DKI Jakarta	10.277.628	70	70	0	70	70	70	100%	100%	0,01	6	6
12	Jawa Barat	47.379.389	22.036	15.680	3.055	18.735	323	228	85%	71%	0,01	23	27
13	Jawa Tengah	34.019.095	53.998	48.546	5.452	53.998	1.091	910	100%	83%	0,03	28	35
14	DI Yogyakarta	3.720.912	95	95	0	95	95	95	100%	100%	0,03	4	5
15	Jawa Timur	39.075.152	11.421	10.845	576	11.421	303	262	100%	86%	0,01	37	38
16	Banten	12.203.148	28	28	0	28	28	28	100%	100%	0,00	6	8
17	Bali	4.200.069	7.978	7.978	0	7.978	6	6	100%	100%	0,00	9	9
18	Nusa Tenggara Barat	4.896.162	92.427	73.758	13.519	87.277	1.168	1.035	94%	89%	0,24	3	10
19	Nusa Tenggara Timur	5.203.514	247.616	215.664	26.989	242.653	28.129	27.278	98%	97%	5,41	0	6
20	Kalimantan Barat	4.861.738	48.790	18.171	29.531	47.702	297	233	98%	78%	0,06	2	14
21	Kalimantan Tengah	2.550.192	18.866	9.105	9.718	18.823	474	456	100%	96%	0,19	5	14
22	Kalimantan Selatan	4.055.479	14.465	8.270	6.195	14.465	2.117	1.978	100%	93%	0,52	4	11
23	Kalimantan Timur	3.501.232	13.152	5.639	7.513	13.152	1.228	1.081	100%	88%	0,35	3	8
24	Kalimantan Utara	666.333	2.538	2.065	473	2.538	22	14	100%	64%	0,03	1	5
25	Sulawesi Utara	2.436.921	23.498	12.028	11.470	23.498	1.752	1.752	100%	100%	0,72	3	12
26	Sulawesi Tengah	2.921.715	32.132	17.871	12.802	30.673	1.446	873	95%	60%	0,49	3	9
27	Sulawesi Selatan	8.606.375	18.986	13.821	4.405	18.226	992	933	96%	94%	0,12	14	24
28	Sulawesi Tenggara	2.770.910	14.435	6.360	8.075	14.435	1.226	1.189	100%	97%	0,44	8	16
29	Gorontalo	1.150.765	13.302	10.275	2.962	13.237	176	173	100%	98%	0,15	2	6
30	Sulawesi Barat	1.306.478	38.091	24.631	13.460	38.091	119	118	100%	99%	0,09	1	6
31	Maluku	1.715.548	53.039	33.758	16.594	50.352	6.780	6.604	95%	97%	3,95	0	3
32	Maluku Utara	1.185.912	29.259	18.718	8.479	27.197	2.888	2.296	93%	80%	2,44	0	2
33	Papua Barat	893.362	73.457	39.579	11.765	51.344	6.063	4.804	70%	79%	6,79	0	1
34	Papua	3.207.444	397.357	319.346	70.303	389.649	147.066	135.406	98%	92%	45,85	0	1
Indonesia		258.924.888	1.520.179	1.092.093	365.765	1.457.858	218.450	201.000	96%	92%	0,84	247	413

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2013-2016

No	Provinsi	API			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	0,44	0,16	0,08	0,05
2	Sumatera Utara	1,30	0,69	0,49	0,27
3	Sumatera Barat	0,26	0,18	0,14	0,12
4	Riau	0,23	0,13	0,10	0,03
5	Jambi	1,11	0,84	0,47	0,14
6	Sumatera Selatan	0,39	0,30	0,31	0,28
7	Bengkulu	3,89	2,17	2,03	1,45
8	Lampung	0,34	0,55	0,49	0,40
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,28	0,86	1,08	0,11
10	Kepulauan Riau	0,49	0,41	0,35	0,36
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,01
12	Jawa Barat	0,00	0,01	0,00	0,01
13	Jawa Tengah	0,04	0,05	0,06	0,03
14	DI Yogyakarta	0,02	0,02	0,03	0,03
15	Jawa Timur	0,00	0,01	0,00	0,01
16	Banten	0,01	0,00	0,00	0,00
17	Bali	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0,57	0,78	0,42	0,24
19	Nusa Tenggara Timur	16,37	12,81	7,04	5,41
20	Kalimantan Barat	0,23	0,17	0,13	0,06
21	Kalimantan Tengah	2,00	1,32	0,42	0,19
22	Kalimantan Selatan	1,43	1,35	0,68	0,52
23	Kalimantan Timur	0,47	0,32	0,46	0,35
24	Kalimantan Utara	-	0,09	0,03	0,03
25	Sulawesi Utara	1,11	0,94	0,88	0,72
26	Sulawesi Tengah	1,13	0,80	0,68	0,49
27	Sulawesi Selatan	0,25	0,10	0,10	0,12
28	Sulawesi Tenggara	0,62	0,46	0,41	0,44
29	Gorontalo	1,08	0,84	0,57	0,15
30	Sulawesi Barat	0,40	0,25	0,17	0,09
31	Maluku	8,25	6,00	5,81	3,95
32	Maluku Utara	4,51	3,32	2,77	2,44
33	Papua Barat	38,44	20,85	31,29	6,79
34	Papua	42,65	29,57	31,93	45,85
Indonesia		1,38	0,99	0,85	0,84

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 6.27

JUMLAH PENDERITA, *INCIDENCE RATE* PER 100.000 PENDUDUK, KASUS MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE* (%)
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Demam Berdarah Dengue			
			Jumlah Kasus	<i>Incidence Rate</i> per 100.000 Penduduk	Jumlah Kasus Meninggal	<i>Case Fatality Rate</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.096.248	2.651	52,02	21	0,79
2	Sumatera Utara	14.102.911	8.618	61,11	46	0,53
3	Sumatera Barat	5.260.528	3.985	75,75	18	0,45
4	Riau	6.500.971	4.170	64,14	39	0,94
5	Jambi	3.458.926	1.553	44,90	14	0,90
6	Sumatera Selatan	8.160.901	3.851	47,19	25	0,65
7	Bengkulu	1.904.793	1.746	91,66	22	1,26
8	Lampung	8.205.139	4.516	55,04	15	0,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.401.827	490	34,95	3	0,61
10	Kepulauan Riau	2.028.169	1.983	97,77	20	1,01
11	DKI Jakarta	10.277.628	20.423	198,71	14	0,07
12	Jawa Barat	47.379.389	36.631	77,31	270	0,74
13	Jawa Tengah	34.019.095	14.376	42,26	213	1,48
14	DI Yogyakarta	3.720.912	6.247	167,89	26	0,42
15	Jawa Timur	39.075.152	24.480	62,65	343	1,40
16	Banten	12.202.848	6.139	50,31	71	1,16
17	Bali	4.200.069	21.668	515,90	62	0,29
18	Nusa Tenggara Barat	4.896.162	2.585	52,80	24	0,93
19	Nusa Tenggara Timur	5.203.514	1.015	19,51	2	0,20
20	Kalimantan Barat	4.861.738	588	12,09	8	1,36
21	Kalimantan Tengah	2.550.196	1.659	65,05	24	1,45
22	Kalimantan Selatan	4.055.479	4.098	101,05	28	0,68
23	Kalimantan Timur	3.501.232	10.712	305,95	103	0,96
24	Kalimantan Utara	666.333	1.055	158,33	11	1,04
25	Sulawesi Utara	2.436.921	1.975	81,04	17	0,86
26	Sulawesi Tengah	2.921.715	2.314	79,20	22	0,95
27	Sulawesi Selatan	8.606.375	7.685	89,29	41	0,53
28	Sulawesi Tenggara	2.792.180	3.444	123,34	33	0,96
29	Gorontalo	1.150.765	746	64,83	20	2,68
30	Sulawesi Barat	1.306.478	873	66,82	8	0,92
31	Maluku	1.715.548	363	21,16	21	5,79
32	Maluku Utara	1.185.912	297	25,04	8	2,69
33	Papua Barat	893.362	105	11,75	0	0,00
34	Papua	3.207.444	1.130	35,23	6	0,53
Indonesia		258.946.860	204.171	78,85	1.598	0,78

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2016

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota			Kabupaten/Kota Terjangkit					
		2014	2015	2016	2014		2015		2016	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	23	23	21	91,30	21	91,30	21	91,30
2	Sumatera Utara	33	33	33	30	90,91	31	93,94	30	90,91
3	Sumatera Barat	19	19	19	18	94,74	18	94,74	19	100,00
4	Riau	12	12	12	12	100,00	10	83,33	12	100,00
5	Jambi	11	11	11	10	90,91	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	17	16	94,12	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	7	5	71,43	7	100,00	6	85,71
11	DKI Jakarta	6	6	6	5	83,33	6	100,00	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	27	27	100,00	27	100,00	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	38	38	100,00	38	100,00	38	100,00
16	Banten	8	8	8	8	100,00	8	100,00	8	100,00
17	Bali	9	9	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	22	6	27,27	11	50,00	11	50,00
20	Kalimantan Barat	14	14	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	15	14	93,33	14	93,33	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	13	100,00	12	92,31	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	22	91,67	23	95,83	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	14	17	17	9	64,29	12	70,59	16	94,12
29	Gorontalo	6	6	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	6	6	100,00	5	83,33	5	83,33
31	Maluku	11	11	11	4	36,36	6	54,55	8	72,73
32	Maluku Utara	10	10	10	6	60,00	6	60,00	8	80,00
33	Papua Barat	13	13	13	3	23,08	5	38,46	5	38,46
34	Papua	29	29	29	7	24,14	5	17,24	10	34,48
Indonesia		511	514	514	433	84,74	446	86,77	463	90,08

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2014-2016

No	Provinsi	2014			2015			2016		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	607	375	1	740	521	1	601	314	0
2	Sumatera Utara	3.255	2.514	10	4.158	3.038	14	3.775	2.880	9
3	Sumatera Barat	3.262	2.435	8	3.358	2.531	7	1.717	1.147	1
4	Riau	848	716	3	1.539	1.290	2	1.110	823	3
5	Jambi	630	570	0	755	718	1	906	889	1
6	Sumatera Selatan	114	62	0	852	880	2	469	447	0
7	Bengkulu	804	559	5	1.017	782	6	1.391	884	5
8	Lampung	626	461	3	1.041	940	0	561	455	1
9	Kep. Bangka Belitung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	112	58	0	522	365	3	554	213	1
13	Jawa Tengah*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	23	8	0	9	9	0	43	43	0
17	Bali	46.877	39.468	2	42.630	29.495	15	33.103	19.760	5
18	Nusa Tenggara Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	5.340	4.582	0	7.386	6.153	2	4.003	3.519	1
20	Kalimantan Barat	188	142	14	599	599	5	1.608	1.418	12
21	Kalimantan Tengah	991	862	5	1.904	1.383	8	1.472	729	5
22	Kalimantan Selatan	175	165	1	100	79	0	179	161	1
23	Kalimantan Timur	867	687	0	670	611	0	505	460	0
24	Kalimantan Utara	38	15	0	*	0	0	86	0	0
25	Sulawesi Utara	3.601	1.701	22	4.346	2.171	28	4.135	1.955	21
26	Sulawesi Tengah	1.212	968	4	1.672	1.379	2	1.815	1.562	5
27	Sulawesi Selatan	775	444	0	3.722	1.999	2	3.173	1.724	0
28	Sulawesi Tenggara	632	571	3	1.187	1.140	2	1.198	1.149	2
29	Gorontalo	563	391	5	674	510	6	545	479	4
30	Sulawesi Barat	425	425	0	30	30	0	0	0	0
31	Maluku	1.532	1.098	6	927	716	4	1.405	1.113	6
32	Maluku Utara	270	264	6	565	560	8	420	409	3
33	Papua Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		73.767	59.541	98	80.403	57.899	118	64.774	42.533	86
Persentase VAR/GHPR		80,7%			72,0%			65,7%		

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
Ket : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmedlab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Postif rabies dan mati
* daerah bebas rabies

Lampiran 6.30

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2016

No	Provinsi	2014			2015			2016		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DKI Jakarta	106	18	16,98	37	4	10,81 10,81	39	0	0,00
2	Jawa Barat	26	-	-	2	1	50,00 50,00	16	2	12,50
3	Jawa Tengah	198	32	16,16	149	24	16,11 16,11	164	30	18,29
4	DI Yogyakarta	154	9	5,84	144	19	13,19 13,19	114	11	9,65
5	Jawa Timur	61	2	3,28	3	0	0,00 0,00	468	12	2,56
6	Banten	0	-	-	31	17	54,84 54,84	32	7	21,88
7	Kalimantan Selatan	5	1	20,00	0	0	0,00 0,00	0	0	-
Indonesia		550	61	11,09	366	65	17,76	833	62	7,44

Sumber : DitjenP2P, Kemenkes RI,2017
Ket. : K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 6.31
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN VEKTOR TERPADU
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016

No	Provinsi	JumlahKabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	22
2	Sumatera Utara	18
3	Sumatera Barat	3
4	Riau	1
5	Jambi	5
6	Sumatera Selatan	7
7	Bengkulu	9
8	Lampung	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	6
10	Kepulauan Riau	4
11	DKI Jakarta	6
12	Jawa Barat	8
13	Jawa Tengah	21
14	DI Yogyakarta	3
15	Jawa Timur	6
16	Banten	3
17	Bali	8
18	Nusa Tenggara Barat	8
19	Nusa Tenggara Timur	10
20	Kalimantan Barat	3
21	Kalimantan Tengah	10
22	Kalimantan Selatan	10
23	Kalimantan Timur	8
24	Kalimantan Utara	1
25	Sulawesi Utara	6
26	Sulawesi Tengah	10
27	Sulawesi Selatan	22
28	Sulawesi Tenggara	8
29	Gorontalo	4
30	Sulawesi Barat	3
31	Maluku	2
32	Maluku Utara	7
33	Papua Barat	3
34	Papua	3
Indonesia		257

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 6.32

JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM

MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pandu PTM	Persentase Puskesmas Pandu PTM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	340	133	39,12
2	Sumatera Utara	571	247	43,26
3	Sumatera Barat	264	149	56,44
4	Riau	213	54	25,35
5	Jambi	183	130	71,04
6	Sumatera Selatan	322	187	58,07
7	Bengkulu	180	64	35,56
8	Lampung	292	212	72,60
9	Kep. Bangka Belitung	62	61	98,39
10	Kepulauan Riau	73	38	52,05
11	DKI Jakarta	340	232	68,24
12	Jawa Barat	1.050	406	38,67
13	Jawa Tengah	875	504	57,60
14	DI Yogyakarta	121	109	90,08
15	Jawa Timur	960	842	87,71
16	Banten	233	167	71,67
17	Bali	120	42	35,00
18	Nusa Tenggara Barat	158	97	61,39
19	Nusa Tenggara Timur	371	90	24,26
20	Kalimantan Barat	238	159	66,81
21	Kalimantan Tengah	195	102	52,31
22	Kalimantan Selatan	230	91	39,57
23	Kalimantan Timur	175	61	34,86
24	Kalimantan Utara	49	13	26,53
25	Sulawesi Utara	188	75	39,89
26	Sulawesi Tengah	189	77	40,74
27	Sulawesi Selatan	448	209	46,65
28	Sulawesi Tenggara	269	84	31,23
29	Gorontalo	93	29	31,18
30	Sulawesi Barat	94	12	12,77
31	Maluku	199	43	21,61
32	Maluku Utara	128	17	13,28
33	Papua Barat	151	30	19,87
34	Papua	393	7	1,78
Indonesia		9.767	4.773	48,87

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 6.33

JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang Melaksanakan Posbindu	% Desa yang Melaksanakan Posbindu	Jumlah Posbindu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	6.474	677	10,46	947
2	Sumatera Utara	6.110	456	7,46	642
3	Sumatera Barat	1.125	468	41,60	799
4	Riau	1.835	129	7,03	197
5	Jambi	1.562	360	23,05	612
6	Sumatera Selatan	3.236	486	15,02	727
7	Bengkulu	1.513	229	15,14	267
8	Lampung	2.640	671	25,42	988
9	Kep. Bangka Belitung	387	288	74,42	477
10	Kepulauan Riau	416	108	25,96	184
11	DKI Jakarta	267	233	87,27	945
12	Jawa Barat	5.962	930	15,60	1.753
13	Jawa Tengah	8.559	1.154	13,48	1.522
14	DI Yogyakarta	438	235	53,65	458
15	Jawa Timur	8.501	2.472	29,08	5.005
16	Banten	1.551	421	27,14	719
17	Bali	716	81	11,31	97
18	Nusa Tenggara Barat	1.137	364	32,01	643
19	Nusa Tenggara Timur	3.313	203	6,13	289
20	Kalimantan Barat	2.076	328	15,80	544
21	Kalimantan Tengah	1.572	186	11,83	302
22	Kalimantan Selatan	2.009	179	8,91	199
23	Kalimantan Timur	1.032	111	10,76	237
24	Kalimantan Utara	482	33	6,85	56
25	Sulawesi Utara	1.837	268	14,59	373
26	Sulawesi Tengah	2.017	205	10,16	276
27	Sulawesi Selatan	3.038	820	26,99	1.190
28	Sulawesi Tenggara	2.223	265	11,92	347
29	Gorontalo	729	110	15,09	137
30	Sulawesi Barat	647	38	5,87	65
31	Maluku	1.231	74	6,01	210
32	Maluku Utara	1.181	45	3,81	51
33	Papua Barat	1.839	75	4,08	125
34	Papua	5.529	50	0,90	87
Indonesia		83.184	12.349	14,85	21.470

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 6.34
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMPUNYAI PERATURAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN MELAKSANAKANNYA
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Peraturan KTR		Implementasi pada 50% Sekolah	
			Jumlah Kumulatif	%	Jumlah Kumulatif	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	23	12	52,2	2	8,7
2	Sumatera Utara	33	7	21,2	2	6,1
3	Sumatera Barat	19	8	42,1	8	42,1
4	Riau	12	6	50,0	2	16,7
5	Jambi	11	5	45,5	4	36,4
6	Sumatera Selatan	17	7	41,2	4	23,5
7	Bengkulu	10	5	50,0	2	20,0
8	Lampung	15	13	86,7	4	26,7
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,0	2	28,6
10	Kepulauan Riau	7	4	57,1	2	28,6
11	DKI Jakarta	6	6	100,0	6	100,0
12	Jawa Barat	27	16	59,3	8	29,6
13	Jawa Tengah	35	13	37,1	3	8,6
14	DI Yogyakarta	5	4	80,0	5	100,0
15	Jawa Timur	38	7	18,4	2	5,3
16	Banten	8	4	50,0	2	25,0
17	Bali	9	9	100,0	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	6	60,0	3	30,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,3	2	9,1
20	Kalimantan Barat	14	2	14,3	3	21,4
21	Kalimantan Tengah	14	8	57,1	3	21,4
22	Kalimantan Selatan	13	6	46,2	3	23,1
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	3	30,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0	2	40,0
25	Sulawesi Utara	15	10	66,7	3	20,0
26	Sulawesi Tengah	13	6	46,2	2	15,4
27	Sulawesi Selatan	24	19	79,2	4	16,7
28	Sulawesi Tenggara	17	2	11,8	2	11,8
29	Gorontalo	6	3	50,0	2	33,3
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3	2	33,3
31	Maluku	11	2	18,2	2	18,2
32	Maluku Utara	10	5	50,0	2	20,0
33	Papua Barat	13	4	30,8	2	15,4
34	Papua	29	1	3,4	2	6,9
Indonesia		514	226	44,0	109	21,2

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017

JUMLAH DAN KORBAN BENCANA MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2016

No.	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6.)	(7)	(8)	(9)
1	Banjir	145	26	42	566	4.435	3	143.805
2	Letusan Gunung Api	2	2	9	2	0	0	1.840
3	Gempa Bumi	12	8	107	456	755	0	92.699
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	119	21	168	76	1.356	24	11.906
6	Banjir Bandang	38	18	81	480	44.854	27	16.704
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	60	14	20	50	97	0	1.150
9	Gelombang Pasang/Badai	10	8	4	6	3.230	2	1.737
10	Banjir dan Tanah Longsor	14	11	11	28	851	1	7.541
	Jumlah Bencana Alam	400	108	442	1.664	55.578	57	277.382
11	Kebakaran	48	11	42	34	112	0	3.104
12	Kebakaran Hutan dan Lahan	2	1	0	0	103	0	500
13	Kecelakaan Transportasi	62	24	252	193	391	45	0
14	Kecelakaan Industri	4	3	1	10	5	0	0
15	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	2	1	0	4	77	0	0
16	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	98	17	34	1.945	2.566	0	0
17	Gagal Teknologi	21	9	20	67	55	0	0
18	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Bencana Non Alam	237	66	349	2.253	3.309	45	3.604
19	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	16	10	13	91	1.808	0	5.391
20	Aksi Teror dan Sabotase	8	5	13	37	23	0	0
	Jumlah Bencana Sosial	24	15	26	128	1.831	0	5.391
	Indonesia	661		817	4.045	60.718	102	286.377

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 6.38

JUMLAH DAN KORBAN BENCANA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2016

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	28	120	573	757	0	130.704
2	Sumatera Utara	28	53	141	136	10	1.132
3	Sumatera Barat	40	27	156	487	2	15.056
4	Riau	11	4	0	1.539	0	13.037
5	Jambi	9	8	2	1	13	401
6	Sumatera Selatan	17	14	157	238	0	2.975
7	Bengkulu	7	5	11	0	4	30
8	Lampung	7	4	8	58	0	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	6	5	811	0	5.253
10	Kepulauan Riau	6	79	6	1	15	0
11	DKI Jakarta	44	35	104	471	0	4.270
12	Jawa Barat	130	95	682	9.555	21	65.338
13	Jawa Tengah	85	106	319	4.599	1	10.400
14	DI Yogyakarta	8	25	35	71	0	35
15	Jawa Timur	95	70	1.012	908	6	1.872
16	Banten	13	25	26	95	4	5.821
17	Bali	9	12	23	197	0	112
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	203	36.320	0	9.159
19	Nusa Tenggara Timur	8	4	276	4	0	2.190
20	Kalimantan Barat	10	2	96	1.633	3	5.487
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	4	0	802
22	Kalimantan Selatan	2	3	0	0	1	137
23	Kalimantan Timur	11	17	10	111	4	15
24	Kalimantan Utara	3	4	2	0	0	6
25	Sulawesi Utara	8	12	2	20	0	2.732
26	Sulawesi Tengah	9	18	5	17	0	1.148
27	Sulawesi Selatan	24	13	58	85	2	1.106
28	Sulawesi Tenggara	3	6	9	2	0	1
29	Gorontalo	4	5	16	1.630	0	1.733
30	Sulawesi Barat	1	0	0	11	0	353
31	Maluku	4	0	4	498	3	2.598
32	Maluku Utara	4	10	24	122	1	112
33	Papua Barat	4	0	33	334	0	1.600
34	Papua	10	25	46	3	12	758
Indonesia		661	817	4.045	60.718	102	286.377

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 6.39
CAPAIAN PEMERIKSAAN PERTAMA JAMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN
TAHUN 2016

No	Provinsi	Cakupan Pemeriksaan sampai dengan 3 bulan sebelum masa operasional tahun berjalan (%)	
		2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	47,45	53,23
2	Sumatera Utara	67,17	43,52
3	Sumatera Barat	55,33	74,06
4	Riau	81,14	97,61
5	Jambi	55,77	63,53
6	Sumatera Selatan	54,71	75,24
7	Bengkulu	61,26	28,79
8	Lampung	42,41	35,45
9	Kep. Bangka Belitung	60,98	95,69
10	Kepulauan Riau	82,09	73,10
11	DKI Jakarta	59,93	102,55
12	Jawa Barat	62,82	78,51
13	Jawa Tengah	62,68	58,83
14	DI Yogyakarta	76,06	81,13
15	Jawa Timur	62,78	67,78
16	Banten	72,39	77,75
17	Bali	18,96	55,69
18	Nusa Tenggara Barat	70,94	34,30
19	Nusa Tenggara Timur	18,94	31,41
20	Kalimantan Barat	5,26	13,45
21	Kalimantan Tengah	29,57	30,29
22	Kalimantan Selatan	71,50	48,79
23	Kalimantan Timur	45,33	37,13
24	Kalimantan Utara	-	-
25	Sulawesi Utara	48,85	66,97
26	Sulawesi Tengah	41,34	59,97
27	Sulawesi Selatan	60,25	63,53
28	Sulawesi Tenggara	66,23	62,26
29	Gorontalo	88,03	80,61
30	Sulawesi Barat	50,86	71,86
31	Maluku	35,03	6,04
32	Maluku Utara	72,59	76,26
33	Papua Barat	69,93	67,91
34	Papua	26,44	11,60
Indonesia		60,93	65,68

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2017
Keterangan: - = Kalimantan Utara masih bergabung dengan Kalimantan Timur (data provinsi diambil dari Siskohat Kemenag).

Lampiran 6.40

PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN KLOTER HAJI
TAHUN 2016

No	Nama Penyakit	Kode ICD-X	Jumlah Kasus	% Rawat Jalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Acute Nasopharyngitis (Common Cold)	J00	70.006	20
2	Acute Upper Respiratory Infectios of Multiple and Unspecified Sites	J06	44.672	13
3	Essential (primary) Hypertension	I10	38.216	11
4	Myalgia	M79.1	23.246	7
5	Influenza Due to Other Identified Influenza Virus	J10	20.725	6
6	Acute Pharyngitis	J02	19.095	5
7	Cough	R05	16.674	5
8	Dyspepsia	K30	9.388	3
9	Non- Insulin- Dependent Diabetes Melitus	E11	9.178	3
10	Headache	R51	7.764	2

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 6.41

JUMLAH JEMAAH HAJI WAFAT DI ARAB SAUDI BERDASARKAN PENYEBAB PENYAKIT
TAHUN 2016

No	Sebab Penyakit	Pra Armina		Armina		Pasca Armina		Total Arab Saudi	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cardiovascular Diseases	59	65,6	31	55,4	90	45,9	180	52,6
2	Respiratory Diseases	12	13,3	13	23,2	69	35,2	94	27,5
3	Infectious and Parasitic Diseases	2	2,2	4	7,1	7	3,6	13	3,8
4	Malignant Neoplasms (Cancer)	4	4,4	2	3,6	7	3,6	13	3,8
5	Circulatory Diseases	4	4,4	0	0,0	8	4,1	12	3,5
6	Endocrine, Nutritional, and Metabolic Diseases	4	4,4	2	3,6	8	4,1	14	4,1
7	Digestive Diseases	4	4,4	3	5,4	1	0,5	8	2,3
8	Diseases of the Genitourinary System	1	1,1	1	1,8	5	2,6	7	2,0
9	Unintentional Injuries	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,3
10	Intentional Injuries	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11	Neuropsychiatric Disorders	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12	Nutritional Deficiencies	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13	Symptoms, Signs, and Abnormal Clinical and Laboratory	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jumlah		90	100,0	56	100,0	196	100,0	342	100,0

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 7.1

JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN2014-2016

No	Provinsi	2014			2015			2016		
		Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa STBM	%	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa STBM	%	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan STBM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	6.474	409	6,32	6.502	849	13,06	6.502	1.471	22,62
2	Sumatera Utara	6.080	466	7,66	5.924	503	8,49	5.924	1.093	18,45
3	Sumatera Barat	1.139	405	35,56	1.140	445	39,04	1.126	514	45,65
4	Riau	1.835	176	9,59	1.814	584	32,19	1.814	1.113	61,36
5	Jambi	1.561	296	18,96	1.547	361	23,34	1.547	543	35,10
6	Sumatera Selatan	3.194	710	22,23	3.189	1.031	32,33	3.191	1.366	42,81
7	Bengkulu	1.513	172	11,37	1.523	386	25,34	1.523	533	35,00
8	Lampung	2.640	528	20,00	2.626	848	32,29	2.626	1.081	41,17
9	Kep. Bangka Belitung	387	250	64,60	381	284	74,54	387	312	80,62
10	Kepulauan Riau	416	102	24,52	386	135	34,97	403	146	36,23
11	DKI Jakarta	267	5	1,87	267	5	1,87	267	26	9,74
12	Jawa Barat	5.960	1.816	30,47	5.936	2.135	35,97	5.936	2.401	40,45
13	Jawa Tengah	8.559	3.257	38,05	8.577	4.125	48,09	8.577	5.222	60,88
14	DI Yogyakarta	438	377	86,07	438	411	93,84	438	422	96,35
15	Jawa Timur	8.499	4.737	55,74	8.497	5.197	61,16	8.499	5.797	68,21
16	Banten	1.551	144	9,28	1.551	379	24,44	1.551	841	54,22
17	Bali	716	246	34,36	716	313	43,72	716	398	55,59
18	Nusa Tenggara Barat	1.137	932	81,97	1.137	1.034	90,94	1.137	1.081	95,07
19	Nusa Tenggara Timur	3.268	1.678	51,35	3.266	2.013	61,64	3.266	2.230	68,28
20	Kalimantan Barat	1.997	295	14,77	1.983	398	20,07	1.983	538	27,13
21	Kalimantan Tengah	1.572	380	24,17	1.565	601	38,40	1.565	738	47,16
22	Kalimantan Selatan	2.007	557	27,75	2.008	824	41,04	2.008	1.045	52,04
23	Kalimantan Timur	1.029	6	0,58	1.013	84	8,29	1.020	207	20,29
24	Kalimantan Utara *	482	89	-	479	18	3,76	479	64	13,36
25	Sulawesi Utara	1.822	338	18,55	1.738	114	6,56	1.738	137	7,88
26	Sulawesi Tengah	2.007	818	40,76	1.950	499	25,59	1.968	685	34,81
27	Sulawesi Selatan	3.038	232	7,64	3.023	978	32,35	3.023	1.570	51,94
28	Sulawesi Tenggara	2.197	188	8,56	2.247	568	25,28	2.247	657	29,24
29	Gorontalo	729	358	49,11	730	242	33,15	730	329	45,07
30	Sulawesi Barat	647	77	11,90	649	349	53,78	649	422	65,02
31	Maluku	1.224	138	11,27	1.076	88	8,18	1.076	144	13,38
32	Maluku Utara	1.180	166	14,07	1.194	159	13,32	1.194	235	19,68
33	Papua Barat	1.715	131	7,64	1.447	244	16,86	1.447	301	20,80
34	Papua	5.225	18	0,34	3.757	213	5,67	3.757	265	7,05
Indonesia		82.505	20.497	24,84	80.276	26.417	32,91	80.314	33.927	42,24

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 7.2

KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT
TAHUN 2016

No	Provinsi	JumlahKabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Penyelenggara Tatanan Kawasan Sehat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	6	26,09
2	Sumatera Utara	33	17	51,52
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	11	91,67
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	14	82,35
7	Bengkul u	10	8	80,00
8	Lampung	15	9	60,00
9	KepulauanBangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	5	71,43
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	6	75,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	31,82
20	Kalimantan Barat	14	8	57,14
21	Kalimantan Tengah	14	2	14,29
22	Kalimantan Selatan	13	10	76,92
23	Kalimantan Timur	10	9	90,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	12	80,00
26	Sulawesi Tengah	13	6	46,15
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	9	52,94
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	4	66,67
31	Maluku	11	3	27,27
32	Maluku Utara	10	2	20,00
33	Papua Barat	13	0	0,00
34	Papua	29	1	3,45
Indonesia		514	350	68,09

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 7.3

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK
TAHUN 2014-2016

No.	Provinsi	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	58,74	61,23	63,31
2	Sumatera Utara	66,86	71,41	70,61
3	Sumatera Barat	62,60	66,58	67,33
4	Riau	72,55	74,24	75,49
5	Jambi	62,01	62,75	63,23
6	Sumatera Selatan	60,75	65,16	63,77
7	Bengkulu	37,47	41,08	37,35
8	Lampung	49,92	55,06	52,41
9	Kep. Bangka Belitung	63,20	68,03	63,95
10	Kepulauan Riau	81,04	84,12	85,31
11	DKI Jakarta	92,10	93,40	92,44
12	Jawa Barat	65,01	67,20	67,62
13	Jawa Tengah	71,11	73,63	76,30
14	DI Yogyakarta	77,28	80,99	81,04
15	Jawa Timur	75,64	76,64	75,83
16	Banten	66,60	67,68	67,47
17	Bali	89,09	91,27	88,71
18	Nusa Tenggara Barat	64,33	71,70	73,98
19	Nusa Tenggara Timur	54,88	62,72	60,04
20	Kalimantan Barat	63,04	68,39	66,19
21	Kalimantan Tengah	56,05	57,01	61,26
22	Kalimantan Selatan	61,72	62,23	58,63
23	Kalimantan Timur	78,48	78,13	78,93
24	Kalimantan Utara	-	84,59	82,69
25	Sulawesi Utara	69,32	71,53	70,22
26	Sulawesi Tengah	58,99	61,49	62,15
27	Sulawesi Selatan	68,89	72,07	73,42
28	Sulawesi Tenggara	68,74	77,19	75,82
29	Gorontalo	63,30	66,47	71,59
30	Sulawesi Barat	47,07	53,89	58,99
31	Maluku	60,77	64,96	67,20
32	Maluku Utara	57,03	60,07	62,99
33	Papua Barat	66,87	68,85	68,76
34	Papua	48,99	51,27	52,69
Indonesia		68,38	70,97	71,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2014- 2016

Lampiran 7.4

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN
TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang Diawasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1.423	83	5,83
2	Sumatera Utara	1.157	71	6,14
3	Sumatera Barat	1.805	740	41,00
4	Riau	1.027	213	20,74
5	Jambi	781	169	21,64
6	Sumatera Selatan	447	27	6,04
7	Bengkulu	619	222	35,86
8	Lampung	877	61	6,96
9	Kep. Bangka Belitung	799	246	30,79
10	Kepulauan Riau	794	85	10,71
11	DKI Jakarta	517	31	6,00
12	Jawa Barat	5.474	738	13,48
13	Jawa Tengah	2.991	450	15,05
14	DI Yogyakarta	130	41	31,54
15	Jawa Timur	2.153	185	8,59
16	Banten	2.547	257	10,09
17	Bali	287	8	2,79
18	Nusa Tenggara Barat	404	73	18,07
19	Nusa Tenggara Timur	359	46	12,81
20	Kalimantan Barat	673	89	13,22
21	Kalimantan Tengah	958	176	18,37
22	Kalimantan Selatan	1.242	216	17,39
23	Kalimantan Timur	1.717	244	14,21
24	Kalimantan Utara	378	98	25,93
25	Sulawesi Utara	367	90	24,52
26	Sulawesi Tengah	554	111	20,04
27	Sulawesi Selatan	1.021	117	11,46
28	Sulawesi Tenggara	278	38	13,67
29	Gorontalo	453	192	42,38
30	Sulawesi Barat	150	59	39,33
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	109	36	33,03
33	Papua Barat	77	6	7,79
34	Papua	10	0	0,00
Indonesia		32.578	5.218	16,02

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

Lampiran 7.5

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014-2016

No	Provinsi	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Aceh	33,68	54,68	62,68
2	Sumatera Utara	66,92	67,89	72,86
3	Sumatera Barat	42,34	45,02	53,24
4	Riau	48,74	51,30	71,36
5	Jambi	58,58	58,21	65,65
6	Sumatera Selatan	59,79	61,30	65,05
7	Bengkulu	33,18	39,22	49,75
8	Lampung	37,27	44,83	58,58
9	Kep. Bangka Belitung	75,67	80,80	83,16
10	Kepulauan Riau	63,45	71,97	79,55
11	DKI Jakarta	87,05	89,28	91,13
12	Jawa Barat	61,00	59,43	63,79
13	Jawa Tengah	67,43	67,20	70,66
14	DI Yogyakarta	82,50	86,31	85,78
15	Jawa Timur	63,70	63,48	68,15
16	Banten	69,51	67,04	73,42
17	Bali	79,38	85,46	89,33
18	Nusa Tenggara Barat	59,41	63,72	70,31
19	Nusa Tenggara Timur	16,12	23,90	40,46
20	Kalimantan Barat	48,59	39,78	52,06
21	Kalimantan Tengah	30,85	35,88	50,97
22	Kalimantan Selatan	48,44	60,13	60,89
23	Kalimantan Timur	72,65	68,83	76,76
24	Kalimantan Utara	-	48,40	64,68
25	Sulawesi Utara	69,82	66,79	75,27
26	Sulawesi Tengah	52,47	55,37	59,94
27	Sulawesi Selatan	71,07	72,36	76,51
28	Sulawesi Tenggara	61,26	63,62	68,26
29	Gorontalo	54,07	54,96	59,85
30	Sulawesi Barat	52,45	51,21	59,81
31	Maluku	62,87	60,02	66,81
32	Maluku Utara	55,75	59,17	64,71
33	Papua Barat	61,85	62,81	64,55
34	Papua	21,66	28,04	31,43
Indonesia		61,08	62,14	67,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2014- 2016

Catatan: Mulai tahun 2015, konsep sanitasi layak ditambah dengan memasukkan plengsengan dengan tutup sebagai jamban /kloset yang dianggap layak

Lampiran 7.6
 PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
 TAHUN 2016

No	Provinsi	Jumlah Tempat-tempat Umum (TTU)	TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan	TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	546	364	66,67
2	Sumatera Utara	713	354	49,65
3	Sumatera Barat	21.423	13.088	61,09
4	Riau	165	115	69,70
5	Jambi	166	107	64,46
6	Sumatera Selatan	251	212	84,46
7	Bengkulu	2.123	1.842	86,76
8	Lampung	8.208	116	1,41
9	Kep. Bangka Belitung	1.334	1.181	88,53
10	Kepulauan Riau	277	127	45,85
11	DKI Jakarta	633	523	82,62
12	Jawa Barat	33.035	23.724	71,81
13	Jawa Tengah	30.871	919	2,98
14	DI. Yogyakarta	699	519	74,25
15	Jawa Timur	2.455	527	21,47
16	Banten	18.724	14.981	80,01
17	Bali	1.520	1.152	75,79
18	Nusa Tenggara Barat	5.792	4.847	83,68
19	Nusa Tenggara Timur	267	181	67,79
20	Kalimantan Barat	288	180	62,50
21	Kalimantan Tengah	265	200	75,47
22	Kalimantan Selatan	175	121	69,14
23	Kalimantan Timur	375	290	77,33
24	Kalimantan Utara	114	102	89,47
25	Sulawesi Utara	616	468	75,97
26	Sulawesi Tengah	165	137	83,03
27	Sulawesi Selatan	11.568	9.561	82,65
28	Sulawesi Tenggara	223	181	81,17
29	Gorontalo	92	62	67,39
30	Sulawesi Barat	134	56	41,79
31	Maluku	2.418	1.425	58,93
32	Maluku Utara	2.241	177	7,90
33	Papua Barat	258	84	32,56
34	Papua	456	302	66,23
	Indonesia	148.590	78.225	52,64

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2017

PUSAT DATA DAN INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2017